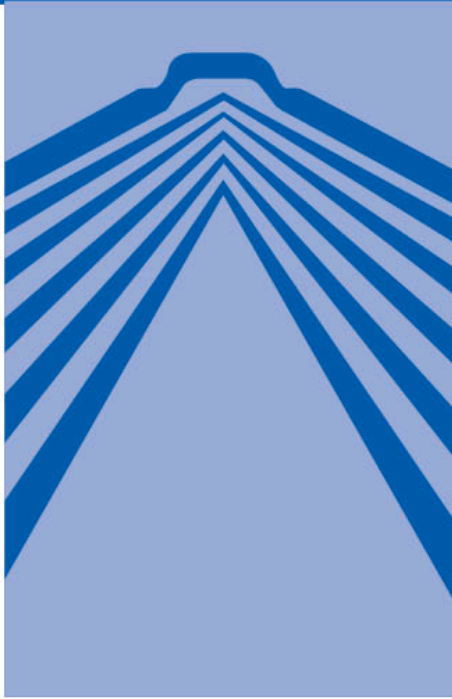




Manual de evaluación del riesgo de violencia

Metodología y ámbitos de aplicación

Ismael Loinaz

Manual de evaluación del riesgo de violencia

Metodología y ámbitos de aplicación

ISMAEL LOINAZ

PROFESOR DE CRIMINOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y PSICOBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB)

Manual de evaluación del riesgo de violencia

Metodología y ámbitos de aplicación

EDICIONES PIRÁMIDE

COLECCIÓN «PSICOLOGÍA»

Director:

Francisco J. Labrador

Catedrático de Modificación de Conducta
de la Universidad Complutense de Madrid

Edición en versión digital

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del copyright.

© Ismael Loinaz, 2017

© Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2017

Para cualquier información pueden dirigirse a piramide_legal@anaya.es

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

Teléfono: 91 393 89 89

www.edicionespiramide.es

ISBN digital: 978-84-368-3709-4

*A mi madre, quien, con su ojo clínico lego,
supo pronosticar durante mi adolescencia un «progreso favorable»,
apostando por mí y gestionando las situaciones de la mejor forma posible.
Sin su apoyo incondicional no sería quien soy.*

*A Mayalen, mi «factor protector»,
por once años de vida compartidos cada día, y los que nos quedan por vivir.*

Índice

Lista de abreviaturas	13
Presentación	15

PARTE PRIMERA **Aspectos básicos**

1. Violencia y delincuencia	21
1. Violencia, agresión, agresividad y delincuencia	21
1.1. Violencia y agresión: conductas	22
1.2. Agresividad: una disposición	23
1.3. Delincuencia y delito: categorías legales	24
1.4. El concepto de violencia en la evaluación del riesgo	25
2. Evaluación de delincuentes y sujetos violentos	27
 2. Trastorno mental y violencia	 29
1. Psicopatología y delincuencia	30
2. Referentes en la investigación sobre trastorno mental y conducta delictiva	33
2.1. Estudio MacArthur	34
2.2. Estudio de Dunedin	35
2.3. Estudio de Cambridge	36

PARTE SEGUNDA **La evaluación del riesgo de violencia**

3. Historia de la predicción del riesgo de violencia	41
1. Historia de la predicción	42
1.1. Antes de 1930	46
1.2. 1930	48
1.3. 1940	50

1.4.	1950	52
1.5.	1960	55
1.6.	1970	58
1.7.	1980	63
1.8.	De 1990 a la actualidad	68
1.8.1.	Generaciones de herramientas	71
1.8.2.	Situación actual	72
2.	De la peligrosidad al riesgo	73
3.	De la predicción a la gestión	74
4.	Factores relevantes en la evaluación del riesgo	77
1.	Factores de riesgo y de protección	80
1.1.	Factores de riesgo	80
1.2.	Factores de protección	80
2.	Factores de riesgo estáticos y dinámicos	82
2.1.	Factores estáticos	82
2.2.	Factores dinámicos	83
2.3.	Modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad	84
3.	Factores de riesgo según su influencia	84
5.	Conceptos clave en la evaluación del riesgo de violencia	87
1.	Aciertos y errores en la estimación	87
2.	Sensibilidad y especificidad	89
3.	Capacidad predictiva o eficacia diagnóstica	90
3.1.	Curva ROC	90
3.2.	AUC (área bajo la curva)	92
4.	<i>Odds ratio</i> , riesgo relativo y otros tamaños del efecto	92
4.1.	<i>Odds ratio</i> (OR)	93
4.2.	Riesgo relativo	94
4.3.	Tamaño del efecto	95
5.	Riesgo asumible	97
6.	Métodos en la evaluación del riesgo	101
1.	Juicio clínico no estructurado	102
2.	Método actuarial	103
2.1.	Árboles de clasificación	104
3.	Juicio profesional estructurado	105
4.	Enfrentamiento entre modelos: lo que la investigación indica	105
7.	Procedimiento: aplicación práctica de la evaluación del riesgo	111
1.	La elección de la herramienta	113
2.	La evaluación	116
3.	Formulación del riesgo	118

4.	Desarrollo de escenarios	122
4.1.	Escenarios en evaluación del riesgo de violencia	123
5.	Gestión del riesgo	124
5.1.	Investigación sobre gestión del riesgo	127
5.2.	Contextos de gestión del riesgo	128
5.3.	Violencia de pareja	129
6.	El resultado de la herramienta	130
6.1.	Formatos nominales o categorías de riesgo	132
6.2.	Puntos de corte	133
6.3.	Formatos numéricos	133
6.4.	Preferencias de los profesionales	135
6.5.	Implicaciones y conclusiones	136
7.	El informe en evaluación del riesgo	137

PARTE TERCERA

Principales herramientas disponibles

Introducción	143
8. Violencia inespecífica	145
1. HCR-20	145
1.1. Avances en la HCR-20 ^{V3}	147
2. VRAG	148
3. LSI-R	150
4. START	150
5. SAPROF	151
9. Violencia de pareja	153
1. DA	155
2. SARA	157
3. B-SAFER	160
4. ODARA	162
5. Herramientas creadas en el contexto español	164
5.1. EPV-R	164
5.2. RVD-Bcn	165
10. Violencia sexual	167
1. SVR-20	167
2. RSVP	169
3. RRASOR	170
4. Static-99	171
5. SORAG	173
6. RM2000	173

11. Violencia juvenil	175
1. SAVRY	175
2. YLS/CMI	177
3. START:AV	178
4. EARL-20B y EARL-21G	179
5. SAPROF:YV	180
6. Violencia sexual juvenil	181
6.1. ERASOR	181
6.2. J-SOAP-II	183
6.3. J-SORRAT-II	185
12. Otros tipos de violencia	187
1. Terrorismo, extremismo y radicalización	187
1.1. VERA	188
1.2. TRAP-18	190
1.3. ERG 22+	192
2. Acoso	193
2.1. SAM	194
2.2. SRP	196
3. Violencia en el ámbito laboral	197
3.1. WRA-20	198
3.2. ERA-20	198
3.3. WAVR-21	198
4. Crímenes de honor	199
4.1. PATRIARCH	200
4.2. DASH	201
13. Evaluación del riesgo en mujeres	203
1. ¿Son aplicables en mujeres las herramientas disponibles para valorar el riesgo? ..	203
2. Violencia inespecífica y delincuencia general	204
2.1. HCR-20	204
2.2. LSI-R	205
2.3. YLS/CMI	205
2.4. VRAG	205
2.5. SAVRY	206
2.6. FAM	207
3. Violencia de pareja	208
3.1. B-SAFER	208
3.2. SARA	209
3.3. ODARA	209
3.4. DA	209
4. Violencia sexual	209
5. Recomendaciones generales para valorar el riesgo de violencia en mujeres ...	210
Anexo	213
Referencias bibliográficas	217
Índice analítico	249

Lista de abreviaturas

AUC	Area Under the Curve (área bajo la curva).
B-SAFER	Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk.
DA	Danger Assessment.
DASH	Domestic Abuse, Stalking and Honour based violence.
EARL-20B	Early Assessment Risk Lists for Boys.
EARL-21G	Early Assessment Risk Lists for Girls.
EPV-R	Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja-Revisada.
ERA-20	Employee Risk Assessment-20.
ERASOR	Estimate of Risk of Adolescent Sex Offense Recidivism.
ERG 22+	Structured Professional Guidelines for Assessing Risk of Extremist Offending.
FAM	Female Additional Manual.
HCR-20	Historical Clinical Risk Management-20.
J-SOAP	Juvenile Sex Offender Assessment Protocol.
J-SORRAT	Juvenile Sexual Offense Recidivism Risk Assessment Tool.
LSI-R	Level of Service Inventory-Revised.
ODARA	Ontario Domestic Assault Risk Assessment.
PCL:SV	Psychopathy Checklist-Screening Version.
PCL-R	Psychopathy Checklist-Revised.
PCL:YV	Psychopathy Checklist-Youth Version.
RM2000	Risk Matrix.
ROC	Receiver Operating Characteristic o Relative Operating Characteristic.
RRASOR	Rapid Risk Assessment for Sex Offense Recidivism.
RSVP	Risk for Sexual Violence Protocol.
RVD-Bcn	Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja.
SAM	Guidelines for Stalking Assessment and Management.
SAPROF	Structured Assessment of Protective Factors for violence risk.
SAPROF-YV	Structured Assessment of Protective Factors for violence risk–Youth Version.
SARA	Spousal Assault Risk Assessment guide.
SAVRY	Structured Assessment of Violence Risk in Youth.

SORAG	Sex Offender Risk Appraisal Guide.
SRP	Stalking Risk Profile.
START	Short-Term Assessment of Risk and Treatability.
START:AV	Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version.
SVR-20	Sexual Violence Risk-20.
TRAP-18	Terrorist Radicalization Assessment Protocol-18.
VERA	Violent Extremism Risk Assessment.
VRAG	Violence Risk Appraisal Guide.
WAVR-21	Workplace Assessment of Violence Risk.
WRA-20	Workplace Risk Assessment-20.
YLS/CMI	Youth Level of Service/Case Management Inventory.

Presentación

La evaluación del riesgo de violencia es un objetivo multidisciplinar en el que pueden participar profesionales de distintas áreas (psicología, psiquiatría, criminología, derecho, trabajo y educación social, enfermería, etc.), distintos organismos públicos (prisiones, juzgados, cuerpos policiales, institutos de medicina legal, hospitales y servicios sociales) o entidades privadas. Diversos profesionales pueden recurrir a su aplicación, por su contacto directo con víctimas o agresores o por la solicitud de un tercero, como un órgano judicial. Por ello es necesario partir de una visión amplia y heterogénea, que tenga en cuenta las particularidades y necesidades de cada contexto y los rasgos en común de los mismos.

Los profesionales que están en contacto con distintas formas de violencia o delincuencia frecuentemente son requeridos para dar su opinión o valorar el riesgo de un sujeto. En general, se habla del riesgo de reincidencia en una conducta violenta o delictiva, con el interés último de poder poner los medios necesarios para reducir este riesgo, evitar la violencia o minimizar las consecuencias de una posible agresión. Psicólogos y psiquiatras pueden valorar el riesgo de un cliente o paciente, profesionales de institutos de medicina legal pueden informar bajo demanda de fiscalía de la urgencia y necesidad de protección en un caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden valorar la situación de riesgo de una víctima para ofrecerle protección, los equipos de instituciones penitenciarias pueden estimar el riesgo de un preso para gestionar el régimen interno o considerar posibles permisos de salida, y así podríamos se-

guir con una larga lista de situaciones en las que se puede valorar el riesgo de violencia.

El notable avance que la disciplina ha experimentado y las limitaciones existentes en el contexto hispanohablante hacen necesaria una formación y actualización constante por parte de todos los implicados en la materia o interesados en ella. Además, el conocimiento de la evolución de la disciplina y el estado actual de la metodología es una necesidad para académicos y profesionales de primera línea. Por ello, este manual va dirigido a profesionales de la psicología, la psiquiatría, el derecho y la criminología, distintas ramas sociales o de la salud, a todos los relacionados con la delincuencia y la violencia, y a estudiantes o investigadores de materias afines interesados en la temática.

El escaso material disponible en español, junto a las limitaciones en el ámbito de estudio señaladas por distintos autores (como la poca formación de los profesionales o el uso inadecuado de los protocolos), hacía necesaria la elaboración de un manual en español que tratase de compilar los principales avances y las recomendaciones disponibles, las indicaciones más actualizadas y la guía de aplicación práctica más útil para profesionales y estudiantes interesados. El manual aborda tanto la revisión histórica de la predicción en criminología, como aspectos más técnicos relacionados con conceptos y cuestiones estadísticas y las últimas novedades en el ámbito, como puede ser la publicación de la tercera edición de la HCR-20 y la SARA, dos de las herramientas más conocidas a nivel mundial.

Pese a que es una temática originada en el contexto forense anglosajón, de recurrente estudio e interés por ella, en el ámbito de formación en España y los demás países hispanohablantes la atención presentada a la cuestión es aún escasa, siendo anecdótico el espacio dedicado al tema en manuales en español comparado con los manuales anglosajones. Este aspecto pone de manifiesto la necesidad de desarrollo que vive esta disciplina.

La evaluación del riesgo de violencia ha experimentado una notable evolución en las últimas décadas. De los primeros intentos y primeras controversias en el ámbito de la criminología, hace ya casi cien años, hemos pasado a un momento de proliferación de estudios y herramientas en el que es fácil que el profesional no dedicado a la investigación o no especializado en la temática (e incluso el que sí lo está) se pueda perder o, lo que es peor, pueda aplicar de forma errónea las distintas herramientas (confundir criterios de aplicación o la muestra destinataria del instrumento, etc.). Por ejemplo, distintos trabajos ponen de manifiesto que la aplicación de los instrumentos sin seguir las instrucciones señaladas por los autores de los mismos puede dar lugar a resultados muy dispares, en muchos casos pudiéndose considerar malas praxis. No solo han evolucionado las metodologías y se ha incrementado el número de herramientas disponibles; también lo ha hecho la terminología utilizada, como es el caso concreto del rechazo al concepto de peligrosidad.

La evaluación del riesgo de violencia tiene un objetivo eminentemente práctico y al servicio de las necesidades de la sociedad en cada momento. Las estrategias de prevención se adaptan a los recursos disponibles en cada contexto y, a su vez, la evaluación responde a los requerimientos jurídicos de cada sociedad. Por ejemplo, esto se hace evidente en la aplicación de medidas de protección para la víctima (distintas según la región y los recursos de la misma) o las implicaciones de un riesgo elevado para el agresor (más o menos graves según la legislación de cada país). Por eso, el lector de este manual deberá adaptar las reco-

mendaciones generales aquí presentadas a la realidad social y jurídica del contexto en el que aplique el método y a la disponibilidad de recursos, principalmente en lo referente a la gestión del riesgo.

Asimismo, los recursos dedicados a cada área de evaluación del riesgo también han respondido a las sensibilidades sociales. En concreto, se puede afirmar que la mayor evolución de material se ha experimentado en el ámbito de la violencia contra la pareja, donde los distintos movimientos sociales han generado mayor presión y donde se han producido más reformas legales, generándose, a su vez, nuevas necesidades prácticas y metodológicas. Sin embargo, los recientes acontecimientos vinculados al terrorismo o radicalización también han hecho que cobre especial relevancia esta temática. Por tanto, los movimientos sociopolíticos y eventos históricos determinan en gran medida la deriva que toma la metodología de la evaluación del riesgo, respondiendo incluso a «modas» en los intereses académicos y sociales.

La formación y la investigación en materia de evaluación del riesgo de violencia

Como ya se ha mencionado, la evaluación del riesgo de violencia es una metodología multidisciplinar que puede ser aplicada por cualquier profesional formado en ello (salvaguardando las excepciones relacionadas con la codificación de ítems que requieren una formación especial, como los relacionados con los trastornos mentales). La evolución experimentada por la disciplina supone un reto para estos profesionales e investigadores. El gran volumen de información y de herramientas disponibles ha hecho que en la actualidad sea imprescindible una formación y actualización constante. Por ello, distintos organismos dedican esfuerzos al establecimiento de pautas y directrices sobre buenas prácticas en la evaluación y gestión del riesgo, así como de líneas de actuación para la investigación y formación de profesionales.

Entre las propuestas más destacadas está la guía *Best Practice in Managing Risk*, del Depar-

tamento de Salud del Reino Unido (DoH, 2007), uno de los principales referentes en el establecimiento de estándares en gestión del riesgo de violencia. En ella se establece la necesidad de actualizar la formación cada tres años, junto a otros puntos clave para el desarrollo y aplicación de la materia. El *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)* también dedica esfuerzos a establecer las mejores prácticas y recomendaciones sobre la gestión de la violencia. En mayo de 2015 actualizó su primera guía dedicada a la gestión a corto plazo de la conducta violenta en contextos psiquiátricos (NICE, 2005), ampliando las directrices a contextos de salud en general y comunitarios (NICE, 2015). En la actualidad, el máximo exponente en el establecimiento de directrices y la valoración de la metodología aplicada y las herramientas disponibles es la *Risk Management Authority (RMA)*. Se trata de un organismo público independiente, establecido por la Justicia Penal de Escocia, dedicado a garantizar la aplicación adecuada de las prácticas de evaluación y gestión del riesgo de violencia con el fin de proteger a la sociedad del riesgo que suponen delincuentes violentos o sexuales. Igualmente, supervisa la aplicación de herramientas y de estrategias de control o gestión, incluyendo la acreditación de profesionales en la materia. De especial interés son sus publicaciones sobre directrices y estándares, así como la valoración de las distintas herramientas para la evaluación del riesgo de violencia.

Esta cuestión de la formación y la supervisión institucional es muy relevante, pues de ello depende que la metodología pueda ser contrastada y se aplique de la mejor forma posible. Webster,

Haque, Augimeri et al. (2014) proponen una serie de cuestiones claves en la formación e investigación en evaluación del riesgo, como las redes de trabajo, el *feedback* a los profesionales que se forman en la materia, la revisión de los talleres para su constante mejora, la formación continua y la revisión de la fiabilidad de los procesos y los instrumentos. Todas estas cuestiones, sin duda, deberían marcar el horizonte de la evaluación del riesgo en el contexto hispanohablante.

Desde mis propios errores, dudas y confusiones en mis primeros contactos con la materia hace ya casi diez años, pasando por las incertidumbres que me transmiten colegas y participantes en cursos y talleres, he podido comprobar cómo la evaluación del riesgo de violencia es un ámbito complejo, plagado de dudas e incluso contradicciones, que requiere un estudio profundo y continuado que permita una mejor comprensión de sus fundamentos y un uso de la metodología ajustado al mejor conocimiento disponible en cada momento.

Por todo lo señalado en esta introducción, el presente manual pretende contribuir al desarrollo de la metodología y los estándares de aplicación en el contexto de habla hispana, suponiendo un compendio del estado actual de la cuestión y abordando desde los fundamentos más básicos hasta las cuestiones más concretas y especializadas. Por ello, tomaremos en consideración estas recomendaciones a la hora de presentar el contenido y ofrecer al lector una referencia en su formación en la evaluación del riesgo de violencia.

Barcelona, 19 de agosto de 2016.

PARTE PRIMERA

Aspectos básicos

Violencia y delincuencia

1

*No hay nada más práctico
que una buena teoría.*

KURT LEWIN

(Psicólogo social germano-estadounidense; 1890-1947)

El estudio de la conducta violenta es un aspecto complejo, cuyo análisis en detalle superaría con toda seguridad la extensión de este manual. Distintos tipos de violencia, motivos relacionados, prevención o intervención son lo suficientemente heterogéneos como para requerir abordajes específicos. Sin embargo, resulta necesaria una breve aproximación tanto al concepto de violencia como a la descripción de su evaluación desde el punto de vista psicométrico, por ser central en la metodología de la evaluación del riesgo. En este capítulo diferenciaremos los distintos conceptos utilizados como sinónimos (aunque muchos no lo sean) y algunas particularidades relacionadas con la evaluación de delincuentes.

1. VIOLENCIA, AGRESIÓN, AGRESIVIDAD Y DELINCUENCIA

Algo evidente en cualquier disciplina, aunque no por ello sea sencillo, es que para poder aplicar un procedimiento de evaluación de forma correcta y adecuada es necesario definir claramente el objeto a valorar. En el caso de la evaluación del

riesgo, o de su predicción, es imprescindible delimitar de forma clara y precisa qué queremos medir o predecir; en esencia, qué entendemos por violencia o reincidencia. Sin embargo, delimitar con precisión el término, qué incluye y qué no debe ser equiparado, es una de las principales limitaciones del ámbito de estudio.

Son numerosos los sinónimos o conductas que se consideran equivalentes: agresión, agresividad, delincuencia o criminalidad son usados como sinónimos en muchos contextos (incluido el académico). Incluso es difícil delimitar los niveles de gravedad en algunos casos, siendo tratadas de forma idéntica conductas muy dispares. ¿Es lo mismo una amenaza, un empujón, un apuñalamiento o la asfixia? No, pero todos ellos pueden ser etiquetados, por ejemplo, como violencia de pareja. Este problema terminológico no solo es propio de los ciudadanos en general, sino que también en el ámbito científico y profesional son muchos quienes confunden y mezclan conceptos.

A continuación delimitaremos estos conceptos para facilitar una mejor comprensión de los mismos y un uso más adecuado.

1.1. Violencia y agresión: conductas

Definir el término violencia no es un objetivo fácil (Tolan, 2007). Acotar el concepto responde muchas veces a factores socio-culturales, debiendo por ello tener en cuenta en cada momento el contexto del que proviene la definición. Esta falta de consenso muchas veces dificulta la comparación de resultados y el establecimiento de políticas de intervención, en especial cuando hablamos de tipos de violencia específicos (sexual o de género, por ejemplo).

La propia Organización Mundial de la Salud —OMS—, en el *Informe mundial sobre la violencia y la salud* (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2002), contempla este problema de definición afirmando que, además, es uno de los motivos por los que apenas se ha considerado la violencia como un problema de salud pública. La definición utilizada por la OMS desde 1996 ha sido la siguiente: *El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones*. Además, contempla tres grandes categorías: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva (Krug et al., 2002). La OMS, en su labor por prevenir y mejorar la situación de la violencia en el mundo, ha publicado una serie de informes en los últimos años dedicados a aspectos concretos, como la creación de programas basados en la evidencia para la prevención de la violencia sexual y de pareja contra las mujeres (OMS, 2011) o la prevención de la violencia interpersonal desde servicios sanitarios, jurídicos o sociales teniendo en cuenta también el hecho de que pueda ser predicha (OMS, 2014). Estos trabajos no solo buscan organizar el conocimiento y las iniciativas a nivel mundial, sino que se esfuerzan en el establecimiento de definiciones precisas que permitan la comparación de cifras. Otra iniciativa vinculada a la unificación de criterios y al establecimiento de estadísticas e indicadores que permitan la elaboración de propuestas internacionales y la compa-

ración de cifras son los informes de la UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*), por ejemplo sobre homicidios (UNODC, 2014) o la clasificación internacional de delitos (UNODC, 2015).

Shaver y Mikulincer (2011), desde el punto de vista de la psicología social, definen la agresión como la conducta desarrollada por una persona con la intención de dañar física o psicológicamente a otra que quiere evitar este daño; la violencia se define como una forma de agresión extrema, especialmente destructiva y cruel. La investigación también establece distinciones entre tipos de agresión o violencia, por ejemplo entre proactiva o reactiva (la primera también conocida como instrumental o premeditada y la segunda como hostil o impulsiva).

Las características propias de la conducta violenta son precisamente las que hacen compleja su predicción y/o prevención. Andrés-Pueyo y Redondo (2007) resumen estas características, ayudando a comprender lo complicado del objetivo de la evaluación del riesgo de violencia. La violencia sería:

- *Compleja*: con componentes de diversa índole y con distintas finalidades.
- *Heterogénea*: existen distintos tipos de violencia, de agresor y de víctima, de relación entre agresor y víctima, etc.
- *Multicausal*: es necesaria la combinación de múltiples factores; cada tipo de violencia tiene los suyos propios.
- *Intencionada*: es resultado de una decisión voluntaria de producir daño, aunque en ocasiones la capacidad de decidir se vea afectada (casos inimputables, semi-imputables o vinculados a problemas de control de los impulsos).
- *Infrecuente*: al margen de la alarma social, la violencia tiene una baja frecuencia que dificulta su predicción.

Un ejemplo claro de las dificultades relativas a la definición del concepto es el caso de la violencia de pareja. Pese a que este término pueda ser

claro y aplicable a distintos tipos de violencia interpersonal entre dos *sujetos* que comparten una relación afectiva (con independencia de su sexo), en la práctica ha sido más que variada la terminología escogida para referirse, en apariencia, al mismo concepto. Prueba de ello son la multitud de sinónimos descritos por McCue (2008) y utilizados en el contexto anglosajón: violencia doméstica, abuso conyugal, abuso doméstico, asalto doméstico, maltrato, abuso de pareja, conflicto conyugal, maltrato de la esposa o abuso a la mujer, entre muchos otros. En el contexto hispanohablante, aunque no con tanta variedad, también son múltiples los sinónimos utilizados: violencia de género, violencia sexista, violencia machista, violencia familiar, violencia doméstica o malos tratos en la pareja, e incluso femicidio o feminicidio en los casos más graves, por citar algunos. De hecho, la equivalencia realizada en el contexto jurídico español entre violencia de género y violencia de pareja no corresponde al significado internacional de la violencia de género, que implica cualquier tipo de violencia cometido contra mujeres, incluyendo la sexual, de pareja, la trata o explotación, mutilación genital, etc.

Un ejemplo de autoinforme de conductas violentas, conocido a nivel mundial, es la Conflict Tactics Scales —CTS-2— (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996), diseñada para medir la violencia en la pareja así como la negociación durante posibles conflictos. La CTS-2 consta de un total de 78 ítems, 39 para cada miembro de la pareja. Contiene cinco escalas, cada una de las cuales se divide a su vez en dos subescalas. La escala de negociación está dividida en «cognitiva» y «emocional», y las escalas de violencia (física, psicológica, sexual y daños) en «menor» y «severa». La CTS-2 mide el grado en que los dos miembros de una pareja (novios, casados o que cohabiten) se ven envueltos en ataques físicos o psicológicos mutuos, así como el uso del razonamiento y la negociación para resolver conflictos por parte de cada miembro. Los distintos formatos de corrección permiten calcular la prevalencia de violencia a lo largo de la relación, la frecuencia de conductas en el último año (o período por el que se pre-

gunte) y la gravedad de la violencia física. La herramienta ha sido utilizada principalmente en muestras universitarias, pero se dispone de algunas referencias y propiedades psicométricas de su uso en agresores en el contexto español (Loinaz, Echeburúa, Ortiz-Tallo y Amor, 2012). Recientemente se ha aplicado también en el estudio de la violencia y la bidireccionalidad en población general adulta (Cuenca, Graña y Redondo, 2015; Graña, Andreu, Peña y Rodríguez-Biezma, 2013; Graña y Cuenca, 2014).

1.2. Agresividad: una disposición

Algo importante a tener en cuenta es que el término violencia podría equivaler al de agresión (aunque el primero sea más amplio y abarque distintos aspectos) pero no al de agresividad (véase, por ejemplo, Buss, 1961). Las primeras son conductas objetivas (es decir, se pueden apreciar), mientras que la agresividad es más una tendencia o un impulso del individuo, algo que le puede llevar a *actuar* de forma violenta. La distinción es necesaria porque cuando hablamos de personas violentas podemos incluir a personas con tendencias agresivas, pero entendemos que deben haber exteriorizado estas tendencias, y lo que queremos predecir o gestionar es precisamente este tipo de expresiones o exteriorizaciones, que son las que pueden dañar a una víctima. La agresividad sería un factor de riesgo, pero por sí misma no podría causar daños a un tercero. Hablaríamos de personas con tendencias agresivas pero que aún no han sido violentas, y obviamente podríamos recomendar intervenciones o hacer estimaciones de su posible conducta violenta futura.

También había sido la postura tradicional en el ámbito jurídico, escenario habitual en el que se trabaja con el riesgo de violencia, castigar, condenar o controlar comportamientos (consumados o intentados —tentativas—), no idearios o impulsos (deseos, tendencias, etc.), aunque esto también esté cambiando en los últimos años, con las distintas reformas penales vinculadas a ideologías o apologías, la radicalización y los distintos

movimientos terroristas. En el contexto jurídico es habitual la distinción entre un accidente (no intencionado), la negligencia (falta de cuidado adecuado que resulta en un daño), la imprudencia (actuar en forma tal que incrementa el posible daño) y los delitos directos (como las agresiones), en los que la intención (*mens rea*) es clave para imputar al sujeto (Tolan, 2007).

Una herramienta clásica para la valoración de dimensiones agresivas es el *Inventario de Hostilidad de Buss y Durkee* —BDHI— (Buss y Durkee, 1957). Compuesto por 75 ítems en su versión original, se creó para evaluar los niveles de hostilidad (66 ítems) a través de siete dimensiones: violencia, hostilidad indirecta, irritabilidad, negativismo, resentimiento, desconfianza y hostilidad verbal. Además, incluye una escala de culpabilidad (de 9 ítems). Pese a haber sido empleado de forma amplia en distintas muestras de agresores, como los de pareja, su principal limitación es que los ítems fueron seleccionados sin unas propiedades factoriales concretas y su escasa fiabilidad (Rathus y Feindler, 2004). Por ello, desde el propio equipo de investigación se propuso el Cuestionario de Agresión —AQ— (Buss y Perry, 1992), que mide cuatro dimensiones (ira, hostilidad, agresión verbal y agresión física) y del que disponemos de validación española (Andreu, Peña y Graña, 2002) e incluso versión breve (Gallardo-Pujol, Kramp, García-Forero, Pérez-Ramírez y Andrés-Pueyo, 2006). Otra dimensión ampliamente estudiada en población violenta es la ira (Potegal, Stemmler y Spielberger, 2010; Potter-Efron, 2015), mediante inventarios como el STAXI-2 (Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 2001; Spielberger, 1999) o los de Novaco, como el NAS-PI —*Novaco Anger Scale and Provocation Inventory*— (Novaco, 2003).

Aunque no sea directamente una disposición agresiva, es habitual incluir en esta sección herramientas para la valoración de la impulsividad, como la Escala de Barratt —BIS-11— (Patton, Stanford y Barratt, 1995), con amplio uso en distintas muestras (Stanford et al., 2009; Vasconcelos, Malloy-Diniz y Correa, 2012) y adaptación

española disponible (Oquendo et al., 2001). Sin embargo, aunque la impulsividad y la agresividad están relacionadas, debemos recordar que son dos constructos diferentes (García-Forero, Gallardo-Pujol, Maydeu-Olivares y Andrés-Pueyo, 2009).

1.3. Delincuencia y delito: categorías legales

Los delitos son consideraciones jurídicas acotadas temporalmente, culturalmente y por un marco legal. Así pues, conductas que antiguamente eran consideradas ilegales hoy en día no lo son. Por el contrario, hemos visto cómo en los últimos años el repertorio de conductas que son consideradas delictivas, especialmente las violentas y enmarcadas en el ámbito familiar, se ha ido incrementando, en búsqueda de una sociedad más respetuosa con las personas, igualitaria y ética. Así pues, hoy en día es común considerar ilícitas conductas de acoso (sexual, laboral, cibernético), el maltrato familiar (a niños, padres, ancianos o entre iguales), la violencia en las relaciones íntimas (de pareja), distintas formas de violencia de género (explotación sexual, trata, mutilación genital, matrimonios forzados) y recientemente, aunque aún de forma insuficiente, el maltrato animal. Todas estas conductas eran igualmente violentas hace algunas décadas, pero sin embargo no eran consideradas delitos.

Por otro lado, estas categorías jurídicas no solo son temporales sino que están delimitadas cultural y geográficamente. Las legislaciones de cada país evolucionan de forma independiente, aunque en algunos casos, como en el contexto de la Unión Europea, se busquen soluciones comunes, al compartir los distintos países miembros un rumbo común. Así pues, conductas que recientemente hemos incorporado en nuestra legislación y para las que se desarrollan servicios y recursos específicos, es posible que en otros ámbitos aún no hayan sido abordadas de igual manera (véase, por ejemplo, el incremento notable de la atención al caso de la violencia filio-parental en el contexto

español, que incluye la creación de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental en 2013). Un ejemplo de la globalización en el contexto jurídico y la búsqueda de actuaciones conjuntas es la *Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 sobre la orden europea de protección*. Esta directiva forma parte del proceso de reconocimiento mutuo entre países de la unión europea de resoluciones penales. Al margen de las complejidades jurídicas y posibles conflictos entre jurisdicciones (véase Cueto, 2014), el objetivo de este tipo de propuestas es garantizar una mejor protección de las posibles víctimas dentro de espacios socio-políticos comunes. Debido a estas particularidades, debemos tener presente que cada sociedad desarrolla herramientas para la evaluación y gestión del riesgo de violencia adaptadas a sus necesidades y coyuntura legal. En general, además, estas formas de violencia son consideradas delictivas.

1.4. El concepto de violencia en la evaluación del riesgo

En el ámbito de la evaluación del riesgo, por violencia se entiende un «*daño físico real, intentado o amenazado, que es deliberado y no consentido*» (por ejemplo, Douglas, Hart, Webster y Belfrage, 2013; Kropp, Hart y Belfrage, 2010). Por otro lado, resulta importante no solo la conducta en sí (violenta, de riesgo, peligrosa), sino también su intención y sus consecuencias. Sirva como ejemplo la siguiente situación (tomada de Watt, 2012):

Ejemplo de conducta de riesgo

Imaginemos el caso de un acosador, que acecha a la víctima, la persigue, controla, somete a vigilancia, atemoriza, etc. No solo nos interesan las posibles agresiones (por ejemplo, un allanamiento de morada, agresión física en la calle, intento de agresión sexual, secuestro, agresión a familiares o amigos, etc.). La conducta de acoso genera, entre otras muchas sensa-

ciones, miedo, inestabilidad y ansiedad. Así pues, un acosador puede decidir enviar felicitaciones de navidad a su víctima. La conducta en sí ni es violenta ni es delictiva (salvo que quebrante una orden de alejamiento o incluya amenazas). Sin embargo, el simple hecho de mantener el contacto con la potencial víctima mediante una felicitación inocua, puede ser una forma de controlar, causar miedo, someter o acechar, especialmente cuando esta se ha visto obligada a cambiar de domicilio por acosos previos. Así pues, el objetivo de una conducta aparentemente inofensiva puede ser considerado violento.

Otra indicación habitual en la definición de la violencia en evaluación del riesgo es que se «*incluyen todas las conductas [violentas] cometidas por la persona, no solo las que terminen en detención, cargo o condena. Los evaluadores deben considerar el autoinforme y los informes de fuentes colaterales creíbles [...], además de los antecedentes penales oficiales*» (Hart et al., 2003).

Al margen de estos rasgos generales, la definición de violencia va a depender del objetivo concreto de cada herramienta o ámbito de aplicación. Para la violencia sexual, el intento, la amenaza o el acto real se refieren específicamente a los contactos sexuales. Este contacto se entiende en sentido amplio y genérico, pudiendo incluir el maltrato sexual (violación o tocamientos), comportamientos ofensivos de contenido sexual (exhibicionismo o llamadas obscenas) y la violación de la intimidad (*voyeurismo* o robo de objetos fetiches). Asimismo, las víctimas pueden ser conscientes de la agresión, pero no dar consentimiento, someterse bajo coacción o no poseer la capacidad de consentir aunque no se opongan (por discapacidad o edad), o ni siquiera ser conscientes de que están siendo agredidas (Boer, Hart, Kropp y Webster, 1997; Hart et al., 2003). En otros casos, como ocurre en el FAM (complemento de la HCR-20 para la evaluación del riesgo de violencia en mujeres), el espectro de conductas se amplía o especifica aún más. En el FAM se incluye como riesgo a evaluar el «*influir*

CLAVE 1.

En la evaluación del riesgo de violencia resulta importante no solo la conducta en sí (violenta, de riesgo, peligrosa), sino también su intención y sus consecuencias. Además, se incluyen todas las conductas cometidas por la persona evaluada y no solo las que terminen en registros oficiales.

en otra persona para que cometa un delito o ser cómplice de la violencia», pues la cooperación y la complicidad en actividades violentas o delic-

tivas se consideran más prevalentes y de interés en las mujeres (de Vogel, de Vries-Robbé, van Kalmthout y Place, 2012). La START (Webster, Martin, Brink, Nicholls y Desmarais, 2009; Webster, Martin, Brink, Nicholls y Middleton, 2004), por otro lado, aborda siete dominios o tipos de riesgo: violencia hacia otros, autolesión, suicidio, salida no autorizada (de una institución), abuso de sustancias, autonegligencia (o abandono) y victimización.

En la tabla 1.1 se presenta un listado de las principales formas de violencia para las que existen herramientas de evaluación del riesgo en el momento actual.

TABLA 1.1
Categorías de violencia para las que existen herramientas para la evaluación del riesgo

- **Violencia interpersonal inespecífica:** dirigida contra cualquier persona con la que no exista una relación de pareja y que no tenga contenido sexual.
- **Violencia sexual:** incluye conductas sexuales de cualquier tipo.
- **Violencia de pareja:** violencia interpersonal cometida contra una persona con la que existe o existía una vinculación afectiva de pareja.
- **Acoso (*Stalking*):** conducta de acecho consistente en contactos de cualquier tipo —comunicación, aproximación, envío de objetos, persecución, acoso en redes sociales, etc.—, repetidos e indeseados por la víctima, que puede ser una persona desconocida, una persona con la que se ha mantenido una relación afectiva o una figura pública.
- **Violencia laboral:** incluye desde conductas airadas, pasando por acoso (por razón de sexo), *mobbing*, amenazas e incluso el homicidio en el contexto laboral.
- **Violencia patriarcal:** hace alusión a los denominados crímenes de honor, dirigidos principalmente —aunque no exclusivamente— contra mujeres a las que una familia o comunidad agrede o ejecuta por considerar que ha ofendido el honor de la familia (relaciones afectivas no aprobadas, rechazo a matrimonios impuestos, etc.), el cual debe ser restaurado a través de esta agresión.
- **Violencia intrainstitucional:** se centra en la violencia en instituciones como centros penitenciarios o psiquiátricos y la valoración del potencial riesgo de agresiones a compañeros del sujeto evaluado o a los profesionales de la institución. En muchos casos se incluyen bajo esta etiqueta las autolesiones y la victimización.
- **Radicalización, extremismo o terrorismo:** principalmente hace alusión a evaluar el riesgo de que un sujeto cometa actos de violencia ideológicamente motivados (cuando esté en libertad), su radicalización o su capacidad para radicalizar a otras personas.
- **Suicidio:** pese a no tratarse de un delito, muchas herramientas incluyen la valoración del riesgo de violencia dirigida contra uno mismo.
- **Maltrato a ancianos (*elder abuse*):** daño físico real, intentado o amenazado, a una persona de edad avanzada cometido por una persona más joven que es, al menos, un conocido de la víctima o una persona de cualquier edad que tiene un deber de cuidado de la víctima.

2. EVALUACIÓN DE DELINCUENTES Y SUJETOS VIOLENTOS

El estudio de la violencia ha sido objeto de interés de disciplinas como la biología (genética, herencia), la etología (comportamiento animal, respuesta adaptativa), la medicina (psiquiatría, neuroimagen, hormonas), la sociología (etiquetado, construccionismo, segregación, conflicto, legitimación, poder) y la psicología (aprendizaje, trastornos, diferencias individuales, personalidad, tratamiento). La psicología de la violencia, entendida como un área (no oficial) de la psicología dedicada al estudio de las distintas formas de violencia, ha permitido establecer diferencias significativas entre distintos aspectos de la violencia humana, como, por ejemplo, la diferencia entre agresividad y violencia o la evaluación psicométrica de agresores y dimensiones relacionadas (como variables de la personalidad).

La evaluación de sujetos violentos o delincuentes es un objetivo muy complejo en el que influyen, entre otros muchos, factores como los siguientes:

- *Deseabilidad*: el hecho de que, en general, la delincuencia y la violencia no sean algo deseable, hace que la confesión o autoinforme de dichas actividades esté afectada por factores como la deseabilidad social o la disimulación/engaño, que estarán presentes en las evaluaciones. Cabe señalar que la deseabilidad social está presente en mayor o menor medida en todos nosotros, pero en especial se da cuando lo informado es socialmente reprochable.
- *Subjetividad*: aunque parezca lo contrario, las características de la violencia no son fácilmente objetivables, por lo que aspectos como su gravedad o tipología, e incluso su frecuencia, están sujetos a variables subjetivas propias de la persona que informa, bien sea la víctima, el agresor o un simple observador. Criterios propios, hábitos o distorsiones influyen en la consideración final.

- *Relación de causalidad*: la causalidad es otra de las principales limitaciones de cualquier cuestión relacionada con la conducta violenta, bien sea médica, psicológica o legal. Por un lado, todos buscamos una explicación a conductas atroces que se distancian de la norma social o que escapan a nuestra comprensión como seres sociales. Por ello, con frecuencia se abusa del estereotipo que vincula estados mentales patológicos con las agresiones (véase capítulo 2). Por otro lado, en el ámbito jurídico, la teoría de la imputación valora la causalidad entre la conducta del acusado y el resultado tipificado (delito). Pero además se valora la imputabilidad del sujeto, que requiere que sea capaz de conocer la antijuridicidad del hecho y actuar conforme a este conocimiento, pues de lo contrario no puede ser considerado responsable de sus actos. Sin embargo, vincular estados o características personales (trastornos, por ejemplo) con la conducta cometida no es algo sencillo ni claro.

Por estas características, y otras mencionadas en el punto 1.1, resulta evidente que la evaluación de delincuentes y sujetos violentos, desde el punto de vista psicométrico, es una tarea plagada de limitaciones y sobre la que escasamente se ha avanzado en la historia de la psicología. De los test proyectivos se evolucionó a los autoinformes de conductas o dimensiones psicológicas (distorsiones o impulsividad, por ejemplo), y en la actualidad se discute la aportación de técnicas de asociación implícita, por ejemplo, en la evaluación de las actitudes hacia la violencia, fácilmente manipulables en evaluaciones explícitas (Brown, Gray y Snowden, 2009; Cantera y Blanch, 2010; Eckhardt, Samper, Suhr y Holtzworth-Munroe, 2012; Ostrosky-Solís, Romero, Velez y Villalpando, 2009). Un ejemplo de desarrollo de estas técnicas ha sido la evaluación de cogniciones o intereses en delincuentes sexuales, en especial hacia menores (Brown et al., 2009; Ciardha y Gormley, 2012; Hempel, Buck, Goethals y van Marle, 2013;

Kanters et al., 2016; Mokros et al., 2013; Nunes, Firestone y Baldwin, 2007; Nunes, Hermann y Ratcliffe, 2013; Schmidt, Gykiere, Vanhoeck, Mann y Banse, 2014).

Son diversas las herramientas y técnicas existentes para evaluar aspectos relacionados con la violencia, la agresividad o variables vinculadas a alguna de estas, como son distintos rasgos de la personalidad (por ejemplo, Carrasco, 2006; Wenger y Andrés-Pueyo, 2016a,b). Sin embargo, como puede ocurrir con otras variables, como los estilos educativos en la delincuencia juvenil (donde casi todos los estilos se han relacionado con alguna forma delictiva), son extremadamente variados los factores que se han relacionado con la conducta violenta, principalmente en estudios transversales¹ (véase recurso 1). Por ello es muy frecuente la descripción de variables psicológicas en delinquentes y agresores, así como la discrepancia entre resultados en los estudios. Sirvan como ejemplo revisiones sobre variables como la ira o la hostilidad (Birkley y Eckhardt, 2015), la empatía (Barnett y Mann, 2013; Harris y Picchioni, 2013; Jolliffe y Farrington, 2004; Vachon, Lyman y Johnson, 2014), la autoestima

(Ostrowsky, 2010; Walker y Bright, 2009), el apego (Dutton y White, 2012; Ogilvie, Newman, Todd y Peck, 2014), la depresión (Dutton y Karakanta, 2013) o la psicosis (Douglas, Guy y Hart, 2009), entre otras muchas disponibles.

Existen algunos manuales que recopilan las herramientas más utilizadas o recomendables para distintas formas de violencia, como la de pareja (Rathus y Feindler, 2004), la familiar (Feindler, Rathus y Silver, 2003), la juvenil (Dahlberg, Toal, Swahn y Behrens, 2005) o la sexual (Thornton y Laws, 2009). Sin embargo, no debemos olvidar que en su mayoría estas propuestas son listados de herramientas de interés para valorar dimensiones que posiblemente sean problemáticas, orientadas hacia la intervención (con medidas pre y postratamiento, por ejemplo) o a la estimación de la magnitud del problema (con el autoinforme de conductas) y que no suponen una valoración del riesgo orientada a la predicción de la reincidencia. La presencia de una variable psicométrica, como veremos en el capítulo 4, puede ser un factor de riesgo, pero no equivale a una evaluación del riesgo de violencia.

¹ Un estudio transversal analiza la presencia de una variable determinada (por ejemplo, la impulsividad) en una muestra seleccionada *ad hoc*. Es decir, se selecciona una muestra de interés, como pueden ser agresores en prisión, y se evalúa la presencia y magnitud de una variable concreta, sin poder valorar la medida en que esta variable tiene una relación causal directa con el evento ocurrido (la agresión).

Trastorno mental y violencia

2

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.

ALBERT EINSTEIN
(Físico alemán; 1879-1955)

La relación entre trastornos mentales y violencia suscita un gran interés tanto en el sector académico como en la sociedad en general (Echeburúa y Loinaz, 2011; Loinaz, 2013b; Loinaz, Echeburúa e Irureta, 2011). Al margen de responder a la necesidad de evitar un grave problema, este interés se debe a las incógnitas, miedos y creencias existentes en el ámbito, así como a la motivación humana por intentar explicar determinadas conductas difíciles de entender, especialmente cuando nos referimos a los casos de violencia extrema. Tal como señala Zimbardo (2008), por mucho que nos resulten atroces determinados actos cometidos por algunas personas, estos agresores o delincuentes no son tan distintos a nosotros y las variables contextuales juegan un papel determinante en muchos de estos sucesos.

Mientras revisaba estas líneas, en época estival, comenzaron a surgir las típicas noticias de la temporada referentes a incendios naturales y provocados. En una de ellas se describía un fuego iniciado con cuatro focos y que había causado situaciones de peligro para las poblaciones colindantes. El responsable del mismo, además de dar la voz de alarma, formaba parte de las brigadas forestales que ayudaban a su extinción. Una vecina de la zona explicaba entre sollozos lo ocurrido

y el miedo vivido, utilizando una descripción del pirómano que igualmente podría ser útil y reflejo de la percepción social en otros delitos violentos. La entrevistada señalaba: «Yo no sé cómo alguien ha podido hacer esto, bien no puede estar. O no tiene cabeza (*loco*) o no tiene corazón (*malo*)» [cursiva añadida por el autor para expresar el significado de la idea]. La frase es el reflejo del aún vigente debate entre malo o loco, «*mad or bad*» en el contexto anglosajón (Maibom, 2008; Wilczynski, 1991, 1997). Un ejemplo de este enfrentamiento sería la obra de Greig (2001) en la que se refleja la disputa entre política, psiquiatría y derecho respecto al control de personas consideradas peligrosas. También lo sería la diferente consideración de las mujeres delincuentes como malas o enfermas según se ajusten a un patrón delictivo o se distancien del rol que la sociedad les asigna (en la línea de la denominada hipótesis de la caballerosidad), con una tendencia a la patologización (Berrington y Honkatukia, 2002; Edwards, 1986; Peter, 2006; Wilczynski, 1991).

En este capítulo abordaremos la relación entre trastorno mental y conducta delictiva, señalando los principales trastornos vinculados a algunas formas delictivas, y describiremos algunos de los estudios referentes en la temática.

1. PSICOPATOLOGÍA Y DELINCUENCIA

Son diversos los resultados existentes y múltiples las ramas que se derivan del análisis de la relación entre psicopatología y conducta delictiva: comorbilidad, variables mediadoras, excepciones, ciclos victimización/agresión, etc. (Loinaz, 2013b). Se afirma con frecuencia que los trastornos mentales son más prevalentes entre delincuentes y personas violentas y, por ello, suponen un factor de riesgo. Sin embargo, las limitaciones de los estudios y la metodología transversal utilizada han contribuido a sembrar muchas dudas. Un aspecto que dificulta el conocimiento de la realidad es la existencia de sesgos como los siguientes:

1. Se analizan casos seleccionados en contextos jurídico-forenses, de los que se presupone un trastorno.
2. No se compara la tasa de delincuencia de las personas con trastorno fuera de estos contextos.
3. No se compara la delincuencia de personas sin psicopatología.
4. No se atiende a la direccionalidad o temporalidad de las variables (por ejemplo, que el trastorno sea posterior al delito, por los efectos del ingreso en prisión).

Como veremos en los siguientes apartados, el establecimiento de la direccionalidad en la relación entre variables ni es fácil ni es un objetivo habitual de las investigaciones. Por ello, es frecuente prestar poca atención a ciclos que influyen en la relación (como el de victimización/agresión; agresión/sintomatología) y que muestran realidades alternativas, como un mayor riesgo de victimización delictiva o violenta en personas con trastorno mental (Loinaz et al., 2011).

Los resultados derivados de amplios estudios como los que analizaremos en este capítulo, aunque pueda parecerlo, no son concluyentes. La revisión exhaustiva de las variables relacionadas con la delincuencia (Ellis, Beaver y Wright, 2009) pone en evidencia las controversias existentes respecto a los trastornos mentales. La gran mayoría

de los estudios encuentran una relación positiva entre ambas variables cuando se analiza la delincuencia oficial. Esto se repite para delitos violentos, contra la propiedad y los relacionados con drogas. Sin embargo, también se señala que la relación se da al margen de que la gran mayoría de las personas con psicopatología no se vean implicadas en estas conductas, y que la gran mayoría de las que se ven implicadas no tengan trastornos.

Ante todo, debemos recordar que un único factor no puede explicar la conducta violenta en la mayoría de las ocasiones, pues la violencia es resultado de la interacción entre variables biológicas, psicológicas, sociales y contextuales/situacionales. En la tabla 2.1 se presenta, a modo de resumen, un listado con los trastornos relacionados con más frecuencia con distintos delitos, así como el mecanismo psicológico que influye en la comisión del delito. Los trastornos de la personalidad (debido a las características que los definen) ocupan un lugar muy significativo a la hora de relacionar diagnósticos y conductas delictivas, violentas o inadaptadas (McMurrin y Howard, 2009), pero pocas veces son la única explicación de la conducta. Además, dimensiones concretas y algunos trastornos están presentes tanto en víctimas como en agresores, por lo que no son variables tan específicas ni explicativas. Incluso rasgos de la personalidad normal (no patológica) están relacionados con el riesgo de violencia o delincuencia, disminuyéndolo (como la timidez o la susceptibilidad al castigo) o incrementándolo (como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones) (Loinaz y Ortiz-Tallo, 2014).

Como veremos a lo largo de este manual, en el ámbito de la valoración del riesgo, los trastornos mentales y determinadas sintomatologías son considerados factores predictores de la conducta violenta. En concreto, los ítems más habituales al respecto son:

1. Abuso de sustancias o problemas relacionados con sustancias o con el consumo abusivo de alcohol y/o drogas.
2. Problemas de salud mental, antecedentes de enfermedad mental con abandonos de

TABLA 2.1
Psicopatología y principales delitos relacionados (Loinaz, 2013)

Trastorno	Mecanismo implicado	Principal delito
Consumo de sustancias		
<i>Abuso o dependencia del alcohol u otras drogas.</i>	Desinhibición y dependencia. Variable mediadora del efecto de los demás trastornos.	Instrumental: dirigido a la obtención de droga o dinero (robos, robos con violencia, lesiones). Reactivo: violencia relacionada con la intoxicación (contra la pareja, sexual, agresiones).
Trastornos de la personalidad		
<i>Paranoide.</i>	Desconfianza y atribuciones hostiles.	Delitos contra las personas, como lesiones (reacciones exageradas). Chantaje, injurias y falsas denuncias. Estilo de personalidad frecuente en agresores de pareja y también presente en delincuentes sexuales.
<i>Esquizotípico.</i>	Malestar interpersonal, distorsiones cognitivas, comportamiento excéntrico. Complicaciones del espectro psicótico.	Descrito en determinados agresores sexuales. Delitos extraños e impulsivos. Criminología semejante a la esquizofrenia (por ejemplo, contexto familiar).
<i>Esquizoide.</i>	Desconexión social y restricción emocional.	Descrito en determinados agresores sexuales. Homicidio, incluido el de la pareja. Secuestro y allanamiento de morada. Hurtos, robos y estafas.
<i>Antisocial.</i>	Desprecio y violación de derechos y normas.	Relacionado con prácticamente cualquier delito, por la estructura del propio trastorno.
<i>Narcisista.</i>	Necesidad de admiración, arrogancia, falta de empatía.	Falsificación, fraude. Explotación de personas. Dimensión descrita en agresores sexuales y de pareja.
<i>Límite.</i>	Impulsividad, inestabilidad y dependencia emocional, ira (comorbilidad toxicológica).	Acoso. Agresión reactiva. Delitos leves relacionados con su inestabilidad: hurtos, conducción bajo el efecto de sustancias. Frecuente en agresores sexuales y de pareja (por ejemplo, relaciones intensas e inestables, personalidad abusiva).
<i>Histriónico.</i>	Exageración emocional, demanda de atención.	Denuncias falsas para llamar la atención.
<i>Evitativo.</i>	Inhibición, falta de confianza, hipersensibilidad a las críticas.	Se ha descrito en delincuentes sexuales (sentimiento de venganza hacia la mujer).
<i>Dependiente.</i>	Sumisión.	Descrito frecuentemente en algunos tipos de agresores de pareja.
<i>Obsesivo-compulsivo.</i>	Orden, perfeccionismo y control.	Negligencias en el hogar. Agresiones desmedidas en determinadas ocasiones (por ejemplo, en el ámbito familiar por rigidez y orden). Delitos con armas.

TABLA 2.1. (continuación)

Trastorno	Mecanismo implicado	Principal delito
Control de los impulsos - impulsividad		
<i>Ludopatía.</i>	Mantenimiento de las necesidades de juego.	Contra la propiedad: robo, estafa, falsificación, malversación.
<i>Trastorno explosivo intermitente.</i>	Explosión repentina de ira.	Contra las personas (lesiones) y contra la propiedad (por ejemplo, destrucción de mobiliario).
Esquizofrenia y psicosis		
<i>Esquizofrenia y psicosis.</i>	Descompensación, mala adherencia al tratamiento (o abandono del mismo). Sintomatología positiva: delirios, alucinaciones, etc.	Delito violento (contra las personas): lesiones y homicidio. Principalmente limitadas al ámbito familiar (<i>crímenes sin historia</i>). Precedidos de señales de alarma: pasivas (por ejemplo, aislamiento o incomunicación) y activas (por ejemplo, conflictos o abandono de pautas).
Depresión y trastorno bipolar		
<i>Depresión.</i>	Fases de mejora. Desesperación, ideación psicótica, aislamiento, rumiación, abuso de sustancias.	Suicidio ampliado (la víctima es un familiar: homicidio por compasión). Asesinato en masa por desesperación. Comportamientos antisociales en adolescentes (hogar, escuela y sociedad). Victimización de personas como chivo expiatorio.
<i>Trastorno bipolar.</i>	Impulsividad y comorbilidad toxicológica.	Fase maníaca: delincuencia general. Agresión impulsiva, delito económico y vandalismo. Fase depresiva: homicidio, acompañado o no de suicidio, especialmente filicidio y parricidio.
Otros trastornos		
<i>Desorden facticio por poderes (síndrome de Munchausen).</i>	Descripción de sintomatología falsa y provocación de la misma.	Abuso de menores, generalmente los propios hijos. Se les inducen problemas médicos para buscar atención, pudiendo llegar a causar la muerte del niño.
<i>Parafilias.</i>	Comportamiento sexual desviado.	Principalmente pedofilia (abuso sexual infantil), <i>froteurismo</i> y exhibicionismo.

tratamiento, síntomas psicóticos y/o maníacos o diagnóstico de esquizofrenia.

3. Psicopatía o trastorno de la personalidad.
4. Impulsividad o trastorno de la personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad conductual.
5. Desviación sexual (para el caso del riesgo de violencia sexual).

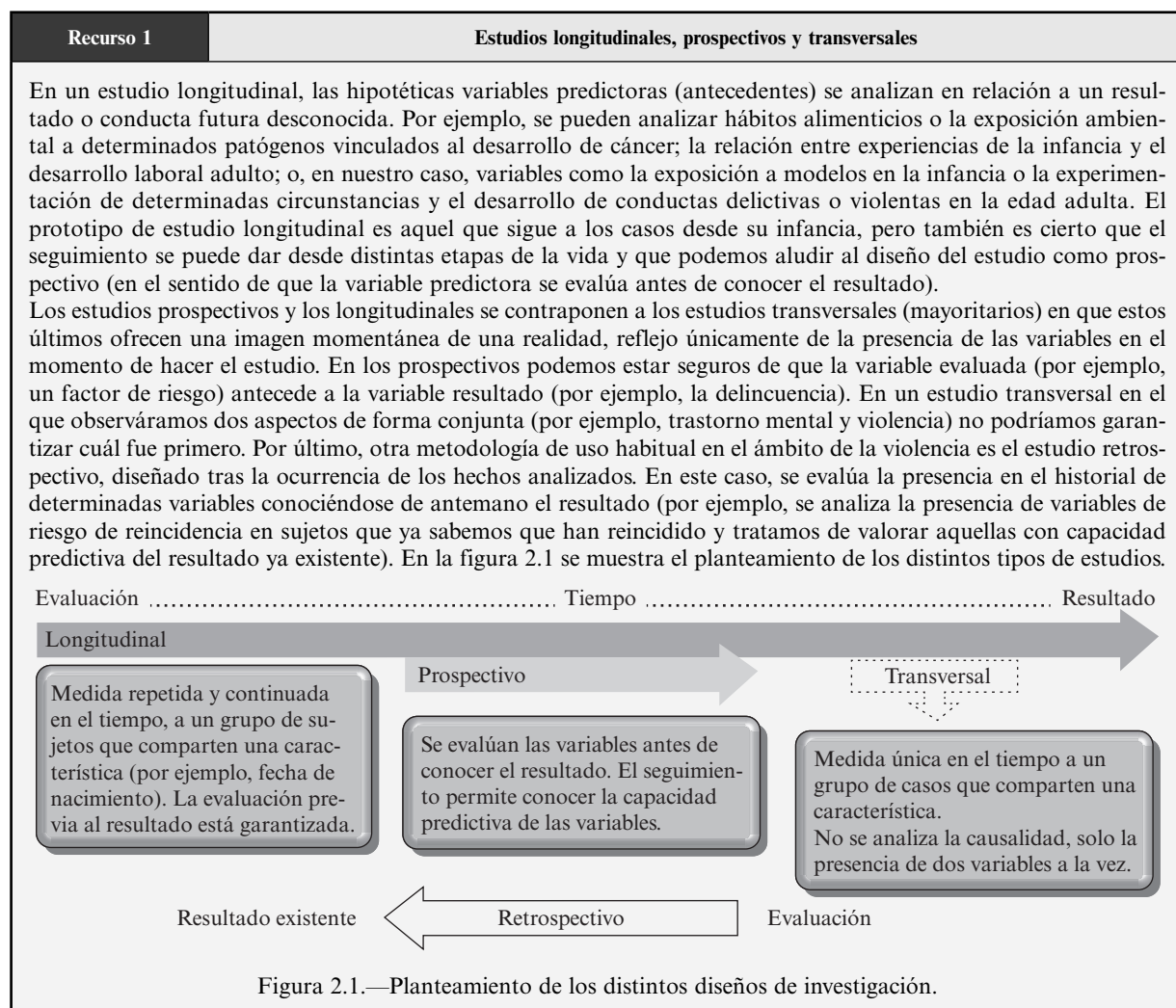
En conjunto, son trastornos concretos que se manifiestan con impulsividad o ira, adicciones y complicaciones relacionadas, o con la mala adherencia al tratamiento cuando hay presencia de trastornos, lo que resulta más relevante en la predicción del riesgo de violencia. La simple presencia de un trastorno, por tanto, no supone por defecto un factor de riesgo.

2. REFERENTES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE TRASTORNO MENTAL Y CONDUCTA DELICTIVA

En la tradición criminológica existen distintos estudios que se han convertido en referentes a la hora de analizar y describir las variables relacionadas con la conducta violenta, su desarrollo y los factores de riesgo (véase Thornberry y Krohn, 2003). Muchos de ellos han permitido la evolución de la denominada criminología del desarrollo y las carreras delictivas (Blumstein, Cohen, Roth y Vis-

her, 1986; MacLeod, Grove y Farrington, 2012; Miller, Dinitz y Conrad, 1982; Piquero y Mazerolle, 2000; Piquero, Farrington y Blumstein, 2007; Piquero, Jennings y Barnes, 2012; Requena, 2014; Savage, 2009; Soothill, Fitzpatrick y Francis, 2009).

Los estudios longitudinales y prospectivos (véase recurso 1) son especialmente interesantes para responder a cuestiones como: ¿son diferentes los delincuentes?, ¿qué variables predicen la conducta delictiva o violenta?, ¿qué causa el comportamiento antisocial?, ¿qué cambios son vitales a lo largo de la vida?



Pese a que desde el punto de vista metodológico los tipos de estudios son claros, como veremos a lo largo del manual, su aplicación al ámbito de la violencia, y en especial a la predicción de la misma, es complicado y controvertido. Solo como adelanto a lo que se abordará en el capítulo 5, tenga presente el lector el caso del estudio de la capacidad predictiva de una herramienta. Si aplicamos en la práctica diaria un instrumento que nos indica que el riesgo es elevado, la lógica y la ética nos obliga a hacer algo (gestionar el riesgo). Este «algo» supone la inclusión en la ecuación de nuevas variables y el intento por evitar el resultado predicho. Por tanto, la predicción es muy posible que resulte equivocada, no porque las variables o la herramienta no sean predictoras, sino porque hemos intervenido para que el resultado no se produzca. Pese a este matiz importante, es habitual el uso de estudios de predicción con seguimiento en los que se presupone, además, que el riesgo es estático (cuando se insiste en que es dinámico y modificable).

Algunos de los estudios longitudinales o de seguimiento de mayor impacto en el ámbito criminológico son los siguientes:

- *Cambridge Somerville Youth Study.*
- *Pittsburgh Youth Study.*
- *Danish Longitudinal Study.*
- *Montreal Longitudinal-Experimental Study.*
- *National Youth Survey Oregon Youth Study.*
- *Seattle Social Development Project.*
- *MacArthur Violence Risk Assessment Study.*
- *Dunedin Longitudinal Study.*
- *Cambridge Study in Delinquent Development.*

A continuación presentaremos brevemente los tres últimos.

2.1. Estudio MacArthur

El *MacArthur Violence Risk Assessment Study* (véase Monahan et al., 2001) es el principal estudio sobre la relación entre trastornos mentales y

conducta violenta. Iniciado entre 1992 y 1995 en tres psiquiátricos de Estados Unidos, la muestra inicial estuvo compuesta por 1.136 pacientes psiquiátricos, de ambos sexos, dados de alta en la comunidad. Los sujetos debían tener entre 18 y 40 años y contar con alguno de los siguientes diagnósticos: esquizofrenia (o trastorno esquizofreniforme), trastorno esquizoafectivo, depresión, distimia, manía, psicosis reactiva breve, trastorno delirante, abuso/dependencia de drogas o trastorno de la personalidad. Su objetivo era y sigue siendo la identificación de factores de riesgo específicos en la población psiquiátrica y la comprensión de la capacidad predictiva de dichos factores, partiendo del hecho de que el primer paso para la prevención es la predicción.

Se analizaron variables provenientes de distintas fuentes, incluyendo registros oficiales y fuentes colaterales como personas que interactuaban de forma regular con los sujetos en la comunidad (Harris y Lurigio, 2007). El autoinforme de violencia, así como la información al respecto proveniente de familiares, personas próximas y registros oficiales, se comparó con una muestra de 519 personas residentes en las mismas zonas en las que los pacientes psiquiátricos residían. Entre las herramientas utilizadas en los seguimientos se incluyó la *Psychopathy Checklist-Screening Version* para evaluar la psicopatía (PCL: SV; Hart, Cox y Hare, 1995).

Algunas de las principales conclusiones del estudio original fueron las siguientes (Monahan et al., 2001):

- *Sexo:* los hombres no son más propensos a cometer actos violentos en el plazo de un año desde su alta, aunque sí cometen más actos relacionados con el consumo de drogas y son arrestados por ello con más frecuencia. La violencia de las mujeres ocurre en entornos familiares y es menos visible y accesible al registro policial.
- *Antecedentes violentos y delictivos:* los delitos y actos de violencia previos están fuertemente relacionados con un mayor riesgo de comisión de un nuevo acto violento.

- *Experiencias en la infancia*: haber sido víctima de abuso sexual en la infancia no está relacionado directamente con la comisión de violencia, pero sí la gravedad del abuso (cuanto mayor es la gravedad, mayor es el riesgo). Asimismo, existe relación entre la violencia del sujeto y conductas de los padres tales como el abuso de drogas, las detenciones y las peleas.
- *Contexto social*: existe relación entre el entorno desfavorable del paciente, como puede ser vivir en un barrio deprimido, y el mayor riesgo de violencia.

Respecto a los trastornos con mayor riesgo de violencia:

- La prevalencia de conductas violentas el año después del alta fue mayor en el grupo con trastornos de la personalidad y abuso/dependencia de sustancias (43 %), frente al grupo con trastorno mental grave (esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar, etc.) con abuso/dependencia de sustancias (31,1 %) o el grupo con solo trastorno mental grave (17,9 %).
- La prevalencia anual de conductas violentas fue mayor en pacientes depresivos (28,5 %) que en pacientes bipolares (22 %) o con esquizofrenia (14,8 %). El riesgo se duplicaba si se sumaba el consumo de sustancias.
- Los rasgos psicopáticos, evaluados con la PCL: SV fueron el mejor predictor de conducta violenta, especialmente el factor antisocial.
- Los delirios estuvieron relacionados de forma negativa, y los sujetos que los padecían tuvieron menor riesgo de ser violentos en periodos cortos tras su alta médica. Las alucinaciones estuvieron algo más relacionadas, especialmente aquellas que implicaban órdenes de actuar de forma violenta.
- A mayor impulsividad también se dio una mayor conducta violenta en la comunidad.

Los datos del estudio son de acceso público, algo que ha facilitado el desarrollo de numerosas investigaciones, como, por ejemplo, sobre el uso de la HCR-20 en mujeres (García-Mansilla, Rosenfeld y Cruise, 2011), sobre la psicopatía (Delisi, Vaughn, Beaver y Wright, 2010; Hodges y Heilbrun, 2009), sobre los delirios (Ullrich, Keers y Coid, 2014), sobre subtipos de agresores de pareja en hombres y mujeres pacientes psiquiátricos (Walsh et al., 2010) o la predicción de la violencia con la VRAG (Harris, Rice y Camilleri, 2004).

A partir de los resultados del estudio MacArthur, surgió una nueva técnica actuarial de predicción del riesgo, denominada Árbol de Clasificación Iterativa múltiple (*Multiple Iterative Classification Tree*, ICT), que finalmente se plasmó en una herramienta informatizada, denominada COVR (*Classification of Violence Risk*; Monahan et al., 2005, 2006), diseñada para clasificar pacientes psiquiátricos. Describiremos la técnica con más detalle en el capítulo 6, apartado 2.

Torrey, Stanley, Monahan y Steadman (2008) señalaron algunos matices a tener en cuenta respecto a las conclusiones generales del estudio MacArthur, entre las que se encuentran las siguientes:

- Se puede concluir que el riesgo atribuido a personas con trastorno mental excede por mucho el riesgo real.
- Para los casos que no abusan de drogas no hay motivos para esperar una mayor probabilidad de violencia que la de un ciudadano cualquiera.
- Los predictores de la violencia en personas con trastorno mental son similares a los de las personas sin trastorno.
- Las personas con trastorno mental son menos propensas a agredir a desconocidos.

2.2. Estudio de Dunedin

Iniciado en 1972 en Dunedin (Nueva Zelanda), se trata de un estudio longitudinal de cohorte.

te (Moffitt, Caspi, Rutter y Silva, 2001). Tras seleccionar un amplio rango de nacimientos representativos de distintos estatus socioeconómicos, se han ido realizando seguimientos a distintas edades (a los 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, etc.). La muestra inicial estuvo compuesta por 1.037 sujetos, de los cuales el 51% eran varones, mayoritariamente blancos. En el seguimiento a 26 años aún se mantenía el 96 % de la muestra (Moffitt, Caspi, Harrington y Milne, 2002). En los distintos análisis y seguimientos se han evaluado cuestiones relacionadas con la salud, el estado psicológico (trastornos, adicciones, etc.) y variables familiares y educativas. Asimismo, se ha evaluado la delincuencia y la violencia.

El principal aporte de este estudio es que permitió desarrollar la teoría taxonómica sobre la delincuencia de Moffitt, describiendo la existencia de «delinquentes persistentes» y «delinquentes limitados a la adolescencia» (Moffitt, 1993, 2003; Moffitt et al., 2002). Según este modelo, los sujetos persistentes comienzan con actividades antisociales a temprana edad, y se diferencian de los demás en variables temperamentales, variables neuropsicológicas, menor inteligencia, hiperactividad, así como un peor contexto social (abusos, negligencias y pobreza). A los 26 años son más propensos a presentar problemas adictivos, sintomatología depresiva, paranoide, postraumática y de personalidad antisocial.

De la magnitud de estudios acumulados sobre la muestra, algunas conclusiones relevantes son las siguientes:

- No todas las personas con trastorno mental en la comunidad (muestra no forense ni psiquiátrica) se ven involucrados en actos violentos. Entre los adultos jóvenes, solo la dependencia de sustancias y los trastornos del espectro esquizofreniforme están relacionados con una violencia mayor. La suma de trastornos incrementa el riesgo.
- En el caso de sujetos con dependencia del alcohol las agresiones se producen tras el consumo, pudiendo vincularse a su efecto desinhibidor.

- Los sujetos con dependencia a las drogas ilegales se ven implicados en delitos y agresiones relacionados con el estilo de vida al margen de la ley y con la adquisición de drogas.
- El riesgo que pueda suponer la esquizofrenia se ve duplicado en el caso de una dependencia de sustancias. En la esquizofrenia, la percepción del mundo como amenazante y un pensamiento distorsionado a edades tempranas explicaría gran parte de la agresión en la edad adulta.

2.3. Estudio de Cambridge

El estudio longitudinal de Cambridge (*Cambridge Study in Delinquent Development*) es uno de los más influyentes en el ámbito de la criminología. Se inició en 1961, en el sur de Londres, con 411 niños nacidos en su mayoría en 1953. Los objetivos originales del estudio eran (Farrington, Piquero y Jennings, 2013; Piquero et al., 2007):

1. Describir el desarrollo de la conducta delictiva en varones de barrios marginales.
2. Valorar la posibilidad de predecir dicha conducta.
3. Explicar los motivos por los que la delincuencia juvenil comienza, así como los motivos por los que termina con frecuencia a los 20 años.
4. Analizar la continuidad y discontinuidad en la actividad.
5. Estudiar el efecto de los estresores vitales.

Las evaluaciones de los sujetos se efectuaron en distintos momentos, con entrevistas y test personales a los 8-9, 10-11, 14-15, 16, 18, 21, 25, 32 (véase Piquero et al., 2007), 48 y 58 años (Farrington et al., 2013). También se hicieron entrevistas con los padres una vez al año, desde que el niño tenía 8 años hasta los 14-15. Los profesores de los jóvenes respondieron cuestionarios a la edad de 8, 10, 12 y 14 años del joven. Las medidas delictivas se obtuvieron de registros oficiales sobre delitos

tanto de los sujetos como de sus familiares, parejas y coautores del delito, tomando como referencia la edad de comisión del delito, no la de su condena. También se utilizaron autoinformes sobre delincuencia a la edad de 15-18, 19-21, 22-24 y 27-32 años.

El estudio de Cambridge ha dado lugar a numerosos manuales y artículos en los que se presentan distintos resultados. Algunos de ellos han sido sintetizados en referencias recientes (por ejemplo, Farrington, 2003; Farrington et al., 2013). En Farrington et al. (2013) puede consultarse una lista completa de los 200 artículos publicados hasta junio de 2012. A continuación se presentan algunos de los principales resultados publicados:

- *Inicio de la actividad*: la edad media de inicio son los 18 años, aunque la más frecuente (moda) es la de los 14 años.

- *Cese de la actividad*: la edad media para desistir en la actividad delictiva son los 30 años.
- *Duración*: la duración media de la actividad delictiva es de 10 años.
- *Prevalencia y frecuencia*: el 42% de la muestra ha sido condenada por algún tipo de delito antes de los 56 años. El 40% antes de los 40 años. El principal pico de actividad delictiva se da a los 17 años.
- *Especialización en violencia*: no se han encontrado pruebas de especialización en delito violento. El mejor predictor de ser un delincuente violento es la frecuencia general de delitos.
- *Cronicidad*: una pequeña proporción de casos dan cuenta de la mayoría de los delitos.
- *Autoinforme*: el autoinforme de delitos es significativamente mayor que las cifras oficiales.

PARTE SEGUNDA

La evaluación del riesgo de violencia

Historia de la predicción del riesgo de violencia

3

*Cuanto más sabes del pasado,
mejor preparado estás para el futuro.*

THEODORE ROOSEVELT
(26.º presidente de EE. UU., 1858-1919)

¿Un capítulo sobre historia? Seguro que muchos lectores se podrán hacer esta pregunta, al igual que ocurre con los participantes en conferencias sobre la temática al ver el título de una sesión sobre historia. La historia suele resultar aburrida, y la dinámica académica ha creado una inercia en la cual lo importante es lo reciente. Referencias actualizadas o el porcentaje de artículos de los últimos cinco años son tan solo algunas de las exigencias de la publicación científica. Además, se buscan los trabajos más recientes, como reflejo de estar al día y de conocer el estado de la cuestión (*state of the art* en el contexto anglosajón). Sin embargo, ignorar los antecedentes de una metodología es una garantía de repetición de errores y, además, genera la falsa ilusión de nuevos descubrimientos.

Por todo ello, y gracias a la facilidad con la que ahora accedemos a material histórico debido a la digitalización de antiguos textos y a la indexación de bases de datos, el conocimiento de los orígenes de la predicción en criminología y en evaluación del riesgo de violencia resulta ahora más sencillo. Este conocimiento es de gran relevancia para todos aquellos interesados en la me-

todología y en especial en la investigación en la materia. En las siguientes páginas se presenta una revisión de los principales momentos históricos, prestando especial atención a los inicios de la predicción en el ámbito criminológico sobre los que ha existido cierto vacío en las referencias más cercanas a nuestro tiempo.

Aunque recientemente es cuando ha alcanzado mayor interés académico, en parte motivado por el cambio de mentalidad de los gobiernos respecto a la intervención sobre la delincuencia, la predicción criminológica cuenta con una larga historia. Desde los primeros estudios sobre la predicción delictiva se han producido cambios relevantes en la metodología. Además, en lo que se refiere a la evaluación del riesgo de violencia, tal como la entendemos hoy en día, dos serían los principales cambios de perspectiva: el paso del concepto de peligrosidad al de riesgo y el paso de la predicción a la gestión. Ambos temas serán abordados de forma individual tras la revisión histórica, en los apartados 2 y 3 respectivamente. A continuación abordaremos las etapas históricas desde los orígenes que nos ha sido posible localizar.

1. HISTORIA DE LA PREDICCIÓN

Aunque para algunos los orígenes de la evaluación del riesgo o de la peligrosidad podrían remontarse a los inicios de la criminología clínica (con postulados como los de Cesare Lombroso o el concepto de *pericolosità* de Garofalo y Ferri de la escuela positiva italiana), en la presente revisión histórica nos centraremos en los desarrollos más próximos en el tiempo y vinculados directamente con la valoración del potencial violento o reincidente en pacientes psiquiátricos o delincuentes. Como se verá, y algunos autores señalan (Webster, Haque y Hucker, 2014; Webster y Huc-

ker, 2007), la realidad sobre la evaluación del riesgo de violencia ha sido, y es, en cierto modo ateórica, siendo distintas las disciplinas y diversos los sectores profesionales interesados e implicados en su desarrollo, e igualmente variados los sujetos a los que está destinado el procedimiento (psiquiatría, psicología, sociología, derecho, criminología, contexto penitenciario, policial o forense, etc.). Esta heterogeneidad se ve reflejada en la evolución histórica de las temáticas de interés y disciplinas implicadas.

En la tabla 3.1 se resumen los principales momentos históricos de la evaluación del riesgo de violencia.

TABLA 3.1
Evolución histórica de la evaluación del riesgo de violencia

Antes de 1930
Healy (1913) Necesidad de métodos de predicción en delincuencia (plazos temporales de predicción, etc.). Hart (1923) Utilización científica de los datos para reducir la reincidencia en libertad condicional. Burgess (1928) Predicción en trabajo social para mejorar la gestión de recursos, interviniendo más sobre quienes más lo necesitan. Tasa de expectativa: afirmación probabilística aplicable a un grupo. Sheldon y Eleanor Glueck (1929) Tablas de predicción: un paso hacia la gestión científica del problema de la delincuencia por los tribunales y agencias de administración.
1930
Glueck y Glueck Manuales sobre carreras delictivas, delincuencia femenina y delincuencia juvenil. 1930. <i>500 Criminal Careers.</i> 1934. <i>Five Hundred Delinquent Women.</i> 1934. <i>One thousand juvenile delinquents.</i> Tibbits (1932) Analizó la estabilidad de sus propias clasificaciones, concluyendo que aquellos factores que requerían más de una fuente de información o interpretación del evaluador eran los menos estables.

TABLA 3.1 (continuación)

1930
Laune (1935) Aplicó el método Burgess y concluyó que si la mayoría de los factores eran externos a la prisión y estáticos no se podía esperar cambios tras el paso por prisión. Propuso una herramienta aplicando criterios de los presos relacionados con sus corazonadas al valorar el riesgo de otros internos. Vold (1935) Predicción del comportamiento intrainstitucional a partir de 29 factores previos al ingreso. Aplicación del método Burgess y del método Glueck, ofreciendo en los mismos casos resultados similares. Lanne (1935) Predicción como ciencia: exhaustividad, número de factores necesarios, fiabilidad, independencia entre variables y método de puntuación. Huff (1936) Puso en duda la visión de la predicción como ciencia, teniendo en cuenta los pasos que describen el método científico.
1940
Monachesi (1941) Puso de manifiesto limitaciones de la fiabilidad de los sistemas de predicción, de la información para cumplimentar las herramientas, de la ponderación de factores y de la aplicación en la vida real. Allen (1942) Concluyó que era necesario un sistema de clasificación científico para prisiones. También señalaba que era difícil reducir a fórmulas objetivas los problemas sociales. Hakeem (1945) Aplicó el método de los Glueck para crear una herramienta de 6 ítems que sirviera para predecir el resultado de la libertad condicional. Hakeem (1948) Utilizó el método Burgess para predecir la reincidencia.
1950
Glueck y Glueck (1950) <i>Unraveling Juvenile Delinquency.</i> Semilla de la predicción en criminología 500 jóvenes delincuentes vs. 500 no delincuentes. Presentan la famosa Tabla de Predicción Social, compuesta por cinco variables familiares. Se trataba de variables ponderadas que permitían el cálculo de un valor numérico que se relacionaba con probabilidades de delincuencia.

TABLA 3.1 (continuación)

1950
Thomson (1953) Las tablas tienen mejor capacidad que los profesionales guiados por su experiencia. Propone la utilidad de las herramientas para evitar el etiquetado de jóvenes como predelinquentes cuando solo están en proceso de adaptación. Meehl (1954) Monografía sobre la comparación del juicio clínico y el actuarial en psicología. Precursor del enfrentamiento vigente entre partidarios y detractores de los métodos actuariales. Glueck y Glueck (1956) Intento de mejora del sistema combinando variables. Plantean dudas sobre la utilidad de las tablas en muestras distintas a las de creación. Glueck (1958) Es necesaria una técnica fiable para individualizar la condena. La tablas no buscan sustituir la experiencia del juez.
1960
Saumench (1960) Primera tesis en España sobre peligrosidad en sentido jurídico. Sistema para deducir objetivamente la peligrosidad potencial de una persona, por medio de la valoración de un índice de peligrosidad social y de un índice de peligrosidad criminal. Goldstein y Katz (1960) Dificultad para establecer con claridad el concepto de peligrosidad y la toma de decisiones. ¿Qué conductas son suficientemente amenazantes y qué grado de certeza requiere el pronóstico? Stott (1960) Propuesta de alternativas a los métodos de los Glueck (fuertemente criticados). Introducción de conceptos técnicos: selectividad, rango predictivo, valor predictivo, etc. Glaser (1962) Solo es precisa la predicción basada en datos grupales. Tablas de predicción como fuente de contraste de la valoración personal del profesional.

TABLA 3.1 (continuación)

1960
Craig y Glick (1963) La tablas de predicción sobreestiman la propensión a la conducta delictiva. Su objetivo debe ser complementar el proceso de evaluación de los profesionales. Montero (1966) Primera aplicación de la tabla de los Glueck en países de habla hispana (Puerto Rico) con resultados satisfactorios.
1970
Dershowitz (1970) ¿Cuán probable debe de ser el evento predicho para justificar una prisión preventiva? Los psiquiatras sobreestiman; los falsos positivos son inevitables. Wenk, Robison y Smith (1972) Proponen una herramienta para evaluar riesgo en adolescentes. Plantean cuestiones éticas de los falsos positivos y se preguntan qué hacer una vez identificado un caso de riesgo. Kozol, Boucher y Garofalo (1972) Muchos factores de riesgo no son indicadores directos de peligrosidad (presentes en sujetos de distinto riesgo). El tratamiento reduce la reincidencia. Rubin (1972) Imposibilidad de evaluar la peligrosidad en sujetos que no han actuado de forma violenta. Shaw (1973) Peligros del propio concepto de peligrosidad. Los sujetos cambian a lo largo del proceso penal. Cocozza y Steadman (1974, 1978) Ausencia de pruebas de la capacidad de los psiquiatras para predecir. Proponen la Legal Dangerousness Scale (LDS) con puntos de corte combinados con la edad. Cohen, Groth y Siegel (1978) Señalan limitaciones, como querer predecir una conducta que nunca ha ocurrido y no considerar variables ambientales durante el seguimiento. Es necesario justificar la opinión final sobre la peligrosidad. Steadman (1978) Propone la «peligrología» como disciplina multidisciplinar. Necesidad de formar a los profesionales.

TABLA 3.1 (continuación)

1980
Steadman (1980) Cuestiones éticas: derechos del evaluado. Sometimiento a restricciones por malas evaluaciones.
Monahan (1981) Predicción clínica peor que el azar. Las estimaciones de psiquiatras y psicólogos solo son acertadas 1 de cada 3 veces.
Steadman y Morrissey (1981) Costes y beneficios de las políticas proteccionistas (protección de la sociedad) y las liberales (derechos del evaluado).
Petrunik (1982) ¿Dónde ponemos la línea en políticas de control de delincuentes peligrosos? Los falsos negativos siempre parecerán muchos y será imposible reducir el gran número de falsos positivos.
Caso Barefoot vs. Estelle (1983) Ojo clínico aceptado en contexto judicial, incluso sin existir evaluación del acusado. Genera reacción en contra, incluso por parte de la APA.
Steadman (1983) Describe como fe en el profesional y como magia la prognosis de violencia.
Menzies, Webster y Sepejak (1985) Herramienta de 15 ítems: <i>Dangerous Behavior Rating Scheme</i>. Resultados negativos de su aplicación llevan a afirmar que no se deberían utilizar estas valoraciones en contextos con implicaciones restrictivas.
Wormith y Goldstone (1984) Proponen una herramienta actuarial de 15 ítems: <i>Recidivism Prediction Scheme</i>. Destacan la poca fiabilidad de los procesos de recolección de la información y que el aporte de información clínica no mejora la predicción actuarial.
Smith y Monastersky (1986) Vinculan el fallo en la predicción de la reincidencia sexual con la variabilidad del riesgo y con el paso del tiempo.

1.1. Antes de 1930

Hace ya más de un siglo, Healy (1913) abordó la necesidad de desarrollar métodos de predicción en el ámbito delictivo. Propuso dar respuesta a cuestiones como qué podía hacer un sujeto en un ambiente determinado o en qué medida eran modificables las tendencias de una persona.

CLAVE 2.

Tasa de expectativa (Burgess, 1928)

Afirmación estadística sobre la probabilidad de una determinada conducta futura aplicable a un grupo de sujetos más que a un caso particular.

El autor reflexionó sobre métodos científicos, plazos temporales en los que comparar las predicciones y sobre una ciencia empírica en desarrollo que necesitaba trabajar con hechos de los que poder sacar conclusiones sobre casos concretos. En esencia, el autor ya planteaba hacer predicciones de la conducta individual a partir de datos grupales y estadísticas generales.

Algunos autores (por ejemplo, Glueck y Glueck, 1929) atribuyen a Hornell Hart la primera propuesta de utilización de las técnicas de compañías aseguradoras al ámbito de la delincuencia. Hart (1923) propuso la aplicación científica de las estadísticas y datos oficiales para reducir la reincidencia en la libertad condicional. En especial, criticó los resultados de un estudio previo (Warner, 1923) por no haber utilizado análisis estadísticos adecuados y reanalizó la muestra proponiendo nuevos resultados. Unos análisis que, como el autor señalaba, en la época solo utilizaban profesionales de la estadística. En definitiva, proponía revisar los sistemas de «pronóstico» y de adjudicación de la libertad condicional para mejorar los resultados y reducir la reincidencia.

Ernest W. Burgess (1928) fue un referente en la propuesta de aplicación de técnicas de predicción en el campo de la libertad condicional. Hizo el seguimiento —durante al menos dos años y medio— a 3.000 varones puestos en libertad antes del 31 de diciembre de 1924. El resultado a predecir era la violación de la libertad condicional, circunstancia que se dio en un 25% de la muestra. Conocidos los reincidentes y el tipo de reincidencia, se procedió a buscar aquellas variables que estaban relacionadas con el resultado, comparando un total de 21 aspectos recogidos en los historiales. Comparó la tasa de reincidencia según las distintas alternativas en las variables (entre otras: niveles de inteligencia, grupos de edad en la puesta en libertad, pronóstico psiquiátrico o años de prisión cumplidos). La última etapa del estudio consistió en combinar las respuestas en cada uno de los 21 factores para obtener una puntuación vinculable al quebrantamiento de la libertad condicional. El criterio adoptado para puntuar el ítem fue que el sujeto se ubicase en el mismo por encima de la media del grupo del que

provenía (centro de internamiento), siendo la puntuación equivalente a la presencia de un factor favorable (positivo o de protección, véase capítulo 4). Por tanto, a mayor puntuación el pronóstico era mejor y se esperaba una menor reincidencia.

El sistema de predicción de Burgess se fundamentaba en las conocidas como «tablas de experiencia», usadas para estimar la probabilidad de ocurrencia de distintos eventos. La tasa de expectativa (*expectancy rate*) hacía alusión a una afirmación estadística sobre la probabilidad de una determinada conducta futura aplicable a un grupo de sujetos más que a un caso particular. El autor analizó la aplicación de este tipo de técnicas para estudiar la correlación del cumplimiento o violación de la libertad condicional con aspectos referentes al evaluado. La predicción se presentaba como sistema para mejorar la gestión de recursos, incrementando la atención en aquellos casos en los que se estimaba una mayor probabilidad de reincidencia y reduciéndola en los que podrían tener un desarrollo favorable con independencia de la intervención.

Otros autores, en la misma época, abordaron la predicción en el terreno del trabajo social. Cooley (1928), al analizar las implicaciones de la contribución de Ernest W. Burgess, señaló que la predicción de la delincuencia ya «no es adivinación, como los antiguos cuando recurrían a sus oráculos [...], sino el análisis científico de la situación social, los rasgos de personalidad, los registros penitenciarios y los factores legales del individuo en sus distintas combinaciones y conexiones lo que proporciona un método práctico» (p. 550). El foco de atención lo puso en el valor de las experiencias pasadas para la predicción del futuro. Por tanto, los datos disponibles de los sujetos evaluados eran utilizados como indicadores del pronóstico futuro, utilizando las tablas de expectativa para anticipar quién fallaría o progresaría satisfactoriamente en la medida aplicada, ofreciendo a los jueces una guía científica para proteger a la sociedad del peligro derivado de la puesta en libertad de sujetos con potencial reincidente. Asimismo, el sistema parecía prometedor para ajustar las intervenciones a las necesidades.

Las publicaciones del Sheldon y Eleanor Glueck, que continuaremos abordando en décadas posteriores, se desarrollaron desde la década de 1920. En sus inicios trataron de solventar las críticas que ellos mismos hacían a las tablas propuestas por Burgess, aunque reconocían que había sido pionero y precursor del ámbito de estudio y de los primeros en reconocer las potencialidades de estos procedimientos. Glueck y Glueck (1929) describieron el proceso seguido para elaborar tablas de predicción vinculadas a la reincidencia o para valorar la aplicación de la libertad condicional. El sistema tomaba en cuenta la relación de las variables con el resultado a predecir (por ejemplo, la reincidencia), y el porcentaje de casos con dicho resultado dentro de las distintas alternativas de las variables (por ejemplo, hábitos laborales: buenos trabajadores, 43% de fracasos; medios, 59% de fracasos; malos, 68% de fracasos en la conducta postdelictiva). El segundo paso consistía en sumar los porcentajes de cada variable, considerando el valor máximo (sumatorio de todos los porcentajes máximos de fracasos posibles) y mínimo (sumatorio de todos los porcentajes mínimos de fracasos posibles) que un sujeto podía sacar al sumar las variables presentes en una tabla. Con una muestra de 510 delincuentes, a los que hicieron un seguimiento de cinco años tras su puesta en libertad condicional, vincularon las puntuaciones con la conducta durante el seguimiento y establecieron la probabilidad de fracaso. Los autores describieron su sistema como «un paso hacia la gestión científica del problema de la delincuencia por los tribunales y agencias de administración» (p. 329). Sin embargo, advertían de que su propuesta no era la aplicación directa de las tablas y porcentajes de éxito o fracaso, sino que era necesario analizar la fiabilidad del sistema en otras muestras.

1.2. 1930

En la década de 1930 el matrimonio Glueck publicó algunos de los trabajos que impulsaron el reconocimiento de sus tablas de predicción. Entre

otros temas, abordaron las carreras delictivas (Glueck y Glueck, 1930), la predicción en mujeres delincuentes (Glueck y Glueck, 1934a) y la predicción de la delincuencia juvenil (Glueck y Glueck, 1934b).

Tibbitts (1931) presentó un nuevo análisis de la muestra estudiada por Burgess (1928), proponiendo nuevas variables con interés predictivo. Valoró la utilidad de un total de 23 variables, de las que 22 permanecieron con aparente relevancia. Cada uno de los 3.000 sujetos fue valorado conforme a la puntuación en dichas variables, sumando el total de variables favorables (relacionadas con una menor probabilidad de reincidencia) o no favorables (relacionadas con una mayor probabilidad de reincidencia). Ningún caso tuvo más de 15 variables favorables y ninguna desfavorable; y ningún caso tuvo más de 11 variables desfavorables y ninguna favorable. Por tanto, con estos dos extremos (15/0 y 0/11) y otros valores intermedios creó una tabla con las tasas de expectativa de éxito o fracaso correspondientes. Pese a que el punto de partida era una mejora del sistema inicial y se proponían nuevas formas de análisis para mejorar la capacidad predictiva de las tablas, los criterios empleados para ponderar las variables o mantenerlas como predictores distaba mucho de los criterios estadísticos empleados décadas después.

Tibbitts (1932), utilizando criterios de investigadores de la época como Vold, reanalizó una muestra de 907 varones puestos en libertad para comprobar la fiabilidad de su propia clasificación inicial (Tibbitts, 1931). El trabajo valoró la estabilidad en la codificación de los ítems y encontró una menor coincidencia en aquellos que requerían más de una fuente de información o cierta interpretación por parte del evaluador. El autor llamó la atención sobre el hecho de que las herramientas debían ser construidas pensando en los usuarios, definiendo con claridad las variables sin dejar lugar a grandes diferencias en interpretaciones. Respecto al desarrollo de la metodología en la época, señalaba la necesidad de que los factores estuviesen relacionados con el resultado a predecir, que fuesen codificables de forma fiable

y, en especial, cuestionaba la utilización de factores interrelacionados, advirtiendo de un posible solapamiento entre ítems (o incluso duplicación) en los estudios disponibles. Teniendo en mente la aplicación de métodos más técnicos en el desarrollo de la materia, concluyó:

[...] se puede alcanzar una mayor precisión de la predicción con la aplicación de algún tipo de test sobre la fiabilidad de la clasificación, y uno puede sentirse bastante seguro de que conforme crezca el interés por este y otros problemas tanto los datos como los métodos de trabajarlos se mejorarán (p. 853).

Vold (1935) propuso la aplicación de la metodología en la predicción del comportamiento intrainstitucional, relacionándola con la respuesta que podrían dar los sujetos a la intervención. Su sistema se basaba en 29 factores previos al ingreso en prisión. Usó en la misma muestra el método Burgess y el método de los Glueck, con resultados similares (el resultado de ambos métodos correlacionaba un 92%). Además, descubrió que los factores con un nivel de contingencia cero o próximo a cero (menor de 0,10) ofrecían tablas con resultados moderadamente satisfactorios, por lo que el uso de métodos de contingencia para señalar la importancia de los factores parecía inadecuado. El autor planteó dudas sobre la diferencia en resultados según la persona que codificase los factores, sobre cuánto mejoraban las tablas de predicción las estimaciones hechas por los profesionales (con su criterio profesional u «ojo clínico») o cuál era la relación entre el resultado de la tabla y la conducta real del caso. Pese a concluir que la conducta en prisión se podía predecir, señaló que las herramientas no debían ser la base para la clasificación penitenciaria, sino un complemento para las clasificaciones para el tratamiento propuestas por experiencia.

En esa época se comenzó a hablar de conceptos y principios necesarios para que la predicción pudiera ser considerada una ciencia (Lanne, 1935):

— *Exhaustividad*: al margen de demostrar que los factores están relacionados con un

resultado, es necesario demostrar que no existen otros factores relacionados con la misma intensidad. El principal problema de los estudios era que la información se seleccionaba por su disponibilidad en los registros y no por su pertinencia para el objeto de estudio.

- *Número de factores necesarios*: esta cuestión impregnaba la investigación de la época, cuestionándose cuál era el número óptimo de factores que debía contener una tabla de predicción. La respuesta no era sencilla. La utilización de pocos factores conlleva riesgos en las clasificaciones, debidos al más mínimo error en la codificación o respuesta al ítem. Por otro lado, el uso de un elevado número de factores conlleva mayor esfuerzo, tiempo y menor significación de las variables. Los estudios concluían que la utilización de menos factores era la mejor opción, pues demostraba una capacidad similar a un mayor número de factores y facilitaba la aplicación de las herramientas.
- *Fiabilidad*: llamó la atención sobre la necesidad de que hubiera una consistencia en las valoraciones de los factores o de los sujetos (por ejemplo, que un mismo profesional puntuara igual un caso con la misma información o en momentos diferentes).
- *Significación*: aunque el autor lo describía como un aspecto *sine qua non* en el ámbito de estudio, muchos de los factores presentes en herramientas no eran relevantes. Además, comparar a los sujetos según el número de factores presentes, cuando todos no contaban con el mismo número de factores respondidos, era un problema. La recomendación era que no debería incluirse ningún factor sin relación significativa con el resultado.
- *Independencia entre variables*: conocida como ortogonalidad en estadística, hacía alusión a que los factores incluidos en la herramienta no estuvieran relacionados por estar midiendo, en esencia, el mismo

constructo. Un ejemplo sería la presencia de un factor de riesgo denominado tipo de delincuente (con categorías como primario, habitual, etc.) y otro factor denominado antecedentes penales (con categorías como ninguno, uno, etc.). En el ejemplo, podría ocurrir que los delincuentes categorizables como habituales cuenten con antecedentes y, por tanto, una misma variable se considere en dos factores diferentes.

- *Método de puntuación:* los métodos enfrentados en la época eran los ponderados, con asignación de valores diferentes a los ítems según su relevancia, y los no ponderados, que asignaban el mismo valor a todos los factores. La investigación sugería un mayor beneficio de los sistemas no ponderados.

Huff (1936) confrontó directamente la visión dada por Lanne (1935) de la predicción de la libertad condicional como ciencia. Utilizando los pasos que describen un método científico, analizó los estudios sobre libertad condicional y valoró su adecuación científica. La conclusión fue que la investigación era muy limitada y planteó más dudas que certezas.

Una de las propuestas de la época, más atípica aunque ingeniosa, fue la de Laune (1935). Al aplicar el método Burgess en Illinois, se observó que la mayoría de los factores eran externos a la prisión y estáticos, por lo que no se podía esperar un cambio tras el paso por prisión. El autor analizó las corazonadas o valoraciones que hacían los propios presos de sus compañeros, para ver la medida en la que el procedimiento podía ser replicado por los profesionales. Los internos valoraron la probabilidad de éxito o fracaso en la puesta en libertad y posteriormente se trató de enumerar los factores utilizados y elaborar una herramienta.

1.3. 1940

Con el cambio de década se acumularon revisiones sobre la investigación precedente, se analizó la aplicación de la predicción en el contexto de

la libertad condicional y se continuó poniendo a prueba las propuestas de Burgess y los Glueck.

Monachesi (1941) revisó los avances en la predicción desarrollados en las décadas precedentes en el ámbito de las ciencias sociales. Puso de manifiesto algunas limitaciones, como la fiabilidad de los sistemas de predicción y de los datos con los que se cumplimentaban los instrumentos, el modo en que se seleccionaban los factores, el modo en que estos factores se ponderaban y la puesta a prueba de las herramientas en la vida diaria (este último el aspecto más ignorado por la investigación). El autor concluyó:

«En la actualidad, parece que hay pocas dudas de que es posible construir instrumentos que pueden ser utilizados para predecir ciertas fases del comportamiento humano. Esto ha sido ampliamente demostrado. Cómo funcionan los dispositivos de predicción disponibles en la predicción real de la conducta humana está aún por demostrar» (p. 486).

Allen (1942), tomando en consideración los estudios de Ernest W. Burgess, Clark Tibbits, el matrimonio Glueck y George B. Vold, concluyó que hacía falta un sistema de clasificación científico para prisiones, que eran los inicios de la administración de la justicia de forma científica y que aún las técnicas no se habían definido bien. Además señaló que «en el manejo de problemas sociales, sin embargo, es difícil reducir todos los datos a fórmulas objetivas y cuantitativas» (p. 554).

Jenkins, Hart, Sperling y Axelrad (1942) desarrollaron una propuesta de sistema para predecir el éxito en la libertad condicional mejorando los sistemas disponibles, al prestar mayor atención a variables psicológicas de los evaluados. En palabras de los autores: «Como cualquier otra acción humana, el delito solo puede entenderse en relación al estado psicológico en que se cometió» (p. 38). Por tanto, la predicción no podía ignorar estas variables psicológicas. Crearon un sistema de variables que había sido sometido a la opinión de psiquiatras y personal encargado de menores infractores, con un total de 95 ítems ponderados desde +4 (para variables positivas) hasta -4 (para variables negativas). Con estos valores, compara-

ron la puntuación de menores bien adaptados y aquellos enviados a correccionales. El trabajo describía la distribución de puntuaciones en ambos casos, pero no llegaba a discutir el solapamiento entre distribuciones, puntos de corte o capacidades predictivas, como se discutiría décadas después o haríamos hoy en día.

Weeks (1943), siguiendo la dinámica habitual de la época, propuso una tabla de predicción estadística para valorar la probabilidad de que un joven se volviera delincuente según la presencia de determinadas variables. Tal como señalaba el autor, la definición de delincuencia utilizada (varón, entre 7 y 18 años, que hubiera comparecido ante un tribunal de menores) estaba orientada a predecir la delincuencia como aparición en un tribunal de menores, pudiendo quedar de lado posibles delincuentes no detectados o que siguiesen otra vía. La muestra estuvo compuesta por 420 chicos con causas judiciales y otros tantos sin causas como grupo de control. De las variables disponibles en los casos judiciales, 14 diferenciaban a los delincuentes de los controles. Weeks utilizó distintos sistemas para crear las tablas de predicción. En el primero las variables no estaban ponderadas (se hacía un sumatorio simple de ítems presentes), y la probabilidad de delincuencia se calculó dividiendo el número de delincuentes en cada puntuación entre el total de casos en dicha puntuación. Un segundo método consistió en considerar los factores más presentes en «no delincuentes» como factores de protección, asignando valores negativos a los factores no relacionados con la delincuencia y positivos a los relacionados con la delincuencia. Por tanto, la predicción se hacía conforme a una serie de puntuaciones estimadas. El último método solo incluía las puntuaciones positivas de las variables ponderadas. Posteriormente se puso a prueba el sistema con una muestra nueva de 500 jóvenes delincuentes. De forma interesante, el autor llamaba la atención (aunque no lo ponía a prueba) acerca de la posibilidad y necesidad de predecir y clasificar a distintos tipos de delincuentes y no abordar la delincuencia como algo general. Por último, señalaba la posible utilidad de los proce-

dimientos para evaluar a los niños con mayor probabilidad de convertirse en delincuentes.

Hakeem (1945b) hizo una revisión sobre los estudios de predicción en criminología, aunque sin valorar cuestiones técnicas. En la época, la metodología tenía siempre el mismo objetivo: la determinación de la probabilidad de un sujeto de tener éxito o no en la adaptación tras la puesta en libertad. Uno de los aspectos señalados por el autor era la falta de aplicación de los métodos propuestos y la escasez de estudios de validación de las herramientas. Afirmaba que: «Probablemente, la razón principal por la cual los dispositivos de predicción casi no se han aplicado en situaciones prácticas es que no ha habido, después de todo, ninguna demostración sorprendente y drástica de su capacidad predictiva» (p. 31). Una de las críticas recibida por estos métodos actuariales era su incompatibilidad con la individualización, y se discutía si con la disponibilidad de una buena información no sería suficiente como para evitar el uso de estas herramientas. Otra fuente de críticas era el uso de información pasada. La metodología de predicción de la libertad condicional podía verse simplemente como una organización y puntuación de información, de tal modo que se determinaba el riesgo de sujetos a partir de experiencias con casos similares evaluados con la misma información.

Hakeem, además, puso a prueba los métodos de Burgess y de los Glueck. En primer lugar, aplicó el método de los Glueck a 1.861 ladrones (Hakeem, 1945a). Hizo una descripción detallada del procedimiento seguido para proponer una tabla de predicción de seis ítems: 1) propuesta de 23 factores de interés; 2) clasificación de la muestra de acuerdo a su adaptación en la libertad condicional (éxito, quebrantamiento menor o quebrantamiento mayor); 3) porcentaje de cada tipo de sujeto en las alternativas de respuesta a cada ítem; 4) análisis de la correlación entre cada ítem y el resultado de la libertad condicional; 5) eliminación de los ítems con una correlación inferior a 0,21; y 6) descripción del porcentaje de quebrantamientos graves dentro de cada uno de los seis ítems restantes. Pese a seguir la metodología

original, incluyó factores distintos, la definición del fracaso o éxito en la libertad condicional era diferente, y el período de seguimiento, entre otros aspectos, no coincidía, por lo que no fue posible la comparación con el trabajo de los Glueck. Al margen de esto, Hakeem confirmó la posibilidad de predecir el resultado de la libertad condicional con el diagnóstico psiquiátrico, la clase social, los antecedentes delictivos, el historial laboral, el tipo de delincuente (primario, ocasional, reincidente, habitual) y la comunidad de pertenencia (tamaño del municipio de residencia). Posteriormente, Hakeem (1948) puso a prueba el método de Burgess en 1.145 sujetos puestos en libertad condicional, a los que se hizo el seguimiento durante casi seis años. Durante el seguimiento, el 27,7% de la muestra fue considerada quebrantadora. Los casos fueron puntuados según el método de Burgess antes de la puesta en libertad, y se valoró su probabilidad de reincidencia conforme a una tabla realizada con sujetos de la misma prisión. El principal problema fue que la tabla contenía ocho factores de riesgo no presentes en la de Burgess. Además, de los presentes en la de Burgess tres fueron eliminados. Por tanto, una vez más, los resultados no eran comparables.

Frente a la pregunta de si las herramientas ofrecían resultados útiles, Monachesi (1945), a partir de sus muestras, concluyó que sí. Pese a darse discrepancias en algunos niveles de riesgo, en conjunto las estimaciones coincidían con el resultado real. El autor señaló que la tendencia de las herramientas a predecir peor la conducta de los sujetos clasificados en puntuaciones intermedias era resultado de una mayor ambigüedad de algunas de las categorías utilizadas en la clasificación de los sujetos.

Ohlin y Duncan (1949) analizaron la eficacia de la predicción en criminología en aquella época (en 16 estudios diferentes) y calcularon un «porcentaje de reducción en el error de predicción» (p. 442). En esencia, consistía en comparar la predicción que podríamos hacer basándonos simplemente en la tasa de reincidencia que conseguiríamos con la herramienta. Por ejemplo, si la tasa de reincidencia fuese del 40%, la mejor predicción

sería estimar que el sujeto no va a reincidir y acertaríamos en el 60% de los casos. El sistema de predicción, por tanto, tendría que reducir este error de predicción del 40%. En general, aunque los avances en la metodología eran considerables, los autores describían los resultados como decepcionantes. Señalaron tres errores que se podían dar al utilizar, en la vida real, los sistemas de predicción propuestos en la investigación. Primero, podría darse una ausencia de relación entre los factores predictores y el resultado en la población. En segundo lugar, incluso con grandes muestras existirán errores aleatorios y variaciones en las muestras que no pueden ser controlados. El último tipo de error estaba relacionado con los plazos temporales. Señalaron que este último era uno de los mayores defectos de los estudios de predicción hasta la fecha. Introducían así dudas sobre la estabilidad de los factores de riesgo como predictores, afirmando que «los cambios secuenciales en los factores que afectan al comportamiento son tan pertinentes para un análisis científico como lo son los “antecedentes” en las historias de las personas» (p. 451).

1.4. 1950

Monachesi (1950) inició la década con una revisión de los estudios estadounidenses en materia de predicción de la reincidencia. Tal como hemos señalado, los grandes referentes eran el método Burgess y el método de los Glueck. Sin embargo, también hizo alusión a otras propuestas que tuvieron mucho menos eco, como el Índice de responsabilidad criminal de Argow (diseñado para estimar la probabilidad de reforma y no reincidencia en delincuentes primarios) o la predicción de la delincuencia juvenil de Weeks. Sin embargo, el autor llamó la atención sobre la escasez de estudios que analizasen la capacidad predictiva de los sistemas propuestos y que, además, los pocos estudios disponibles ofrecían resultados contradictorios. Como propuesta prometedora, señalaba el ya citado sistema de Ohlin y Duncan (1949). Entre los factores que influían en la eficacia de

CLAVE 3.**Tablas de predicción (Glueck y Glueck, 1950)**

Sistema consistente en variables ponderadas según su capacidad predictiva, que ofrecen un valor final organizado en categorías numéricas vinculadas a la probabilidad de conducta delictiva.

los sistemas, se señalaba la precisión de la información utilizada para responder a los ítems (por ejemplo, registros oficiales). Por otro lado, influía la interpretación de la información tanto entre personas como en una misma persona en distintos momentos. También se señalaba la limitación de que el número de predictores valorados dependiera directamente de la información disponible y que nadie podía garantizar que esos factores disponibles fuesen los relacionados de forma más significativa con la conducta a predecir. Puso en duda la utilidad de los factores de riesgo dinámicos (algo que precisamente en la actualidad tiene la lectura contraria: interesa la presencia de factores modificables para que el riesgo no sea estático). Por último, se sugería la necesidad de medidas estandarizadas que no necesitasen la interpretación del profesional.

En la década de 1950 podemos encontrar una de las obras que posiblemente más atención ha obtenido en el ámbito de la predicción delictiva. Eleanor y Sheldon Glueck publicaron el libro *Unraveling Juvenile Delinquency* (Glueck y Glueck, 1950), en el que difundieron su sistema de Tablas de Predicción, proveniente de la acumulación de estudios desde la década de 1920. En esencia, agruparon variables en tres tablas destinadas a predecir qué jóvenes en edad escolar serían delincuentes persistentes a no ser que se interviniera para modificar el comportamiento inadaptado (Glueck y Glueck, 1956). Se iniciaba así la mentalidad de lo que ahora conocemos como gestión del riesgo. Las variables se derivaban de su estudio, en el que comparaban 500 jóvenes delincuentes y 500 no delincuentes (Glueck y Glueck, 1950). En una de las tablas incluyeron

cinco factores familiares (etiquetados por los autores como sociales): supervisión del joven por parte de la madre, disciplina por parte del padre, afecto de la madre hacia el joven, afecto del padre hacia el joven y unión de la familia. Otra tabla incluía variables del test Rorschach: asertividad social, actitud desafiante, suspicacia, destructividad y labilidad emocional. La última incluía cinco rasgos temperamentales: intrepidez, extroversión, sugestionabilidad, terquedad e inestabilidad emocional. La más conocida de ellas fue la que contenía cinco variables familiares, conocida como Tabla de Predicción Social (*Social Prediction Table*).

El sistema consistía en ponderar distintas variables, asignándoles valores numéricos según su relevancia (*weighted score*) de forma que al reunir las en una tabla o listado de variables permitiesen el cálculo de un valor numérico (*weighted score class*), que era el utilizado para estimar el riesgo. Posteriormente se establecían probabilidades de delincuencia, categorizadas según dichas puntuaciones, partiendo de la prevalencia de conducta delictiva o no delictiva de los sujetos que obtenían dichas puntuaciones en sus muestras de estudio. La incidencia de delincuentes y no delincuentes en cada rango de puntuaciones expresaba la probabilidad de conducta delictiva de personas que fueran asignadas a dicha categoría numérica (por ejemplo, eran delincuentes el 8,2% de los que puntuaban por debajo de 200; el 37% de los que puntuaban entre 200 y 249; el 63,5% de los que puntuaban entre 250 y 299; y el 89,2% de los que puntuaban 300 o más en la Tabla de Predicción Social) (Glueck y Glueck, 1950).

Glueck y Glueck (1956) buscaron la mejora del sistema, mediante la combinación de variables entre las distintas tablas, con una submuestra de 424 chicos (205 delincuentes y 219 no delincuentes). Los distintos intentos llevaron a la conclusión de que la Tabla de Predicción Social era la más recomendable, por obtener resultados similares a los de las combinaciones de más variables y porque requería una menor inversión temporal y de conocimientos en su aplicación. Sin embargo, del mismo análisis también se podía

desprender que la capacidad predictiva de las tres tablas (y por tanto de sus variables) era similar.

Glueck (1958) abordó la individualización de la condena llamando la atención sobre la necesidad de una técnica fiable para ajustar las intervenciones. Para el autor, la individualización de una medida (sentencia o tratamiento) requería en primer lugar diferenciar a cada delincuente en variables como la personalidad o la motivación delictiva y, en segundo lugar, determinar qué medidas de las disponibles se adaptaban mejor al sujeto. El objetivo era resolver el conjunto de problemas presentes, de forma que se pudiera reducir la probabilidad de comisión de delitos en el futuro. Propuso no utilizar directamente las herramientas de predicción, sino que los profesionales (jueces en aquel momento) realizaran su valoración habitual y compararan su opinión con el resultado de las tablas de predicción. Posteriormente los estudios podrían demostrar la utilidad de un criterio frente al otro.

Como se puede apreciar, la perspectiva del matrimonio Glueck era actuarial, pues asignaban valores ponderados a las variables y estimaban el riesgo en formato probabilístico (véase capítulo 6). Las tablas estaban diseñadas para ayudar al juez a valorar a un sujeto tomando en consideración la experiencia con otros cientos de casos que, en aspectos cruciales, se parecían a la persona a juzgar. Al igual que ocurre en la actualidad, los autores ya se planteaban en aquel momento la aplicabilidad y utilidad de sus tablas con muestras distintas a las que se habían utilizado para su creación (Glueck y Glueck, 1956).

Glueck (1956) revisó la evolución de la aplicación de sus tablas en los estudios de la época como reflejo de la validación de su metodología. Tras la publicación de *Unraveling Juvenile Delinquency* en 1950, la única que se aplicaba era la denominada Tabla de Predicción Social. Una de estas aplicaciones la hizo Thomson (1953), utilizando la muestra del clásico estudio longitudinal *Cambridge-Somerville Youth Study*. En su aplicación a cien casos consiguió una clasificación correcta del 91 %. Comparando la capacidad de la tabla con la de tres profesionales guiados por su

experiencia clínica y el análisis de entre 21 y 59 variables, «los cinco factores ponderados del contexto social incluidos en la escala de los Glueck [parecían] ser de mucha mayor capacidad predictiva» (pp. 469-470). La conclusión del autor también iba en una dirección tal vez no lo suficientemente enfatizada en el conjunto de estudios de la época (o incluso en la historia de la aplicación de esta metodología), que es el valor de estas herramientas para «evitar el etiquetado de tantos jóvenes como predelinquentes, cuando en realidad su molesto mal comportamiento puede ser una manifestación sintomática temporal del esfuerzo por ajustarse en el difícil proceso de socialización» (p. 470). Por tanto, no solo se pensaba en prevenir y gestionar el riesgo, sino que se intentaba también no actuar sobre sujetos que no lo requirieran ni etiquetar a las personas de forma errónea.

Aunque se han señalado diversos antecesores, el trabajo del matrimonio Glueck puede considerarse precursor de la predicción de la delincuencia como metodología empírica. Su impacto fue notorio en la época, con aplicaciones incluso en países de habla hispana, como Puerto Rico (Montero, 1966). Andrews y Bonta (2010) consideran el trabajo del matrimonio Glueck como uno de los referentes más validados en la psicología criminal. Las investigaciones del matrimonio son referencia en la historia de la criminología y también fueron pioneros en la investigación de carreras delictivas (Soothill et al., 2009). Pese a ello, no quedaron al margen de críticas, por ejemplo respecto a la selección de variables (Weis, 1974) o especialmente respecto a su argumentada capacidad predictiva (Walters, 1956). Otras fuentes de crítica han sido las limitaciones de los estudios de validación (con análisis parciales de las eficacias predictivas o selección de muestras con elevada conflictividad) y la ausencia de criterios objetivos para valorar la afección o disciplina de los progenitores (véase Stott, 1960a), variables centrales en el proceso de predicción. Tampoco son utilizados como referentes en los desarrollos recientes en el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia (véase, por ejemplo, la evolución de la contribución canadiense a la evaluación del riesgo en Bloom, Webster, Hucker y De Freitas, 2005).

En esta misma década, Meehl (1954) publicó su monografía sobre la comparación del método actuarial y el juicio clínico en psicología, señalando la superioridad del primero. El análisis se considera el precursor del avivado enfrentamiento que existe aún hoy en día entre partidarios y detractores de los métodos actuariales en la evaluación del riesgo de violencia (véase capítulo 6, apartado 4).

1.5. 1960

En la década de 1960, el foco de atención se puso en la peligrosidad de pacientes psiquiátricos y se mantuvo el interés por la predicción en los casos de libertad condicional. Goldstein y Katz (1960) abordaron el debate sobre la puesta en libertad de pacientes considerados inimputables por la presencia de un trastorno mental. En la base del debate estaba la dificultad de establecer con claridad el concepto de peligro potencial o peligrosidad, así como probar las decisiones. Los autores señalaban dos problemas fundamentales:

«el tipo de conductas suficientemente amenazantes como para ser llamadas “peligrosas” y el grado de certeza necesario con el que un pronóstico debe establecer la probabilidad de ocurrencia, en un período concreto de tiempo, del tipo o tipos de conductas denominadas peligrosas» (p. 235).

El problema de esta falta de claridad llevaba a que los profesionales pudiesen aplicar el denominado «mejor juicio» (o, dicho en otras palabras, su criterio profesional o personal).

Stott (1960a) intentó introducir una alternativa a las criticadas (entre otros por él mismo) tablas de predicción de los Glueck. El autor trataba de rebatir resultados y validaciones previas, aportando conceptos técnicos que permitieran una valoración más realista de las propiedades de los instrumentos propuestos. Por ejemplo, utilizaba el concepto «selectividad» (*selectivity*) para referirse a la proporción de sujetos que realmente terminaban siendo delincuentes, entre todos los etiquetados

como de riesgo, y «rango predictivo» (*predictive range*) para la proporción de delincuentes entre la población evaluada que fueron detectados como propensos. El «valor predictivo» (*predictive value*) de una herramienta sería la medida en que detecta la mayoría de los sujetos de riesgo (delincuentes, reincidentes, o cualquiera que sea el criterio) sin incluir en la misma etiqueta a un gran número de sujetos no delincuentes o de riesgo bajo. Aunque con conceptos diferentes a los utilizados en la actualidad (véase capítulo 5), el autor ponía de manifiesto la importancia de establecer criterios o puntos de corte ajustados, de forma que no se dejaran muchos sujetos de riesgo sin detectar ni se etiquetaran muchos sujetos como de riesgo cuando realmente no lo eran. Stott intentó proponer un nuevo sistema de clasificación de menores en edad escolar con potencial delictivo (*Bristol Social Adjustment Guide*) que corrigiera las críticas hechas a las tablas de los Glueck (Stott, 1960b). Sin embargo, aunque en la actualidad aún se utiliza en estudios longitudinales de Reino Unido, no tuvo un impacto comparable al de los Glueck en lo que a predicción de la delincuencia se refiere.

Craig y Glick (1963) revisaron diez años de experiencia con la Tabla de Predicción Social de los Glueck, con un seguimiento hasta los 16 años de 244 chicos evaluados a los seis años. La principal conclusión del trabajo era que, excepto para los extremos (tanto de menor como de mayor riesgo), la tabla sobreestimaba la propensión a la conducta delictiva. Desde la dirección de menores en la que se desarrollaba el proyecto se propuso la utilización de solo tres factores, modificando además uno de los originales. Finalmente, la tabla de predicción social revisada incluía los siguientes factores: 1) supervisión por parte de la madre; 2) disciplina por parte de la madre (antes el ítem era disciplina por parte del padre, pero en muchos casos el padre estaba ausente, por lo que el ítem no se podía aplicar); y 3) cohesión de la familia. La nueva propuesta mejoraba las clasificaciones correctas, pasando del 85% al 96,4% en la precisión de la predicción de los no delincuentes y del 70% al 85,1 % para los delincuentes. El estudio señalaba la importancia de revisiones en

las tablas originales de los Glueck como medio para mejorar el proceso de análisis de los factores de riesgo por parte de los profesionales, añadiendo que no buscaban sustituir el juicio clínico sino complementarlo con una herramienta.

Analizando de forma crítica la evolución de los estudios sobre las tablas de predicción, se podría afirmar que, pese a intentar mejorar de forma empírica la capacidad predictiva, lo que se producía era una adaptación constante a muestras concretas, cuya utilidad para valorar el riesgo en muestras venideras siempre quedaba en duda.

En aquellos inicios, Sarbin (1967; p. 286) consideraba que «[...] el comportamiento agresivo o violento que nos lleva a adjuntar la etiqueta de “peligroso” a un delincuente puede entenderse como el resultado predecible de ciertos antecedentes y condiciones concurrentes». En esencia, se tenía en mente una predicción de la conducta violenta en la misma dirección que hoy en día.

Heiler (1969) abordó la cuestión de la peligrosidad, definida como «[...] la anticipación o predicción de daño o violencia a una persona u otro objeto valioso [...]» (p. 6). En un artículo de opinión más que de revisión, insistía en la necesidad de analizar la naturaleza del peligro, el objeto en peligro y las circunstancias que hacen al sujeto susceptible tanto de ser peligroso como de estar en peligro (en otras palabras, características del agresor y de la víctima). Sin embargo, al margen de una mezcla demasiado genérica de posibles variables psicológicas, orgánicas o ambientales, que podían determinar la peligrosidad de un sujeto, muchos de los argumentos utilizados eran equivocados, aunque propios de valoraciones de la época y de momentos recientes. Sirva como ejemplo la siguiente afirmación referente a las características de la víctima relacionadas con el riesgo: «entre las actitudes o “juegos” llevados a cabo habitualmente por mujeres víctimas encontramos la vestimenta, postura o forma de andar provocativa, acompañada de una defensa rígida y tenaz de la integridad genital» (p. 11). En la actualidad, insistimos en que el riesgo es del potencial agresor, aunque efectivamente haya características de la víctima (en caso de tipos de violencia

dirigidos hacia víctimas identificadas, como la de pareja) que le hagan más vulnerable a una agresión (falta de recursos o de apoyo social, por ejemplo; véase capítulo 9). En todo caso, sin un agresor motivado y de riesgo ninguna característica de la víctima le podrá victimizar.

Dershowitz (1968) adoptó una postura crítica hacia las leyes vinculadas a la peligrosidad, partiendo de las ficciones o ilusiones que se mantenían respecto a la predicción y el tipo de sesgos que cometían los profesionales. Señaló:

«El psiquiatra casi nunca aprende acerca de sus predicciones erróneas de violencia [...]. Pero siempre aprende sobre sus predicciones erróneas de no violencia, a menudo de titulares de prensa [...]. Esta mayor visibilidad de predicciones erróneas de no violencia le inclina, ya sea consciente o inconscientemente, a sobreestimar en lugar de subestimar el comportamiento violento» (p. 377).

Sería un ejemplo de lo que coloquialmente describimos como *más vale prevenir que curar* (respecto a estas cuestiones y el efecto de los distintos tipos de error, véase el capítulo 5, apartado 5). Los psiquiatras tomaban decisiones de gran relevancia, respondiendo a la posible ocurrencia de un daño en términos de probabilidad (si la ocurrencia de un daño era *probable*) con alternativas de respuesta categóricas (sí o no). Sin embargo, cada profesional podía tener una idea de qué significaba *probable*, fundamentada en sus propias preferencias. Es en este punto donde se comenzaría a discutir cuestiones como los niveles de riesgo, las tasas base o los formatos de presentación de los resultados

CLAVE 4.

Tablas de configuración (Glaser, 1962)

Tabla para la estimación de la probabilidad de reincidencia consistente en la selección de las variables más significativas de forma consecutiva, partiendo de la respuesta dada a la que más discrimina entre reincidentes y no reincidentes.

(por ejemplo, probabilidad alta, del 90 %, etc.). En aquel momento, muy pocos estudios analizaban de forma empírica la capacidad predictiva de los psiquiatras, y los pocos que estaban disponibles concluían que estos profesionales eran más bien imprecisos en términos generales y comparados con otros profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, o con herramientas actuales como las tablas de predicción.

Glaser (1962) afirmó que «la única predicción de la libertad condicional consistentemente precisa no es el pronóstico en casos individuales, sino la predicción de las tasas de resultados relativos para distintos grupos de delincuentes» (p. 239). Propuso un nuevo sistema de predicción, denominado Tabla de Configuración (*configuration table*), que según el autor podía ser utilizado de forma más fácil que las tablas precedentes, que facilitaba una mayor comunicación entre jueces o comités de libertad condicional y el estadista responsable de las tablas, y que predecía con mayor precisión que las tablas disponibles. Glaser consideraba que el procedimiento era similar al usado por los profesionales en la toma de decisiones, solo que los profesionales hacían conexiones y estimaciones mentales que ahora se reflejaban en las tablas de configuración. El autor también advertía sobre la posibilidad de que hubiera casos en los que la sola presencia de un factor, incluso no presente en las tablas de predicción, fuese suficiente para considerar un riesgo elevado según el criterio del profesional. Este planteamiento sigue vigente hoy en día, al afirmarse que el riesgo no correlaciona de forma lineal con el número de factores presentes y la posible consideración de ítems críticos, incluso aunque no estén entre los presentes en la herramienta utilizada, que determinen nuestra valoración final.

La intención del autor era utilizar lo menos posible las matemáticas y clasificar a los sujetos conforme a las variables disponibles en los archivos. Analizó un total de 63 variables, para ver cuáles tenían categorías que permitieran ubicar a la muestra en mayor medida en un riesgo alto o bajo, con la menor proporción de niveles intermedios. La variable que mejor diferenciaba era la

presencia de ingresos previos en prisión. Por tanto, esta variable era la primera categoría o decisión en la tabla de configuración. El siguiente paso consistió en seguir clasificando las muestras conforme a las restantes variables con el mismo criterio. La siguiente variable que mejor clasificaba a los sujetos sin ingresos previos fue la edad de la puesta en libertad, y la última que permitía una clasificación era el historial de empleo en libertad. En esencia, el sistema sería similar al conocido hoy en día como árbol de clasificación (véanse apartados 2.2.1 y 6.2), que supone la valoración de variables de forma consecutiva, modificando las que se deben considerar en función de la respuesta en cada una.

Carney (1967) propuso lo que podríamos traducir como «categorías de expectativa base» (*base expectancy categories*), que suponían categorías de sujetos, agrupados según una serie de variables, vinculadas a tasas de reincidencia. El estudio se realizó con 363 sujetos puestos en libertad, y se incluyeron variables previas al ingreso (historial militar, detenciones previas, etc.), variables referentes al ingreso (conducta institucional, por ejemplo) y variables posteriores a la puesta en libertad (tipo de libertad, tipo de comunidad a la que se incorpora, etc.). El seguimiento se hizo durante cuatro años. Una vez conocidos los sujetos reincidentes (54,5 %), las variables se dividieron en dos categorías y se calculó el porcentaje de reincidentes en cada categoría (por ejemplo, edad ≤ 29 vs. ≥ 30). La variable que mejor discriminaba entre reincidentes y no reincidentes se seleccionaba y se procedía a una nueva división de la muestra conforme a otra variable de forma sucesiva, hasta que la muestra no permitiese análisis significativos (por ejemplo, edad ≤ 29 , con historial de ingreso en prisión previo, con antecedentes distintos a delitos contra las personas). Siete variables resultaron significativas: edad en la condena actual, condenas previas, edad en la primera detención, número de arrestos previos, conducta institucional, tipo de delito y trastornos conductuales (como adicciones). Como conclusión, pese a proponerse ocho categorías de sujetos, el autor señalaba que la muestra podía dividirse en dos

categorías generales: con alta o baja probabilidad de reincidencia. La mejor predicción se daba con la combinación de la edad en el delito actual y el historial de delitos: a menor edad y más antecedentes, mayor probabilidad de reincidir.

Las categorías podían ser utilizadas como ayuda en la toma de decisiones, para evaluar el impacto de los programas de tratamiento o para informar sobre qué sujetos eran más o menos propensos a beneficiarse de los tratamientos. Al igual que otros desarrolladores de herramientas de predicción como los Glueck, el autor señalaba que esas categorías solo eran un complemento para la toma de decisiones y que no debían sustituir a otros aspectos relevantes como la experiencia de los profesionales. El principal beneficio era el aporte de objetividad que daban al proceso y hacer que los profesionales considerasen variables que de otra manera podrían pasar por alto.

En esta década se mantuvo el interés por mejorar el sistema de predicción del matrimonio Glueck (1963). Podemos encontrar una monografía, derivada de un congreso de la *American Psychiatric Association* dedicado a la evaluación de la peligrosidad en pacientes con trastorno mental (Rappeport, 1967), así como la que posiblemente sea la primera tesis doctoral en español sobre la materia, titulada *Cálculo médico legal de un índice de peligrosidad*, defendida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (Saumench, 1960). Un trabajo que, sin duda, podría parecer de plena actualidad de no ser, evidentemente, porque está desarrollado en un contexto sociocultural y un marco legal absolutamente diferente al actual (con leyes como la de «vagos y maleantes» vigentes y, por tanto, considerando peligrosos socialmente a los etiquetados por el régimen como tal: prostitutas, homosexuales, timadores o jugadores, entre otros).

1.6. 1970

La década de 1970 puede considerarse el inicio de los debates científicos sobre el concepto de peligrosidad y su evaluación, con análisis éticos

sobre las implicaciones de la metodología y los primeros estudios empíricos sobre la precisión de las predicciones. Tal como Megargee (1976) indicaba, nunca hasta entonces la predicción de la conducta violenta había suscitado tanta preocupación. Por ello, y porque muchas de las discusiones y sugerencias de la época siguen aún vigentes, nos detendremos especialmente en los trabajos de esta década, algo inasumible para momentos posteriores por el volumen de material disponible.

Dershowitz (1970) analizó críticamente el por aquel entonces ampliamente utilizado internamiento preventivo, destinado a aquellos sujetos considerados peligrosos aunque no hubieran cometido un delito. Su planteamiento era que la estrategia preventiva (internar) no se había acompañado de una prueba sistemática de los principios en los que se fundamentaba (valoración de la peligrosidad) y que, por tanto, ningún sistema de internamiento basado en predicciones podía ser preciso o justo. En la base de su discurso crítico se encontraban aspectos que hoy en día vuelven a tener vigencia. Por ejemplo, una de las cuestiones que planteaba el autor era:

«¿Cuán probable debe de ser el evento predicho para justificar una prisión preventiva? Incluso si se está de acuerdo, por ejemplo, en que prevenir una agresión física grave podría justificar el encarcelamiento, aún se debe decidir en qué medida la ocurrencia de la agresión predicha es suficientemente probable como para justificar la condena» (p. 45).

Dershowitz (1970) insistía en su puesta en entredicho de la capacidad de los psiquiatras (al igual que en su trabajo de 1968), concluyendo que, además, los psiquiatras cometían particularmente un error, la sobreestimación:

«Una razón para este exceso de predicción es inherente a las matemáticas de la situación: la conducta violenta es extremadamente rara, incluso entre los enfermos mentales, y cualquier intento de predecir un evento raro necesariamente se traduce en un número indebido de falsos positivos» (p. 46).

Wenk, Robison y Smith (1972), en su artículo «Can violence be predicted?», realizaron uno de los primeros intentos por desarrollar una herramienta para valorar el riesgo en adolescentes (en la línea de los disponibles en la actualidad), con una muestra de 4.146 casos a la que se le hizo un seguimiento de 15 meses en libertad condicional. Utilizaron variables provenientes del historial (como el consumo de drogas, los intentos de suicidio, el uso de armas, la presencia de psicosis o trastornos de la personalidad, por ejemplo), medidas psicométricas (de inteligencia, personalidad, etc.) y valoraciones sobre el futuro (referentes a aspectos de potencial desarrollo, académico por ejemplo). Con todo ello, aplicaron ecuaciones de regresión para tratar de predecir la reincidencia violenta. De la muestra, un 2,5% reincidió en el período de seguimiento. Se crearon subgrupos de delincuentes, tratando de detectar diferencias significativas en las cifras de reincidencia (comprobando qué grupo, compuesto por sujetos con factores de riesgo compartidos, era el que más reincidía). Las conclusiones del estudio fueron algo pesimistas, afirmando que el estado de la cuestión era poco prometedor respecto al desarrollo de un instrumento de evaluación que justificara el uso de programas preventivos. En el estudio llegaban a una cuestión de vital importancia a la que solo recientemente se le ha prestado la atención necesaria; «una vez identificados de forma adecuada los casos potencialmente violentos, ¿entonces qué?» (p. 402). Igualmente, se hacía alusión a las cuestiones éticas derivadas de la aplicación de intervenciones en casos erróneamente clasificados (falsos positivos, véase capítulo 5).

Kozol, Boucher y Garofalo (1972) realizaron un seguimiento de diez años a delincuentes violentos (principalmente delincuentes sexuales) partiendo de la clasificación de *peligrosidad* indicada por los profesionales que los atendieron durante su encarcelamiento. Un total de 435 delincuentes fueron puestos en libertad. De estos, los profesionales habían recomendado la libertad a 386, mientras que la habían contraindicado en 49 casos. Los resultados indicaron que los sujetos con recomendación de libertad reincidieron signi-

ficativamente menos que los que no contaban con dicha recomendación (8% vs. 34,7%). A su vez, el tratamiento tenía un efecto positivo en ambos tipos de agresores, reduciendo la reincidencia de un 8,6% a un 6,1% en el grupo de libertad recomendada y del 38,7% al 27,8% en el grupo de libertad contraindicada. Los autores concluían que los factores de riesgo, como los de personalidad, están presentes en distintos tipos de agresores y niveles de riesgo, por lo que no son indicadores directos de la peligrosidad del sujeto.

Las revisiones y reflexiones seguían siendo habituales. Por ejemplo, Rubin (1972) desarrolló una revisión sobre el estado de la predicción de la peligrosidad en delincuentes con trastorno mental. En esencia, su trabajo se centró en plantear el gran número de cuestiones sin respuesta relacionadas con el procedimiento: relevancia de los factores, cantidad de factor necesaria para determinar la conducta delictiva (por ejemplo, de los abusos en la infancia), etiquetado de personas como delincuentes cuando nunca habían cometido un delito, etc. Por otro lado, el autor puso de manifiesto la imposibilidad de evaluar la peligrosidad en una persona que no hubiera actuado con anterioridad de forma violenta. Shaw (1973), en *The Dangerousness of Dangerousness*, expuso los peligros propios de la utilización del concepto peligrosidad, principalmente debido a la gran intuición utilizada en los procedimientos y a las limitaciones de las estadísticas, solo representativas de algunos delincuentes.

Steadman (1973) analizó los criterios utilizados por los psiquiatras para considerar peligrosos a 256 acusados, así como la medida en la que la decisión judicial era concordante con el informe psiquiátrico. La variable más significativa a la hora de considerar peligroso al sujeto era la presencia de violencia contra las personas en su delito. De estos, el 71% fue considerado peligroso, con independencia de la edad o el diagnóstico psiquiátrico. Otro hallazgo llamativo fue que los psiquiatras que no se dedicaban a estas valoraciones como actividad habitual hacían valoraciones más completas, yendo más allá de los cargos del sujeto, mientras que los que se dedicaban a

ello la mayor parte del tiempo se veían influenciados mucho más por los delitos imputados. La razón más frecuente para considerar a alguien peligroso era la presencia de delirios (56%), la segunda era el delito actual (30%), la tercera causa era el potencial de violencia que se estimaba (27,5%) y el cuarto criterio más utilizado era la imprevisibilidad (26%), siendo cuanto menos irónica la predicción en dichos casos. Pese a las limitaciones de las evaluaciones, se daba un 87% de coincidencia entre la recomendación psiquiátrica y la decisión judicial.

Monahan y Cumming (1974) estudiaron uno de los posibles factores vinculados al sobrediagnóstico de riesgo elevado: las consecuencias para el sujeto cuyo riesgo se está valorando. Como muestra de estudio emplearon a estudiantes universitarios a los que se les presentaron 22 casos (en formato viñeta) que describían las características de personalidad del delincuente, pidiéndoles que valorasen su riesgo de reincidencia (la mitad representando a sujetos de riesgo y la otra sin riesgo). La variable independiente, consecuencia de la valoración, se manipuló asignando a una mitad de la muestra que la valoración de riesgo conduciría al ingreso psiquiátrico y la ausencia de riesgo a ir a prisión; y en la otra mitad que la valoración de riesgo conduciría al ingreso en prisión y la de ausencia de riesgo al ingreso psiquiátrico. Los resultados mostraron unos niveles de riesgo asignado superiores (estimación de reincidencia mayor) en los casos en los que la valoración tenía como consecuencia el ingreso hospitalario frente a los que suponían el ingreso en prisión.

Cocozza y Steadman (1974) pusieron a prueba la eficacia de las predicciones en pacientes psiquiátricos (los conocidos como pacientes Baxstrom), con quienes elaboraron una herramienta denominada *Legal Dangerousness Scale* (LDS), compuesta por cuatro características de la actividad delictiva: presencia de antecedentes juveniles, número de arrestos previos, condenas por delitos violentos y gravedad del último delito. En su revisión de las predicciones establecieron un punto de corte en la herramienta (valor numérico de 5)

combinado con otro referente a la edad (categoría de mayores o menores de 50 años). Así, los sujetos de mayor riesgo de reincidencia eran aquellos que puntuaban más de cinco y eran menores de 50 años. La predicción para la reincidencia en general parecía adecuada, pero al buscar la predicción de una conducta peligrosa (entendida como agresión grave a una persona) los resultados eran menos satisfactorios, pues muchos arrestos eran por conductas poco relevantes, como intoxicación o desorden público. Los autores detectaron que la mayor parte de los arrestos no correspondían a comportamientos peligrosos, mientras que otros que no terminaban en arresto sí podían ser clasificados como peligrosos. Por eso mostraron la necesidad de valorar «[...] un comportamiento posterior peligroso en general y no solo aquel que terminase en arresto [...]» (p. 1013), algo que ahora forma parte de la definición de violencia adoptada en la mayoría de guías de juicio clínico estructurado (véase capítulo 1, apartado 1). Pese a los esfuerzos por mejorar la predicción estadística, el número de falsos positivos era tan elevado (70%) que la predicción siempre sería más acertada afirmando que ningún sujeto iba a reincidir en una conducta peligrosa (en cuyo caso solo se fallaba en 14 de los 98 sujetos del estudio —los 14 reincidentes—).

Respecto a la predicción de la peligrosidad en psiquiatría, Diamond (1974) concluía de forma drástica y pesimista:

«Ni psiquiatras ni otros científicos de la conducta son capaces de predecir la ocurrencia de una conducta violenta con la suficiente fiabilidad como para justificar la restricción de la libertad de las personas en base a la etiqueta del potencial de peligrosidad. En consecuencia, se recomienda que los tribunales ya no pidan su opinión a este tipo de expertos» (p. 452).

El mismo escepticismo manifestaron Cocozza y Steadman (1978), afirmando que «la confianza depositada en la habilidad de la psiquiatría para predecir el potencial de conducta peligrosa es injustificada» (p. 255).

El interés por poner a prueba la tabla de predicción social de los Glueck seguía vigente. Loftus (1974) valoró su capacidad predictiva en 663 varones delincuentes juveniles primarios en fase presentencial. Tras un seguimiento medio de 4 años, la conclusión era que la tabla de predicción, con una reincidencia del 35%, no era más efectiva que usar como predictor la tasa base. Al margen de esto, se demostró que las interacciones paternofiliales problemáticas estaban vinculadas a la reincidencia, pero la capacidad de las variables era inferior a la argumentada en los estudios de los Glueck. Weis (1974) se sumó al grupo de trabajos que cuestionaban las pruebas a favor de la metodología de los Glueck, concluyendo que los datos disponibles no permitían dar respuesta a las promesas que se habían señalado décadas atrás, principalmente porque no fueron validadas. Distintos estudios aplicando el método de los Glueck proponían nuevas variables, pero la mayoría no comparaba las muestras que se presuponía que debían ser capaces de comparar.

Carroll (1977) diseñó un estudio experimental para conocer el uso de información (tasas base de reincidencia frente a información específica del caso) en la predicción de la reincidencia por parte de estudiantes de criminología. La duda de la que partía era si la gente podía utilizar la información estadística de forma adecuada. El principal resultado fue que, cuando había información del caso disponible, no se atendía a la información ofrecida por datos estadísticos como las tasas base. Estas cuestiones siguen generando dudas hoy en día, en la medida en que hay distintos formatos de presentación de resultados y la comprensión de los mismos difiere entre profesionales (véase capítulo 7, apartado 6).

Scott (1977) publicó un artículo de revisión en el que trataba de abordar la definición de «peligrosidad» y la imposibilidad, en aquella época, de predecir de forma acertada la comisión de delitos. En el artículo se revisaban los principales indicadores considerados a la hora de valorar la peligrosidad de un caso, entre los que se encontraban el tipo de delito, el historial delictivo, el sexo, la edad, rasgos de personalidad, trastorno

mental o comportamiento durante la condena, entre otros. El autor recordaba la necesidad de valorar los factores teniendo en cuenta la historia vital del sujeto, la posibilidad de que la información no sea fiable, la existencia de un modelo explicativo de la conducta (¿se trata de aprendizaje social, o de una afectación psicológica?) y la motivación o la necesidad que se busca satisfacer con la conducta (lo que en la actualidad conocemos como formulación del riesgo; véase capítulo 7, apartado 3). Como conclusión, el autor afirmaba que la evaluación a corto plazo era mucho más fiable que la realizada a largo plazo (estando esta última más allá de nuestro alcance).

Steadman y Cocozza (1978) continuaron valorando las limitaciones existentes en las predicciones psiquiátricas que se fundamentaban esencialmente en el delito violento imputado, algo que no requería ningún tipo de pericia, que podía ser utilizado igualmente por cualquier persona sin conocimientos específicos y que podía ser considerado discriminatorio. De forma general, las predicciones de los psiquiatras eran acertadas, pues la reincidencia era mayor en el grupo etiquetado como peligroso; sin embargo, estas diferencias no eran significativas salvo para la agresión intrahospitalaria (31 % vs. 44 %). El trabajo señalaba la ausencia de pruebas de la capacidad predictiva de los psiquiatras y, por tanto, la falta de apoyo para su inclusión en los procesos de decisión sobre peligrosidad.

Partiendo de las limitaciones de la psiquiatría, Steadman (1978) propuso formar a profesionales específicamente en el ámbito de la predicción del riesgo si se iba a extender el uso de la metodología como herramienta del sistema de justicia. Junto al hecho de prestar más atención a las variables situacionales (frente a las personales), surgió el término *dangerology* («peligrología») como campo multidisciplinar dedicado al estudio de la predicción del comportamiento violento futuro, que debería encargarse de estudiar la metodología, formar a profesionales y coordinar las políticas de uso adecuado de las predicciones.

Cohen, Groth y Siegel (1978) buscaron la relación entre las leyes de internamiento indetermi-

nado para delincuentes sexuales peligrosos y la capacidad de predecir y tratar de forma adecuada dicha peligrosidad. Los autores llamaron la atención sobre las principales limitaciones de los estudios de predicción. Por ejemplo, muchos estudios trataban de predecir una conducta que nunca había ocurrido en el pasado (algo que en la actualidad, de hecho, es una condición para aplicar la mayoría de los procedimientos de evaluación del riesgo: que el sujeto esté identificado como agresor); otros muchos no consideraban variables ambientales propias del contexto en el que se desarrolla el sujeto durante el seguimiento. Los autores opinaban que el internamiento estaba justificado, pero también señalaban que en aquella época no se disponía del conocimiento necesario para hacer las predicciones adecuadas. Como conclusión, ponían el acento en la necesidad de justificar de forma clara los factores predictores, emitir no solo la opinión final sino la justificación de la misma (en qué se fundamenta el profesional para concluir sobre un determinado riesgo) y ofrecer los recursos necesarios para promover el cambio del sujeto (la denominada gestión del riesgo).

Williams y Miller (1977) estudiaron de forma empírica la evaluación de la peligrosidad a través de variables personales (como la raza o la clase social) y la conducta pasada. Por un lado, pidieron a cien profesionales que opinaran sobre la peligrosidad de una serie de historiales de pacientes a los que se modificaba la raza, la clase social y el historial delictivo. A los profesionales se les pidió que cuantificasen la peligrosidad en una escala del 1 al 7, recomendasen la intervención (máxima seguridad, hospital psiquiátrico civil o puesta en libertad) y describieran las características que habían motivado su decisión. En otra fase del estudio compararon los perfiles de 30 pacientes psiquiátricos considerados peligrosos y otros 30 considerados no peligrosos. En este caso, las variables relacionadas con la conducta durante el ingreso tenían tanto peso como los antecedentes delictivos. Además, las variables CI, raza, relación matrimonial, nivel educativo y nivel socio-económico eran las más relevantes. En ambos

estudios, la clase social y la historia de violencia (partiendo del supuesto de que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada) marcaban la diferencia. Los autores también señalaron que las características del evaluador influían, por ejemplo, según los años de experiencia o el lugar de trabajo (hospital o comunidad). Por último, concluyeron que depositar toda la capacidad predictiva de la violencia en la conducta pasada no requería ningún entrenamiento para la toma de decisiones, y que si éramos conscientes de las implicaciones morales y consecuencias sociales de las evaluaciones debíamos detener estas predicciones a la espera de alcanzar un mayor conocimiento. Levinson y York (1974) también confirmaron que, con independencia del diagnóstico psiquiátrico, algunas características incrementaban la probabilidad de ser considerado peligroso: el sexo masculino, la menor edad, el no estar casado, el tratamiento previo y la solicitud de atención por personas ajenas a la institución se consideraban variables relevantes.

Insistiendo en esta visión crítica de la metodología, Megargee (1976) dedicó un artículo completo a analizar los errores cometidos en la predicción de la conducta delictiva. El primer aspecto a destacar fue que el propio concepto de peligrosidad era problemático, pues asumía la existencia de un rasgo relativamente estable (como la inteligencia), cuando en realidad el riesgo de una persona, para sí misma o para los demás, variaba en función de distintos factores. Además, presentaba una cuestión que abordaremos más tarde en este manual (véase riesgo asumible en el capítulo 5, apartado 5), que es el nivel de error que estamos dispuestos a tolerar y en qué medida se causa más daño haciendo malas predicciones que no haciendo predicciones. Entre las causas de los errores se encuentran las propias de la evaluación, por ejemplo, al analizar aspectos como la motivación o la agresividad con autoinformes fácilmente manipulables y considerarlas disposiciones estables, cuando no lo son. Otro aspecto importante era la relevancia de los factores situacionales, mucho menos atendidos por los profesionales (en comparación con las variables

personales) y que escapan al control al estar en continuo cambio. Asimismo, el hecho de querer predecir eventos muy poco frecuentes (tasa base de reincidencia violenta) incrementa la presencia de errores (amplio número de sujetos mal clasificados) y, en consecuencia, la clasificación errónea de numerosas personas que no reincidirán a pesar de haber sido etiquetadas como de riesgo (falsos positivos que afectan a una gran proporción de sujetos no reincidentes) y de otras que lo harán habiendo sido etiquetadas como de bajo riesgo (proporción de falsos negativos referente al pequeño grupo de reincidentes). Por último, puso de relieve la necesidad de tener en cuenta las implicaciones de las evaluaciones del riesgo, pues de ello dependía el que fuera ético aplicar procedimientos con semejante nivel de error, destinar las evaluaciones para aquellos sujetos con historial de conducta violenta y no opinar de forma dicotómica sino con puntuaciones de referencia. Otro autor que reflexionó sobre los dilemas éticos en la predicción de la delincuencia fue Wilkins (1974), quien insistió en la pregunta ya señalada en trabajos previos: ¿cuántas personas está justificado etiquetar de forma errónea como reincidentes (falsos positivos) para asegurar la detección de los verdaderamente futuros reincidentes?

Mesnikoff y Lauterbach (1975) revisaron algo sobre lo que aún hoy en día seguimos debatiendo, la relación entre trastornos mentales y la conducta violenta peligrosa. Clasificaron los estudios desarrollados entre 1955 y 1975 en cuatro tipos según las muestras:

- a) Presencia de trastorno mental entre delinquentes: muestras de hombres y mujeres mostraban una mayor prevalencia de sociopatía, alcoholismo y adicción a otras drogas, comparados con la población general, pero no más trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno cerebral orgánico. Sin embargo, sí se encontraba mayor esquizofrenia en prisiones federales. Pese a ello, señalaban la gran variabilidad en las prevalencias y la imposibilidad de comparar muchas de las muestras,

del mismo modo en que se mezclaban todos los tipos de delinquentes, siendo imposible valorar la relevancia de las variables para el caso de los violentos.

- b) Violencia en antiguos pacientes psiquiátricos: encontraron un cambio de patrón, respecto a resultados anteriores, que indicaba una mayor presencia de conductas violentas en estas muestras. Pese a ello, las cifras de detenciones eran inferiores a las que los profesionales esperaban encontrar, y mucho más bajas de lo que la sociedad espera de pacientes psiquiátricos.
- c) Violencia relacionada con disfunciones cerebrales orgánicas (como la epilepsia del lóbulo temporal): se proponía herramientas de cribado para poder detectar el riesgo en contextos hospitalarios e intervenir con tratamientos farmacológicos.
- d) Predicción de la violencia entre pacientes psiquiátricos: pese a las propuestas más recientes de la época, como la Escala de Personalidad sobrecontrolada o subcontrolada de Megargee, los estudios carecían de métodos adecuados para las predicciones.

1.7. 1980

La década de los ochenta puede considerarse el origen de la era actual en la evaluación del riesgo de violencia, no por ser los inicios de la metodología, como hemos visto ya al analizar décadas anteriores, sino por ser la época de los referentes de las técnicas y herramientas que actualmente guían la metodología. El principal tema de estudio de estos años fue la predicción en psiquiatría, y más en concreto por psiquiatras. Sin duda, el principal referente de aquel momento fue John Monahan, quien rebatió el uso del ojo clínico (opinión profesional fundada exclusivamente en la experiencia personal) como método válido para las valoraciones en contextos judiciales.

Al inicio de la década, Steadman (1980) sacó a debate una cuestión esencial relacionada con la ética, las prioridades político-criminales y la pre-

cisión de los procedimientos. Las tasas de falsos positivos excedían los estándares aceptados en procesos penales, y el autor analizó el problema de este error en la predicción desde la perspectiva del derecho del evaluado a no ser considerado de riesgo cuando no lo es (o dicho de otra forma, el derecho a no ser sometido a medidas restrictivas por un supuesto riesgo potencial mal estimado). En este mismo sentido, Steadman y Morrissey (1981) señalaron cómo, por un lado, la investigación de la época demostraba la poca capacidad predictiva de profesionales y herramientas y, por otro lado, la sociedad estaba en su derecho a querer protegerse de personas peligrosas. Por tanto, ¿cómo compensar el derecho de la sociedad con el del sujeto a no ser un falso positivo? En esencia, el debate se centraba en un análisis de costes y beneficios de la posición proteccionista (ante la duda, los sujetos son clasificados como de riesgo alto o alta probabilidad de reincidencia y, por tanto, sometidos a medidas restrictivas) y la liberal (supone que, ante la duda, el sujeto es considerado de riesgo bajo, en el mismo sentido que en justicia se aplica el principio *in dubio pro reo*).

Por su parte, Petrunik (1982) debatió las políticas sobre peligrosidad para el control de delincuentes en Europa y Norteamérica, con una cuestión de vital importancia aún hoy en día: ¿dónde se debe poner la línea? (véase discusión sobre riesgo asumible en el capítulo 5). Los falsos negativos (sujetos valorados como de bajo riesgo que terminan agrediendo) siempre van a parecer muchos, siendo imposible reducir el gran número de falsos positivos (sujetos valorados como de alto riesgo cuando no lo son). La duda era si tasas de falsos positivos del 50% o superiores eran simplemente un precio a pagar por protegernos de sujetos peligrosos. El autor ponía el ejemplo de distintas leyes destinadas a delincuentes peligrosos, pero aplicadas en muy pocos casos (ley canadiense para delincuentes peligrosos, estatutos para delincuentes peligrosos en Dinamarca o Finlandia, etc.) y descritas como simbólicas más que instrumentales. Otro aspecto interesante, y que también nos recuerda la situación actual en España, era la persistente popularidad del con-

cepto de peligrosidad y su incorporación progresiva en distintas leyes, al margen del volumen de posturas contrarias al concepto.

Hiday y Markell (1980) plantearon una serie de cuestiones referentes a la peligrosidad: ¿cómo se define?, ¿existen elementos objetivos para valorarla?, ¿debe ser vinculada a un trastorno mental o al comportamiento del sujeto? Las leyes de internamiento no establecían en qué fundamentarse para considerar a una persona peligrosa. La decisión de psiquiatras y psicólogos se fundamentaba en el diagnóstico. Por ello, una alternativa era el establecimiento de un criterio legal que se fundamentara en la presencia de un intento o una amenaza de daño grave, con tres componentes a valorar: tipo de conducta, proximidad temporal de la misma y gravedad del daño. A estos tres aspectos se añadía la probabilidad de ocurrencia de una conducta capaz de causar daño. A través de la revisión de 414 casos y 213 criterios, los autores analizaron la adecuación del internamiento involuntario conforme al concepto de peligrosidad. Entre los resultados destacaba que en un 42% de los casos no se justificaba ningún tipo de comportamiento peligroso. Los autores llamaban la atención sobre la necesidad de analizar de forma empírica los criterios utilizados en las evaluaciones.

Tal como hemos resumido en el anterior periodo histórico, en estas primeras décadas la capacidad de los profesionales de la salud mental para predecir la conducta violenta era puesta en entredicho por tres motivos (Monahan, 1981): 1) porque la predicción exacta por parte de profesionales de la salud mental era imposible; 2) porque la predicción de la violencia y el internamiento preventivo fundamentado en una conducta futura podía violar derechos civiles; y 3) porque la predicción de la violencia y la consecuente intervención para evitarla contravenían el rol asistencial de las profesiones sanitarias.

El caso de Thomas Barefoot (véase recurso 2) puede considerarse un hito en la historia de la evaluación del riesgo de violencia, tal como distintas revisiones señalan (Conroy y Murrie, 2007; Costanzo y Krauss, 2012; Monahan, 2013). En Barefoot vs. Estelle (1983), la Corte Suprema de EEUU.

Recurso 2

El caso Barefoot (Barefoot vs. Estelle, 1983)

La Corte Suprema de EEUU admite como prueba el testimonio de dos psiquiatras acerca de la peligrosidad en un caso de pena de muerte

Thomas Andy Barefoot fue condenado a la pena capital por el asesinato de un policía. El estado en el que se le juzgó (Texas) requería, y sigue requiriendo, que el jurado responda a dos preguntas a fin de condenar al acusado a muerte:

1. Si la conducta que causó la muerte fue cometida deliberadamente y con expectativas razonables de que la muerte del fallecido o de otra persona tendría lugar.
2. Si hay probabilidad de que el acusado cometa actos delictivos violentos que constituyan una amenaza constante para la sociedad.

Para complementar las pruebas respecto a la segunda cuestión se solicitó la opinión de dos psiquiatras (James Grigson —apodado Dr. Muerte— y John Halbrook), quienes respondieron a hipotéticas preguntas sin haber evaluado personalmente al acusado. Ambos psiquiatras afirmaron que el acusado probablemente continuaría cometiendo actos violentos y que representaba una amenaza constante para la sociedad. De hecho, entre las valoraciones los profesionales indicaron lo siguiente:

- Dr. Holbrook: diagnosticó a Barefoot, «dentro de un grado razonable de certeza», como un «sociópata criminal». Declaró que él no conocía ningún tratamiento que pudiera cambiar esta condición y que dicha condición no podría cambiar a mejor sino que «podría llegar a exacerbarse» en los próximos años. Por último, el doctor Holbrook declaró que, «dentro de una certeza psiquiátrica razonable», había «una probabilidad de que Thomas A. Barefoot en ese hipotético futuro cometería actos delictivos violentos, que podrían constituir una amenaza constante para la sociedad», y que su opinión no cambiaría si la «sociedad» en cuestión fuese aquella de dentro de las prisiones de Texas en lugar de la sociedad fuera de la cárcel.
- Dr. Grigson: describió a Barefoot «dentro de una certeza psiquiátrica razonable» como una persona con «un trastorno de la personalidad sociopático bastante clásico y típico» y lo colocó en la categoría «más grave» de los sociopatas (en una escala del uno al diez, Barefoot estaba «por encima de diez»). Declaró que no había cura conocida para su condición. Por último, el doctor Grigson testificó que tanto si Barefoot estaba en la sociedad en general o en una sociedad penitenciaria había una probabilidad del «cien por cien y absoluta» de que cometería futuros actos delictivos violentos que constituirían una amenaza continua para la sociedad.

La situación fue tal que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 1983) llegó a presentar un *amicus curiae* (información presentada por un tercero ajeno a un litigio sobre algún apartado de interés en el proceso) indicando que las predicciones de psiquiatras sobre la peligrosidad eran notoriamente imprecisas, erróneas dos de cada tres veces (Conroy y Murrie, 2007).

El *amicus curiae* señalaba: «[la] falta de fiabilidad de las predicciones psiquiátricas de peligrosidad futura a largo plazo es por ahora un hecho establecido dentro de la profesión». Citando el trabajo de Monahan (1981), sobre la capacidad predictiva del juicio clínico, recordaban que: «la “mejor” investigación clínica existente en la actualidad indica que psiquiatras y psicólogos son precisos en no más de una de cada tres predicciones de la conducta violenta». El acusado también presentó un recurso por inconstitucionalidad del proceso con los siguientes argumentos (entre otros):

«[...] el uso de los psiquiatras en las vistas para sentencia condenatoria para hacer predicciones sobre la conducta futura del solicitante es inconstitucional porque los psiquiatras, en forma individual y como colectivo, no son competentes para predecir la peligrosidad futura. Por tanto, sus predicciones son tan propensas a producir veredictos erróneos que su uso viola la Octava y la Decimocuarta enmienda».

También se alegó que:

«[...] permitir respuestas a preguntas hipotéticas por parte de psiquiatras que no han evaluado personalmente al solicitante es un error constitucional».

La Corte de Apelación desestimó el recurso respondiendo:

- Carece de fundamento el argumento del solicitante de que los psiquiatras, de forma individual o como grupo, son incompetentes para predecir, con un grado aceptable de fiabilidad, que un delincuente concreto cometerá otros delitos en el futuro y, por tanto, supone un riesgo para la comunidad [...].
- La declaración psiquiátrica no necesita fundamentarse en la evaluación personal del defendido, sino que puede emitirse de forma adecuada en respuesta a preguntas hipotéticas [...].
- No estamos más convencidos ahora [que en el caso Estelle vs. Smith, en el que se desestimó una apreciación similar] de que el punto de vista de la APA debiera convertirse en una norma constitucional que prohíba una categoría completa de testimonios expertos.
- El *amicus curiae* no sugiere que no haya otros puntos de vista sostenidos por miembros de la Asociación [APA] o de la profesión en general. De hecho, como este y otros casos indican, existen doctores médicos que están bastante dispuestos a testificar en la vista para sentencia, que piensan y dirán que saben de lo que están hablando y que están expresamente en desacuerdo con el punto de vista de la Asociación [APA].

consideró constitucional utilizar las predicciones clínicas para determinar quién era apto para ser condenado a la pena de muerte, con independencia de los resultados que indicaban la baja fiabilidad de estas opiniones (Monahan, 2013). Pese a la oposición y crítica de la propia Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 1982), el «ojo clínico» era aceptado a nivel jurídico, incluso sin existir una evaluación directa del acusado (véase Heilbrun, 2009; Shuman y Darwin-Looney, 2008). Posiblemente, este descrédito del juicio clínico motivó la adhesión de muchos investigadores y profesionales a las técnicas actuariales durante las siguientes décadas, llegándose a afirmar que estas debían sustituir al juicio clínico, eliminándolo del proceso.

Los trabajos de Monahan —por ejemplo *Predicting violent behavior: An assessment of clinical techniques*, de 1981— impulsaron el interés por la predicción de la violencia. De hecho, el autor fue el primero en revisar la precisión de las predicciones clínicas, concluyendo que psiquiatras y psicólogos acertaban en no más de una de cada tres predicciones (Monahan, 1981).

En el contexto forense, Menzies, Webster y Sepejak (1985) propusieron una herramienta psicométrica de 15 ítems (en su versión original estaba compuesta por 22) para valorar la peligrosidad, la

Dangerous Behavior Rating Scheme. Las conclusiones derivadas de la evaluación de 215 casos en un servicio forense de Toronto no fueron positivas. Los autores sugirieron una serie de indicaciones a tener en cuenta en la evaluación del riesgo. En primer lugar, no se trataría de una cuestión médica, y personas con formación específica en el procedimiento podían alcanzar niveles de predicción similares a los de psiquiatras. Además, las opiniones deberían ser recomendaciones y no valoraciones deterministas. Las valoraciones sobre la peligrosidad de un sujeto no se deberían dar en contextos donde el resultado tuviera implicaciones restrictivas, como puede ser un internamiento, debido a la limitada capacidad predictiva de los sistemas disponibles. Las estimaciones eran más fiables a corto plazo y para aquellos casos más extremos (tanto de riesgo bajo como alto).

Steadman (1983) describió la amplia difusión de las predicciones en ámbitos tan dispares como la economía, la psicología, la física o incluso en la astrología (por ejemplo, con la lectura de manos). La credibilidad de dichas predicciones residía, según el autor, en la madurez de la disciplina más que en la precisión de las mismas. La evolución de la predicción por parte de psiquiatras simplemente correspondía a la atribución de dicha capacidad,

sin haberlo demostrado, por ser los profesionales que dirigían las instituciones psiquiátricas en las que las personas podían ser internadas a causa de su supuesta peligrosidad. El autor discutía si esta predicción podía considerarse medicina o magia. En primer lugar, describía como fe en el profesional la capacidad de prognosis atribuida, lo que en el contexto de la violencia se entiende por predicción. Por otro lado, el propio concepto de peligrosidad era un artefacto jurídico sobre el que no existían conexiones claras con variables del paciente. En este punto es donde el autor definía la metodología como magia. Por otro lado, se señalaba la falta de interés por realizar seguimientos y estudios empíricos para contrastar la fiabilidad de las predicciones psiquiátricas y que, en los pocos casos en los que se realizaban estos estudios, los datos mostraban una capacidad similar a la del azar, aspectos ya señalados por Monahan (1981).

Mulvey y Lidz (1984) analizaron aspectos relacionados con la evaluación clínica de la peligrosidad en pacientes psiquiátricos, afirmando que no existía ningún factor con suficiente validez predictiva como para fundamentarnos únicamente en su valoración. Sin embargo, las variables situacionales y familiares se señalaban como muy relevantes en la comprensión del inicio y mantenimiento de la conducta violenta. Respecto al proceso de predicción, era necesario delimitar de forma clara qué se quería predecir, se sugería el uso de información estadística como punto de partida (como la tasa base de ocurrencia del fenómeno a predecir) y se recordaba que el proceso de predicción se podía mejorar tomando en cuenta tanto a la persona como el contexto o la situación en la que estaría la persona evaluada.

Wormith y Goldstone (1984) pusieron a prueba las propiedades de una herramienta denominada *Recidivism Prediction Scheme* (RPS), desarrollada en Canadá y de tipo actuarial (predicción matemática a través de 15 variables ponderadas que categorizaban a los sujetos según su puntuación en cinco grupos de riesgo). Entre los hallazgos, se constató la poca fiabilidad en los procesos de recolección de información y codificación de las variables, que mejoraba cuando se ofrecían

criterios de valoración detallados. Por otro lado, encontraron que la incorporación de información clínica a la predicción actuarial del RPS no mejoraba la validez predictiva. Este hallazgo es interesante, pues, como veremos a lo largo del libro, distintos estudios han encontrado también lo contrario, que la incorporación de información estadística no mejora la predicción clínica.

Monahan (1988), partiendo de las limitaciones en la materia argumentadas por él mismo en una revisión previa (Monahan, 1984), valoró el progreso en la evaluación del riesgo de violencia en pacientes psiquiátricos. Sus conclusiones eran que, pese a ciertos progresos metodológicos, aún era necesario mejorar aspectos relacionados con los predictores, como la variedad de factores, el desarrollo de nuevas herramientas, el etiquetado correcto del paciente según criterios DSM o el análisis de variables situacionales. Otra limitación era el resultado a predecir, para lo que proponía el uso de la hospitalización por motivos violentos (además de los delitos ya utilizados), incluir autoinformes de violencia e informes de personas allegadas y hacer evaluaciones continuas en distintos períodos temporales. Un último problema era el hecho de que los investigadores no fuesen sincronizados, por lo que los resultados no aportaban respuestas a las dudas ya existentes.

Aadland y Schag (1984) revisaron los factores de riesgo tenidos en cuenta para considerar peligrosos a los delincuentes y mantenerlos en programas de intervención. Encontraron que aquellos que eran puestos en libertad con más frecuencia contaban con apoyo, estaban motivados para el cambio, reconocían sus problemas y los abordaban de forma adecuada en la terapia y no tenían un diagnóstico de trastorno psicótico. Con esto, los autores identificaron las variables a partir de las cuales los clínicos estimaban la peligrosidad de un sujeto, y confirmaron que las variables clínicas predominaban en estos juicios y que variables posiblemente con más relación empírica eran excluidas.

Smith y Monastersky (1986) evaluaron el riesgo de reincidencia en 112 agresores sexuales juveniles varones y concluyeron que la predicción era mala. Entre las razones se mencionaba la baja

prevalencia de reincidencia sexual. Por otro lado, el criterio utilizado (registro oficial) siempre es más restrictivo y da como resultado menos aciertos. El seguimiento (17 meses) también era breve, por lo que muchos simplemente no habían tenido tiempo aún de reincidir. Además, muchos delinquentes simplemente habrían modificado sus variables por el tratamiento y la supervisión, por lo que la cualidad dinámica del riesgo empeoraba la capacidad predictiva de las estimaciones. Otro aspecto relevante era el hecho de que el acceso a información relevante para la predicción fuese limitado y que, por tanto, los profesionales simplemente se fundamentaran en los datos disponibles para sus estimaciones. Además, el conocimiento sobre subtipos de agresores sexuales juveniles era escaso, resultando evidente que no se podía juzgar con las mismas variables a sujetos muy diferentes tanto personalmente como en su tipo de violencia. Por último, información muy importante referente al contexto en el que se producían las agresiones muchas veces tampoco estaba disponible. La valoración del riesgo iba asociada a cierto tipo de gestión, por lo que los profesionales tomaban una postura más conservadora y la mayoría de los errores hacían referencia a falsos positivos. Por último, la precisión de la predicción dependía de la fiabilidad de las fuentes de información, y el uso de criterios actuariales mejoraba la predicción clínica.

Miller y Morris (1988) ofrecieron una serie de motivos por los que la predicción de la peligrosidad, en especial en el contexto jurídico, se debía usar con cautela o de forma limitada. Revisaron distintas sentencias que evidenciaban las limitaciones del uso de la metodología y apoyaban su argumento en los estudios empíricos de la época, que ponían en duda la capacidad de los profesionales para hacer predicciones acertadas. En especial, se hacía hincapié en problemas relacionados con la confianza en la fiabilidad del criterio de profesionales de la psiquiatría o la psicología en procesos judiciales en los que era necesario usar pruebas y no conjeturas. El uso del concepto «peligrosidad» también estaba asociado a sesgos del sistema no apoyados en datos, por ejemplo para

minorías raciales. En definitiva, se presentaba un dilema ético al aceptar el uso de sistemas estadísticos o actuariales y la necesidad de reflexionar sobre el balance entre restricciones de las libertades individuales y el riesgo para la comunidad. Los autores concluían afirmando:

«mientras que nuestros sistemas de justicia penal y de salud mental no pueden funcionar sin predicciones de la peligrosidad, las personas en estos sistemas deben tener en cuenta que inherente al propio concepto existe una verdadera amenaza tanto a la libertad individual como al control eficaz del delito» (p. 281).

De no aplicarse una serie de principios éticos y científicos, concluían, la extensión del uso de la evaluación de la peligrosidad será una amenaza al sistema judicial.

Otros trabajos de la época analizaban aspectos como la influencia del engaño o la simulación por parte de los evaluados (Hall, 1982). De la misma década datan manuales, en los que no nos detendremos, como los de Hinton (1983) desde una perspectiva psicológica, el multidisciplinar de Dutile y Foust (1985) o el compendio de trabajos dirigido por Farrington y Tarling (1985).

1.8. De 1990 a la actualidad

La década de 1990, salvo los matices concretos que analizaremos más adelante, corresponde a la época actual en lo que respecta al enfoque de la evaluación del riesgo, uso de herramientas y metodología vigente. De esta época se presenta como pionero y precursor el trabajo de Hare, sobre psicopatía, que dio lugar a la *Psychopathy Checklist-Revised* —PCL-R— (Hare, 1991) y sus versiones derivadas, la versión de cribado PCL:SV (Hart et al., 1995) y la versión para adolescentes PCL:YV (Forth, Kosson y Hare, 2003). Este es el punto de vista, en especial, del contexto canadiense (Bloom et al., 2005), aunque como ya hemos comprobado en los apartados anteriores la base de toda la metodología encuentra sus orígenes muchas décadas atrás.

En la década de los noventa también encontramos el cisma entre los autores, que daría origen al enfrentamiento entre los métodos actuariales y las guías de juicio clínico estructurado. Inicialmente ambas metodologías compartieron espacio y se presentaron de forma complementaria en el manual *The violence prediction scheme. Assessing dangerousness in high risk men* (Webster, Harris, Rice, Cormier y Quinsey, 1994), conocido como el *Libro rosa* por el color de su portada. En él se proponía un sistema de evaluación que combinaba ambas metodologías. La primera parte del proceso era actuarial, proponiendo el uso de la *Risk Assessment Guide* (de 12 factores), y la segunda parte era clínica, con 10 factores que permitían al profesional modificar el riesgo actuarial. Este fue el fundamento de las mundialmente conocidas HCR-20 (para la predicción estructurada) y VRAG (para la predicción actuarial), que a partir de entonces serían las representantes del enfrentamiento entre modelos y seguirían caminos separados.

En lo referente a investigaciones, el foco de atención comenzó a centrarse en el análisis empírico de la relación entre trastornos mentales y violencia (por ejemplo, Monahan y Steadman, 1994; Prins, 1999), junto a la proliferación de manuales sobre la evaluación del riesgo con análisis más técnicos, que incluían propuestas de instrumentos (por ejemplo, Campbell, 1995; Quinsey, Harris, Rice y Cormier, 1998), y en especial la disputa entre los modelos actuariales y los de juicio clínico estructurado (disputa aún vigente).

Monahan (1996) señalaba que la metodología utilizada para dar respuesta a la predicción de la conducta violenta en las dos décadas anteriores era diferente, así como las conclusiones que obtenían los investigadores. Además, pronosticaba que en 20 años (lo que equivaldría a la actualidad) las cuestiones legales y las metodologías utilizadas serían probablemente diferentes. Como el lector podrá comprobar, estas predicciones fueron acertadas, y en la actualidad somos testigos de nuevos aportes, metodologías y usos de instrumentos, así como cambios en los paradigmas fundamentales de la evaluación del riesgo (como

es el caso del paso de la predicción a la gestión que analizaremos más adelante).

Quinsey et al. (1998), en su revisión de la situación histórica de la evaluación del riesgo, señalaron la sensación de repetición en la forma en que la sociedad afronta la delincuencia violenta, ciclos que se repiten en parte por la ausencia de constancia en los trabajos empíricos sobre la reducción del riesgo en delincuentes y por el hecho de que la evaluación y gestión de los delincuentes esté impulsada principalmente por ideologías y modas. Sirva como ejemplo de esta situación la derogación en España de la *Doctrina Parot*, como consecuencia de una resolución del tribunal de derechos humanos de Estrasburgo en 2013. La Doctrina Parot, en esencia, supuso un hábito de interpretación de la ley (utilizado por primera vez en 2006 con Henri Parot, un terrorista de ETA), que implicaba que la reducción de la pena por beneficios penitenciarios ya no se aplicaba sobre la condena máxima legal en España (30 años), sino sobre cada una de las condenas del sentenciado. Como resultado, terroristas y otros delincuentes graves (en especial violadores en serie) cumplían condenas superiores a las legamente establecidas (para una revisión véase Ríos y Sáez, 2014). La resolución generó una enorme alarma social y la solicitud de cambios legales en caliente, sin tener en cuenta que las consecuencias que se producían al poner en libertad a delincuentes de alto riesgo habían sido desatendidas en muchos casos durante más de 20 años (los que llevaban algunos de los implicados en prisión). Transcurridos pocos meses de la puesta en libertad de algunos de los agresores sexuales, muchos de ellos reincidieron en el mismo delito. En relación a esta respuesta social y política situacional y reaccionaria, cíclica y muchas veces ideológica, resultan de interés los trabajos de Redondo (2009) y Larrauri (2007).

Debido a que el volumen de material disponible a partir de esta década hace inasumible su resumen en este capítulo (el resto del libro irá abordando las distintas cuestiones que han surgido y que rigen el debate en la actualidad), en la tabla 3.2 se presenta un breve resumen de los principales hitos desde 1990.

TABLA 3.2
Principales aportes en la evaluación del riesgo de violencia desde 1990

1990-1999	
Inicio de la división entre herramientas actuariales y guías de juicio profesional estructurado.	— En 1991 Hare publica la primera edición de la PCL-R, para la evaluación de la psicopatía, considerada por muchos la precursora de las herramientas para la valoración del riesgo de violencia. — Las técnicas actuariales son las protagonistas, surgidas como solución a los criticados métodos clínicos. Referentes entre las herramientas actuariales son la VRAG (Harris, Rice y Quinsey, 1993), la SORAG (Quinsey et al., 1998) y el STATIC-99 (Hanson y Thornton, 1999). — En la misma década comienzan a desarrollarse las guías de juicio estructurado, con la HCR-20 (Webster, Eaves, Douglas y Wintrup, 1995) como principal referente, aunque también surgió en la época la SARA (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1995) y el SVR-20 (Boer et al., 1997). — Se publica la primera herramienta para la valoración del riesgo en menores, la EARL-20B, para chicos (Augimeri, Koegl, Webster y Levene, 1998).
2000-2009	
La argumentada poca eficacia aplicada de las herramientas actuariales promueve la evolución y mejora de las herramientas de juicio estructurado desarrolladas en la década anterior, con la inclusión de nuevos pasos, tipos de violencia específicos y consideración de factores de protección.	— Nuevas herramientas para la evaluación del riesgo en menores, como el SAVRY (Borum, Bartel y Forth, 2002, 2006), el YLS/CMI (Hoge, Andrews y Leschied, 2002) y la primera específica para niñas, la EARL-21G (Levene et al., 2001). — Se publican dos herramientas para valorar el riesgo de violencia en el contexto laboral, la ERA-20 (Bloom, Webster y Eisen, 2002) y la WRA-20 (Bloom, Eisen, Pollock y Webster, 2000). — 2003. El foco de atención se centra en la gestión del riesgo, principalmente con el desarrollo del RSVP (Hart et al., 2003), un protocolo de juicio estructurado para la violencia sexual. — 2004. Se publica la primera herramienta plenamente dinámica y que toma en consideración la tratabilidad del sujeto, la START (Webster et al., 2004). — 2008. Se publica la SAM (Kropp, Hart y Lyon, 2008), primera guía de juicio estructurado para valorar el riesgo de acoso. — 2009. Se publica el SAPROF (de Vogel, de Ruiter, Bouman y de Vries-Robbé, 2009), primer instrumento que evalúa específicamente factores protectores (en 2012, 2.ª ed.). — 2009. Se publica la primera herramienta para valorar el riesgo de violencia extremista, llamada VERA (Pressman, 2009). También la SRP (MacKenzie et al., 2009) para el acoso.

TABLA 3.2. (continuación)

2010-2016	
Avance en los objetivos de la metodología y especificidad de las herramientas.	2010. Se publica la segunda versión de la B-SAFER (Kropp, Hart y Belfrage, 2010), que incorpora cinco factores de riesgo de la víctima, la versión para adolescentes de la START (Nicholls, Viljoen, Cruise, Desmarais y Webster, 2010) y el manual de la WAVR-21 (White y Meloy, 2010) para la valoración del riesgo en contextos laborales, superando las limitaciones de sus predecesoras en la ERA-20 y la WRA-20. 2011. Se publica la ERG 22+, herramienta para valorar la violencia extremista. 2012. Se publica el FAM, primer complemento para la evaluación del riesgo de violencia específicamente en mujeres adultas (de Vogel, de Vries-Robbé et al., 2012), un avance en las perspectivas del estudio de la violencia. 2013. Se publica la HCR-20^{V3} (Douglas et al., 2013), con modificaciones relevantes fruto de la evolución en la metodología y los resultados desde 1995. Se incluye la formulación como paso en la evaluación. 2015. Se propone un protocolo para valorar la radicalización terrorista, el TRAP-18 (Meloy, Roshdi, Glaz-Ocik y Hoffmann, 2015). Se publica la SAPROF:YV (de Vries Robbé, Geers, Stapel, Hilterman y de Vogel, 2015) para la evaluación de factores protectores en menores. 2016. Se publica la SARA-V3 (Kropp y Hart, 2016), que modifica factores de riesgo presentes en versiones previas y añade seis ítems referentes a la víctima siguiendo la línea del B-SAFER v2. Se publica la revisión de la SVR-20 para la violencia sexual.

1.8.1. Generaciones de herramientas

La evolución de la metodología ha sido descrita por algunos autores como *generaciones de herramientas* (por ejemplo, Andrews y Bonta, 2010; Andrews, Bonta y Wormith, 2006; Conroy y Murrie, 2007; Esbec, 2003; Monahan, 1984; Otto, 1992; Wong, Olver y Stockdale, 2009):

- *Primera generación:* se trataría del juicio profesional no estructurado, el denominado «ojo clínico». Su precisión sería muy limitada, por el uso de criterios no formales (no observables) y por prestar atención

a características del delincuente que no tienen una relación empírica con la conducta delictiva (Andrews y Bonta, 2010).

- *Segunda generación:* incluye instrumentos para la valoración del riesgo derivados de la investigación empírica, pero compuestos esencialmente por ítems estáticos. Pertenecen a este grupo herramientas como la VRAG (Harris et al., 1993), la SORAG (Quinsey et al., 1998) o el Static-99 (Hanson y Thornton, 1999). Poseen una buena capacidad predictiva comparados con la primera generación. Su principal problema es que no informan sobre la modificación

del riesgo en el sujeto ni los objetivos de intervención.

- *Tercera generación:* suponen el uso mixto de factores estáticos y dinámicos. Su principal orientación está unida a la rehabilitación y control del sujeto, en línea con los principios de riesgo, necesidad y responsividad (categorización de niveles de riesgo para ajustar las intervenciones). En la tercera generación de herramientas, la evaluación y categorización sustituye a la predicción propia de la segunda generación, «[...] los delincuentes particulares se hacen más “conocibles” (y por tanto más controlables), aunque no necesariamente más predecibles» (Kemshall, 2003, p. 54). Las herramientas combinan métodos actuariales (para estimar la probabilidad de un posible riesgo) con técnicas de entrevista (que permiten una mayor atención a factores dinámicos) (Kemshall, 2008). Un ejemplo sería el *Level of Service Inventory-Revised* (LSI-R; Andrews y Bonta, 1995).
- *Cuarta generación:* la evolución de las herramientas en la cuarta generación se dio hacia el enfoque multifactorial, la consideración del impacto de dichos factores y el posible resultado de los planes de gestión (Kemshall, 2008). También se ha señalado como la cuarta generación la de las herramientas denominadas árboles de clasificación (Stalans, Yarnold, Seng, Olson y Repp, 2004), un enfoque que se fundamenta en las teorías de toma de decisiones y fomenta la elección entre distintas posibilidades de forma sistemática y basada en la evidencia (Kemshall, 2008).

1.8.2. Situación actual

Debido a la extensión de la metodología, tanto entre países como entre distintos tipos de profesiones (psicología, psiquiatría, criminología, enfermería, trabajo social, policía, etc.), una de las fuentes de información sobre el uso

de la metodología y las herramientas han sido las encuestas. Hurducas, Singh, de Ruiter y Pettilä (2014) revisaron las encuestas disponibles sobre el uso de la evaluación del riesgo entre enero del año 2000 y enero de 2013, con un total de nueve trabajos relacionados. Como resulta habitual, también en la bibliografía, las herramientas más utilizadas o referenciadas eran la HCR-20 y la PCL-R, y los contextos de estudio Reino Unido y Estados Unidos. Ninguna encuesta comparaba las prácticas entre continentes ni la utilidad percibida de los instrumentos en la gestión del riesgo.

Para resolver parte de las limitaciones, recientemente se desarrolló una encuesta internacional que demostró que la utilización de herramientas en la evaluación del riesgo de violencia está absolutamente extendida a nivel mundial (Singh, Desmarais, Hurducas et al., 2014). Pese a estimarse que existen más de 200 instrumentos comercializados y otros 200 desarrollados por instituciones, 12 serían las herramientas más utilizadas, liderando esta lista la HCR-20, seguida de la PCL-R y la PCL:SV (no es de extrañar, por ser la PCL y sus derivados pionera en este ámbito y porque la HCR-20 incluía hasta su tercera versión el ítem psicopatía, que requiere la aplicación de la PCL-R o la PCL:SV). Por otro lado, las mejor valoradas fueron la HCR-20, la HKT-30, la FOTRES, la START y la SAPROF. Al margen de esta extensión y globalización, hay regiones en las que aún es poco frecuente el uso de herramientas (frente al juicio no estructurado), como Latinoamérica o Asia (Singh, Desmarais, Hurducas et al., 2014). Al analizar 46 profesionales encuestados en Argentina y Chile (Singh, Condemarin y Folino, 2013), los resultados indicaban que tanto psiquiatras como psicólogos y trabajadores sociales utilizan herramientas para evaluar el riesgo y que la HCR-20 era la más utilizada en estos países. Como datos llamativos, cabría destacar que la mitad de las evaluaciones del riesgo se siguen haciendo sin herramientas (utilizando el *ojo clínico*) y que la utilización de herramientas distintas a las principales es muy prevalente (por lo que se requieren

más evidencias sobre fiabilidad y aplicación de estos protocolos). Respecto a los 40 profesionales encuestados en España (Arbach et al., 2015), la mayoría eran psicólogos y las herramientas más aplicadas eran la HCR-20 y la PCL-R, aunque la mejor percibida era el LSI-R. Por otro lado, en la mayoría de los casos la utilización de las herramientas no es un requisito en su trabajo y cuando se aplican no existe un seguimiento del caso (ni por tanto un *feedback* sobre la adecuación de las estimaciones o propuestas de gestión). El lector interesado en esta encuesta internacional puede encontrar una monografía reciente en la que se abordan los resultados en detalle y con matices por países (Singh, Bjørkly y Fazel, 2016). En el contexto latinoamericano, además, se he constatado la escasez de profesionales que utilizan la metodología, así como una lenta difusión de los conocimientos (Goldstein, James y Folino, 2015). Existe una escasa publicación en español, y algunas de las necesidades actuales en el contexto latinoamericano son la sistematización de la práctica, el desarrollo de programas y la creación de bases de datos.

En conjunto, de este tipo de encuestas se deduce la necesidad de más investigación sobre el *feedback* que reciben los profesionales encargados de las evaluaciones del riesgo y el conocimiento sobre la implementación de los planes de gestión del riesgo propuestos tras la evaluación, así como estudios sobre la generalizabilidad de los resultados para distintos contextos y la extensión de la formación para profesionales.

2. DE LA PELIGROSIDAD AL RIESGO

Uno de los principales aspectos que se debe analizar al revisar la evaluación del riesgo de violencia es la diferencia entre peligrosidad y riesgo. La evolución en materia de riesgo ha supuesto el paso del concepto «peligrosidad» al de «riesgo» (Harrison, 2011). Ambos conceptos presentan diferencias significativas, en especial respecto a sus implicaciones, tal como describimos a continuación.

Peligrosidad

Se trata de una categoría habitual en el ámbito jurídico, que hace referencia, entre otras cosas, a la propensión de una persona a actuar de forma violenta o peligrosa. Su origen puede considerarse clínico, derivado de la asociación entre una enfermedad mental y la violencia, incluso similar a las ya superadas postulaciones lombrosianas respecto a los rasgos fisionómicos del hombre o la mujer delincuente, o las teorías de Ferri o Garofalo sobre la *pericolosità*. La peligrosidad puede equipararse a un estado mental patológico, a un atributo disposicional inmodificable o a un predictor de la violencia único. Es un tipo de decisión basada en un juicio clínico no estructurado, con las siguientes características:

- *Discreta*: es dicotómica, se es o no se es peligroso, no hay una graduación ni niveles.
- *Estática*: no es modificable, se es peligroso para siempre.
- *Genérica*: es inespecífica, no se relaciona con un tipo de conducta y no permite distinguir entre tipos de violencia.

Uno de los problemas del concepto de peligrosidad, además, es su significado polisémico según la disciplina que lo utilice: estado mental patológico para la clínica-forense, o reiteración delictiva y posibilidad de reincidencia en la tradición jurídica (Andrés-Pueyo, 2013). El concepto se considera insuficiente e impreciso y no ofrece garantías jurídicas en la toma de decisión por parte de los profesionales (Andrés-Pueyo y Arbach, 2014), al no seguir ningún procedimiento delimitado.

Riesgo

La evaluación del riesgo, por el contrario, no supone la toma de una decisión arbitraria y no estructurada, sino que es el resultado de la relación empírica entre determinados predictores

(factores de riesgo) y conductas específicas (tipos de violencia). El pronóstico está fundamentado en la aplicación de protocolos contrastados, no en una opinión individual. El concepto de riesgo, por tanto, hace referencia a un constructo:

- *Continuo*: es una dimensión, que va de menor a mayor riesgo.
- *Variable*: es un valor modificable, que cambia con el tiempo conforme cambian las características del sujeto o las circunstancias del caso.
- *Específico*: se valora para un tipo de conducta, un tipo de violencia, un tipo de víctima, etc.

A lo largo del manual nos referiremos a este concepto, tanto para los métodos actuariales como para el juicio profesional estructurado. Comprender la diferencia entre riesgo y peligrosidad no solo tiene un interés semántico. En la diferencia entre ambas reside la esencia de la evaluación del riesgo, que es dar una opinión con fundamento empírico y siguiendo los pasos establecidos en una guía o herramienta. El sujeto peligroso lo es para cualquier delito, para cualquier víctima y para siempre. Sin embargo, un sujeto con un determinado nivel de riesgo puede requerir una mayor o menor atención o gestión del riesgo según el momento.

El cambio de paradigma ha supuesto el uso cada vez más extendido del concepto de riesgo, pese a que en el ámbito jurídico el discurso sobre el delincuente peligroso sigue siendo predominante, en especial en relación al imputable (véanse Armaza, 2013; Caruso, 2014; Demetrio y Maroto, 2013; Landa-Gorostiza, 2014; Martínez, 2014). Sin ir más lejos, en 2014 el Consejo de Europa redactó una recomendación relativa al abordaje de los denominados delincuentes peligrosos (Council of Europe, 2014); y la reciente modificación del código penal español, en 2015, también hace alusión a la peligrosidad, por ejemplo, en la aplicación de la prisión permanente revisable.

3. DE LA PREDICCIÓN A LA GESTIÓN

Junto al cambio en la terminología, de la peligrosidad al riesgo, la evolución del objetivo central de la metodología es otro de los aspectos clave del estado actual de la evaluación del riesgo. Teniendo en cuenta el rumbo actual de la metodología, podríamos establecer de forma figurada dos polos en la evolución histórica del procedimiento, tal como se ilustra en la figura 3.1. Ambos polos representarían la transición de la predicción a la gestión.

En los orígenes de la metodología, los esfuerzos se centraban en la anticipación o previsión de una conducta futura, en concreto un tipo específico de violencia. Esta previsión o predicción era, a priori, neutra; es decir, no implicaba o establecía ninguna actuación posterior a la evaluación por parte del profesional. En la actualidad, y en especial a partir del desarrollo del RSVP (Hart et al., 2003), podríamos afirmar que el objetivo no es la predicción (al menos en un sentido estadístico o matemático y en el modelo de juicio clínico estructurado), sino la facilitación de la toma de decisiones al profesional encargado de evaluar el riesgo, con el objetivo último de poner los medios necesarios para prevenir, evitar o minimizar la posible conducta futura. Esto se ha hecho patente en la reciente publicación de la HCR-20^{V3} (Douglas et al., 2013), donde se ensalza este objetivo.

A este objetivo preventivo se le conoce como gestión del riesgo (véase capítulo 7, apartado 5); podríamos afirmar que se ubica entre la predicción matemática (actuarial) y la intervención clínica. En esencia, no interesaría solo saber si el riesgo de reincidencia es alto o bajo (estimación), sino intervenir para reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Este cambio de perspectiva metodológica ha tenido consecuencias tanto para la investigación como para la práctica profesional. En el ámbito de la investigación han surgido diversos problemas, como el hecho de valorar la eficacia de las herramientas cuando se interviene sobre el agresor, cosa que afecta a los aciertos en la predicción. Por tanto, hemos pasado de centrarnos en la eficacia predictiva de un

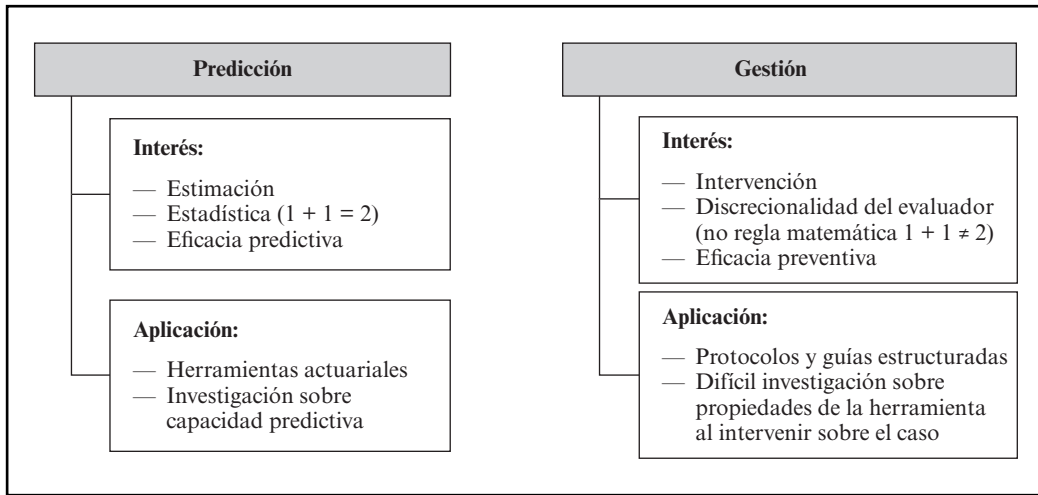


Figura 3.1.—Evolución de los objetivos de la evaluación del riesgo de violencia.

instrumento (con cuestiones que abordaremos en el capítulo 5) a intentar valorar la capacidad preventiva del procedimiento o, lo que es lo mismo, la medida en que somos capaces de evitar o reducir los daños con la evaluación del riesgo.

Además, aunque sigue vigente el modelo actuarial, que supone la aplicación de reglas matemáticas en las estimaciones del riesgo (con ítems ponderados y sumatorios), ha tomado mucha fuerza el modelo que trata de devolver la capacidad de decisión al evaluador tras la aplicación de las herramientas. Es evidente que esta evolución tiene pros y contras. El principal beneficio radica en centrar la atención en la prevención y, por tanto, dotar a la metodología de un objetivo más

concreto y útil para los implicados, principalmente para las víctimas. Sin embargo, la discrecionalidad del evaluador supone una gran limitación. El hecho de que el evaluador pueda contribuir con su opinión final al margen de rangos numéricos, como veremos en otros apartados, puede ser un problema. Este hándicap es evidente cuando quien realiza la evaluación no está suficientemente formado o se aplican las técnicas sin los conocimientos necesarios sobre la evaluación del riesgo o sobre el tipo de violencia concreto que se analiza. Otro riesgo añadido sería el hecho de que la «opinión» del evaluador o sus recomendaciones de actuación no se adecúen a la realidad.

Factores relevantes en la evaluación del riesgo

4

Cuenta la fábula que un escorpión quería pasar un río y pidió ayuda a una rana. El escorpión dijo —Amiga rana, no sé nadar, ¿podrías ayudarme a cruzar el río llevándome sobre tu lomo?—. La rana, alarmada, respondió —¡No!, si te llevase a mi espalda me picarías y moriría—. A lo que el escorpión replicó —No seas tonta, si te picase te hundirías y yo lo haría contigo—. La rana, entonces, se lo replanteó y accedió a ayudarlo. Ambos comenzaron a cruzar el río, pero cuando estaban a mitad de camino el escorpión picó a la rana. La rana, al darse cuenta, le preguntó —¿Por qué lo has hecho? ¿No te das cuenta de que te vas a hundir conmigo y tú también vas a morir?—. El escorpión respondió —No lo he podido evitar, es mi naturaleza.

El reputado biólogo y entomólogo Edward O. Wilson, en su libro *La conquista social de la tierra* (Wilson, 2012), utiliza la fábula de la rana y el escorpión para adentrarse en el lado oscuro de la naturaleza humana, el mismo que nos lleva sin exclusividad entre épocas y culturas a las guerras y los genocidios, el mismo que nos ha permitido socializar y ser altruistas. La moraleja de la fábula es que la naturaleza humana, en ocasiones, es tan fuerte que es capaz de hacernos actuar en contra de nuestros intereses, llegando a perjudicarnos como lo hizo el escorpión. Otras lecturas posibles serían la incapacidad de alterar lo que somos o incluso el determinismo —incapacidad de actuar de forma distinta a la que se supone que deberíamos—. En el debate criminológico aún siguen vigentes los enfrentamientos entre posturas a favor de una naturaleza humana mala (visión de Hobbes) y las posturas partidarias de una naturaleza humana buena (visión de Rousseau), a las que hemos añadido posturas más empíricas y menos deterministas, como la ya mencionada visión de

Zimbardo (2008), partidario de que todos somos capaces de cometer hechos atroces según las variables contextuales a las que nos expongamos, dando, por tanto, relevancia a los factores situacionales que pueden dirigir nuestra acción y no a rasgos innatos que determinan nuestro futuro.

Aunque parezca extremo y caricaturesco, para muchos profesionales dedicados a la violencia interpersonal será fácil traer a la memoria casos de víctimas, generalmente femeninas, que retoman o inician una relación de pareja con un agresor, generalmente varón, que ha tenido previamente problemas de violencia de pareja (bien sea con o sin condena). Las víctimas muchas veces confían en que la persona ha cambiado o incluso en que ellas serán capaces de hacerle cambiar. El fin de la historia, con frecuencia, es trágico y nos recuerda a la fábula: en el mejor de los casos, la mujer termina siendo agredida y el agresor condenado; en el peor, la víctima es asesinada.

Este problema no solo es una fuente de discusión de la población en general (¿puede cambiar

un agresor?, ¿lo volverá a hacer?, ¿por qué una mujer vuelve con quien le ha pegado?). Esta realidad ha llevado a la aprobación de leyes destinadas al control de agresores/delincuentes o a la protección de las víctimas o posibles víctimas, cuya intención es combatir esta idea de naturaleza humana inmutable (dicho de otro modo, esa propensión a la reincidencia de determinados delincuentes), como los registros de pederastas (véase recurso 3). Por ejemplo, en 2014 Reino Unido aprobó una ley conocida como *Ley Clare*, que se deriva de un caso sucedido en Inglaterra en el que una mujer de 36 años (Clare Wood) fue asesinada por su expareja, un chico al que conoció a través de Facebook y que contaba con antecedentes por violencia contra mujeres, habiendo sido condenado a tres años de prisión por acosar a una pareja anterior y a otros seis meses por quebrantar una orden de alejamiento contra otra expareja. La ley permite comprobar el historial delictivo de una persona con la que se tiene una relación o que tiene una relación con una persona allegada y de la que se teme que pueda estar en una situación de abuso.

Este tipo de casos no son anecdóticos. De hecho, en España, en agosto de 2015, atendimos conmovidos a la noticia del asesinato de dos jóvenes a manos de la expareja de una de ellas (Sergio Morante), quien huyó a Rumanía tras los hechos (donde finalmente fue detenido). El agresor

había sido condenado a tres años de prisión por secuestro y vejaciones a una expareja anterior, así como, con posterioridad a dicha estancia en prisión, a una condena de un año (que no cumplió) por posesión de pornografía infantil. El desenlace fatal y la presencia de antecedentes en el agresor facilitan el hecho de que nos preguntemos si una ley como la de Reino Unido sería necesaria y deseable en nuestro contexto, o si habría sido útil para evitar lo ocurrido.

La metodología de evaluación del riesgo de violencia va más allá de determinismos y estereotipos. No se centra en un único aspecto definitorio del agresor, ni siquiera en su conducta pasada como determinante de su conducta futura. Por el contrario, se evalúan sistemáticamente distintos factores relacionados empíricamente con el tipo de violencia analizado, y a través de esta evaluación se obtienen resultados numéricos (relacionados con niveles de riesgo o cifras de reincidencia) o categorías de riesgo (bajo, medio o alto, por ejemplo) orientadas a una intervención específica (véase capítulo 7).

A continuación analizaremos qué factores y de qué tipo se relacionan con la violencia, aspecto esencial de la evaluación del riesgo. En concreto describiremos tres bloques: los factores de riesgo y los de protección; los factores estáticos y los dinámicos; y los factores motivadores, desinhibidores y desestabilizadores.

Recurso 3	Leyes derivadas de casos llamativos
	Ley Clare Clare Wood, de 36 años, fue asesinada en febrero de 2009 por su expareja, George Appelton. El agresor, al que había conocido en Internet, contaba con antecedentes por violencia contra parejas anteriores, incluyendo una condena a tres años de prisión por acosar a una y otros 6 meses de condena por quebrantar una orden de alejamiento contra otra. Pese a que la víctima había señalado a la policía que Appelton le había agredido, acosado e incluso había abusado sexualmente de ella, finalmente la estranguló y se ahorcó. La campaña, llevada a cabo por el padre de Clare, hizo que el Reino Unido aprobara una ley llamada <i>Domestic Violence Disclosure Scheme</i> (traducible como plan de divulgación o información en violencia doméstica), conocida como <i>Ley Clare</i>, que se puso en marcha en marzo de 2014. La ley permite comprobar el historial delictivo de una persona con la que se tiene una relación o que tiene una relación con una persona allegada y de la que se teme que pueda estar en una situación de abuso. En esencia, da respuesta al <i>derecho a preguntar</i> (por parte de posibles víctimas y personas cercanas) y el <i>derecho a conocer</i> (que supone informar por parte de la policía a víctimas potenciales que consideren que están en riesgo). La

ley establece el protocolo a seguir en caso de detección de una situación de riesgo, e incluso en los casos en los que se decida no informar, frente a una solicitud del tipo «derecho a conocer», se promueve que la policía oriente y dé soporte a la persona que solicita la información. En mayo de 2015 el gobierno de Nueva Gales del Sur (Australia) sacaba a debate público el pilotaje de una ley *Domestic Violence Disclosure Scheme* propia.

Ley Sarah

Se propuso tras el asesinato de Sarah Payne en el año 2000 por un pederasta fichado. Entró en vigor en Inglaterra y Gales el 4 de abril de 2011, permitiendo el acceso a Registros de Delincuentes Sexuales solicitando a la policía la verificación del posible riesgo de personas que tengan contacto con niños y niñas. Si la persona sobre la que se solicita información tiene antecedentes por delitos sexuales contra niños, o supone un riesgo de causar daño, la policía puede informar a los padres, tutores o cuidadores que han solicitado la información. En su primer año de aplicación la policía había recibido 1.600 solicitudes de información, de las que 160 tenían relación con delitos sexuales y 58 con otros tipos de delitos (www.gob.uk, 4 abril 2012).

Ley Jacob Wetterling

Jacob Wetterling, de 11 años, fue secuestrado en 1989 en Minnesota, pero hasta el 4 de septiembre de 2016 no se resolvió el caso (tras la confesión de su secuestrador y asesino y la aparición de los restos mortales). Cuatro meses después del secuestro, sus padres, Jerry y Patty Wetterling, formaron la Fundación Jacob Wetterling, un grupo en defensa de la seguridad de los niños. En 1994, la «Ley Jacob Wetterling de Crímenes contra Niños y de Registro de Delincuentes Sexuales», conocida como la Ley Jacob Wetterling, fue aprobada en su honor. Fue la primera ley en establecer recomendaciones para los estados de EEUU respecto al registro de delincuentes sexuales. La ley ha sido modificada varias veces; la más conocida de las reformas ha sido la denominada Ley Megan en 1996.

Ley Megan

Se trata de una enmienda de la ley Wetterling. La Ley Megan lleva el nombre en recuerdo de Megan Nicole Kanka, una niña de siete años de Nueva Jersey, que fue violada y asesinada en 1994 por un conocido delincuente sexual registrado. El agresor se había mudado enfrente de la casa de la familia sin el conocimiento de estos. Los padres de la niña crearon una fundación (<http://www.megannicolekankafoundation.org>) centrada en el derecho a conocer la residencia y las mudanzas de delincuentes sexuales para proteger a los niños. La ley tiene efecto en todos los estados de EEUU y, en esencia, obliga a los estados a notificar a la sociedad (de la forma en que cada estado considere más adecuada) si un delincuente sexual reside en la zona. Permite proporcionar información específica acerca de las personas que están obligadas a registrarse como delincuentes sexuales en California. La información proviene de una base policial estatal y es de acceso público online.

Ley Walsh

Adam Walsh, de seis años, fue secuestrado en un centro comercial de Florida el 27 de julio de 1981. Dos semanas después apareció su cadáver. Los padres del chico se han dedicado desde entonces a la protección de la infancia. La Ley Adam Walsh de protección y seguridad de los niños (*Adam Walsh Child Protection and Safety Act*) es una ley que entró en vigor en julio de 2006. La ley clasifica a los delincuentes sexuales en tres niveles, de acuerdo al delito cometido, regulando la obligatoriedad de actualización de la información en los registros. El nivel más grave (3) requiere la actualización cada tres meses de por vida; en el nivel 2, el delincuente debe actualizar su paradero cada seis meses durante 25 años; en el nivel 1, la actualización se realiza cada año durante un período de 15 años. El no cumplimiento de estos plazos es un delito. Además, los estados hacen pública la información de los niveles 2 y 3.

Ley Pam Lychner

Pam Lychner era una agente inmobiliaria de Texas que sufrió un intento de violación por un agresor sexual de menores que ya había sido condenado previamente y que estaba en libertad condicional dedicándose a la limpieza de casas. Aunque fue condenado a 20 años, a los dos años volvió a ser puesto en libertad. En aquel momento, Pam, junto a dos mujeres, creó una fundación llamada «Justicia para Todos» e inició su campaña en búsqueda de una ley que protegiera a las víctimas. Pam falleció en 1996, en un accidente de aviación, tras lo cual se aprobó la «Ley de seguimiento e identificación de delincuentes sexuales Pam Lychner». Establece una base de seguimiento y control por parte del FBI de delincuentes sexuales puestos en libertad en estados en los que la base de delincuentes sexuales no cuente con los mínimos requeridos. Además, modifica los plazos de seguimiento.

1. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN

La primera distinción que se puede establecer a la hora de describir las variables relacionadas con el riesgo de violencia es diferenciar entre aquellas que lo incrementan y aquellas que pueden reducir la probabilidad de que una persona actúe de forma violenta o vuelva a delinquir. Los primeros serían factores de riesgo y los segundos factores de protección.

1.1. Factores de riesgo

Un factor de riesgo es una característica del sujeto, o circunstancia que le rodea, que está asociada con una mayor probabilidad de conducta delictiva (Andrews y Bonta, 2010) o que incrementa la posibilidad de su ocurrencia. Por tanto, este tipo de variables son las descritas como predictores de la violencia y son las que en la investigación han mostrado una correlación positiva con el resultado a predecir. La investigación sobre factores de riesgo es muy variada, siendo múltiples los factores predictores descritos en los distintos tipos delictivos. Cogniciones, actitudes, estilo de vida, drogas y trastorno mental (como veíamos en el capítulo 2), o las relaciones sociales y familiares, entre otros muchos, son factores de riesgo descritos habitualmente en la bibliografía criminológica.

Los factores de riesgo relacionados con la motivación delictiva se han denominado necesidades criminógenas y, como veremos en el punto 4.2,

son factores de riesgo dinámicos y modificables. Los cambios en este tipo de factores modifican la probabilidad de delinquir o agredir. Por el contrario, los cambios producidos en necesidades no criminógenas no tienen por qué producir este efecto. Sin embargo, también es cierto que centrarnos en necesidades no criminógenas, pero que sean relevantes para el sujeto, puede promover la motivación para participar en el tratamiento.

Los factores de riesgo son la principal fuente de información a la hora de gestionar la reincidencia o la violencia y, además, están relacionados con las diferencias en los perfiles de agresor y en las carreras delictivas (Loinaz, 2013a).

1.2. Factores de protección

Entre las posibles limitaciones de los procedimientos de valoración del riesgo se ha señalado su excesiva focalización en factores y características individuales que incrementan el riesgo, sin prestar atención a posibles factores protectores o que reduzcan el riesgo (de Ruiter y Nicholls, 2011; Desmarais, Nicholls, Wilson y Brink, 2012; Hart, 2008). Uno de los aportes recientes en la evaluación del riesgo y en el estudio de los factores relacionados con la delincuencia y la violencia ha sido la toma en consideración de factores protectores, es decir, aquellos que distancian de la comisión de conductas delictivas o violentas. La evaluación de factores protectores se ha propuesto como un complemento de mejora a la habitual evaluación del riesgo. El punto de partida es que,

al igual que existen variables que incrementan la probabilidad de que una persona se vea implicada en conductas violentas o delictivas, existen factores que alejan a las personas de estas conductas y que, por tanto, reducen su reincidencia.

Llamados también fortalezas, estos factores son características de la persona, o sus circunstancias, que están relacionadas con una reducción en la probabilidad de conducta delictiva. Por ejemplo, las actitudes frente a la violencia pueden ser contrarias a esta, neutras o favorables. Si las contrarias están relacionadas con una menor delincuencia que las neutras, entonces son variables protectoras. Si están relacionadas con una mayor delincuencia, entonces son de riesgo (véase Andrews y Bonta, 2010, p. 23). En algunos casos hablamos de factores específicamente protectores (como puede ser un estilo de personalidad), pero en la mayoría de casos nos referimos a un mismo factor, cuyo exceso, defecto, presencia o ausencia supondrá un factor de riesgo o de protección (por ejemplo, la presencia de empatía es un factor protector, mientras que su ausencia es un factor de riesgo).

Así pues, una de las principales novedades en el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia es el desarrollo de herramientas que evalúan factores protectores que pueden influir en la evaluación y gestión del riesgo, como la *Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk* (SAPROF; de Vogel et al., 2009; de Vogel, de Ruiter, Bouman y de Vries-Robbé, 2012), que también dispone de versión para adolescentes (SAPROF-YV; de Vries Robbé et al., 2015). Asimismo, algunas escalas de riesgo incluyen entre sus ítems, o en la forma de puntuarlos, factores protectores. Este es el caso del SAVRY (*Structured Assessment of Violence Risk in Youth*; Borum, 2006) o el IORNS (*Inventory of Offender Risk, Needs and Strengths*; Miller, 2006).

Un caso especial que responde a la señalada posible ambivalencia de los factores es la START (Webster et al., 2004, 2009). Esta herramienta, y su versión para adolescentes —START:AV— (Desmarais, Sellers et al., 2012; Viljoen, Beneteau et al., 2012), contempla la opción de que el mismo factor sea de riesgo o de protección. El objetivo

de escalas que solo evalúan factores protectores es complementar a las herramientas de predicción del riesgo de violencia que solo consideran factores de riesgo, ofreciendo predicciones más precisas (de Vogel, de Vries-Robbé, de Ruiter y Bouman, 2011). Por otro lado, las escalas que incluyen ambos tipos de factores, o la opción de que el mismo factor sea de riesgo o de protección, buscan un mejor equilibrio entre variables y una visión más completa del sujeto.

Los factores protectores pueden incrementarse con el tratamiento, y se ha encontrado una fuerte correlación entre estos factores y una menor reincidencia violenta (de Vries-Robbé, de Vogel y de Spa, 2011). Así pues, escalas como la SAPROF pueden resultar de utilidad en el diseño y la evaluación de programas de intervención. Una línea de interés relacionada con este aspecto sería el estudio de casos de alto riesgo que, tras ser puestos en libertad, no reinciden (de Ruiter y Nicholls, 2011). ¿Qué variables están presentes y pueden haber influido en su no-reincidencia?, ¿son factores que compiten con el riesgo?, ¿qué hace que frente a la misma presencia de factores de riesgo unos sujetos reincidan y otros no? Estas son algunas de las cuestiones pendientes de respuesta. Otra cuestión sin resolver es la forma en que se combinan ambos tipos de factores, pues se trata de una relación cualitativa y más cercana al caso único (lo que en evaluación del riesgo se describe como perspectiva «idiográfica», específica del caso) que a explicaciones globales y genéricas (perspectiva «nomotética», basada en datos grupales) (véase DeMatteo, Batastini, Foster y Hunt, 2010; Scurich, Monahan y John, 2012, para un análisis de esta cuestión).

CLAVE 5.

Perspectiva idiográfica y nomotética

La perspectiva idiográfica es aquella dedicada al análisis del caso único o combinación específica de factores en una persona concreta.

La perspectiva nomotética utiliza datos grupales para sacar conclusiones o deducciones globales de un tipo de conducta o caso.

Algunos ejemplos de factores de protección serían la motivación para el cambio, la adherencia al tratamiento, la red social, el soporte familiar, los planes de futuro, la vinculación laboral, las habilidades laborales y la supervisión externa. Sin embargo, como hemos señalado, muchos factores pueden ser de riesgo o de protección, según se manifiesten en el sujeto.

2. FACTORES DE RIESGO ESTÁTICOS Y DINÁMICOS

La forma más habitual de clasificar los factores de riesgo es según su estabilidad temporal (Mills, Kroner y Morgan, 2011; Olver y Wong, 2011; Waisanen y Ackerman, 2010; Wong et al., 2009). Así, diferenciaríamos los factores estáticos (a priori factores estables en el tiempo) de los dinámicos (modificables, bien por el paso del tiempo o por algún tipo de intervención externa), tal como se describe en la tabla 4.1.

Se afirma que ambos tipos de factores son las caras de una misma moneda. Mientras que los factores dinámicos valoran la medida en que el comportamiento vigente del sujeto es disfuncional, los factores estáticos evalúan la presencia de indicadores históricos sobre el comportamiento disfuncional del sujeto y estilo de vida delictivo (Wong et al., 2009).

2.1. Factores estáticos

Los factores de riesgo estáticos son, por definición (aunque con cautela, como indicaremos a continuación), inmodificables, por lo que la gestión a través de programas de tratamiento, por ejemplo, no tendrá un efecto en la reducción del nivel de riesgo y de intervención requerido. Estos factores hacen alusión a variables del pasado del sujeto (como la edad de comisión del primer delito) o a variables idiosincrásicas del mismo (ser varón), todas ellas inmodificables por definición.

Atender a factores estáticos supone fijarnos en lo que la persona *es*, de manera irremediable (por ejemplo, varón), o *era* (su pasado), en contra de lo que la persona es en el momento actual, representado por factores dinámicos (Wong et al., 2009). Los factores estáticos o históricos pueden ser buenos predictores de la conducta futura, pero no son los más relevantes. Estos factores no nos indican nada sobre la situación o el funcionamiento actual de la persona, aspectos que pueden ser precursores de la conducta violenta e indicadores de cambio. Por tanto, la predicción se enfrentaría al tratamiento.

Al igual que en la fábula de la rana y el escorpión (con la moraleja de que este no pudo actuar de otra forma porque esa era su naturaleza), popularmente se piensa que el «mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada», del

TABLA 4.1
Factores de riesgo estáticos y dinámicos

Dinámicos	Estáticos
Factores modificables con la intervención o el paso del tiempo. Hacen que el riesgo sea variable. Factores: – Afrontamiento del estrés. – Soporte social. – Distorsiones cognitivas. – Actitudes/creencias. – Adicción/consumo de sustancias. – Trastorno mental. – Etc.	Son principalmente inmodificables, aunque su estado puede variar, por ejemplo, con la disponibilidad de nueva información. Factores: – Edad de comisión del delito. – Antecedentes delictivos. – Abusos en la infancia. – Historia de trastorno mental. – Etc.

mismo modo en que se tiende a afirmar que «las personas no cambian» (en especial cuando la persona es un delincuente). Sin embargo, esto no es cierto desde el punto de vista empírico. Tal como señalan Hart et al. (2003, p. 38):

«Es fácil sobreestimar la utilidad de conductas pasadas como predictoras del comportamiento futuro, [pero si estas] fuesen tan buen predictor no habría necesidad de evaluar el riesgo: asumiríamos que toda persona sin historia de violencia [...] no cometería estos actos en el futuro y que toda persona que ha cometido violencia [...] en el pasado continuará haciéndolo. [...] nuestro modelo predictivo, por tanto, sería incorrecto para todos los delincuentes violentos: todos, en algún momento de su vida, aún no han cometido violencia [...] y, por tanto, la predicción de que nunca lo harían habría sido incorrecta; y en todos, una vez cometida una agresión [...], se predeciría que iban a reincidir.»

Sea cual sea el carácter del factor de riesgo, la recomendación es actualizar la información disponible sobre el mismo. El fundamento para ello es que, incluso los factores de riesgo estáticos, como el historial delictivo, pueden cambiar con el paso del tiempo, bien como resultado de cambios reales en la historia de la persona (por ejemplo, nuevas condenas) o por cambios en la información disponible (por ejemplo, surgimiento de nuevos datos referentes al historial delictivo) (Hart et al., 2003). Esta variabilidad de ambos tipos de factores de riesgo requerirá la reevaluación del caso con mayor o menor celeridad, según distintos criterios. Lo dicho sería especialmente relevante para aquellos factores relacionados con el historial delictivo del sujeto: edad de comisión del primer delito, antecedentes penales o delictivos, agresiones previas, quebrantamientos, etc. Por tanto, como norma general, asumiremos que, pese a ser denominados factores estáticos, estos pueden cambiar. Asimismo, es más lógico esperar que cambien de consideración de ausentes a presentes (por ejemplo, por la disponibilidad de nuevos datos).

En agresores de pareja, serían factores de riesgo estáticos la edad en el primer delito —ser joven—,

la violencia en la familia de origen, la conducta antisocial pasada —incluida la agresión generalizada y la delincuencia no violenta—, la agresión previa a la pareja y los trastornos de la personalidad o psicológicos graves (Loinaz, 2011). En agresores sexuales se relacionan con la reincidencia sexual la menor edad en la comisión del delito, un mayor número de delitos específicos y generales previos, la versatilidad delictiva, la violencia en los delitos, la escalada en la gravedad de los delitos, la presencia de víctimas desconocidas, la psicopatología grave o los ingresos psiquiátricos, acciones excéntricas, parafilias y perfil psicopático (factor 1) (Redondo, Luque, Navarro y Martínez, 2005; Redondo, Pérez y Martínez, 2007).

2.2. Factores dinámicos

Se describen como factores de riesgo dinámicos aquellos que a todas luces son modificables. Estos factores pueden cambiar por la respuesta a un tratamiento o intervención, o conforme pasa el tiempo o cambia el contexto. Además, son los que otorgan al concepto de riesgo, frente al de peligrosidad, su cualidad de variable (modificable, dinámico). Por ejemplo, el consumo o abuso de sustancias puede ser un factor de riesgo para distintas conductas delictivas. La persona, en un momento dado, puede tener un nivel de adicción problemático, pero, bien por su evolución personal o por el sometimiento a un tratamiento, puede dejar de presentar este problema. Lo mismo ocurriría con otras variables, como determinados síntomas o trastornos psicológicos.

Los factores de riesgo dinámicos se relacionan directamente con el paradigma de la intervención, el tratamiento y la gestión del riesgo, promoviendo incluso la evolución de métodos actuariales, típicamente estáticos, a procedimientos actuariales-dinámicos (véase Mills et al., 2011). Asimismo, se afirma que la motivación delictiva está integrada por factores dinámicos modificables (Redondo, 2008). Por tanto, el tratamiento de delincuentes debería centrarse en este tipo de factores dinámicos que, mediante su modifica-

ción, pueden alterar la motivación del sujeto para agredir o delinquir.

Los factores dinámicos pueden ser bastante comunes entre distintos tipos de agresores. Por ejemplo, la ira, las distorsiones cognitivas y actitudes machistas o favorables a la violencia, el consumo de sustancias, la dependencia emocional y algunos problemas psicológicos son frecuentes en agresores de pareja (Loinaz, 2011). En agresores sexuales, se indican como factores de riesgo de reincidencia la negación/racionalización, una baja motivación para el tratamiento, poca competencia personal, cogniciones, valores, pares y hábitos delictivos, consumo de drogas, preferencia por estímulos desviados, bajo control y perfil psicopático (factor 2) (Redondo et al., 2005; 2007).

2.3. Modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad

Un pilar criminológico fundamental para el tratamiento diferencial de agresores (Loinaz, 2011, 2013a,b), que toma en cuenta lo dinámico del riesgo, es el modelo de Andrews y Bonta *Riesgo-Necesidad-Responsividad* —RNR— (véase Andrews y Bonta, 2010; Andrews, Bonta y Wormith, 2011). Los tres principios hacen referencia a dimensiones relevantes en la evaluación y tratamiento de delincuentes:

- El principio de *riesgo* establece que la intensidad de la intervención se debe ajustar al riesgo de reincidencia del sujeto.
- El principio de *necesidad* pone de manifiesto la importancia de atender a las denominadas necesidades criminógenas, es decir, aquellas variables que impulsan al sujeto a delinquir. La clave sería atender a las necesidades propias de cada sujeto.
- El principio de *responsividad* señala que cada sujeto presenta capacidades diferentes de respuesta al tratamiento y que estas deben ser tenidas en cuenta para ajustar la intervención.

El principio de riesgo se centraría en la protección y la reducción de la reincidencia, y el de responsividad en cómo se aplican las intervenciones para aumentar su efectividad (Farrow, Kelly y Wilkinson, 2007). La adhesión a estos principios ha demostrado tener un efecto positivo en la reducción de la reincidencia para distintos tipos de delitos, incluidos los violentos (Olver y Wong, 2011).

3. FACTORES DE RIESGO SEGÚN SU INFLUENCIA

Una cuestión clave a la hora de analizar los factores relacionados con la conducta delictiva y/o violenta es la descripción de roles causales o posibles vías de influencia que expliquen o determinen el comportamiento. Sin embargo, estas relaciones causales son difíciles de establecer en un comportamiento complejo y multicausal como es la violencia. A continuación describiremos la posible agrupación de los factores de riesgo según su influencia en las esferas cognitivas, emocionales o conductuales. Debemos tener presente que un mismo factor de riesgo puede ejercer los tres tipos de influencia, tal como se muestra en la figura 4.1.

Los factores de riesgo pueden clasificarse en tres tipos (Watt, 2012):

1. **Motivadores:** son aquellos que dirigen la conducta hacia la violencia e incrementan la percepción de ganancias. En esencia, bajo circunstancias normales percibimos la conducta delictiva con un valor/beneficio concreto respecto a lo que nos puede aportar. Bajo el efecto de factores motivadores, este valor se incrementa y somos más propensos a actuar de forma violenta o delictiva para obtener dichos beneficios. Por tanto, percibimos más ganancias derivadas de la violencia o la delincuencia que otras personas o de lo que percibimos nosotros mismos de forma habitual. Entre los factores que aumentan la percepción

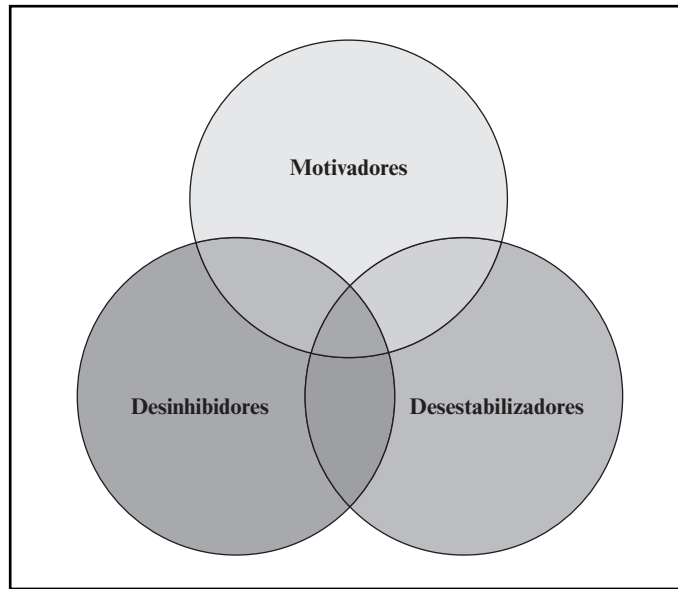


Figura 4.1.—Factores de riesgo según su influencia.

de beneficios de la violencia se encuentran:

- Justicia/honor.
- Ganancia/beneficio (aspectos concretos como el dinero).
- Estatus/estima.
- Poder/control.
- Defensa/distanciamiento.
- Expresión/liberación.
- Activación (*arousal*)
- Proximidad/afiliación.

2. **Desinhibidores:** estos factores facilitan la toma de decisión de actuar de forma violenta, reduciendo la percepción de costes y superando los posibles inhibidores o barreras que tenga el sujeto. En estado «normal» la persona tiene una serie de límites que frenan su conducta. Los factores desinhibidores favorecen la conducta delictiva/violenta al reducir o bloquear los posibles frenos. Por ejemplo, se afirma que haber actuado de forma violenta con

anterioridad es un factor de riesgo, por implicar la superación de las barreras sociales y límites propios. Entre los factores desinhibidores se podrían incluir:

- Actitudes negativas.
- Autoconcepto negativo.
- Alienación (como pérdida del sentimiento de propia identidad).
- Nihilismo (negación de todo principio religioso, político y social).
- Ausencia de culpa.
- Ausencia de ansiedad.
- Ausencia de *insight* (autopercepción o conciencia de uno mismo y sus estados)
- Ausencia de empatía.

3. **Desestabilizadores:** estos factores interfieren en la normal toma de decisiones del sujeto, es decir, en su forma habitual de razonar. El sujeto, en su día a día, puede ser capaz de controlar su conducta y actuar conforme a las normas. Los factores desestabilizadores alteran este patrón ha-

bitual, favoreciendo la aparición de conductas delictivas o violentas. Posibles alteraciones que causan una afectación de la toma de decisiones cuidadosas son:

- Problema de atención.
- Problema de percepción.
- Afectación intelectual.
- Afectación de la memoria.
- Comportamiento impulsivo.
- Comportamiento inflexible.

Tal y como se analizará en el capítulo 7, a la hora de valorar el riesgo de violencia no solo debemos atender a la presencia o ausencia de determinados factores de riesgo o de protección. Tam-

bién es necesario atender a la conexión entre factores, a la relevancia de los mismos y al rol que ejercen en la conducta del sujeto. Esta clasificación de factores puede resultar de utilidad en este objetivo y corresponde al conocido como modelo de las 3Ds: *drivers* (motivadores), desestabilizadores y desinhibidores (Hart y Logan, 2011; Logan, 2014).

En la formulación del riesgo, como veremos, el profesional deberá unir todos sus conocimientos (prácticos y teóricos) y el conocimiento del caso evaluado, para combinar los factores de riesgo presentes y su influencia y así explicar la posible conducta futura, partiendo de lo ocurrido en el pasado y de las variables presentes.

Conceptos clave en la evaluación del riesgo de violencia

5

*Hacer predicciones es muy difícil,
especialmente cuando se trata del futuro.*

NIELS HENRIK DAVID BOHR
(Físico danés; 1885-1962)

Antes de adentrarnos en la parte práctica de la evaluación del riesgo es conveniente detenernos en un apartado algo más técnico, el dedicado a la terminología y los conceptos específicos. Aunque el capítulo pueda resultar muy técnico para algunos lectores, un aspecto fundamental de la evaluación del riesgo de violencia es la comprensión de la metodología y los conceptos utilizados tanto en la investigación como en la práctica diaria (Hilton, Harris y Rice, 2010; Quinsey et al., 1998). Esto puede ayudar al profesional a ser crítico con las herramientas y tener conocimientos suficientes para poder optar por la mejor alternativa para su evaluación.

En los siguientes apartados analizaremos conceptos de uso habitual en el ámbito de la evaluación del riesgo. Estos están presentes tanto en los estudios en la materia (algo que el lector deberá tener siempre presente para poder mantenerse actualizado) como en los manuales de aplicación de las distintas herramientas. Asimismo, la terminología se emplea casi inevitablemente en los procesos de información, asesoramiento y gestión del riesgo.

1. ACIERTOS Y ERRORES EN LA ESTIMACIÓN

La primera cuestión que se vincula a cualquier predicción del futuro es si esta es acertada o no. La evaluación del riesgo de violencia es una metodología con base científica. Por tanto, los conceptos utilizados para valorar los resultados o, mejor dicho, su precisión y adecuación, son algo diferentes a los comúnmente utilizados «acierto» y «error».

La forma habitual de presentar los resultados sobre predicción de eventos es mediante tablas de contingencia 2×2 (Andrés-Pueyo, 2009; Costanzo y Krauss, 2012). Las filas de la tabla corresponden a nuestra valoración: ¿supone un riesgo elevado el sujeto?, ¿estimamos que volverá a agredir?, ¿reincidirá? Las columnas corresponden a lo que realmente ha ocurrido, al resultado: ¿ha reincidido el sujeto?, ¿ha hecho lo que esperábamos?

En la tabla 5.1 se muestran las posibilidades existentes en los modelos de predicción. Las opciones incluyen, como es lógico, dos tipos de aciertos:

TABLA 5.1
Combinación de aciertos y errores en los modelos de predicción

		RESULTADO REAL (por ejemplo, reincidencia)	
		Sí	No
PREDICCIÓN (Riesgo estimado: por ejemplo, alto)	Sí	Acierto VERDADERO POSITIVO	Error FALSO POSITIVO
	No	Error FALSO NEGATIVO	Acierto VERDADERO NEGATIVO

- *Verdaderos positivos*: aciertos relacionados con la ocurrencia del evento (estimar que un sujeto reincidirá y confirmar que finalmente lo hace).
 - *Verdaderos negativos*: aciertos relacionados con la no ocurrencia del evento (estimar que un sujeto no reincidirá y confirmar que finalmente no lo hace).
- Sin embargo, para el ámbito de la evaluación del riesgo son aún más relevantes los dos tipos de error posibles:
- *Falsos positivos*: consisten en haber atribuido un resultado positivo (riesgo alto, reincidirá, enfermo) a un sujeto que finalmente no actúa en la dirección predicha (no reincide, sano). Puede ser denominado error tipo I o alfa.
 - *Falsos negativos*: consisten en haber estimado como negativa la ocurrencia del evento (riesgo bajo, no reincidirá, sano) en un sujeto cuyo resultado final es positivo (reincide, agrede, enfermo). Puede ser denominado error tipo II o beta.

Como el lector habrá podido anticipar, son especialmente relevantes y preocupantes los falsos

negativos, por el riesgo que suponen para la seguridad de distintas personas. Tal como analizaremos en la figura 5.2, los errores «asumibles» en materia de evaluación del riesgo son diferentes a los asumibles en otras disciplinas o metodologías. En este caso responden principalmente a cuestiones de seguridad y protección de posibles víctimas.

El cálculo de falsos positivos y falsos negativos está fundamentado en decisiones dicotómicas, algo que en muchos casos no es coherente ni con las herramientas aplicadas (que no determinan el resultado en dos categorías) ni con el resultado de la conducta humana, que, en el caso de la violencia, puede variar en su gravedad de forma dimensional. ¿Qué queremos estimar, cualquier agresión o una agresión con resultado de muerte? Distintos trabajos han encontrado diferencias según el tipo de resultado que se quiera estimar, existiendo herramientas que sobreestiman la violencia letal o que requieren determinados antecedentes para poder ser aplicadas de forma correcta (Storey y Hart, 2014; Watt, Storey y Hart, 2013).

El resultado objetivo que se suele utilizar en la investigación es la reincidencia oficial (ha reincidido, se le ha detenido o condenado). Sin embargo, el resultado que puede estar disponible es

mucho más heterogéneo, proveniente del autoinforme del evaluado, de la víctima o de un registro oficial: nueva agresión física, psicológica o sexual, nuevo comportamiento violento, presencia de un atestado, presencia de una denuncia. Junto a estos resultados relacionados con la violencia, se puede tomar como objetivo de una predicción otros indicadores, como el tipo de agresor o el abandono del tratamiento (por ejemplo, estimar la pertenencia de un sujeto a un subtipo de agresor según su puntuación en una herramienta; véase Loinaz, 2014b).

De hecho, existen distintos tipos de reincidencia (Luque, Ferrer y Capdevila, 2005), y bajo el mismo concepto se pueden incluir numerosas conductas o resultados, incluso dentro de la misma modalidad delictiva. Sirva como ejemplo el caso de la investigación sobre reincidencia en violencia contra la pareja, donde la definición de reincidencia se ha medido como la respuesta afirmativa a ítems de las escalas de agresión en herramientas como la CTS-2, una nueva condena, una detención o cualquier actividad policial o judicial con independencia del veredicto final (Loinaz, 2011). Por todo ello, la eficacia diagnóstica o capacidad predictiva de una herramienta (véase apartado 3) puede hacer alusión a distintos aspectos, según sea el objetivo de la aplicación de la herramienta.

2. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

Los aciertos y errores, a nivel estadístico y técnico, dan lugar a dos conceptos relevantes a la hora de valorar cuán buena es una metodología, una herramienta o una predicción: la *sensibilidad* y la *especificidad*, que hacen alusión a cuestiones de precisión en los aciertos positivos y aciertos negativos respectivamente. Ambos son igualmente aplicables a distintas ramas del conocimiento, como la capacidad diagnóstica de una prueba médica, la precisión de detección de un radar, etc.:

- *Sensibilidad*: una herramienta es *sensible* cuando es capaz de detectar correctamen-

te aquellos casos que *sí* cumplen con el criterio resultado, esto es, haber reincidido o vuelto a agredir (verdaderos positivos). Su cálculo se establece dividiendo el total de aciertos positivos entre el total de resultados positivos o reincidencias (o, lo que es lo mismo, suma de verdaderos positivos y falsos negativos). La sensibilidad también se llama fracción de verdaderos positivos.

- *Especificidad*: una herramienta es *específica* cuando es capaz de diferenciar aquellos casos que no cumplen con el criterio resultado, esto es, aquellos que no reinciden o no vuelven a agredir (verdaderos negativos). Su cálculo se establece dividiendo el total de verdaderos negativos (gente que no reincide) entre el total de no reincidentes (verdaderos negativos y falsos positivos). La especificidad también se llama fracción de verdaderos negativos.

La compensación entre ambos valores da como resultado la denominada eficacia diagnóstica o capacidad predictiva. En la tabla 5.2 se muestran las ecuaciones utilizadas para el cálculo de estos valores.

Junto a la sensibilidad, la especificidad y la eficacia diagnóstica, existen otros dos indicadores de interés para valorar las propiedades de una herramienta de predicción (Quinsey et al., 1998; Singh, 2013): el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo.

- *Valor predictivo positivo (VPP)*: proporción de casos positivos (que cumplen con el criterio resultado: enfermos, reincidentes, etc.) clasificados correctamente (verdaderos positivos) entre el total de sujetos etiquetados como positivos (enfermedad, riesgo alto).
- *Valor predictivo negativo (VPN)*: proporción de casos negativos (que no cumplen con el criterio resultado: sanos, no reincidentes, etc.) clasificados correctamente

TABLA 5.2
 Cálculo de la sensibilidad, la especificidad y la eficacia diagnóstica

Sensibilidad	$= \frac{VP}{VP + FN} \times 100 = \text{---} \%$
Especificidad	$= \frac{VN}{VN + FP} \times 100 = \text{---} \%$
Eficacia diagnóstica	$= \frac{VP + VN}{\text{Muestra total}} \times 100 = \text{---} \%$
Valor predictivo positivo	$= VPP = \frac{VP}{VP + FP} \times 100 = \text{---} \%$
Valor predictivo negativo	$= VPn = \frac{VN}{VN + FN} \times 100 = \text{---} \%$

NOTA: véase tabla 5.1 y figura 5.2 para una mejor comprensión de los conceptos.

(verdaderos negativos) entre el total de sujetos etiquetados como negativos (sanos, riesgo bajo).

Una diferencia de ambos valores respecto a la sensibilidad y la especificidad es que dependen de la prevalencia de la condición o criterio en la muestra analizada, no solo de la precisión de la herramienta (Zhou, Obuchowski y McClish, 2011). Así pues, al indicar el VPP y el VPN se recomienda señalar también la prevalencia del problema en la muestra de estudio (enfermedad o reincidencia, por ejemplo).

Tal como analizaremos en el siguiente apartado, se puede jugar con los valores en sensibilidad y especificidad para buscar el punto de corte que más se adecúe a nuestro objetivo. Sin embargo ambos conceptos siempre están contrapuestos, y la mejora de uno empeorará el otro (si queremos detectar más casos reincidentes —sensibilidad— lo haremos a costa de detectar peor aquellos que no reincidentes —especificidad—), por lo que la decisión final puede dejarse en manos de criterios estadísticos o de estrategias sociopolíticas (en especial en lo referente al interés mayor de la protección de la posible víctima frente al sospechoso).

3. CAPACIDAD PREDICTIVA O EFICACIA DIAGNÓSTICA

Como adelantábamos, de la combinación entre sensibilidad y especificidad surge la capacidad predictiva de una herramienta. Esta capacidad es la expresión numérica del total de clasificaciones correctas de una predicción; es decir, el total de aciertos (verdaderos positivos y verdaderos negativos). A nivel estadístico, la expresión y cálculo de esta capacidad o combinación se obtiene mediante las denominadas curvas ROC y su correspondiente área bajo la curva.

3.1. Curva ROC

ROC, acrónimo de *Receiver Operating Characteristic* o *Relative Operating Characteristic*, hace referencia a la representación gráfica de un sistema de clasificación. La técnica está ampliamente extendida en todo tipo de predicciones en medicina, psicología, marketing, meteorología, etc. Sus orígenes se remontan a la II Guerra Mundial en el análisis de señales de radar, apareciendo en la bi-

bliografía científica en la década de 1950 (Krzyszowski y Hand, 2009).

La curva ROC se calcula con la combinación de aciertos (verdaderos positivos; sensibilidad) y falsos positivos (1-especificidad) para cada uno de los posibles puntos de corte de la herramienta (Quinsey, Harris, Rice y Cormier, 2005). El resultado que se obtiene es un gráfico curvilíneo; de ahí que se denomine curva ROC. El eje vertical (sensibilidad) se busca que sea próximo a 1, mientras que el horizontal (1-especificidad) debe tender a 0 (véase figura 5.1).

CLAVE 6.

Interpretación de valores AUC (Rice y Harris, 2005)

AUC	<i>d</i>	<i>r_{bp}</i>	
0,556	0,2	0,1	Pequeño
0,639	0,5	0,24	Mediano
0,714	0,8	0,37	Grande

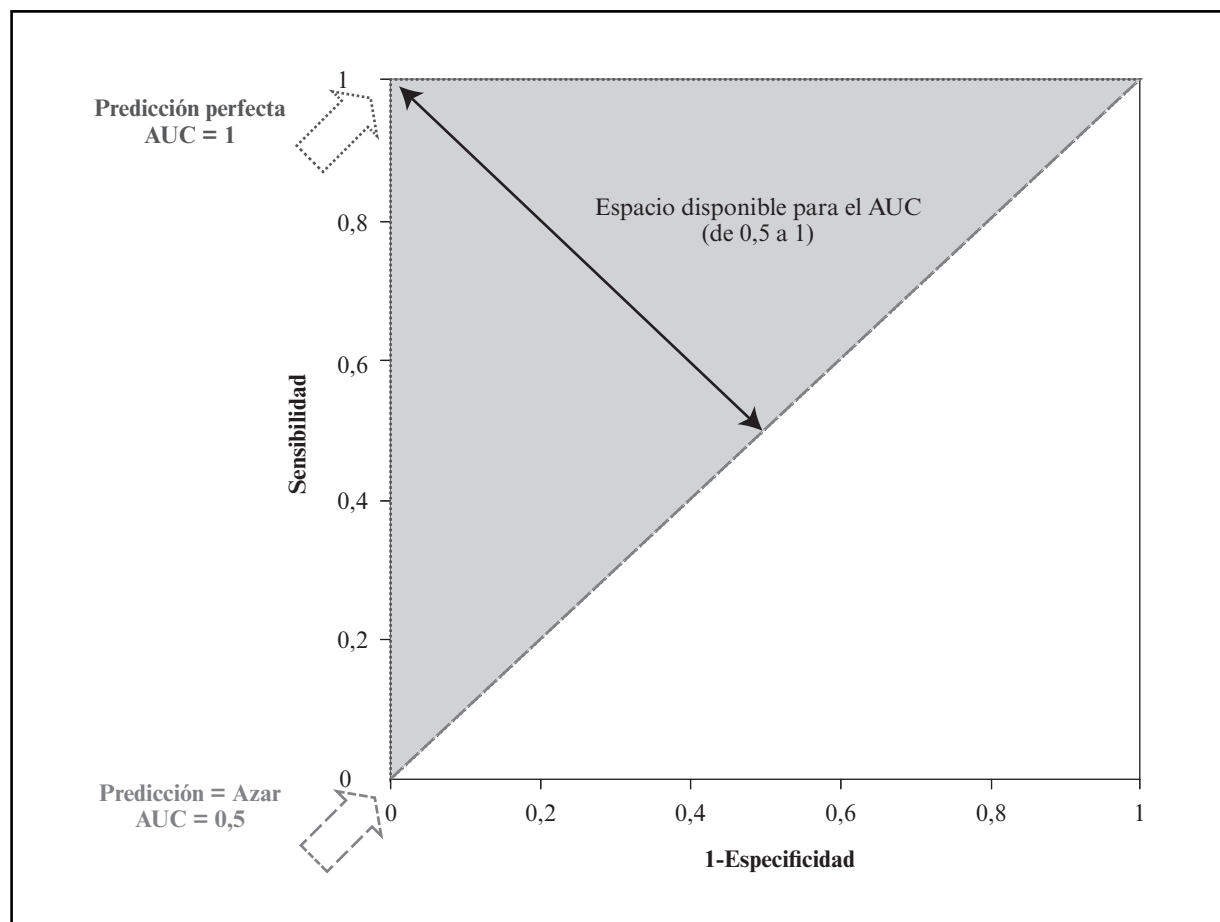


Figura 5.1.—Curva ROC y área bajo la curva (AUC).

Un aspecto íntimamente unido a las curvas ROC son los puntos de corte. Este tipo de análisis permite establecer el mejor punto de corte para una herramienta o técnica desde el punto de vista estadístico (en evaluación del riesgo, en psicometría, en análisis médicos, etc.), consiguiendo el mayor número posible de casos correctamente clasificados. En esta representación gráfica es donde aparece la denominada área bajo la curva (AUC), referencia que se utiliza para valorar la precisión de la medida.

3.2. AUC (área bajo la curva)¹

Tal como se presenta en la figura 4, el AUC (del inglés *Area Under the Curve*) equivale al espacio que queda entre el algoritmo de predicción (curva representada por los puntos de combinación sensibilidad/especificidad para cada valor de la herramienta) y el valor mínimo que equivale a una predicción hecha al azar (línea diagonal equivalente a un AUC = 0,5; probabilidad de acierto del 50%).

Una herramienta cuya capacidad predictiva fuese perfecta alcanzaría un valor AUC = 1, mientras que una herramienta cuya capacidad predictiva fuese equiparable a echar una moneda al aire obtendría un AUC = 0,5. Un criterio utilizado para valorar la mejora que supone la herramienta respecto al azar es el siguiente: $\leq 0,69$ capacidad marginal; 0,70-0,79 capacidad moderada; $\geq 0,8$ capacidad grande. Gorunescu (2011) propone unos criterios algo más precisos: 0,90-1 excelente; 0,80-0,90 buena; 0,70-0,80 regular; 0,60-0,70 pobre; y 0,50-0,60 mala. Para el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia, Rice y Harris (2005) describieron la correspondencia entre distintos valores estadísticos y propusieron los siguientes criterios para un AUC: baja hasta

0,556; media hasta 0,639 y grande a partir de 0,714 (véase clave 6).

De forma sencilla, el área bajo la curva puede describirse como la probabilidad de que, cogiendo dos casos al azar, el caso que cumpla con el criterio de referencia (por ejemplo, que sea reincidente o presente la enfermedad) puntúe más que el sujeto que no lo cumple (no reincidente o sano). Cuanto mayor sea el AUC mayor será la probabilidad de que la clasificación sea acertada.

Por ejemplo, un AUC = 0,80 significa que, cogidos dos sujetos al azar, hay una probabilidad del 80% de que un sujeto que cumpla el criterio diagnóstico (enfermedad, reincidencia, etc.) puntúe más que el que no cumple el criterio (sano, no reincidente, etc.). El valor AUC no equivale a la probabilidad de reincidencia del sujeto, solo a la mayor puntuación en la herramienta.

En la tabla 5.3 se muestra una serie de áreas bajo la curva obtenidas en distintos estudios sobre precisión de la evaluación del riesgo de violencia. El lector podrá comprobar, a partir de las definiciones ofrecidas en este capítulo, la capacidad de distintas herramientas para valorar distintos objetivos (violencia de pareja, violencia sexual y violencia inespecífica).

4. ODDS RATIO, RIESGO RELATIVO Y OTROS TAMAÑOS DEL EFECTO

Dos indicadores estadísticos de posible uso en estudios de predicción son la *odds ratio* y el riesgo relativo. Ambos hacen referencia a medidas de asociación entre variables y se utilizan para describir el incremento de presencia de un resultado (probabilidad o riesgo de presencia del resultado) en un grupo frente a otro que presenta una diferencia (presencia de una variable de riesgo, sometimiento a tratamiento, etc.). Junto a estos dos valores, se suelen utilizar otros indicadores del tamaño del efecto o, lo que es lo mismo, cuantificadores de la magnitud del efecto observado (principalmente *r* de Pearson y *d* de Cohen).

¹ Aunque las normas de publicación científica (tipo APA) señalan que aquellos índices estadísticos cuyo valor máximo es 1 deben presentarse sin 0 delante del decimal, a lo largo de todo el manual haremos alusión a valores AUC y otros estadísticos con la notación habitual para decimales (por ejemplo, 0,1), por resultar de más fácil lectura.

TABLA 5.3
Valores medios de AUC descritos en revisiones o metaanálisis

	Rango de AUC	AUC medio
Violencia inespecífica		
HCR-20	0,56-0,88 ^a	0,70 ^b
VRAG	0,60-0,80 ^a	0,74 ^b
LSI	0,55-0,73 ^a	0,67 ^b
Violencia de pareja		
DA	0,56-0,92 ^c	0,62 ^d
SARA	0,52-0,70 ^c – 0,59-0,77 ^c	0,70 ^b -0,68 ^d -0,63 ^c
ODARA	0,64-0,77 ^c	0,67 ^d
Violencia sexual		
SVR-20	0,58-0,83 ^f	0,78 ^b
RRASOR	0,55-0,77 ^a	—
Static-99	0,54-0,77 ^a	0,70 ^b
SORAG	0,58-0,77 ^a	0,75 ^b
RM2000	0,55-0,76 ^f	0,67 ^f
Violencia juvenil (incluida la sexual)		
SAVRY	0,64-0,78 ^g	0,71 ^b
YLS/CMJ	0,50-0,79 ^g – 0,57-0,75 ^h	—
ERASOR	—	0,66 ⁱ
J-SOAP-II	—	0,67 ⁱ
J-SORRAT-II	—	0,64 ⁱ

^a Mills et al. (2011); ^b Singh, Grann y Fazel (2011); ^c Hilterman, Nicholls y van Nieuwenhuizen (2014); ^d Messing y Thaller (2013); ^e Helmus y Bourgon (2011); ^f Tully, Chou y Browne (2013); ^g Olver, Stockdale y Wormith (2009); ^h Schwalbe (2007); ⁱ Viljoen, Mordell y Beneteau (2012).

4.1. Odds ratio (OR)

Odds es un término inglés utilizado para describir la probabilidad de ocurrencia de un resultado. Su cálculo consiste en dividir la probabilidad (%) de ocurrencia del evento entre la probabilidad de no ocurrencia del mismo [$odds = p/(1 - p)$]. Por ejemplo, si un 20% de los fumadores desarrollan cáncer, la *odds* de desarrollar cáncer es $20/80 = 0,25$ (20% de los que desarrollan cáncer entre el 80% de los que no lo desarrollan en el grupo de fumadores). Si el 1 % de los no fumadores desarrollan

cáncer, la *odds* de desarrollar cáncer en este grupo es $1/99 = 0,01$. La comparación de dos *odds* da lugar a la *odds ratio* (OR), de manera que podamos concluir si un resultado es más probable en uno de los grupos (fumadores y no fumadores, tratados o no tratados, riesgo de violencia bajo o alto, etc.). En el ejemplo del cáncer, la ratio de ambos grupos es $0,25/0,01 = 25$. Esto significa que los fumadores tienen 25 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que los no fumadores.

Generalmente, la OR es un dato derivado de la comparación de variables con tablas de con-

tingencia 2×2 . Existen dos fórmulas para calcularla: a partir de las frecuencias (número de casos en las casillas) o a partir de la proporción (%) de ocurrencia de los eventos (Moral, 2006b; Szumilas, 2010), tal como se indica en las fórmulas del Recurso 4. La OR, o Exp (β) en los análisis de regresión hechos en SPSS (Field, 2009), se interpreta como el cambio de probabilidad de ocurrencia del evento por cada unidad que cambia la variable predictora. Cuando la variable predictora es categórica (por ejemplo, tratamiento sí/no) la *odds* equivale a la probabilidad de ocurrencia del evento frente a la de no ocurrencia (por ejemplo, reincidencia/no reincidencia) cuando la variable predictora está presente. En este caso, para conocer la influencia de la variable se pondrá como numerador la *odds* de ocurrencia del resultado en presencia de la variable que consideramos que es de riesgo (cáncer en fumadores, reincidencia en no tratados, violencia en riesgos altos, etc.) y se compara con la *odds* de ocurrencia del evento en los que no presentan la variable (Field, 2009).

Una OR = 1 señala que no hay ningún efecto de la variable, una OR > 1 señala una mayor probabilidad en caso de exposición a la variable y una OR < 1 una menor probabilidad en caso de exposición a la variable.

4.2. Riesgo relativo

Otro indicador es el denominado riesgo relativo —RR— (riesgo como concepto estadístico referente a la probabilidad de ocurrencia de un evento) (Moral, 2006a). Representa el cociente entre el riesgo en el grupo que presenta la variable problema (fumar, no someterse a tratamiento, tener un riesgo alto, etc.) y el riesgo en el grupo de referencia (sin presencia de la variable). Por tanto, expresa la asociación entre la exposición a un factor y un resultado o, lo que es lo mismo, la probabilidad de ocurrencia de un resultado (desarrollo del evento de interés: enfermedad, violencia, etc.) en los sujetos expuestos al factor (variable de riesgo, nivel de riesgo, etc.) en relación

a aquellos no expuestos al mismo factor (Aedo, Pavlov y Clavero, 2010).

El RR tiene valores entre 0 e infinito. El valor 1 indica que no hay relación entre la presencia del factor y el resultado; un valor superior a 1 indica una relación positiva y un valor negativo implica una relación negativa.

4.3. Tamaño del efecto

Aunque la *odds ratio* y el riesgo relativo se consideran también tamaños del efecto (Field, 2009; Wilson, 2010), como decíamos, existen indicadores estadísticos denominados específicamente tamaños del efecto y utilizados como complementos en comparaciones de muestras. En concreto, los más utilizados (también en la investigación sobre evaluación del riesgo) son la *d* de Cohen y la *r* de Pearson (para esta última existen complementos no paramétricos, como la *r* de Spearman y la τ_b de Kendall). Los tamaños del efecto se emplean para cuantificar la relevancia de un resultado significativo, como puede ser la diferencia entre dos grupos con una prueba *t* (comparación de medias). En la actualidad, la inclusión del tamaño del efecto en la comparación de grupos se ha convertido en una norma en la publicación científica. El tamaño del efecto también es un pilar básico de los estudios de metaanálisis, cuyo objetivo es deducir implicaciones para la población a partir de distintas muestras.

La *d* de Cohen se conoce también como diferencia de medias estandarizada (Wilson, 2010) y refleja la diferencia de medias entre dos grupos en dos o más variables dependientes. El propio Cohen propuso los siguientes criterios de interpretación (Rice y Harris, 2005): 0,2 efecto pequeño; 0,5 efecto mediano; y 0,8 efecto grande. Existen calculadoras para obtener el valor de *d*, aunque una ecuación sencilla cuando se realiza una prueba *t* para comparar medias es la siguiente:

$$d = t \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \times n_2}}$$

Por su parte, el coeficiente de correlación de Pearson (r) mide la asociación entre dos variables continuas (preferiblemente que tengan distribución normal), aunque también puede aplicarse cuando una de ellas es dicotómica, denominándose correlación biserial puntual $-r_{bp}$ (Field, 2009). En esencia, su objetivo es saber si dos variables crecen al mismo tiempo (correlación positiva), si cuando una crece la otra decrece (correlación negativa) o si no hay ninguna relación. Tiene valores entre 0 (sin relación) y 1 (relación perfecta), pudiendo ser también negativos. La elevación del coeficiente de correlación al cuadrado (r^2) refleja el porcentaje de varianza explicado por la variable. Respecto a si el efecto es grande o pequeño, se pueden utilizar los siguientes criterios: $r = 0,1$ (efecto pequeño): explica el 1% de la varianza; $r = 0,3$ (efecto mediano): explica el 9% de la varianza; y $r = 0,5$ (efecto grande): explica el 25% de la varianza.

Tal como se ha presentado en el apartado dedicado al AUC, Rice y Harris (2005) publicaron un trabajo con la equivalencia entre puntuaciones expresadas como AUC, d de Cohen y r_{bp} (correlación

biserial puntual), aplicable a cualquier variable predictora continua u ordinal y variable dependiente dicotómica. Respecto a la elección del mejor indicador, recordaron que la d está pensada para la comparación de dos grupos en variables continuas y con una distribución normal (algo poco habitual en estudios sobre riesgo de violencia). La r depende de la propia correlación y de la tasa base, por lo que los autores recomendaban el uso del AUC. Propuestas recientes, sin embargo, recomiendan el uso de indicadores más allá del AUC, por las limitaciones de este indicador, como el hecho de que dos herramientas puedan ofrecer AUC iguales, aunque en la práctica tengan utilidades diferentes por predecir cada una bien solo un tipo de sujetos (una riesgos altos y la otra riesgos bajos); se propone la inclusión de otros estadísticos, como los valores de predicción positivos y negativos, verdaderos y falsos positivos y negativos (Fazel y Bjørkly, 2016) y trabajos de revisión sobre la eficacia de las herramientas, que informan sobre valores como la d (por ejemplo, Yang, Wong y Coid, 2010).

Recurso 4

Cálculo y ejemplo de Odds ratio y Riesgo relativo

A partir de una investigación sobre tipologías, riesgo y reincidencia en agresores de pareja en prisión (Loinaz, 2014b), se obtuvo en una submuestra de 40 casos a los que se hizo el seguimiento, tras su puesta en libertad, una reincidencia penitenciaria del 17,5%. Se pudo constatar que de los 32 agresores que se habían sometido a tratamiento reincidió el 9,4% (3 casos), mientras que de los ocho que no lo habían hecho reincidió el 50%. A la hora de crear una tabla de contingencia 2×2 podemos trabajar tanto con los casos (n) como con los porcentajes (lo que nos ofrece probabilidades en cada casilla; p).

Formato tabla 2×2

		Resultado	
		Sí	No
Presencia de la variable de riesgo	Sí	a	b
	No	c	d

a = casos NO tratados que reinciden.

b = casos NO tratados que no reinciden.

c = casos tratados que reinciden.

d = casos tratados que no reinciden.

Odds ratio

$$OR = \frac{a/c}{b/d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \quad \text{o} \quad OR = \frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)}$$

$$OR = \frac{\frac{\text{Resultados positivos con el factor}}{\text{Resultados positivos sin el factor}}}{\frac{\text{Resultados negativos con el factor}}{\text{Resultados negativos sin el factor}}}$$

Riesgo relativo

- El riesgo de reincidir en el grupo de riesgo alto o con el factor presente sería $R = a/(a + b)$.
- El riesgo de reincidir si se tiene el riesgo bajo o el factor está ausente es $R = c/(c + d)$.
- El riesgo relativo (RR) expresa el cociente de probabilidades del número de sujetos que desarrollan el problema de interés (violencia, reincidencia, enfermedad) entre el total de sujetos que presentan un determinado factor (nivel de riesgo, variable concreta), dividido por el número de sujetos que desarrollan el problema entre el total de sujetos que no presentan el factor.

$$RR = \frac{a/(a + b)}{c/(c + d)} = \frac{p_1 \text{ (presencia del factor de riesgo)}}{p_2 \text{ (ausencia del factor de riesgo)}}$$

Aplicación

Si la reincidencia en un grupo de agresores de pareja no tratados fue del 50% ($a = 4$), la *odds* de reincidencia tras la prisión en este grupo es $0,5/(1 - 0,5) = 1$ o $50/50 = 1$ (en este caso, la probabilidad de éxito sería la misma). Si los sujetos tratados reinciden un 9,4% ($c = 3$), la *odds* de reincidencia en este grupo sería $0,094/(1 - 0,094) = 0,1037$ o $9,4/90,6 = 0,1037$ [la de éxito sería $90,6/(1 - 90,6) = 9,64$]. La razón de ambos valores es la *odds ratio*. Si comparamos ambos grupos, podemos afirmar que la probabilidad de éxito en el grupo tratado es 9,6 veces superior a la del grupo no tratado.

$$Odds\ ratio = \frac{\left(\frac{0,50}{1 - 0,50}\right) \text{ grupo NO tratado}}{\left(\frac{0,094}{1 - 0,094}\right) \text{ grupo tratado}} = \frac{1}{0,1037} = 9,6$$

$$OR = \frac{4/3}{4/29} = \frac{4 \cdot 29}{3 \cdot 4} = 9,6$$

En el mismo ejemplo, donde los sujetos no tratados tienen una probabilidad del 50% de reincidir y los tratados una probabilidad del 9,4%, consideraremos la ausencia de tratamiento como variable de riesgo (p_1) y la presencia de tratamiento como ausencia de la variable (p_2). El riesgo relativo corresponde a 5,3. Los sujetos no tratados tienen 5,3 veces más riesgo de reincidir.

$$RR = \frac{4/8}{3/32} = 5,3$$

5. RIESGO ASUMIBLE

Con el concepto riesgo asumible se quiere hacer alusión a los criterios que utilizamos para establecer los puntos de corte en una herramienta de riesgo. De forma sencilla, el riesgo asumible es el precio que estamos dispuestos a pagar como consecuencia de la aplicación de la metodología y de nuestros criterios de decisión.

Para ejemplificar la cuestión confrontaremos lo que denominaríamos riesgo asumible en el caso de la credibilidad en el contexto forense frente al caso de la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo estaríamos hablando del etiquetado de personas como de riesgo alto cuan-

do en realidad no lo son o, en el caso contrario (sujetos de alto riesgo clasificados como de bajo riesgo), la omisión de una medida de protección de la víctima cuando esta lo requiera.

En la figura 5.2 se ha tratado de plasmar la situación o dilema al que nos enfrentamos. Por cuestiones prácticas se han representado dos distribuciones normales y un punto de corte dicotómico (riesgo bajo o alto). Las distribuciones no suelen ser normales ni de igual tamaño, tanto porque el riesgo no se distribuye de esta forma como porque la reincidencia real no alcanza tasas del 50% (dos distribuciones de igual tamaño implicarían valores del 50% para reincidentes y no reincidentes; véase Quinsey et al., 2005).

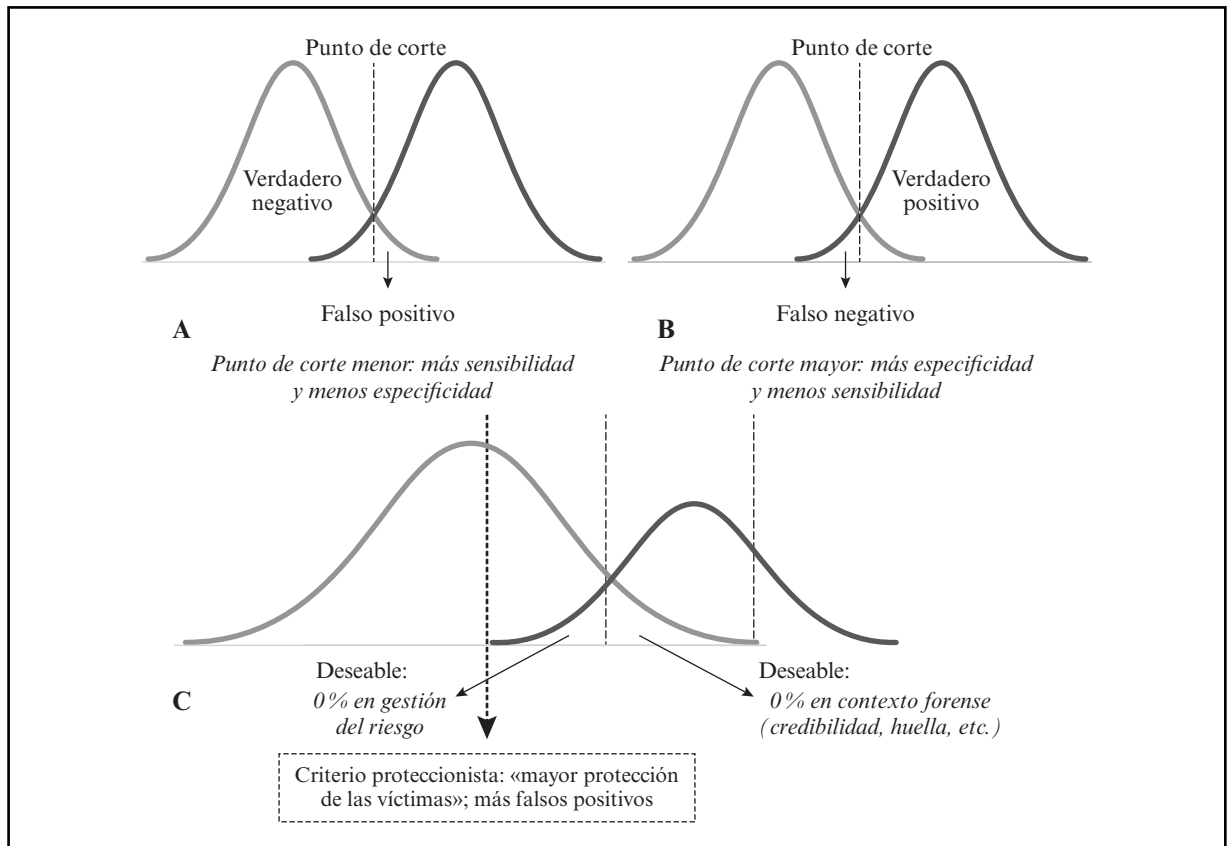


Figura 5.2.—Representación gráfica de puntos de corte, errores posibles y comparación de criterios en el contexto forense y en el de gestión del riesgo.

Componentes de la gráfica

- En el *eje de abscisas* o X (eje horizontal) encontraríamos el nivel de riesgo descrito de forma cuantitativa (numérica) o número de factores de riesgo, yendo de menos a más de izquierda a derecha. Para cualquier otra temática, la línea horizontal representaría el criterio cuantitativo a partir del cual vamos a tomar la decisión o diagnóstico.
- En el *eje de coordenadas* o Y (eje vertical) encontraríamos el porcentaje de casos en cada valor de riesgo o número de sujetos con cada puntuación o suma de factores presentes.
- En la *curva de la izquierda* tendríamos la distribución de las puntuaciones de los casos que no son de riesgo o no cumplen con la variable criterio: los verdaderos negativos (por ejemplo, distribución de las puntuaciones de los no reincidentes).
- En la *curva de la derecha* estarían las puntuaciones de aquellos que sí cumplen con la variable criterio (por ejemplo, distribución de las puntuaciones de los reincidentes).
- La *línea discontinua vertical* indica el punto de corte que hemos establecido para delimitar a partir de qué valor un sujeto puede corresponder a cada categoría (línea que divide los grupos en riesgo alto y bajo, por ejemplo; en una situación ideal la línea debería separar ambas distribuciones de forma perfecta).
- La unión entre ambas distribuciones o curvas da pie a ciertos solapamientos que quedan a la izquierda o la derecha del punto de corte adoptado:
 - La parte de la distribución de verdaderos negativos (izquierda) que se solapa con la curva de verdaderos positivos (derecha) equivale a los denominados falsos positivos (figura 5.2, gráfica A). Estos hacen alusión a aquellos casos que son etiquetados con un riesgo su-

prior al que les correspondería en realidad por haber ajustado a la baja el punto de corte (sujetos no reincidentes que, al puntuar igual que sujetos reincidentes, son clasificados como de riesgo alto). Por tanto, el solapamiento que queda a la derecha del punto de corte corresponde a los falsos positivos.

- La parte de la curva de verdaderos positivos (derecha) que se ubica dentro de la de los verdaderos negativos (izquierda) corresponde a la proporción de falsos negativos (figura 5.2, gráfica B). Es decir, aquellos casos que consideramos que no cumplen o no van a cumplir con la variable criterio (reincidencia, por ejemplo) pero que en la realidad sí lo hacen (puntuación igual o menos que los no reincidentes pero que sí reinciden). Por tanto, el solapamiento que queda a la izquierda del punto de corte corresponde a los falsos negativos.

Si las distribuciones correspondiesen a un estudio sobre reincidencia, la gráfica mostraría la distribución de aquellos sujetos que han reincidido (derecha) y la de aquellos que no lo han hecho (izquierda). La puntuación de aquellos sujetos que reinciden, de media, suele ser mayor que la de los que no lo hacen. Sin embargo, hay un espacio compartido entre ambas distribuciones, correspondiente a aquellos casos que han reincidido con puntuaciones menores a las de los que no lo han hecho y, por otro lado, sujetos que no han reincidido y que tenían puntuaciones iguales o superiores a las de los reincidentes.

En la práctica, existe la opción de mover la línea o punto de corte hacia la derecha o la izquierda, aumentando o reduciendo los falsos positivos o negativos. Tal como se presentaba en el punto 3, existen pruebas estadísticas para poder ajustar de forma matemática estos valores. Sin embargo, al margen de la estadística, a continuación valoraremos la medida en que este criterio puede responder a intereses o necesidades de cada contexto.

Por ejemplo, en medicina, en determinadas patologías puede resultar más peligroso no diagnosticar la presencia que sobrediagnosticarla, en especial cuando la falta de diagnóstico puede estar asociada a la muerte del paciente. En materia de evaluación del riesgo de violencia, si desplazamos la línea hacia la izquierda establecemos un punto de corte más bajo, con lo que aumentan los falsos positivos pero garantizamos un nivel de protección mayor para las víctimas. Esta última elección correspondería a un criterio proteccionista desde el punto de vista victimológico, una elección habitual en la metodología de evaluación del riesgo. Por el contrario, si desplazamos el punto de corte hacia la derecha reducimos el número de falsos positivos (ningún sujeto es valorado como de riesgo alto injustamente, ni se le aplican restricciones), pero asumimos más falsos negativos, con el riesgo que ello supone para las víctimas. Este criterio sería el liberal o más garantista desde el punto de vista de los derechos del evaluado.

Para poner un ejemplo sobre los criterios aplicados a la hora de establecer puntos de corte, vamos a comparar las perspectivas adoptadas en el contexto forense para el análisis de la credibilidad del testimonio y el criterio habitual aplicado en la evaluación del riesgo. En la figura 5.2 se presentaban los conceptos de falsos positivos y negativos a partir de un punto de corte (gráficas A y B). La combinación de la distribución de resultados positivos y negativos (por ejemplo, reincidentes y no reincidentes o testimonios reales frente a no reales) permite valorar el efecto del punto de corte (gráfica C). Tal como se ha mencionado previamente, en la evaluación del riesgo se aplica un criterio proteccionista en el sentido de la mayor garantía para la víctima. En el contexto forense, para el caso de la credibilidad, el criterio es garantista en sentido restrictivo: se busca la menor probabilidad de que un testimonio falso sea valorado como creíble y, en consecuencia, se pueda condenar a un inocente. Por

tanto, se exige que el relato cumpla con más criterios de realidad (véase Arce y Fariña, 2014; Arce, Fariña, Carballal y Novo, 2009). En esencia, en evaluación del riesgo se exige un menor número de factores de riesgo para considerar un riesgo elevado, y en credibilidad se sube el punto de corte o número de criterios de credibilidad necesarios para considerar un relato creíble y, por tanto, poder acusar a un sujeto.

¿Qué número de errores estamos dispuestos a asumir? Cuando los niveles de falsos negativos son muy elevados, el punto de corte se debe reducir. El número de falsos negativos se reduce, pero el número total de aciertos también lo hace, pues se eleva el número de falsos positivos o falsas alarmas. Por tanto, no se puede reducir el número de falsos negativos sin aumentar los falsos positivos, algo que se denomina compensación o conjugación entre sensibilidad y especificidad (Quinsey et al., 2005). Así pues, ¿qué valoramos más?, ¿qué riesgos estamos dispuestos a asumir?, ¿hacia dónde inclinamos la balanza? Estas son cuestiones que se debe responder a la hora de establecer protocolos de evaluación asociados a gestión o restricción de libertades.

Debemos tener presente que el establecimiento de un punto de corte no solo corresponde a una regla matemática, sino que es una elección para la que se debe tomar en consideración ambos tipos de error, sus costes y beneficios y los criterios sociopolíticos. En este caso, el entorno del delincuente y el de la víctima tendrán perspectivas diferentes, siendo los primeros partidarios de más errores a costa de ningún falso positivo, mientras que los segundos querrán un riesgo de falsos negativos igual a cero (Quinsey et al., 2005). En el ámbito de la credibilidad, este mismo criterio supondría la consideración de casos creíbles cuando no lo son y, por ello, la condena/acusación del imputado. La mejor solución a todos los casos será desarrollar una herramienta con mayor tamaño del efecto.

Métodos en la evaluación del riesgo

6

La única función de las predicciones financieras es hacer que la astrología parezca respetable.

EZRA SOLOMON
(Economista estadounidense; 1920-2002)

Como ya se ha anticipado en capítulos anteriores, la evaluación del riesgo de violencia no corresponde a una única metodología. De hecho, en secciones como la revisión histórica hemos descrito las distintas formas en las que se pueden realizar estimaciones de la conducta futura. En concreto, un profesional puede aplicar simplemente su experiencia para sacar una conclusión sobre el riesgo de un caso; también se pueden utilizar fórmulas matemáticas que produzcan resultados vinculables a conductas futuras (o su probabilidad de ocurrencia) o se pueden realizar estimaciones guiadas por una serie de pautas y factores.

En este capítulo describiremos con más detalle estos métodos y analizaremos sus principales limitaciones y beneficios. Además, profundizaremos en el enfrentamiento entre el juicio clínico estructurado y el método actuarial, aproximando al lector a la respuesta sobre cuál de los dos parece mejor.

El origen de la polémica entre predicción clínica y actuarial ha sido atribuido por algunos autores al trabajo de Paul Meehl (Meehl, 1954), quien en su monografía sobre la comparación de ambos métodos concluyó que la estadística (método actuarial) superaba a la predicción profesional (ojo clínico). En el continuo de la evaluación del riesgo encontraríamos un polo perteneciente al juicio clínico, similar a la intuición pero en un profesional al que se le presupone cierta capacidad para pronosticar la potencial conducta de una persona, y el polo opuesto perteneciente al método actuarial, rígido y que combina reglas matemáticas para dejar en manos del evaluador el menor peso posible. Entre ambos métodos surgió el juicio clínico estructurado, que permite al profesional estimar la conducta futura del sujeto guiado por una herramienta o pautas de evaluación. En la tabla 6.1 se presentan las características prototípicas de las tres modalidades de evaluación.

TABLA 6.1
Principales características de los distintos métodos de evaluación del riesgo de violencia
(adaptado de Costanzo y Krauss, 2012)

Método	Fundamento	Fortaleza	Debilidad
Juicio clínico no estructurado	Experiencia del profesional.	Es ideográfico. Relacionado con el individuo concreto que se está evaluando.	Puede estar sesgado por las creencias y percepciones del profesional. Tiende a sobreestimar el riesgo de violencia (falsos positivos). No tiene en cuenta las tasas base de reincidencia. En general no incluye el seguimiento para ofrecer <i>feedback</i> al profesional.
Método actuarial	Investigación empírica sobre factores de riesgo con capacidad predictiva en la muestra de estudio concreta.	Fundamentado en grandes* muestras, eliminando sesgos subjetivos.	Nomotético: en ocasiones puede no ser generalizable al caso evaluado. Puede confiar demasiado en factores estáticos. No tiene en cuenta factores de riesgo raros (poco frecuentes).
Juicio estructurado	Combinación de la experiencia profesional y factores derivados de la investigación empírica.	Asentado en factores de riesgo obtenidos empíricamente. No se basa en una muestra específica, por lo que evita los problemas de la generalizabilidad. Puede incluir factores de riesgo raros, dinámicos y de gestión del riesgo.	Puesto que el profesional asigna pesos y combina factores, puede ser susceptible a sus sesgos.

* La alusión a grandes muestras de validación en las herramientas actuariales, sin embargo, es puesta en duda y criticada por los partidarios del juicio estructurado, quienes consideran que las muestras no son representativas.

1. JUICIO CLÍNICO NO ESTRUCTURADO

El juicio clínico no estructurado corresponde básicamente a la opinión personal de un profesional, tomada sin aplicar ningún tipo de procedimiento estructurado ni herramienta. También se le denomina método intuitivo, por no seguir ningún tipo de regla respecto a cómo se debe recolectar la información, ponderar los

factores o determinar el resultado (Costanzo y Krauss, 2012).

Las limitaciones del juicio clínico o profesional se pusieron de manifiesto en los primeros estudios en el ámbito de la psicología o las ciencias médicas (Quinsey et al., 2005). Profesionales de estas disciplinas cometían gran cantidad de errores en sus predicciones, con problemas a la hora de conectar o ponderar variables, poca coinciden-

cia entre profesionales y decisiones muy similares entre legos y expertos.

A todo esto debemos añadir que la predicción de la conducta violenta es especialmente susceptible a sesgos personales y limitaciones de la temática. Entre los aspectos que afectan a la predicción se encuentran las tasas base de reincidencia, es decir, la cifra de sujetos reincidentes en una población concreta. Cuanto más baja sea esta tasa, más difícil será la predicción. El juicio clínico, además, tiende a sobreestimar la probabilidad de reincidencia, debido a los sesgos personales de los profesionales, entre los que se encontrarían el no considerar las cifras de reincidencia de la muestra, no ponderar correctamente los factores de riesgo o actuar conforme a estereotipos o ideas preconcebidas (Krauss, McCabe y McFadden, 2009). Debido a estas limitaciones del juicio clínico, se propuso el uso de técnicas actuariales que limitan el impacto de estos criterios personales.

2. MÉTODO ACTUARIAL

Las técnicas actuarias o actuariales, principalmente en el contexto económico y más concreto en aseguradoras, son aquellas en las que se aplican modelos estadísticos y cálculos matemáticos en el asesoramiento y gestión de determinados procesos. De hecho, en España existe el Instituto de Actuarios, que es la organización colegial de profesionales habilitados para la actuación en todas las cuestiones de técnica matemática y económica de las Instituciones de Seguros, Ahorro y Capitalización. En esencia, el método actuarial implica la utilización de estadísticas con distintos fines.

En las herramientas actuariales, los factores de riesgo son seleccionados en estudios de seguimiento en los que se acumulan datos sobre reincidencia. Los factores que demuestran una capacidad predictiva son seleccionados y combinados para ofrecer el mejor resultado en la predicción del objetivo (Krauss et al., 2009). El método compara a un sujeto con una muestra de referen-

cia y facilita una estimación numérica (en algunas herramientas en formato probabilístico) de la violencia futura, en sentido absoluto (sin matices cualitativos como la gravedad), por medio de reglas matemáticas. Al seleccionarse y ponderarse los ítems conforme a algoritmos derivados de la investigación, su principal ventaja es la transparencia en la toma de decisiones (Hart, 2008), pues el evaluador no aporta ninguna variable subjetiva.

El método ha sido criticado, por no considerar factores contextuales y por presentar implicaciones mínimas de cara a la implementación de estrategias preventivas (Au et al., 2008), aunque las herramientas actuariales han evolucionado considerablemente y en la actualidad pueden considerar variables del contexto del sujeto y tienden a estar vinculadas a la gestión y prevención de la violencia valorada. Por otro lado, se les ha achacado el hecho de que permitan predecir el riesgo de cometer un delito pero no lo expliquen (Buruma, 2004); si valoramos desde el mismo prisma a las enfrentadas herramientas de juicio estructurado podríamos concluir por igual, pues la herramienta no explica nada, sino que es el profesional el que debe reflexionar sobre el caso (algo que puede hacer igualmente considerando los factores de riesgo presentes en una herramienta actuarial).

Además, este tipo de herramientas han sido criticadas al ponerse en duda los siguientes aspectos (Krauss et al., 2009):

1. Su generalización más allá de la muestra con la que han sido creadas. Este aspecto es su principal limitación, así como una prioridad a la hora de validar un procedimiento actuarial: debe estar ajustado a la muestra en la que se va a utilizar.
2. La no incorporación de factores de riesgo o de protección atípicos, pero muy importantes. Se trata de factores que reducen o incrementan el riesgo de forma muy significativa, pero que no ocurren con suficiente frecuencia en la muestra con la que se crea la herramienta como para ser incor-

porados. El juicio estructurado, sin embargo, permite incorporar factores no considerados en la herramienta.

3. Menor incorporación de factores de riesgo dinámicos, modificables en el tiempo, lo que impide cambios en los niveles de riesgo. Esta crítica era especialmente cierta en las primeras herramientas actuariales, aunque en los desarrollos más recientes lo que se modifica es el procedimiento de aplicación y corrección (ponderación matemática, por ejemplo) y no así el tipo de factores que pueden ser igualmente dinámicos.

Algunos autores indican que estas herramientas cometen grandes errores al valorar casos individuales, por haberse derivado de muestras muy pequeñas (Hart, Michie y Cooke, 2007). En ocasiones, además, el método puede suponer un trato injusto para algunos sujetos, por pertenecer a un supuesto grupo de riesgo (Buruma, 2004), y muchas veces los parámetros de predicción no han sido puestos a prueba en muestras independientes (Hart, 2008). Así pues, cuanto más heterogénea sea una muestra y más se distancie de la muestra de validación mayor será la probabilidad de error.

Se señala, además, que estas herramientas conciben el riesgo solo en términos probabilísticos, ignorando otras facetas de la violencia como su posible naturaleza, gravedad, inminencia, duración o frecuencia (Hart, 2003). Habitualmente se usa el símil meteorológico para reflejar este problema. A la hora de pronosticar lluvias, una cosa es decir que la probabilidad de precipitaciones es del 90% y otra cosa es conocer la cantidad de lluvia que se espera. Los modelos de predicción meteorológica más modernos tienden a ofrecer ambas estimaciones por separado, de forma que podemos saber por un lado si se espera lluvia, y con qué probabilidad, y por otro lado la cantidad de agua esperada (si serán simples gotas o si la lluvia será intensa, con una gran cantidad de litros por metro cuadrado).

Una forma de mejorar las predicciones actuariales es permitir la incorporación del juicio clíni-

co para establecer el riesgo final, algo que ya se aplica en distintos procedimientos (por ejemplo, en contextos policiales o penitenciarios, donde el resultado de la herramienta puede ser corregido por el profesional en caso de no estar conforme, justificando el motivo de dicho cambio). Esto es lo que se conoce como enfoque actuarial ajustado. Sin embargo, precisamente esta incorporación de la subjetividad clínica fue el origen del establecimiento de reglas matemáticas en herramientas actuariales (Krauss et al., 2009), por lo que resolver la controversia no es algo sencillo. En resumen, si se crean herramientas de tipo matemático para evitar la subjetividad del evaluador y mejorar la precisión de las evaluaciones, perdería todo el sentido poder modificar el resultado matemático de la herramienta si el evaluador no está conforme con el mismo.

2.1. Árboles de clasificación

A partir de los resultados del estudio MacArthur (véase apartado 2.2.1) surgió una nueva técnica actuarial de predicción del riesgo denominada Árbol de Clasificación Iterativa Múltiple (*Multiple Iterative Classification Tree*; Monahan et al., 2000). La metodología de los árboles de clasificación consiste en agrupar a los sujetos por niveles de riesgo mediante la combinación de distintas variables. Se centran en interacciones, permitiendo diferentes combinaciones de factores de riesgo para clasificar al sujeto en un riesgo alto o bajo. Su principal diferencia respecto a otras metodologías es que la evaluación de un factor afecta a qué factor será evaluado posteriormente. La evaluación comienza por el factor que más predice el problema en cuestión (una pregunta común para todos los sujetos evaluados) y, en función de la primera respuesta, se aplica una nueva pregunta. Esto se repite hasta asignar el nivel de riesgo final. Por tanto, el tipo de factores analizados varía entre distintos sujetos según las respuestas sucesivas. Con ello se busca la mejor discriminación entre reincidentes y no reincidentes. Sin embargo, como el lector habrá podido intuir, el ajuste de

este tipo de herramientas no es una tarea sencilla, y de ahí que sea una técnica poco extendida.

En total, en el estudio MacArthur se tomaban en cuenta 134 factores de riesgo presentes en pacientes psiquiátricos (Monahan et al., 2001, 2005), que se fueron depurando a 106 para la creación de la herramienta (Monahan et al., 2000). En la actualidad la técnica ha sido informatizada y el instrumento se denomina COVR (*Classification of Violence Risk*; Monahan et al., 2005, 2006). Está diseñado para clasificar pacientes psiquiátricos conforme a su nivel de riesgo de conducta violenta tras su alta. El algoritmo informático permite evaluar el caso sin necesidad de responder a los 106 factores de riesgo (en función de las respuestas que se van dando sucesivamente). La eficacia del COVR al ser aplicado en muestras distintas a la de su creación ha sido puesta en entredicho en distintos estudios (véase McCusker, 2007).

3. JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO

El juicio profesional estructurado surgió como respuesta a las evidentes limitaciones del juicio clínico y como alternativa al uso puramente matemático de los factores de riesgo. Su principal fundamento es el establecimiento de una serie de directrices que guían la evaluación del profesional indicando los aspectos a los que se debe prestar atención, qué información es necesaria, etc.

CLAVE 7.

Arbitrariedad en la consideración de factores de riesgo

El riesgo no correlaciona linealmente con el número de factores presentes, sino que es una combinación entre las características del caso, el contexto, la oportunidad, etc. Las guías de juicio profesional estructurado incluyen los factores de riesgo más comunes y con capacidad predictiva, lo cual no significa que no puedan existir otros factores suficientemente relevantes como para ser incorporados por el profesional.

(Hart, 2008). El origen de este tipo de guías se sustenta en estudios empíricos que pueden resultar de utilidad para el profesional a la hora de tomar su decisión. Una de sus virtudes es atender a factores más dinámicos y orientar la evaluación hacia la gestión. Los factores de riesgo provienen de la investigación acumulada, pero no han sido seleccionados de una muestra concreta. Las guías no ponderan los factores ni indican la forma en la que deben combinarse o sumarse para alcanzar el nivel de riesgo final.

Sin embargo, el hecho de que estas guías permitan incorporar el juicio personal, dejando al evaluador que pueda añadir nuevos factores de riesgo y ponderar la relevancia de los ítems según su criterio, es también su principal fuente de críticas (Au et al., 2008; Krauss et al., 2009). En muchos casos, además, la consistencia interevaluador es muy baja, algo que conlleva cuestionamientos éticos importantes a la hora de fundamentar una medida de seguridad en una escala sensible a la subjetividad del evaluador. El juicio clínico estructurado puede ser más útil en el ámbito terapéutico (Buruma, 2004), en el que la evaluación puede ayudar a diseñar la intervención.

4. ENFRENTAMIENTO ENTRE MODELOS: LO QUE LA INVESTIGACIÓN INDICA

El enfrentamiento entre predicción clínica y actuarial en psicología, como hemos visto en el apartado histórico, hunde sus raíces en trabajos como el de Meehl (1954), en el que se enfrentaba el ojo clínico y la predicción actuarial, resultando vencedora a la última. Además, en los inicios de la predicción de la violencia se puso de manifiesto cómo los profesionales (psiquiatras en aquellos momentos) no superaban la capacidad predictiva del azar (Monahan, 1981). Otro de los puntos de inflexión en la separación entre el juicio estructurado (guías de juicio estructurado) y el método actuarial se dio tras la publicación del conocido como *Libro rosa* (Webster et al., 1994), en el que ambos procedimientos aún formaban parte de una sola metodología (el juicio profesio-

nal estructurado complementaba la predicción actuarial). En las décadas posteriores, los defensores de ambos métodos se han criticado y han argumentado las bondades de su propuesta y las limitaciones de su competidora.

Al margen de estas disputas originarias, muchas veces surgidas como reacción a los movimientos imperantes en cada momento (como el abuso de opiniones profesionales sin fundamento ni metodología en los ochenta), en la actualidad el enfrentamiento es más ideológico, fruto de la defensa de una parcela académica e incluso empresarial, que real o fundamentado en las pruebas empíricas. Dejando de lado la inferioridad del criterio profesional (u ojo clínico), los dos métodos o modelos enfrentados en la evaluación del riesgo de violencia son el actuarial y el juicio clínico estructurado. Ambos tienen sus beneficios y sus críticas, tal como hemos señalado. Pero, ¿qué indica la investigación al respecto?

Conocer cuál de estos métodos es el más adecuado es una pregunta a la que los investigadores llevan tiempo queriendo dar respuesta. Desde el punto de vista de los creadores de las herramientas, encontraríamos dos grandes frentes entre los partidarios de los métodos actuariales (Harris y Rice, 2007) y sus detractores y creadores de las guías de juicio profesional estructurado (Hart et al., 2007). A este respecto, Singh, Grann y Fazel (2013) realizaron un estudio sobre el sesgo de autor, algo que debemos recordar a la hora de interpretar los resultados. Los autores compararon estudios desarrollados por los autores de las propias herramientas con aquellos desarrollados por investigadores independientes. Encontraron una influencia estadísticamente significativa del sesgo del autor, con capacidades predictivas informadas por los autores de las herramientas que podían duplicar las halladas en estudios independientes. Además, llamaron la atención respecto a la ausencia de indicaciones sobre el posible conflicto de intereses informado en estudios de los propios autores o adaptadores de las herramientas, muchas veces solicitado en las publicaciones. En esencia, se ponía en duda la credibilidad de estos estudios con conflictos de intereses y sin ninguna indicación al respecto.

La elección de una u otra modalidad de herramienta, por el profesional ajeno a estas polémicas, no es una tarea fácil y tiene implicaciones relevantes. Pese a las discrepancias existentes entre los dos modelos predominantes en la valoración del riesgo, en la actualidad están disponibles diversas revisiones y metaanálisis que concluyen que ambos tipos de herramientas presentan capacidades predictivas similares (Campbell et al., 2009; Singh y Fazel, 2010; Singh et al., 2011; Skeem y Monahan, 2011).

Ægisdóttir et al. (2006) desarrollaron un amplio metaanálisis revisando 56 años de investigación en el que comparaban la predicción clínica y la estadística. Se consideró predicción clínica cualquier juicio producido utilizando sistemas informales e intuitivos para integrar y combinar la información del caso. La revisión no solo incluyó investigaciones sobre la predicción del riesgo, sino también la predicción de aspectos como el daño cerebral, el diagnóstico psiquiátrico o el desempeño académico, entre otros. La conclusión general fue que la predicción estadística era algo mejor que la clínica, al ser correcta en un 9% más de los casos. El resultado, aunque positivo, solo indicaba que la disputa entre los defensores de ambos métodos se debería calmar, pues la mejora que ofrecían los procedimientos estadísticos no era abrumadora. Pese a ello, recomendaban el uso de técnicas estadísticas para las decisiones más importantes, como el riesgo de violencia o de suicidio. Por otro lado, los profesionales considerados expertos en una tarea de predicción lo hicieron mejor que los no expertos y, a la vez, igual que los métodos estadísticos. Sin embargo, la familiaridad del profesional con el ámbito de predicción no producía resultados mejores que los de los métodos estadísticos. Finalmente, recomendaban que los profesionales se familiaricen con los métodos estadísticos, para así poder mejorar sus predicciones.

Hilton, Harris y Rice (2006) ampliaron su metaanálisis a 66 años de enfrentamiento entre métodos clínicos y actuariales. Entre los hallazgos, se señalaba que las herramientas actuariales eran cada vez más precisas, que había sistemas actua-

riales disponibles pero muchas veces no eran utilizados, y que la búsqueda de un terreno neutral entre la evaluación clínica y las herramientas actuariales, con las técnicas de juicio profesional estructurado, implica la persistencia de la dependencia del juicio clínico (el juicio estructurado permite al evaluador incorporar nuevos ítems y establecer niveles de riesgo sin ningún criterio específico). Además, la pericia se puede adquirir con la experiencia en los seguimientos (los profesionales pueden aprender de los casos evaluados), pero los estudios longitudinales ofrecen a las herramientas actuariales la ventaja del *feedback* empírico. Por tanto, recordaban que se debían usar las herramientas más precisas, que para ellos eran las actuariales.

En una revisión de 88 estudios, Campbell, French y Gendreau (2009) señalaron que la gran variedad de herramientas para la evaluación del riesgo es un reto para los profesionales, con muestras además poco representativas (con escasas mujeres, por ejemplo). Los datos mostraban que la reincidencia violenta se predecía mejor con instrumentos compuestos principalmente por factores dinámicos (mejor resultado con herramientas de tercera generación frente a las de segunda), aunque herramientas como la VRAG producían resultados similares. Los autores concluían que, aunque las capacidades predictivas eran comparables entre herramientas actuariales y de juicio estructurado, ello no quería decir que fuesen igualmente útiles en la planificación del caso para la reducción del riesgo. Al margen de valores predictivos, se sugería la consideración del contexto y objetivo de la evaluación, así como el contenido y estructura de la herramienta para tomar la mejor decisión.

Singh et al. (2011), con la revisión sistemática de estudios hasta el 2011, indicaron que la validez de ambos tipos de herramientas era similar. Sin embargo, los autores concluían que existen muchas diferencias en la capacidad predictiva de distintas herramientas. Por ejemplo, la capacidad predictiva es mejor en herramientas diseñadas para objetivos o muestras específicas que en las diseñadas para poblaciones generales, como po-

dría ser el LSI-R o la PCL-R. Además, cuanto más parecida sea la muestra de estudio a la muestra original con la que se desarrolló la herramienta, mayor será la validez predictiva. Por ello, los autores concluyeron que, dado que no hay ninguna prueba de que las herramientas de juicio clínico estructurado tengan un nivel superior de validez predictiva, los profesionales deberían centrarse en identificar qué herramienta produce la mayor validez predictiva para su muestra y contexto de interés. Por último, recordaron que casi el 18% de los estudios que utilizaban herramientas de juicio estructurado lo habían hecho de forma actuarial (estableciendo puntos de corte, por ejemplo), por lo que sería recomendable que cada instrumento fuese utilizado en el formato original con que fue diseñado.

Berlin, Galbreath, Geary y McGlone (2003) señalaron que los profesionales pueden cometer muchos errores si atribuyen el riesgo general de un grupo, evaluado previamente, a un sujeto concreto. La recomendación era solo usar herramientas actuariales en procesos de cribado (*screening*) y no así en la toma de decisiones graves (como puede ser la cadena perpetua). Revisaron las características del STATIC-99, del RRASOR y del MNSOST-R, instrumentos actuariales utilizados en la condena de delincuentes sexuales. Los resultados mostraban cómo, pese a que el riesgo estaba relacionado con la reincidencia, no todos los sujetos con el mismo nivel de riesgo reincidían igual (habiendo hasta un 50% de no reincidentes en las categorías de mayor riesgo). Ahondando en este enfrentamiento entre métodos actuariales y guías de juicio estructurado, Hart et al. (2007) llegaron a concluir que los instrumentos de evaluación del riesgo actuariales no pueden ser utilizados para estimar el riesgo de un sujeto con ningún grado de certidumbre, y deberían ser utilizados con mucha cautela o no ser utilizados. Respecto a los problemas derivados del uso de probabilidades en el contexto legal, Hart (2003), utilizando el estudio de Berlin et al. (2003), señaló la necesidad de que los profesionales valoraran las herramientas desde el punto de vista profesional, científico y legal. Además, puso

en duda la admisibilidad legal del testimonio profesional fundado en herramientas actuariales, señalando que el profesional debería justificar por qué ha elegido una herramienta de este tipo cuando carece de muestras de validación independientes, tasas de error, etc.

La discusión, por tanto, va más allá de cuál de los dos modelos predice mejor y abarca la medida en que las herramientas actuariales, diseñadas para valorar niveles de riesgo a partir de estimaciones grupales, deben ser aplicadas a nivel individual (por ejemplo, para la imposición de medidas de seguridad) cuando la adaptación de la escala a la muestra específica no cumple con una serie de criterios que garanticen la representación del caso concreto entre los baremos disponibles (Hart et al., 2007). Asimismo, no solo resulta importante la obtención de valores matemáticos sobre la mayor o menor capacidad predictiva de distintos instrumentos. También se presta atención a la fiabilidad interevaluador y al propio proceso de toma de decisiones, analizando las variables que influyen en la aplicación de una gestión del riesgo diferencial, por ejemplo, con el empleo de métodos de investigación cualitativos (Sutherland et al., 2012).

Más allá de los enfrentamientos, uno de los aspectos que resulta de mayor interés en este tipo de evaluaciones es la eliminación, en la medida de lo posible, de la subjetividad del evaluador, en especial en lo referente a sesgos y prejuicios. Por ello, el juicio clínico subjetivo será el último recurso, únicamente necesario en los casos en los que no se disponga de información suficiente para tomar en cuenta la predicción de una escala. Además, se ha demostrado que el juicio clínico, por ejemplo en la valoración del tratamiento de agresores de pareja, tiene una capacidad débil para predecir incidentes violentos futuros (Gondolf y Wernik, 2009). Una forma adecuada de reducir el efecto de la subjetividad del evaluador es mejorar el entrenamiento y garantizar la ac-

tualización de conocimientos de los profesionales implicados en el proceso, así como la elaboración de guías detalladas y revisadas conforme se avanza en la aplicación de la escala.

Como hemos visto, la principal crítica a los métodos actuariales es que son imprecisos (Hart y Cooke, 2013; Hart et al., 2007). Esto es así, generalmente, debido a que se crean y ajustan a partir de muestras «pequeñas», que pueden no ser representativas de la población en la que se quiere aplicar el instrumento, y porque se juzga a sujetos particulares a partir de características grupales. Sin embargo, es preciso señalar un hecho relevante. Por un lado, se indica y argumenta que los procedimientos relacionados con el denominado Juicio Profesional Estructurado (básicamente guías y protocolos de evaluación del riesgo) están diseñados para gestionar el riesgo y no para predecirlo. Por otro lado, se acepta la dificultad (y en ocasiones imposibilidad) de valorar la capacidad predictiva de estas herramientas, por existir una intervención que interfiere en la normal evolución del agresor y, por tanto, en el resultado predicho. Entonces, ¿cómo se puede comparar la capacidad predictiva de herramientas de ambos métodos o argumentar que son más imprecisos los métodos actuariales? De hecho, este uso de modo actuarial de las herramientas de juicio estructurado ha sido criticado (Kropp y Gibas, 2010), del mismo modo en que se critica la incorporación del juicio profesional a las herramientas actuariales.

Es evidente que existe material científico a favor y en contra de ambos métodos, por lo que no podemos posicionarnos de forma clara a favor de un método. Tal vez una posible solución sería una fusión de los dos, tal como se propone en la figura 6.1. En esencia, supondría un ajuste minucioso de los métodos actuariales a las muestras de interés, la vinculación de los niveles de riesgo a medidas de gestión y el análisis de la eficacia de las valoraciones para reducir la reincidencia.

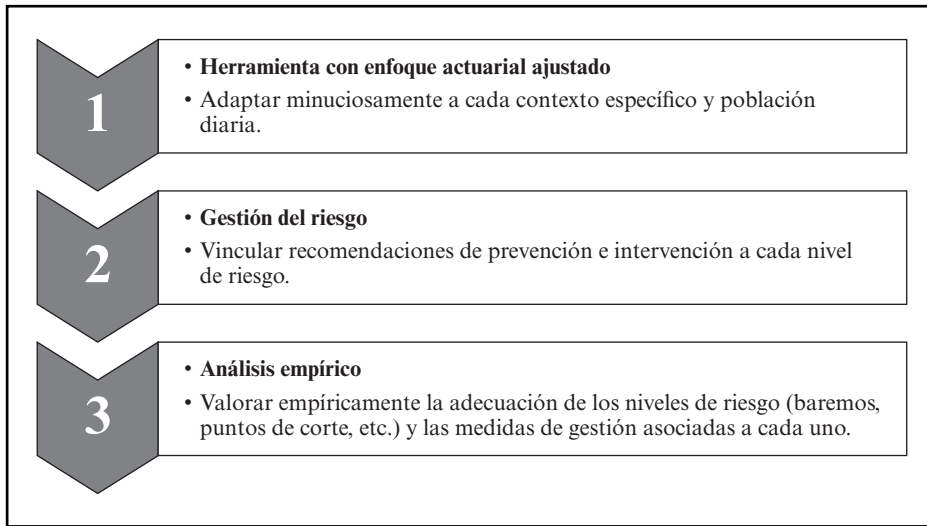


Figura 6.1.—Alternativa al habitual enfrentamiento entre enfoques actuariales y de juicio profesional estructurado.

Procedimiento: aplicación práctica de la evaluación del riesgo

7

Cuando es obvio que los objetivos no se pueden alcanzar, no ajustes los objetivos, ajusta los pasos a seguir.

CONFUCIO

(Filósofo chino, 551 a. C.-479 a. C.)

Una correcta evaluación del riesgo de violencia requiere el conocimiento de la metodología y de los pasos a seguir. En capítulos previos hemos analizado los fundamentos de la evaluación del riesgo (incluyendo definiciones, factores y conceptos técnicos), hemos revisado la evolución histórica de la predicción en criminología (pudiendo ver cuestiones que se repiten en distintos momentos y contextos) y hemos comparado los principales métodos (en concreto el actuarial y el juicio profesional estructurado). El presente capítulo pretende aportar al lector aquellos conocimientos prácticos que le pueden permitir elegir la metodología o herramienta más adecuada, tomar las decisiones necesarias durante el proceso de evaluación, informar sobre el riesgo estimado y aplicar el proceso de evaluación del riesgo de la forma más rigurosa y provechosa.

En lo que podría considerarse aún los inicios de la evaluación del riesgo de violencia como metodología sistematizada, Monahan (1981) señaló una serie de cuestiones que el profesional debía plantearse en la predicción del riesgo:

1. ¿Se ha solicitado una valoración del riesgo de conducta violenta?

2. ¿Estoy capacitado profesionalmente para ofrecer una estimación de la probabilidad de violencia futura?
3. ¿Hay algún problema personal o ético relacionado con el caso?
4. ¿Teniendo en cuenta mis respuestas a las preguntas anteriores, es el caso apropiado para emitir una predicción?
5. ¿Qué eventos han precipitado cuestionarse el potencial riesgo de violencia de la persona y en qué contexto sucedieron estos eventos?
6. ¿Cuáles son las características demográficas relevantes de la persona?
7. ¿Cuál es la historia de conducta violenta de la persona?
8. ¿Cuál es la tasa base de conducta violenta entre sujetos con el historial de esta persona?
9. ¿Cuáles son las fuentes de estrés en el ambiente actual de la persona?
10. ¿Qué factores cognitivos y afectivos indican que la persona puede estar predispuesta a responder frente al estrés de forma violenta o no violenta?
11. ¿Cuán similares son el contexto en el cual la persona ha utilizado mecanismos

de afrontamiento violentos en el pasado y el contexto en el que la persona va a estar en el futuro?

12. ¿Cuáles son las víctimas probables de las conductas violentas de la persona y cuán accesibles son?
13. ¿De qué medios dispone la persona para cometer conductas violentas?

Monahan (1981), además, recordaba la utilidad de disponer de la opinión de otros colegas o profesionales sobre la evaluación del caso. En casos complicados o que nos generen dudas, resulta conveniente conocer cómo valorarían la presencia de factores otros colegas o qué estimación u opinión emitirían sobre el riesgo final (lo que en la investigación se contrasta con la fiabilidad interjueces).

En el estado actual de la evaluación del riesgo con guías de juicio estructurado, el procedimiento se organiza en siete pasos (véase figura 7.1), todos ellos incluidos en la publicación de la HCR-20^{V3}, que incorporó como nuevo paso la formulación, tras los seis pasos descritos en el RSVP. Estos siete pasos son los siguientes:

1. *Recopilar la información del caso:* debemos realizar, recabar o recopilar entrevistas, protocolos, sentencias, informes profesionales o cualquier otra posible fuente de información que nos resulte de interés para el caso.
2. *Valorar la presencia de los factores de riesgo y/o protección:* incluye localizar la información necesaria para determinar la presencia o ausencia de cada factor, justi-

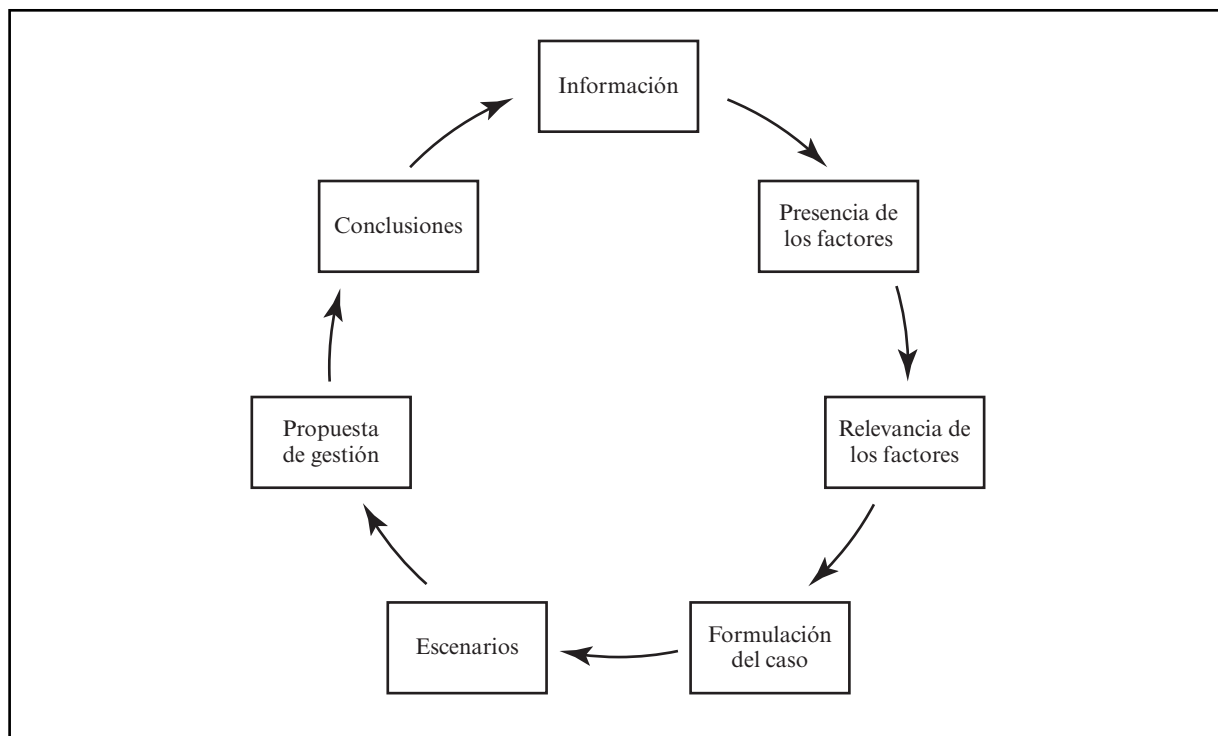


Figura 7.1.—Etapas en la valoración del riesgo de violencia con guías de juicio profesional estructurado.

ficando la valoración a partir de las fuentes mencionadas en el punto 1.

3. *Determinar la relevancia de los factores de riesgo*: no solo es importante conocer si un factor de riesgo está presente o si el número de factores que están presentes es mayor o menor, sino que es necesario conocer la relevancia específica que tienen las distintas variables para el caso concreto. Como veremos, un factor puede estar presente pero no ser relevante.
4. *Formular el riesgo*: consiste en conceptualizar el caso, la relevancia de los factores y cómo interactúan entre sí, pensando en el futuro a partir de la información presente, los problemas pasados y el contexto futuro.
5. *Describir escenarios de riesgo*: son estimaciones sobre situaciones y posibles futuros que nos permitirán anticipar aquellas situaciones que consideramos que pueden suceder y hacer las propuestas necesarias para prevenirlas.
6. *Proponer estrategias de gestión del riesgo*: son los pasos a seguir para reducir el riesgo estimado o minimizar las consecuencias de una posible agresión.
7. *Ofrecer las conclusiones sobre el riesgo*: incluye la valoración (opinión) final, la justificación de la misma, la posibilidad de que haya un daño grave, el nivel de intervención requerido, la necesidad de acción inmediata, otros posibles riesgos detectados y cualquier comentario que ayude a gestionar el caso.

Pese a este orden en la aplicación de los pasos necesarios en el juicio estructurado, a continuación modificaremos los bloques, por resultar más útil para quien debe realizar una evaluación del riesgo. Así, el primer paso consistirá en elegir la herramienta más adecuada para nuestro objetivo. Este paso no se describe en la estructura anterior, incluida en las guías, por considerarse que si se está leyendo el procedimiento de aplicación de un instrumento es porque ya consideramos que ese es el adecuado. En la práctica diaria, es habitual

que el profesional use la misma herramienta siempre, pero muchos usuarios, investigadores o profesionales que se inician en el ámbito primero deban decidir qué usar.

En nuestra descripción de pasos, la recopilación de información (paso 1), la codificación de los factores (paso 2) y la delimitación de la relevancia de los mismos (paso 3) las incluimos bajo el punto *evaluación*, por considerar que forman parte del mismo procedimiento u objetivo. La formulación (paso 4), el desarrollo de escenarios (paso 5) y la propuesta de gestión del riesgo (paso 6) las presentamos de forma separada, por tener entidad diferenciada y además seguir un orden lógico en la aplicación. Por último, el paso referente a las conclusiones (paso 7) lo dividiremos en dos secciones, resultado de la herramienta e informe del riesgo, tanto por la relevancia de las temáticas como por tener ambos aspectos una entidad suficientemente compleja como para requerir apartados separados (preferencias, formatos, opciones, significados, desarrollo del informe, etc.).

Insistimos en que estos pasos son los que vertebran en la actualidad el juicio profesional estructurado. Esto significa que en etapas anteriores las guías no incluían todos estos pasos y que la aplicación de una herramienta actuarial no requiere la adhesión a los mismos. En estos instrumentos, generalmente, se obtiene la información, se valora la presencia de los factores, y los ítems (ya ponderados por los autores de la herramienta) son sumados manual o informáticamente para producir el resultado final. Este resultado final se podrá vincular a probabilidades de reincidencia o medidas de gestión, según la herramienta que hayamos utilizado.

1. LA ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Llegado este punto, tal como se resume en la figura 7.2, sabemos que existen numerosas escalas diseñadas para valorar el riesgo de distintos tipos de violencia y de distintos tipos de agresores. Sin embargo, en muchos casos, la información

CLAVE 8.**Precaución. Las herramientas para valorar el riesgo:**

- NO valen para determinar si alguien ha cometido un delito violento.
- NO valen para determinar si alguien se ajusta al perfil de un tipo de agresor (sexual o de pareja, por ejemplo).
- NO valen para cualquier tipo de violencia.

sobre la población diana para la que se han diseñado es poco precisa, afirmándose que son igualmente válidas para jóvenes o adultos y para hombres o mujeres (pese a carecerse de estudios que respalden esta afirmación). En la actualidad, se tiende a desarrollar herramientas cada vez más específicas tanto para tipos de problemas a valorar (violencia sexual, de pareja, suicidio, acoso, conducta penitenciaria, radicalización, etc.) como para poblaciones o muestras concretas (por edad o por sexo).

La elección de la herramienta más adecuada depende de las exigencias que se señalan en los manuales de aplicación y, principalmente, de la accesibilidad a la información necesaria para valorar los ítems que las componen (por ejemplo, hay herramientas que requieren información de la víctima o diagnósticos de trastorno mental). Recordemos que evaluar el riesgo de violencia consiste en dar una opinión informada, que toma en cuenta la relación empírica (proveniente de la investigación acumulada) entre determinados factores de riesgo (o predictores) y una conducta objetivo (violencia o reincidencia). Por ello, como veremos, es imprescindible disponer de fuentes de información suficientes, válidas y fiables para poder responder sobre la presencia o ausencia de determinados factores.

Antes de comenzar la evaluación, y para elegir el mejor método y la mejor herramienta, debemos tener presentes los siguientes puntos:

1. *Delimitar el objetivo de la evaluación:* por ejemplo, realizar un informe sobre la ido-

neidad de una medida, la aplicación de medidas de protección a una víctima o valorar la evolución de un caso en distintos contextos.

2. *Accesibilidad a fuentes de información:* hemos de ser conscientes de la riqueza de la información (variedad de datos), la diversidad de fuentes (ámbito familiar, informes profesionales, bases de datos oficiales, etc.) y la medida en la que se cubren los requisitos de la herramienta.
3. *Fiabilidad de la información disponible:* al margen de la disponibilidad de fuentes y de la exactitud de las mismas, se debe tener en cuenta la credibilidad de la víctima, la disimulación o simulación del acusado, la imparcialidad del informante, etc. En definitiva, conocer en qué medida podemos confiar nuestra toma de decisión en la información disponible o en la fuente que la proporciona.
4. *Temporalidad de la información:* es necesaria una evaluación actual de la situación reciente del caso. La utilidad de la información tendrá un plazo de vigencia o caducidad; de hecho, muchas herramientas establecen criterios temporales a la hora de codificar sus factores de riesgo. En algunos casos se señalan marcos temporales en los que considerar la presencia de un factor (por ejemplo, amenazas graves el último mes en la EPV-R), y en otros distintos momentos para la codificación de los ítems (por ejemplo, presencia del factor el último mes o en el pasado —anterior al último mes— en el B-SAFER, o presente —último año—, pasado y futuro en el RSVP).
5. *Especificidad y temporalidad de la evaluación:* la valoración se realiza en términos específicos (para tipos de conducta concretos o para contextos determinados; no podemos utilizar cualquier herramienta para cualquier violencia) y para períodos limitados en el tiempo (el riesgo es variable, por lo que la vigencia del resultado se debe acotar temporalmente). Relacionado

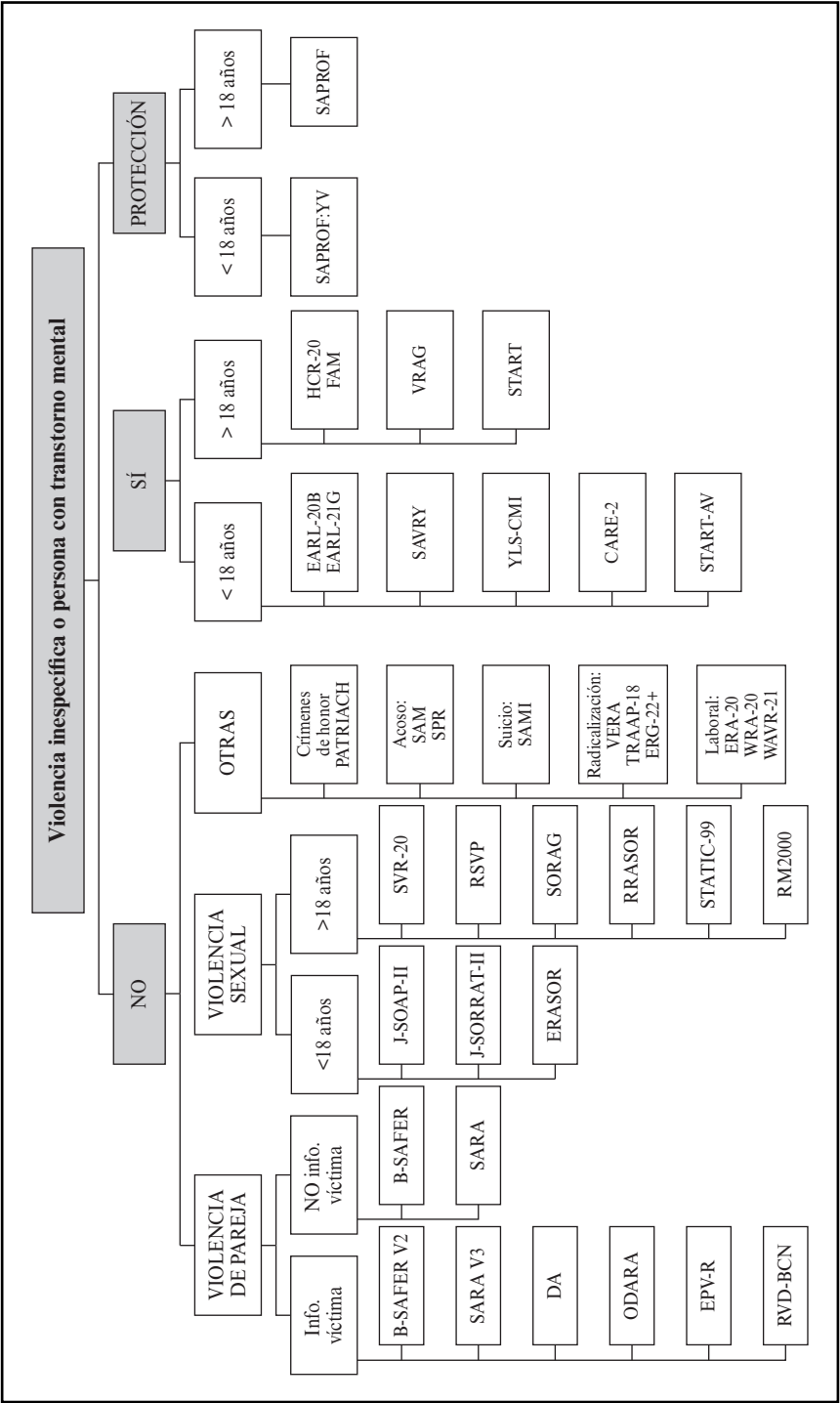


Figura 7.2.—Mapa de decisión para la elección de algunas de las herramientas disponibles.

CLAVE 9.**Especificidad y temporalidad del riesgo**

La predicción se realiza en términos específicos (para tipos de violencia concretos o contextos determinados) y para períodos limitados en el tiempo (el riesgo es variable, por lo que la vigencia del resultado está acotada temporalmente).

con el punto cuatro, el riesgo es dinámico porque la vigencia de los factores de riesgo es limitada debido a la evolución de los casos, las situaciones y los contextos.

Teniendo en cuenta estos cinco puntos clave, el profesional deberá optar por la herramienta que mejor se adecúe a sus objetivos y con la que pueda desarrollar una evaluación más precisa y fiable, en términos de riqueza de información e utilidad del resultado. En la figura 7.2 se presenta un sencillo árbol de decisión para escoger algunas de las herramientas disponibles según el tipo de violencia que nos interese estimar, el posible agresor y su edad; en el caso de la violencia de pareja se elige también según el acceso a información de la víctima.

2. LA EVALUACIÓN

Con evaluación nos referimos al paso concreto en el que el profesional procede a estimar la presencia y relevancia de los factores que componen una herramienta. Ello supone recopilar la información de interés, determinar la presencia de los factores de riesgo y valorar la relevancia de los factores para el caso concreto (tal como se enumera en la tabla 7.1).

a) Recopilar la información del caso

Como ya hemos mencionado, un aspecto importante es conocer la información que requerimos para cumplimentar la herramienta. En este

sentido, es habitual que necesitemos entrevistas con los distintos implicados en el problema: agresor, víctima, familiares y otros profesionales (aunque algunas herramientas se fundamentan exclusivamente en las respuestas de la víctima, como la DA). También se suele requerir información proveniente de protocolos o pruebas psicométricas (en especial para valorar sintomatología psicológica o la presencia de trastornos) o diagnósticos clínicos provenientes de otros profesionales, información de sentencias y registros oficiales para los datos correspondientes a actividades delictivas (policiales y judiciales principalmente, sobre antecedentes, historial, ingresos en prisión, quebrantamientos, detenciones, etc.), historiales penitenciarios o psiquiátricos e informes de otros profesionales.

Se recomienda incluir en algún apartado concreto (si es que no incluye dicho espacio el protocolo que estemos aplicando) un listado de las fuentes consultadas. Esto es importante por varios motivos: 1) porque justifica las bases en las que se fundamenta la opinión; 2) porque pone de manifiesto las posibles limitaciones de la evaluación; 3) porque sirve como lista de comprobación de cara a futuras valoraciones en las que se deba ampliar la información; y 4) porque es de ayuda para cualquier profesional al que llegue la valoración del caso y quiera hacerse una idea de cuán comprehensivo ha sido el trabajo previo.

b) Sinopsis del caso

Algunas guías de juicio estructurado incluyen en la primera página de su hoja de trabajo (plantilla en la que se recopilan las respuestas a los ítems) un espacio necesario para incorporar detalles del caso que son relevantes para la evaluación del riesgo. Este apartado suele ser un espacio para un resumen en el que describir los antecedentes, el tipo de violencia, los acontecimientos más llamativos, los posibles desencadenantes, evaluaciones previas, etc. Como veremos en pasos posteriores, esta sinopsis podrá ser de utilidad en la formulación del riesgo.

TABLA 7.1
Esquema de pasos para valorar los factores de riesgo

Paso 1. Recopilar la información de interés. Según la amplitud de la herramienta y su contenido, será necesaria más o menos información para cumplimentarla y se deberá recurrir a distintas fuentes (por ejemplo, víctima y agresor, informe psicológico, etc.).
Paso 2. Elaborar una breve sinopsis. Suele resultar útil, por lo que en algunas hojas de trabajo se incluye un apartado específico en el que describir un breve resumen sobre el caso, con los aspectos más relevantes. Este resumen sirve para agrupar la información más importante del caso concreto y resulta de ayuda para otros profesionales que deban valorar el caso o para futuras valoraciones del riesgo que deba hacer el mismo evaluador.
Paso 3. Codificar cada ítem a) Codificar la presencia o ausencia de los ítems con la siguiente pauta: — SÍ (presente): cuando el factor está claramente presente. — NO (ausente): cuando el factor está claramente ausente. — ? (parcialmente presente): cuando no es clara la presencia o ausencia del factor, la presencia del mismo es parcial o la instrucción del ítem así lo indica (por ejemplo, con un punto de corte). <i>Importante:</i> debemos recordar que la ausencia de información para responder a un ítem es una limitación de nuestra valoración del riesgo y que no equivale a las codificaciones «?» o «No». Debido a los errores que se podían derivar por este motivo, las herramientas más recientes (como HCR-20^{V3} y SARA-V3) señalan también la omisión del ítem (O) entre las opciones de codificación. b) Justificar cada valoración añadiendo información del caso que explique la decisión sobre la presencia o ausencia del ítem.
Paso 4. Valorar la relevancia de los factores. Puede no corresponder a ningún apartado concreto de la herramienta, pero supone considerar cuáles de los factores presentes son especialmente relevantes para el caso concreto y la conducta específica que queremos valorar.

c) Valorar la presencia de los factores de riesgo y/o protección

Con la información recopilada, debemos ser capaces de valorar la presencia o ausencia de cada factor de riesgo y/o protección, además de justificar el motivo por el cual lo codificamos como presente o ausente. Por ello, este punto incluye localizar la información necesaria para dar respuesta a cada factor dentro del listado de fuentes descrito en el apartado a). Recordamos que la falta de información necesaria es una limitación de nuestra evaluación y que el ítem al que

afecte dicha limitación deberá ser codificado como omitido.

Algunas herramientas solicitan que se codifique la presencia o ausencia de los factores en el momento actual o en el pasado (por ejemplo, B-SAFER y RSVP). Otras solicitan que se valore si ha habido un cambio en el factor, mejorando o empeorando (por ejemplo, SVR-20). En el SAVRY, por su parte, la codificación de los factores de riesgo (24 de los 30) se hace conforme al criterio de «bajo, moderado o alto», siendo equivalente a ausente, parcialmente presente o que no sea grave, y presente o que cause deterioro, respectivamente.

d) Determinar la relevancia de los factores de riesgo

La experiencia acumulada en la investigación sobre evaluación del riesgo ha demostrado que no solo es relevante la acumulación de factores de riesgo o la presencia de determinadas variables en un caso. Es necesario conocer la relevancia específica que tienen las distintas variables para el caso concreto, pues el mismo factor puede influir de forma distinta en cada persona y, por otro lado, el riesgo no correlaciona de forma lineal con el número de factores presentes. Además, el hecho de que un factor de riesgo esté presente no implica de forma automática que sea relevante para el caso. Por ejemplo, un sujeto puede tener problemas de empleo, pero estos no tener ninguna relación con su conducta violenta, o con las circunstancias que la rodean, o no ser relevantes de cara a la posible reincidencia.

La versión 2 de la SARA contempla la posibilidad de señalar hasta tres factores que el evaluador considere críticos, teniendo presente que la sola presencia de uno de estos es suficiente para considerar el caso de riesgo alto. Esta opción no se ha mantenido en la tercera versión de la herramienta (2016), siendo ahora necesario considerar la relevancia de cada uno de los factores teniendo en mente la formulación del caso, al igual que ocurre en la HCR-20^{V3}. Como pauta general, se utiliza el código de codificación descrito en la tabla 7.1.

3. FORMULACIÓN DEL RIESGO

La formulación del riesgo ha sido y sigue siendo la gran desatendida en el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia. Stephen Hart, promotor del juicio profesional estructurado, afirma que esto se ha debido a la proliferación de herramientas actuariales y al predominio del enfoque predictivo, con el uso casi exclusivo de métodos de análisis cuantitativos. Para el autor, ahora hemos empezado a dejar de pensar en números para pasar a un pensamiento basado en la evidencia, o, lo que es lo mismo, ir de la fórmula

CLAVE 10.

Formulación del riesgo

Método para integrar la información de un caso, que busca ofrecer una explicación sobre la violencia cometida y los roles causales que juegan los distintos factores de riesgo y de protección presentes en el caso.

Su objetivo es diseñar las estrategias preventivas adecuadas para reducir el riesgo de que esta violencia pueda repetirse.

(matemática) a la formulación (véase Hart y Logan, 2011). En el momento actual, y en especial con la publicación de la HCR-20^{V3}, la formulación ha cobrado relevancia en el procedimiento. Precisamente, su inclusión como paso específico en la evaluación del riesgo ha sido el principal aporte de la HCR-20^{V3}.

La formulación ha estado presente en el contexto clínico-forense desde mucho tiempo atrás, método con el que se ha querido explicar la conducta delictiva. En especial, se han vinculado variables de personalidad predisponentes, el rol causal de la ira y la relación de los trastornos mentales y la delincuencia (Thomas-Peter y Howells, 1996). La formulación del riesgo se introdujo en la metodología en la década de los noventa (Lewis y Doyle, 2009). Las propuestas iniciales supusieron un aporte al juicio estructurado en comparación con el juicio clínico y el método actuarial (Doyle y Dolan, 2002). De forma similar al análisis funcional en el contexto clínico, la formulación en evaluación del riesgo trata de dar una explicación al caso y proponer la mejor intervención según esta explicación. La formulación buscaría dar respuesta, tras la evaluación, a cuestiones como cuáles son los antecedentes, qué factores están presentes (de riesgo y de protección), qué personas concretas están en riesgo, qué factores pueden incrementar o reducir el riesgo, etc.

Hart, Sturmey, Logan y McMurran (2011) definen la formulación en el ámbito de la salud mental como «el proceso o producto de la obtención e integración de diversa información

para desarrollar un relato conciso de la naturaleza y etiología de los problemas que afectan a la salud mental de una persona para guiar el diseño del tratamiento ideográfico¹ y la toma de decisiones» (p. 118). En el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia, por formulación del caso se entiende el ofrecer una posible explicación, o serie de asunciones o especulaciones, sobre la violencia del caso evaluado (Cook, Murray, Amat y Hart, 2014). Se busca entender el problema del sujeto, a partir de su conducta pasada y las circunstancias y motivos que pueden hacer que se repita la violencia, para diseñar las intervenciones más adecuadas (Logan, Nathan y Brown, 2011). Equivaldría a la que puede ser la mejor explicación a una serie de hechos relevantes en nuestro sujeto.

Las guías de juicio profesional estructurado sirven como herramientas de análisis que ayudan a los evaluadores a desglosar los factores de riesgo relevantes para el caso, centrar su atención en un volumen relativamente pequeño de información de gran relevancia y reconstruir estas piezas de información en una formulación que se apoya en la teoría y la investigación (Cook et al., 2014). En esencia, ayudan a simplificar un caso, reduciéndolo a factores mínimos para generar una explicación precisa y detallada.

Según Hart y Logan (2011), en el juicio estructurado la formulación se organiza de dos formas: 1) se analiza la violencia pasada como una toma de decisión, y 2) se especula sobre la violencia futura y se desarrollan planes de gestión utilizando la planificación de escenarios. Entender la violencia como una decisión supone la comisión de actos voluntarios dirigidos a un objetivo, que incluye la elección de la persona hacia la que se dirige la violencia, el tipo de violencia que se cometerá y cuándo se hará. Una de las preguntas que nos debemos hacer es: ¿por qué la persona cometió un acto violento, de un tipo concreto y

contra una persona determinada? En esta toma de decisión, se argumenta, la persona habrá pasado por un proceso de cuatro pasos:

1. La idea de actuar de forma violenta le rondó la cabeza al sujeto y este no la desechó.
2. Valoró las posibles consecuencias positivas de esta violencia y consideró que tendría beneficios. Este punto lo consideran crítico, pues si no entendemos en qué medida la violencia fue percibida por la persona como beneficiosa realmente no entenderemos por qué actúa de forma violenta. Es lo que hemos definido como motivadores en el apartado 3 del capítulo 4.
3. Valoró las posibles consecuencias negativas de la violencia y consideró que los costes eran aceptables. Entre los costes se incluyen el malestar derivado de la empatía, los remordimientos, la ansiedad ante posibles castigos, la disonancia con valores personales, la pérdida de respeto, la pérdida de relaciones e incluso la pérdida de la libertad. Es lo que hemos definido como desinhibidores en el apartado 3 del capítulo 4.
4. Evaluó las opciones para cometer la violencia y la consideró viable. Incluso cuando la gente quiere actuar de forma violenta debe superar distintas barreras: cómo localizar a la víctima, cómo contactar con ella o aproximarse, cómo amenazar o causar daño y cómo huir o evitar ser detenido.

De acuerdo con el modelo de toma de decisión, la tarea de la evaluación del riesgo consiste en conocer cómo y por qué la persona tomó la decisión de actuar de forma violenta y comprender los factores que influyeron en esta decisión. Estos factores podrán haber motivado, desinhibido o desestabilizado la toma de decisión, tal como hemos analizado en el apartado 3 del capítulo 4. Además, la gestión consistirá en determinar estrategias que permitan al sujeto tomar la decisión de actuar de forma prosocial o desalentar las decisiones de actuar de forma violenta.

¹ Por ideográfico se entiende un enfoque individualizado que solo pretende explicar o afectar a un caso concreto. Es lo opuesto a nomotético, que busca explicaciones universales o grupales.

Logan (2014) describe la formulación como el acto de comprender el mecanismo que hay detrás del potencial violento de un individuo, con el fin de desarrollar hipótesis para facilitar el cambio, que sean sensibles y proporcionadas (incorporadas dentro del plan de gestión). El punto de partida es la organización de la información más relevante del caso, respondiendo con el modelo clínico de las 5Ps (añadiendo el «problema» a las 4Ps de Weerasekera, 1996): problema (riesgo de qué), predisponentes (debilidades), precipitantes (disparadores), perpetuadores (mantenedores) y protectores. Lo más importante es responder al tipo de problema concreto (¿riesgo de qué?), y mejor con más detalle que de forma genérica («violencia física contra la pareja» mejor que «violencia»). Otro modelo de análisis propuesto es el de las 3Ds: motivadores (*drivers*), desinhibidores y desestabilizadores. Una vez organizada la información relevante con cualquiera de estos modelos, el evaluador puede comenzar la formulación del riesgo, que se traduce en una narración que explica los mecanismos que están en la base de la violencia del sujeto.

Cook et al. (2014) diferencian entre la formulación en evaluación del riesgo (para comprender los posibles roles que juegan distintos factores de riesgo en la decisión del evaluado sobre por qué, cómo, cuándo, dónde y contra quién actuar de forma violenta) y la formulación de los planes de gestión (los métodos de planificación de escenarios pueden ayudar a los evaluadores a identificar las estrategias que parecen razonablemente necesarias para una prevención efectiva de la violencia).

Lewis y Doyle (2009) propusieron un modelo de evaluación del riesgo en cinco pasos, en el que la formulación es clave para planificar el tratamiento y tomar decisiones sobre la gestión. El procedimiento supone ir más allá del simple análisis de factores de riesgo, para pensar en cómo interactúan las variables en el caso concreto (predisponentes, precipitantes, mantenedores y protectores). La estructura de su modelo es la siguiente:

1. Información del caso.
2. Presencia de factores de riesgo.

3. Presencia de factores protectores.
4. Formulación del riesgo:
 - a) *Historia* (predisponentes): naturaleza, gravedad y frecuencia de la violencia.
 - b) *Presente* (precipitantes): inminencia, probabilidad y signos de riesgo.
 - c) *Futuro*: factores o circunstancias que puedan reducir el riesgo (protectores) y factores o circunstancias que puedan aumentar el riesgo (mantenedores).
5. Plan de gestión: tratamiento, seguimiento, supervisión, planes de seguridad para la víctima e intervención en crisis.

El proceso de formulación en salud mental es (Hart et al., 2011): 1) *deductivo* (explica o justifica las predicciones); 2) *orientado a la acción* (ayuda al profesional en la comprensión del problema, la priorización del tratamiento y la planificación de las estrategias, anticipando las respuestas del sujeto); 3) *guiado por una teoría* (sobre la causa del problema o su solución); 4) *individualizado* (pese a partir de una teoría, también tiene en cuenta la información individual de cada caso); 5) *narrativo* (no se fundamenta en fórmulas o cálculos numéricos); 6) *diacrónico* (en el sentido de considerar pasado, presente y futuro del sujeto); 7) *evaluable* (al tratarse de una teoría individual, orientada a la formulación, está diseñada para ser puesta a prueba); y 8) *ampliador* (trasciende el simple resumen de información disponible para generar nuevo conocimiento sobre el caso).

Algunos autores han propuesto una serie de criterios para valorar la calidad de una formulación (Cook et al., 2014; Hart et al., 2011):

1. Su apoyo en un marco teórico aceptado (coherencia externa).
2. La calidad de los hechos en los que se fundamenta.
3. Estar libre de contradicciones o hacer asunciones compatibles (coherencia interna).

4. Su amplitud explicativa, incorporando tanta información relevante como sea posible.
5. La capacidad de juntar el pasado, el presente y el posible futuro del caso.
6. La claridad y sencillez de las expresiones (simplicidad).
7. Su fiabilidad o medida en la que distintos profesionales desarrollarían formulaciones similares o estarían de acuerdo con la formulación hecha.
8. La capacidad de generar predicciones precisas y contrastables (aplicabilidad).
9. Su precisión o capacidad de predecir los hechos más importantes.
10. Su aceptación por parte de los implicados (sujetos evaluados, profesionales), promoviendo la comprensión del caso y guiando actuaciones.

En conclusión, la formulación hace más efectiva la comunicación del riesgo (Lewis y Doyle, 2009). A diferencia del uso de etiquetas categoriales (bajo, medio o alto; véase apartado 6), la formulación del riesgo puede verse como un enfoque explicativo centrado en la comprensión del riesgo, de sus causas y de las circunstancias en las que se manifestará. Se trata de un paso clave para desarrollar recomendaciones de gestión más sensibles y proporcionadas, pero el conocimiento es aún limitado y la investigación escasa (Lewis y Doyle, 2009; Logan, 2014). Junto a las principales referencias mencionadas en este apartado, específicas de la evaluación del riesgo de violencia, podemos encontrar distintas referencias sobre la formulación en contextos clínico-forenses (por ejemplo, Sturmey, 2009; Sturmey y McMurrin, 2011).

Recurso 5

Elaboración de una formulación del riesgo

El proceso de formulación se debe realizar teniendo en mente que se trata de una explicación de la conducta del sujeto y que deberá ayudarnos a destacar aquellas piezas de la ecuación que pueden evitar que la agresión vuelva a ocurrir o el riesgo se reduzca.

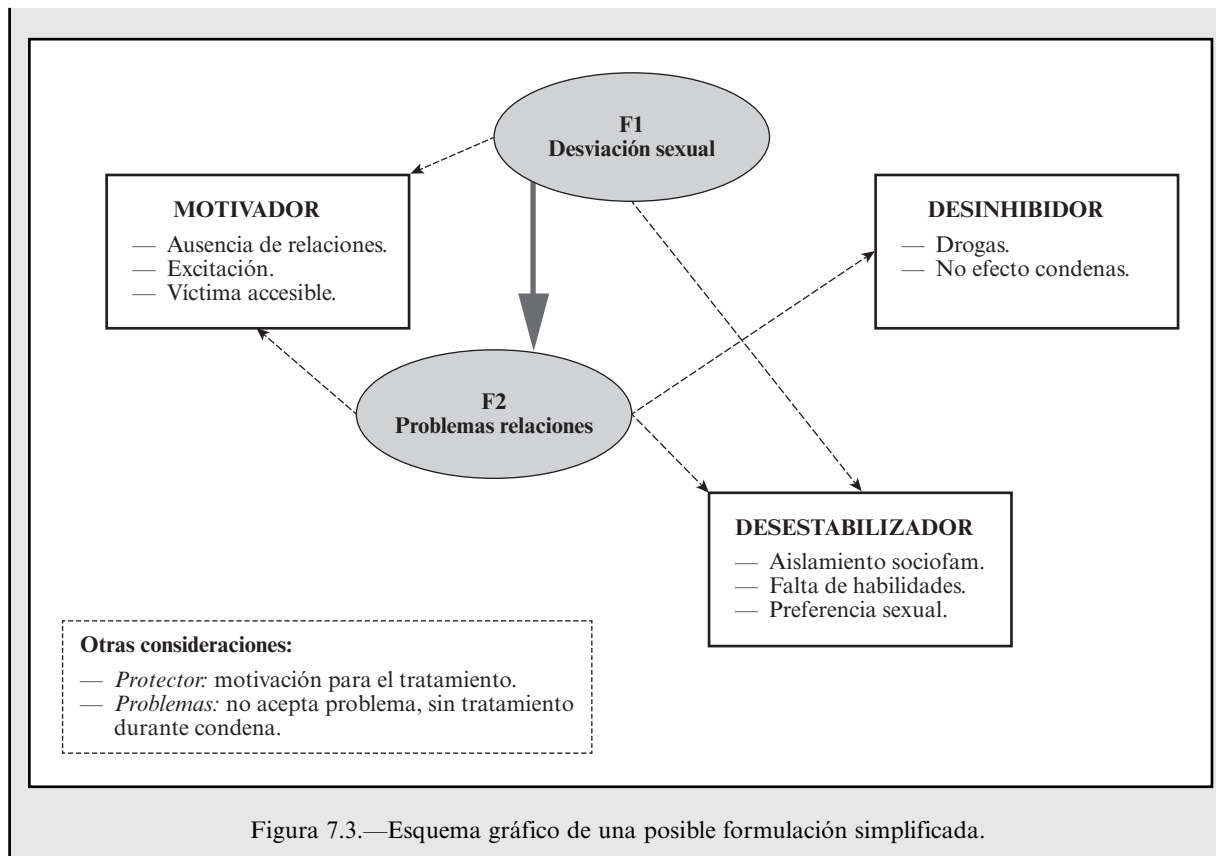
En primer lugar, se debe pensar en los **factores de riesgo identificados**, tanto en la herramienta aplicada como cualquier otro que esté presente en el caso y sea de interés. Debemos considerar su relevancia para entender, explicar y prevenir la conducta violenta del sujeto.

Identificaremos posibles causas primarias, representadas en el gráfico con la letra F en un círculo, que equivalen a las principales explicaciones de la violencia de nuestro caso: conflicto marital (p. ej., disputas económicas), toxicomanía, problemas relacionales, desviación sexual, trastorno mental, estilo de vida antisocial, etc. Pueden tener conexiones entre sí o con los factores de riesgo.

Identificaremos los roles causales que pueden cumplir los factores presentes: motivadores, desinhibidores y/o desestabilizadores. Los tres roles se representan en el gráfico en los cuadrados. Los factores, además, pueden desempeñar o haber desempeñado distintas funciones, según la siguiente tabla. En nuestro análisis deberemos tener estas funciones presentes.

Predisponentes	Precipitantes	Perpetuadores	Protectores
Debilidades ↓ Historia	Disparadores ↓ Presente	Mantenedores ↓ Futuro	Distancian del problema

Causas primarias y factores de riesgo podrán tener distintas conexiones (representadas con fechas) que expliquen el problema del caso. Nuestro modelo conviene que esté apoyado en alguna teoría delictiva (p. ej., habituación, preferencia sexual, estrés, etc.) y deberá ayudarnos a explicar y entender la **función que cumple la violencia**, detectando aquellos ámbitos que requieren mayor intervención.



4. DESARROLLO DE ESCENARIOS

Junto a la formulación, que requiere una gran reflexión y un análisis en profundidad del caso, el desarrollo de escenarios es una de las etapas más complicadas de la evaluación del riesgo. Puede parecer un proceso de adivinación, pues implica imaginarnos el futuro para poder gestionarlo; por ello, para algunos resulta complicado comprenderlo desde el punto de vista técnico. A continuación describiremos su fundamento teórico y el proceso de aplicación en el caso de la evaluación del riesgo de violencia.

El desarrollo de escenarios no es una técnica específica de la predicción de la violencia, sino que

ha sido utilizada en distintas disciplinas y, de hecho, es en estas disciplinas donde más material podemos encontrar. En contextos dedicados a la gestión, especialmente empresarial, el desarrollo de escenarios se presenta como el método para la toma de decisiones en situaciones de futuros inciertos, con cambios tecnológicos veloces, mercados financieros volátiles, rápidos cambios sociales e inestabilidad política (véase Martelli, 2014). En estas circunstancias, el análisis de escenarios ofrece un enfoque sistemático para pensar en cómo podría ser el futuro y una guía para la toma de decisiones estratégicas.

La planificación de escenarios se ha descrito como un método para desarrollar y analizar posi-

bles futuros y vías de desarrollo (Schoemaker, 1995). Su objetivo no es predecir, sino comprender mejor las vías lógicas que dan lugar a distintos escenarios y así desarrollar estrategias para afrontarlos. Entre los objetivos de los escenarios se señalan el reemplazar los análisis de tipo lineal o predicciones únicas, reducir la incertidumbre y anticipar la complejidad (Martelli, 2014). La planificación de escenarios es el enlace entre los posibles futuros y las acciones estratégicas (Lindgren y Bandhold, 2009).

Wulf, Meissner, Brands y Stubner (2013) señalan una serie de pasos compartidos por la mayoría de modelos de planificación de escenarios:

- *Definir objetivos*: también conocido como preparación, consiste en determinar cuál es el objetivo del escenario delimitando aspectos como el marco temporal.
- *Analizar percepciones* de los implicados en la planificación del escenario. Se contrastan opiniones de terceros no implicados en el caso para ampliar la perspectiva de futuro.
- *Analizar tendencias e incertidumbres*, considerando y priorizando las variables implicadas en el problema.
- *Construir escenarios*: las incertidumbres del paso anterior se convierten en escenarios futuros y se añaden otros factores para crear posibles futuros.
- *Definir estrategias*: se ponen a prueba distintas respuestas para los escenarios planteados, de forma que los gestores tienen más respuestas entre las que escoger.
- *Monitorizar*: se establecen indicadores que señalarán si son necesarias nuevas estrategias (respuestas frente a cambios del ambiente).

Esta estrategia de gestión, proveniente principalmente de la acción empresarial, ha sido el modelo incorporado al juicio profesional estructurado en la evaluación del riesgo de violencia, pese a que el desarrollo empírico y teórico de la materia esté aún en sus inicios en este ámbito. A continuación describiremos los matices específicos en materia de violencia.

4.1. Escenarios en evaluación del riesgo de violencia

La elaboración de escenarios no equivale a una predicción sobre lo que pasara, sino un pronóstico general o especulación sobre lo que podría pasar, teniendo en cuenta el conocimiento general y la experiencia del evaluador, así como los aspectos específicos del caso con el que se está trabajando (Hart y Logan, 2011). Los escenarios son hipótesis de futuro fundamentadas en los datos provenientes de la evaluación del riesgo (situaciones futuras, con posibilidad de ocurrir, estimadas a raíz de la aplicación de los pasos previos). Pensar en escenarios equivale a pensar en qué puede hacer el sujeto, qué tememos, bajo qué circunstancias y cómo se podría reducir ese riesgo (lo cual propondremos en el apartado de la gestión).

Para desarrollarlos se debe considerar la naturaleza de la violencia, su gravedad, su inminencia, su frecuencia o duración y, por último, su posibilidad de ocurrencia. La descripción de escenarios es un paso que requiere una alta implicación del profesional en la evaluación y grandes conocimientos y experiencia en el tipo de caso evaluado.

Describir un escenario no solo supone resumir en una situación probabilística (probable en sentido de incierto, estimado, posible, no en sentido numérico) aquellos aspectos detectados en la evaluación, sino que implica ir más allá, tratando de anticipar qué problemas se le pueden presentar al sujeto.

CLAVE 11.

Escenarios

Son hipótesis de futuro fundamentadas en los datos provenientes de la evaluación del riesgo.

NO equivalen a una predicción sobre lo que pasara, sino a un pronóstico general o especulación sobre lo que podría pasar.

Un punto de partida para la elaboración de un escenario puede consistir en dar respuesta a cuestiones como ¿cuáles son los posibles futuros?, ¿qué situaciones requieren mayor atención?, ¿qué estrategias pueden maximizar el éxito en la prevención? Entre los aspectos a considerar para la elaboración de un escenario se señalan los siguientes (Hart y Logan, 2011; Watt, 2012):

- *Repetición*: pensar en un escenario que incluya una violencia similar a la ya cometida por el sujeto. Se recomienda considerar todo tipo de violencia pasada, no solo la más reciente. Este escenario representaría una trayectoria lineal.
- *Mezcla*: se trata de escenarios en los que la naturaleza de la violencia cambia, bien en la selección de la víctima o bien en el tipo de agresión. Se recomienda valorar los posibles cambios en motivantes, victimología y comportamientos.
- *Escalada*: también considerado un escenario pesimista, supone imaginar una trayectoria al alza en la frecuencia o la gravedad de la violencia. Se trataría del peor caso posible, pudiendo llegar a incluir la posibilidad de violencia letal.
- *Mejora*: consiste en imaginar un escenario optimista, uno en el que la trayectoria de violencia decrece o la violencia es menos grave. Supone incluir la mejor hipótesis posible o incluso el desistimiento.

Al margen de estas recomendaciones, hay que tener presente que los escenarios se deben ajustar a la realidad del caso evaluado y que, por tanto, no es válido para cualquier caso estimar una mezcla en el tipo de violencia o víctima, o una escalada con posibilidad de agresión letal. Por tanto, los escenarios (el mejor y peor de los casos) deben ser realistas y plausibles, reflejo de la historia, trayectoria, situación actual y situación futura de nuestro caso.

Una vez ideados los posibles escenarios, estos pueden ser sometidos a evaluación atendiendo a los siguientes aspectos (Watt, 2012): *plausibilidad*

(su fundamento debe ser relevante, comprensivo y creíble), *utilidad* (que el escenario guíe el desarrollo de estrategias de gestión del riesgo específicas) y *consenso* (que distintos evaluadores puedan imaginar escenarios similares). Aunque el espectro de escenarios a imaginar podría ser infinito, se recomienda diseñar solo aquellos que sean plausibles y más útiles para nuestro caso, lo que en la práctica se suele traducir en entre tres y cinco. En cada escenario el evaluador deberá detallar la naturaleza, gravedad, inminencia, frecuencia o duración y la probabilidad de la violencia. Los escenarios serán utilizados para la gestión propuesta en el siguiente paso.

5. GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo (*risk management*), aunque objetivo prioritario del procedimiento, ha permanecido en segundo plano en la tradición de la predicción del riesgo, donde la máxima era acertar o fallar (véase apartado 3 del capítulo 3). Gestionar el riesgo consiste en dar los pasos necesarios, tras una evaluación, que permitan reducir el riesgo, evitar una futura agresión o minimizar las consecuencias en caso de que esta se produzca (Hart, 2008; Kropp, 2008). Esto es importante, porque muchas veces no podemos evitar que algo ocurra, pero sí que tenga consecuencias fatales.

Storey y Hart (2011) diferencian entre tácticas y estrategias de gestión:

- *Táctica*: actividad específica cuyo objetivo final es promover el cese de la violencia o reducir la vulnerabilidad de la víctima (por ejemplo, en el caso del acoso, proponen la instalación de medidas de seguridad, cambio de número de teléfono que no sea de dominio público o advertencia policial al acosador).
- *Estrategia*: grupo de tácticas que tienen el mismo objetivo o que afrontan el objetivo en una forma similar (por ejemplo, mejorar la seguridad o disuadir al acosador).

Existen distintas formas de gestionar el riesgo. En esencia, las opciones disponibles responden a los recursos de cada contexto. Por ello, es imprescindible que quien evalúe el riesgo y haga una propuesta de gestión tenga presentes los recursos y las limitaciones del ámbito en el que desarrolla su actividad. Por ejemplo, no tiene sentido hacer una propuesta de tratamiento a un servicio policial, donde los encargados de la gestión ni están capacitados ni se dedican al tratamiento del agresor, o en una zona donde no hay tratamientos disponibles. Sin embargo, la misma recomendación puede tener sentido si se dirige a los servicios y recursos que pueden desarrollar una intervención.

Justo a la pertinencia de la propuesta se dan una serie de errores habituales en las propuestas de gestión (Conroy y Murrie, 2007): 1) hacer propuestas sin base científica (por ejemplo, proponer tratamientos de forma genérica o hacer atribuciones sobre la influencia de variables concretas en la reincidencia, cuando la investigación no lo avala); 2) centrarse en un único objetivo (por ejemplo, es habitual que psiquiatras y psicólogos focalicen la gestión en el tratamiento psicológico, cuando la prevención del riesgo debe ser multidisciplinar y abordar distintas fuentes de riesgo); y 3) aplicar soluciones de talla única (programas estándar para grupos heterogéneos). Por tanto, nuestras propuestas de gestión deben ir más allá de estas convencionalidades o rutinas, muchas veces equivocadas.

Las actividades para gestionar el riesgo se pueden clasificar en cuatro grupos (Hart, 2008; Kropp, 2008):

- *Monitorización*: evaluaciones repetidas para valorar modificaciones del riesgo; puede incluir entrevistas frecuentes con el agresor, con la víctima o con otros informantes.
- *Tratamiento*: su objetivo es la rehabilitación del sujeto mejorando déficits psicosociales.
- *Supervisión (control)*: conlleva la restricción de derechos individuales del agresor,

por ejemplo con localización permanente, órdenes de alejamiento, etc.

- *Planes de seguridad para la víctima*: buscan reducir las consecuencias de una posible agresión.

Las propuestas de gestión estarán basadas en el conocimiento del contexto (recursos disponibles), en la experiencia del profesional (funcionamiento en casos previos) y en la investigación disponible (recomendaciones provenientes de estudios empíricos). Entre los posibles pasos que se deben seguir para adoptar la mejor alternativa de gestión se encuentran los siguientes (Hart, 2008):

1. Las estrategias de gestión deben ser el reflejo del riesgo específico del sujeto, así como de la naturaleza y magnitud de la violencia estimada. Se pueden describir distintos escenarios en los que gestionar el riesgo y cuantificar el grado de riesgo del sujeto en términos absolutos (posibilidad de ocurrencia) o en términos relativos (expresando la atención necesaria: prioridad baja, moderada o alta, por ejemplo).
2. Las distintas propuestas de intervención (o gestión) se deben dirigir a aspectos o factores de riesgo específicos, de modo que puedan quedar neutralizados por las acciones planteadas. Como hemos señalado ya, los factores de riesgo pueden ser relevantes por distintos motivos: por ser *motivadores* (hacen la violencia atractiva o reforzante), *desinhibidores* (implican una menor obediencia de las normas y menor efecto disuasorio) u *obstructores* (disminuyen la eficacia de las actividades de prevención).
3. Las estrategias deben personalizarse en la medida de lo posible para poder maximizar su eficacia. Para mejorar el efecto, cada factor de riesgo debería tratar de neutralizarse con varias estrategias.

El formato en el que el profesional propone la modalidad de gestión puede variar. Las guías de juicio estructurado suelen ir acompañadas de ho-

jas de trabajo en las que el profesional plasmará sus recomendaciones sobre la propuesta de gestión. Un ejemplo de este apartado se muestra en la tabla 7.2.

TABLA 7.2
Ejemplo del apartado dedicado a la gestión del riesgo en hojas de trabajo prototípicas de las guías de juicio estructurado

Paso 4. Estrategias de gestión Recomendar estrategias para gestionar el riesgo a partir de los pasos 2 y 3			
	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Monitorización • ¿Cuál es la mejor forma de controlar las señales de alerta de que el riesgo que supone la persona puede estar incrementando? • ¿Qué eventos, incidentes o circunstancias deberían dar lugar a una reevaluación del riesgo?			
Tratamiento • ¿Qué tratamiento o estrategias de rehabilitación podrían ser implementadas para gestionar el riesgo que supone la persona? • ¿Qué déficits en el ajuste psicosocial son de alta prioridad para la intervención?			
Supervisión • ¿Qué estrategias de supervisión o vigilancia podrían ser implementadas para gestionar el riesgo que supone la persona? • ¿Qué restricciones en la actividad, movimiento, relaciones o comunicación están indicadas?			
Planes de seguridad para la víctima • ¿Qué pasos se podrían dar para mejorar la seguridad de cualquier víctima potencial? • ¿Cómo podrían mejorarse la seguridad física o las habilidades de autoprotección de las potenciales víctimas?			
Otras consideraciones • ¿Qué eventos, incidentes o circunstancias podrían incrementar o reducir el riesgo? • ¿Qué más podría hacerse para gestionar el riesgo?			

Adaptado y reproducido con permiso ©2010, Mental Health, Law, & Policy Institute. Simon Fraser University, todos los derechos reservados.

Conroy y Murrie (2007) propusieron diez principios para una gestión del riesgo efectiva:

1. El mayor número de recursos y energía debe destinarse a los sujetos con mayores niveles de riesgo, en la línea del modelo RNR.
2. Los factores de riesgo identificados deben relacionarse directamente con las estrategias de gestión.
3. Una entidad claramente identificada debería monitorizar el plan de gestión (hay muchas disciplinas implicadas en la evaluación del riesgo, siendo necesario un encargado de centralizar y supervisar el plan de trabajo).
4. Los gestores deben pensar más allá de los tratamientos convencionales (los tratamientos estándar no funcionan con todos los sujetos, por lo que se deben ajustar a las necesidades concretas del evaluado).
5. Los planes de gestión se deben ajustar a las realidades situacionales (la propuesta debe incluir recursos disponibles y su implementación debe ser viable, teniendo en cuenta las infraestructuras del contexto concreto, cuestiones de transporte, capacidad de los profesionales, etc.).
6. Se deben identificar canales de comunicación claros (interlocutores implicados, responsables de transmitir la evaluación, supervisores del caso, etc.).
7. El plan debe ser específico pero flexible, implicando al evaluado lo máximo posible (se debe explicar cuáles son los motivos de nuestra decisión y qué circunstancias harán que se modifique).
8. Los mecanismos deberán estar en marcha para ofrecer intervenciones inmediatas y graduales (se deben anticipar a la violencia y no solo destinar a incapacitar o castigar al sujeto; además, deben ser capaces de detectar e impedir la escalada de violencia).
9. Se deben aclarar cuestiones relativas a la confidencialidad e informe legal (pese a

la confidencialidad existente en profesionales de la salud mental, en el contexto de la gestión del riesgo el informe a las autoridades judiciales suele ser necesario; por ello, se deberá aclarar al evaluado qué es confidencial y qué no lo es, en especial en contextos en los que se mezcla el rol terapéutico).

10. Debe haber un mecanismo en marcha que permita una reevaluación regular del caso y la modificación del plan de gestión (la gestión parte de la idea de que el riesgo es dinámico, por lo que se debe garantizar la reevaluación y reconsideración de la medida).

5.1. Investigación sobre gestión del riesgo

En la actualidad, la gestión del riesgo es un aspecto imprescindible e inseparable de la evaluación del riesgo; se presta especial atención a las estrategias de gestión, los pasos en la toma de decisiones y cómo afectan distintos aspectos (como los factores de riesgo, el entrenamiento de los profesionales, la intensidad de la intervención o el tipo de estrategia de gestión) a la relación entre gestión y reducción de la violencia (Belfrage et al., 2012).

Las propias estrategias de gestión del riesgo influyen directamente en el análisis de la precisión de las distintas herramientas, tal como Belfrage y Strand (2012) han puesto de manifiesto con el B-SAFER, con niveles mayores de intervención en casos graves y peor predicción en estos mismos. Este hecho es el principal impedimento en la investigación sobre eficacia predictiva, pues se interfiere en el resultado natural que ocurriría en caso de no aplicar una gestión específica para el riesgo que fue valorado con la herramienta.

Pensemos en una condición experimental o de investigación (puede ser un estudio prospectivo o retrospectivo, véase apartado 2 del capítulo 2) en la que se valora el nivel de riesgo de reincidencia

de determinado agresor, pero no se hace ninguna gestión. Al tratarse de una investigación que no implica intervención podremos medir los niveles de acierto de la herramienta utilizada (capacidad predictiva, sensibilidad y especificidad). Si la investigación se desarrolla en un contexto aplicado, como puede ser el judicial, el policial o el penitenciario, en los que la valoración del riesgo está asociada a una medida preventiva, la gestión aplicada está destinada precisamente a contrarrestar el nivel de riesgo estimado, por lo que de forma deseable el resultado será distinto al predicho (la reincidencia estimada no se producirá). Ante un nivel de riesgo elevado sobre el que se intervenga, si logramos que el sujeto no reincida la predicción de reincidencia inicial habrá sido errónea.

Por tanto, ¿es una buena medida de la utilidad de una herramienta considerar su capacidad predictiva calculada en contextos aplicados? Además, el interés actual está en valorar la *capacidad preventiva*, o grado en que la herramienta o metodología es capaz de reducir el número de victimizaciones o situaciones de riesgo. El único recurso que queda en estos casos es el análisis de los falsos negativos, aquellos casos en los que se estimó un riesgo bajo o poca probabilidad de reincidencia, no se intervino (o se hizo de forma leve) y el sujeto finalmente reincidió. Este problema se planteó al analizar las aplicaciones de la EPV-R por la Ertzaintza, que a su vez realiza las tareas de protección de la víctima destinadas a neutralizar el riesgo (Echeburúa, Amor, Loinaz y de Corral, 2010). Por tanto, al intervenir para neutralizar el riesgo, las predicciones (aciertos) se ven afectadas en la medida en que se espera que incluso los sujetos con riesgo más elevado no consigan agredir a la víctima. Otra opción de estudio sería la de los casos de alto riesgo que cumplen con su medida o condena y, por tanto, quedan en libertad y exentos de control, seguimiento o gestión.

5.2. Contextos de gestión del riesgo

El ámbito en el que más se ha desarrollado la materia es en la evaluación del riesgo a cargo de

cuerpos policiales (Loinaz, 2013). Sirvan como ejemplo los trabajos de Storey y cols. sobre las estrategias de gestión aplicadas por la policía y su eficacia en casos de acoso (Storey y Hart, 2011), gestión del riesgo por la policía en casos de agresoras de pareja (Storey y Strand, 2012) o la gestión policial utilizando la SARA (Belfrage et al., 2012). A nivel policial, las estrategias habituales suelen ser la protección de la víctima, los planes de seguridad para la víctima, la supervisión próxima del caso con contacto telefónico o el seguimiento (en algunos casos) del agresor o de la víctima (Belfrage et al., 2012; Echeburúa et al., 2010). En el contexto jurídico-forense, las medidas de seguridad y la libertad vigilada son también alternativas de gestión. En el contexto penitenciario, la gestión pasa por la modificación de ubicación del interno, propuesta de programas, negación de permisos o restricción de libertades, etc. Además, los planes de preparación para la libertad, las actividades en el centro, el desarrollo de actividades laborales o la atención a problemas de salud también son estrategias de gestión del riesgo (UNODC, 2016). El riesgo puede ser genérico o específico para una víctima, puede incluir al propio interno (suicidio), a trabajadores de la prisión o a compañeros del interno. Además, se puede estimar el riesgo de reincidencia en el delito concreto ya cometido o de reincidencia en cualquier otro delito.

En el contexto de la gestión institucional (prisiones y psiquiátricos), una de las propuestas destacada ha sido el PRISM, una serie de pautas de evaluación estructurada cuyo centro de atención no es el sujeto sino la propia institución (Cooke y Johnstone, 2010). La guía se diseñó revisando la literatura sobre factores de riesgo de violencia en contextos institucionales, recopilando información de los propios internos y profesionales de los centros, y depurando ambas fuentes de información para establecer 21 ítems divididos en cinco dominios: gestión, características del personal de la institución, historia de violencia en la institución, aspectos físicos y de seguridad, y factores organizacionales.

En el contexto sanitario, Allnutt et al. (2013) equiparan la evaluación del riesgo a la medida de la temperatura para argumentar que la evaluación se debe implementar aunque finalmente no se reduzca la violencia. La fiebre es un indicador de infección (factor de riesgo) y un antibiótico es una medida de gestión para evitar un daño peor. El problema ya existe, pero se intenta mitigar males mayores y resolverlo. La evaluación del riesgo puede que no cambie el resultado final y tiene que ir siempre acompañada de una propuesta de gestión. En el contexto psiquiátrico se puede recurrir al uso de fármacos, como los antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia, pero esto no es suficiente para gestionar el riesgo a largo plazo. En muchos casos, la gestión del paciente se hará en la comunidad estando dado de alta, por lo que los servicios se deben coordinar. En estos contextos, la evaluación del riesgo debe ser el precursor del tratamiento y la propuesta de gestión. En psiquiatría resulta de vital importancia la evaluación del riesgo, tanto en la rutina institucional (con pacientes internados, respecto al riesgo de violencia autodirigida, entre pacientes o hacia los profesionales) como también en la evaluación en urgencias. El principal problema puede ser la falta de hábito en el uso de estas herramientas en contextos sanitarios (Benavides-Gélvez, Escobar-Córdoba y Molina-Ojeda, 2014).

5.3. Violencia de pareja

El caso de la violencia contra la pareja es de los más estudiados en materia de gestión del riesgo. Esto se debe a que víctima y agresor están identificados cuando se procede a valorar el riesgo y porque, además, es un tipo de violencia interpersonal, que ocurre en contextos de cercanía, familiaridad y espacio acotado. Por tanto, la ges-

tión de ambientes, actividades, rutinas e implicados resulta más sencilla. En este contexto, la orden de alejamiento entre víctima y agresor es una de las principales medidas de gestión del riesgo. Sin embargo, la investigación ha demostrado que tiene poco efecto a la hora de disuadir a los agresores (Frantzen, Miguel y Kwak, 2011). En concreto, Strand (2012) señaló que la reincidencia era igual en los grupos con y sin orden de alejamiento y que solo era efectiva en los casos de bajo o medio riesgo. En los casos en los que más se aplica, los de riesgo alto, la orden de alejamiento parece carecer de efecto, pudiendo suponer incluso una falsa ilusión de seguridad para la víctima, lo que hace que sea necesaria la búsqueda de otras alternativas de gestión para estos sujetos.

A su vez, la gestión debe ser proporcional al riesgo. Belfrage et al. (2012) encontraron que altos niveles de intervención se asocian con una menor reincidencia en casos de alto riesgo (evaluados con la SARA), pero con una mayor reincidencia en casos de bajo riesgo en los que la estrategia de gestión había sido excesiva. Storey, Kropp, Hart, Belfrage y Strand (2014) confirmaron este resultado y además encontraron que la gestión policial estaba relacionada con los niveles de riesgo medidos con el B-SAFER.

En estos casos, resulta de especial interés ver en qué medida la policía es capaz de asociar distintos niveles de riesgo con estrategias de gestión específicas aplicadas por ellos mismos. En el caso policial, es especialmente frecuente la aplicación de medidas de protección para la víctima asociadas al nivel de riesgo. Sirva como ejemplo el caso de la EPV-R (Echeburúa et al., 2010), diseñada para la policía del País Vasco, en la cual cada punto de corte está relacionado con un nivel de gestión policial del riesgo (véase tabla 7.3) y cada medida tiene criterios específicos de aplicación, duración y revisión (véase Peña, 2009).

TABLA 7.3
Niveles de gestión del riesgo de la Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca) asociados a las puntuaciones en la EPV-R

Nivel de riesgo		Medida de protección mínima obligatoria
Básico (0-9 puntos)	1	Oferta de formación en medidas de autoprotección en un plazo no superior a 48 horas.
	2	Comprobaciones aleatorias mediante teléfono.
	3	Oferta de teléfono de teleasistencia.
Moderado (10-17 puntos)	4	Oferta de traslado al juzgado para su primera comparecencia.
Alto (18-23 puntos)	5	Vigilancia sobre rutinas y sobre zonas (tres semanales de cualquier tipo, excepto que la víctima disponga de pulsera electrónica).
	6	Activación de contravigilancia, solo si dispone de orden de alejamiento y si, a juicio del Equipo Instructor del Expediente, existen sospechas de quebrantamientos consentidos.
	7	Si dispone de orden de alejamiento, oferta de pulsera electrónica.
Especial (24-48 puntos)	8	Vigilancia sobre rutinas y sobre zonas (siete semanales, debiendo ser dos de ellas sobre rutinas, excepto que la víctima disponga de vigilancia permanente o pulsera electrónica).
	9	Oferta de vigilancia permanente, en todos los casos.
	10	Si dispone de orden de alejamiento y no desea vigilancia permanente ni pulsera electrónica, se activarán contravigilancias.

Más información sobre actuación en violencia doméstica y de género en www.ertzaintza.eus.

6. EL RESULTADO DE LA HERRAMIENTA

La comunicación del riesgo puede considerarse un elemento esencial del proceso de evaluación. Sin embargo, se ha prestado mucha atención a la capacidad predictiva de las herramientas y poca a la efectividad de la comunicación del riesgo.

La comunicación presenta dos aspectos diferenciados: el resultado de la evaluación (numérico o categórico) y la forma en la que se transmite la información a las partes interesadas, mediante un informe escrito o verbal (véase apartado 7).

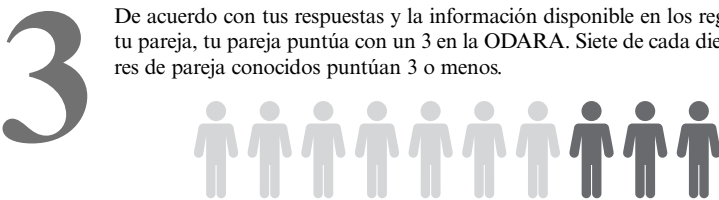
En este punto analizaremos los distintos formatos de presentación del riesgo o resultado de la evaluación en las principales herramientas.

En primer lugar, debemos recordar que los protocolos o guías de evaluación del riesgo no son escalas psicométricas ni miden un constructo psicológico. Una confusión muy habitual entre las personas poco habituadas a la metodología es la búsqueda o solicitud de baremos o la exigencia de propiedades psicométricas similares a las de los test psicológicos, como la fiabilidad test-retest, la consistencia interna de la herramienta o el análisis

factorial de los ítems, aspectos innecesarios en escalas para la evaluación del riesgo (Dutton y Kropp, 2000; Hilton et al., 2004; Kropp, 2004) o incluso contraproducentes (como la fiabilidad test-retest en plazos amplios de tiempo, al ser el riesgo un constructo dinámico y modificable).

En la tabla 7.4 se describen tres formatos de presentación del resultado: el formato nominal o categorial (etiquetas), las categorías asociadas a puntos de corte y el formato asociado a tasas o porcentajes. A continuación nos detendremos en cada uno de ellos.

TABLA 7.4.
Ejemplos de formatos del resultado

Herramienta	Tipo	Formato del resultado
ODARA	Actuarial	Dos formatos de resultado visual y útil para explicar a la víctima: Frecuencia: 1. ¿Cómo es mi pareja comparada con agresores de pareja conocidos?  De acuerdo con tus respuestas y la información disponible en los registros de tu pareja, tu pareja puntúa con un 3 en la ODARA. Siete de cada diez agresores de pareja conocidos puntúan 3 o menos. Tasa absoluta: 2. ¿Qué probabilidad hay de que mi pareja vuelva a agredir? Puntuación ODARA = 5-6: el 60% de los agresores de pareja de este tipo cometieron una nueva agresión contra su pareja (o, en algunos casos, contra una nueva mujer), que fue detectada por la policía en un plazo medio de cinco años. 
HCR-20 SVR-20 RSVP SARA B-SAFER Etc.	Guías de juicio estructurado	Categorías nominales. Tres niveles de riesgo a elegir por el evaluador (sin punto de corte): • Bajo. • Moderado. • Alto.
EPV-R	Actuarial Ajustado	Puntos de corte. Tres niveles de riesgo asociados a un valor numérico: • 0-9: bajo. • 10-23: moderado. • 24-48: alto.

6.1. Formatos nominales o categorías de riesgo

El formato más frecuente de estimación del riesgo de un caso es el *nominal*, formado por categorías sin ningún tipo de condición numérica asociada: riesgo *bajo*, *medio* o *alto*. Se afirma que las categorías nominales señalan un nivel de reincidencia superior al esperado o estimado por el profesional (Hanson, Lloyd, Helmus y Thornton, 2012). Por otro lado, en algunos casos el profesional, ante la duda, tiende a asignar un nivel de riesgo superior, por lo que se sobreestima la probabilidad real de reincidencia y, por tanto, la asignación de recursos.

El principal problema de las categorías nominales se deriva del distinto significado que cada persona atribuye a una misma etiqueta (Hilton, Carter, Harris y Sharpe, 2008). Dependiendo de lo que consideremos bajo, medio o alto (o incluso lo que consideremos normal o asumible; véase apartado 5 del capítulo 5), uno puede valorar un caso como de riesgo medio o con probabilidad de reincidencia media, mientras que otro puede considerarlo de riesgo alto o incluso bajo. Por tanto, es evidente que estas etiquetas son muy inespecíficas y poco útiles si no van acompañadas de otros argumentos, indicaciones o recomendaciones. Además, no existe consenso entre profesionales y, por consiguiente, los mensajes categoriales son menos precisos y no dejan claro el límite o punto de corte que diferencia una categoría de otra (Monahan y Steadman, 1996). Para algunos autores, esta complicación es resultado del uso de distinto «idioma» o lenguaje por parte de las personas implicadas, lo que obliga a explicar qué entiende cada uno por cada categoría nominal disponible (Hanson et al., 2012).

Los problemas derivados del uso de etiquetas nominales se dan especialmente en las herramientas que no vinculan estas categorías a valores numéricos obtenidos en análisis empíricos de la escala. La discrecionalidad a la hora de categorizar un caso como de riesgo bajo, medio o alto, con independencia del número total de factores de riesgo presentes o puntuación numérica obtenida en la evaluación, puede dar pie a muchos errores,

mayores cuanto menor sea el entrenamiento del profesional encargado de la evaluación. Este aspecto ha sido la principal fuente de críticas de las guías de juicio estructurado, que permiten estimar un riesgo alto con la sola presencia de un factor, o añadir factores de riesgo no incluidos en la herramienta.

Sirva como ejemplo, a la hora de analizar dicha crítica, un resultado de riesgo alto en un caso que «solo» presenta síntomas activos de trastorno mental grave con ideación homicida o fantasías sexuales sádicas. En este caso, es evidente que el sujeto presenta un riesgo alto, al margen de que no vaya acompañado de un número elevado de los factores de riesgo que componen las principales guías de juicio estructurado. Esta discrecionalidad o formato abierto en las herramientas tiene una doble interpretación, tal como el lector habrá podido anticipar. Por un lado, es acertada en el sentido de que el riesgo no correlaciona linealmente con el número de factores presentes, sino que es una combinación entre las características del caso, el contexto, la oportunidad, etc. (tal como se ha comentado en el capítulo 6). Por otro lado, sin embargo, puede considerarse una postura equivocada, pues genera incertidumbre sobre la valoración final, promoviendo la subjetividad del evaluador y una mayor comisión de errores (teniendo en cuenta la heterogeneidad, y muchas veces limitaciones, en la formación de los profesionales). Asimismo, reduce el poder de la «relación empírica entre factores de riesgo y violencia» argumentada en contra del juicio meramente clínico y que es la base científica del juicio profesional estructurado.

Monahan y Steadman (1996) recuerdan que no es necesario dividir las categorías en tres niveles, aunque sí como mínimo tres para no volver a la ya superada dicotomía «peligroso o no». De hecho, en la actualidad distintos cuerpos policiales incluyen un cuarto nivel de riesgo, superior al alto, denominado especial o extremo (véase tabla 7.3), al que se destinan los niveles de protección más extraordinarios. Estas clasificaciones del riesgo corresponden a criterios de gestión de recursos y adecuación de las medidas de protección.

6.2. Puntos de corte

Como ya hemos descrito en secciones previas, las herramientas actuariales trabajan con puntuaciones y con guías de juicio estructurado no. Existe alguna excepción a esta regla, como es la edición de la SARA por *Multi-Health Systems*, que incluye la corrección con centiles (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1999). Sin embargo, en numerosas investigaciones se suelen proponer puntos de corte para las guías estructuradas y se trabaja con criterios de predicción numéricos. Esto podría definirse como un artificio científico por distintas cuestiones: por usar puntos de corte con herramientas que no los proponen y por usar niveles de riesgo pasados, para predicciones a largo plazo, cuando el riesgo es dinámico y, por tanto, en el plazo de seguimiento ha podido modificarse en numerosas ocasiones entre la evaluación y el resultado final. Estos puntos de corte, no formales por no ser propuestos en las guías originalmente, se establecen en muestras de estudios empíricos específicos y son resultado de investigaciones concretas. Sin embargo, pueden ser utilizados como referencia por los profesionales interesados en tener un criterio numérico orientativo para su toma de decisiones.

CLAVE 12.

Enfoque actuarial ajustado

Es aquel que parte de la aplicación de una herramienta y metodología actuarial, pero que permite al profesional modificar el resultado final estimado.

Esta opción está presente, por ejemplo, en herramientas de uso policial en España, que solicitan al evaluador que indique si está conforme con el resultado y lo modifique, justificando la decisión si lo considera oportuno.

Debido a la posible preferencia de los usuarios o a cuestiones de aplicabilidad, herramientas recientes creadas en el contexto español han establecido desde un primer momento puntos de cor-

te derivados de la muestra con la que han sido diseñadas (este ha sido el caso de la EPV-R o la RVD-Bcn, que explicaremos en el capítulo 9). En el extremo del uso de puntuaciones se encuentran las herramientas actuariales que describen el riesgo de un sujeto en términos probabilísticos (o porcentajes) o valores numéricos, comparándolos con muestras de referencia.

Los puntos de corte son criterios numéricos que ayudan al profesional a ubicar al sujeto en una etiqueta nominal correspondiente al riesgo. En cierto modo, como veremos en el siguiente apartado, son similares al uso de centiles, pues dividen a la muestra en niveles de riesgo según unos rangos de puntuación. A diferencia de los centiles, no hay una división continua de la muestra (porcentaje de sujetos que quedan por encima o por debajo de una puntuación determinada dentro de los valores máximos y mínimos de la herramienta). El punto de corte simplemente divide la muestra en los tres o cuatro niveles de riesgo nominales que se suelen utilizar. El punto de corte también se puede establecer en estudios de seguimiento en los que se comprueba la reincidencia y la vinculación de esta con puntuaciones de riesgo (como se ha hecho, por ejemplo, con el B-SAFER y la reincidencia penitenciaria de agresores de pareja en España; Loinaz, 2014b). En otros casos se establecen puntos de corte según la gravedad de las agresiones (como se ha hecho, por ejemplo, en la EPV-R y la RVD-Bcn).

6.3. Formatos numéricos

Una forma de comunicar el riesgo es utilizando criterios no arbitrarios basados en la investigación, como pueden ser las tasas absolutas de reincidencia (10% de reincidentes, en un período de tiempo concreto, para una puntuación determinada y en una muestra específica), los coeficientes de riesgo (riesgo de reincidencia dos veces superior al de otra puntuación) o los percentiles (un 5% de los agresores se ubica en un determinado valor de la escala) (Hanson et al., 2012). Esta sería una perspectiva de estilo actuarial.

Otra forma de clasificar los formatos numéricos de comunicación del riesgo es con probabilidades o frecuencias (Conroy y Murrie, 2007). El formato probabilístico ofrece una estimación de la probabilidad de conducta violenta expresada en forma de porcentaje; por ejemplo, «el sujeto presenta una probabilidad del 30% de cometer violencia». Estas estimaciones provienen de una muestra particular y se ofrecen en herramientas actuariales como la VRAG. El formato de frecuencias expresa el riesgo en forma de número comparativo, por ejemplo: «de cada 100 sujetos con este nivel de riesgo, 30 cometen violencia». Para muchos, ambas afirmaciones pueden significar lo mismo (30 de cada 100 y 30%), pero se ha comprobado que las interpretaciones son diferentes (Monahan et al., 2002; Slovic, Monahan y MacGregor, 2000), considerando de mayor riesgo los niveles expresados en formato de frecuencia (por la posible imagen mental que se genera al pensar en un número de sujetos reincidiendo).

Este estilo de comunicación del riesgo está presente, por ejemplo, en la ODARA (Hilton et al., 2004), una herramienta actuarial que facilita la expresión del riesgo concreto en términos probabilísticos y la ubicación de la puntuación del agresor respecto a la muestra de referencia (véase tabla 7.4). Este formato de resultado, además, está pensado para facilitar la comunicación del mismo a las víctimas, con la intención de que se comprenda mejor la situación que con una categoría nominal como «medio». Por tanto, no solo es resultado de una elección metodológica (actuarial), sino que está orientado directamente a la comunicación y mejor transmisión de lo percibido por los profesionales a los implicados en la situación de riesgo. Este aspecto es de gran relevancia, pues es una cuestión poco analizada y sobre la que, además, existen discrepancias. Algunos consideran que la víctima no necesita conocer realmente su situación de riesgo, por no poder entenderlo y por suponer una alarma innecesaria e inútil. Otros, sin embargo, opinan justo lo contrario y consideran imprescindible que la víctima conozca su situación de riesgo, para que pueda adoptar las medidas de autoprotección necesarias (véase Campbell, 2004).

La principal limitación de este tipo de formatos es la necesidad de adaptar y validar la herramienta a muestras específicas y representativas, para poder ubicar de forma adecuada el riesgo de un agresor concreto en una población determinada (este aspecto sería necesario, por ejemplo, en el caso de la adaptación del instrumento al español). Que un número de factores de riesgo esté relacionado con un porcentaje de reincidencia o permita ubicar a un sujeto en relación a un grupo de agresores parecidos, solo es válido para la muestra con la que se han establecido las puntuaciones, no así para cualquiera en la que podamos utilizar la misma herramienta (a no ser que podamos garantizar que ambas muestras son comparables).

Entre estas opciones, la forma más sencilla de tener un criterio de referencia es la utilización de centiles, pues no requieren un estudio de reincidencia. Los centiles permiten ordenar las puntuaciones de una muestra de forma que podemos ubicar a nuestro sujeto por encima o por debajo de una proporción de casos. Esta ha sido una fórmula propuesta en la segunda edición de la SARA en su versión publicada por MHS (Kropp et al., 1999), como excepción a la norma propia del juicio estructurado. Las puntuaciones se establecieron con 638 agresores de pareja presos y 1.671 en libertad condicional de Canadá. Las tablas de clasificación permiten comparar la puntuación total de nuestro sujeto respecto a la muestra penitenciaria, la muestra en libertad condicional o la muestra global. Por ejemplo, a partir de 20 puntos sobre 40, el sujeto puede ser etiquetado como de riesgo alto y se ubicaría en el centil 86 respecto a la muestra en libertad, en el 73 respecto a los de prisión y en el 82 para la muestra combinada. Además, permite comparar el número de factores presentes, sin utilizar una corrección numérica en los ítems (para la anterior corrección, los ítems presentes valdrían 2 puntos, los dudosos 1 y los ausentes 0). En este caso, a partir de ocho factores presentes se señala que el caso puede ser etiquetado como de riesgo alto, y en la comparación el agresor se ubicaría en el centil 88 respecto a la muestra en libertad,

en el 75 respecto a los de prisión y en el 84 para la muestra combinada. La lectura que debemos hacer de un centil es que el sujeto deja por debajo a la proporción de la población correspondiente al centil asignado. En los casos citados, por ejemplo, un caso que obtuviera 20 puntos dejaría por debajo al 82% de la población general de los agresores de pareja, y aquel que tuviera presentes 8 factores dejaría por debajo al 84% de la misma población. En definitiva, es un formato útil y sencillo destinado a comparar nuestro caso con un grupo, con la finalidad de saber si su puntuación es mayor o menor de la obtenida por una muestra de referencia. Un ejemplo de otro uso de centiles en agresores lo encontraríamos en la aplicación de la CTS-2 en agresores de pareja en España (Loinaz et al., 2012).

El uso de estos formatos de resultado tampoco está exento de críticas. Por ejemplo, respecto a las probabilidades de reincidencia, Elwood (2016) recuerda que el concepto de riesgo real refleja la visión frecuentista y que el riesgo real de una única persona no puede ser del 45%; o se reincide o no. Además, cuando se habla de probabilidades, no todos los sujetos con el mismo riesgo tienen la misma probabilidad de reincidir, tal como demuestran los estudios con herramientas actuariales (Berlin et al., 2003) (véanse las críticas al modelo actuarial en el apartado 4 del capítulo 6).

6.4. Preferencias de los profesionales

Pese a estos inconvenientes, los estudios sobre las preferencias de los profesionales, entre distintos formatos para la comunicación del riesgo, encuentran que las categorías nominales son la opción más aceptada. Por ejemplo, Kwartner, Lyons y Boccacini (2006) concluyeron que los jueces preferían el formato categorial (54%), seguido del probabilístico (26%) y del de frecuencia (20%). Por otro lado, se ha encontrado que los jueces que tienen una actitud positiva hacia la evaluación del riesgo son más propensos a considerar las pruebas sobre evaluación del riesgo de un caso concreto más comprensibles, relevantes y

decisivas (Dolores y Redding, 2009). Entre psiquiatras y psicólogos, se prefiere aquellos formatos que incluyen la descripción de los factores relevantes y las estrategias para reducir el riesgo (Heilbrun, Dvoskin, Hart y McNiel, 1999; Heilbrun, O'Neill, Strohman, Bowman y Philipson, 2000; Heilbrun et al., 2004).

Esta preferencia por formatos categoriales se puede deber a que, por un lado, las etiquetas nominales son consideradas más naturales y más fáciles de usar y entender, aunque también se da una preferencia inicial por recibir la información de forma numérica y por transmitirla nominalmente (Wallsten, Budescu, Zwick y Kemp, 1993). En otros casos, se puede explicar por la desconformidad con la información estadística. Por ejemplo, los detractores de las herramientas actuariales afirman que no se puede utilizar datos de una población en un sujeto (Hilton, Harris, Rawson y Beach, 2005) y, por tanto, es mejor utilizar palabras que números. Monahan y Steadman (1996) hicieron una analogía con la predicción meteorológica y la psicología forense. En los inicios de la predicción meteorológica se usaban categorías dicotómicas (deterministas) como «lloverá» o «no lloverá». Con la inclusión de predicciones probabilísticas (p. ej., probabilidad del 40% de lluvia), las encuestas señalaban que, pese a la resistencia inicial, el público se adaptó rápido y pronto prefirió ese formato.

Scurich y Krauss (2013) estudiaron el efecto del denominado enfoque actuarial ajustado en 362 ciudadanos aptos para formar parte de jurados. El enfoque actuarial ajustado consiste en que el profesional puede modificar el nivel de riesgo obtenido en una herramienta actuarial. La investigación valoró la medida en la que los posibles jurados tomaban una u otra decisión, relativa a un hipotético acusado, en función de la dirección en la que iba la modificación del riesgo (al alza o a la baja). El estudio encontró que el enfoque afectaba a las decisiones de los ciudadanos sobre la condena de un acusado, pero solo cuando el ajuste incrementaba el riesgo. El efecto ocurría sin que el profesional diera ninguna explicación sobre su ajuste. Los participantes pare-

cerían verse envueltos en lo que se conoce como razonamiento motivado, que hace referencia a la tendencia a dar crédito o descrédito a la información dependiendo de si es congruente o no con el resultado deseado (si esperamos que el sujeto sea de riesgo alto, aceptaremos la modificación cuando vaya en esta dirección, pero no cuando tienda a reducir el riesgo).

6.5. Implicaciones y conclusiones sobre los formatos de resultado

Debemos tener presente que el formato de presentación del riesgo también afecta a las estrategias de gestión y a la eficacia de la predicción. Algunos resultados de herramientas se asocian directamente a medidas de protección de la víctima, como en el caso de la EPV-R para la gestión del riesgo de violencia de pareja por parte de la Ertzaintza o la VPR (López-Ossorio, González-Álvarez y Andrés-Pueyo, 2016) para uso por parte de otros cuerpos policiales en el contexto español. Por tanto, la seguridad de esta va a depender de cómo presentemos el riesgo y la precisión de la estimación (por ejemplo, al asignar un riesgo bajo, medio o alto con las diferencias de protección que ello supone; véase punto 5 dedicado a la gestión del riesgo).

Para Wallsten et al. (1993), mientras que el uso únicamente de información estadística es insuficiente para comunicarse, también es cierto que legos y profesionales utilizan términos nominales vagos al hacer predicciones. Por tanto, se debería trabajar para darles un significado explícito, no arbitrario, por ejemplo con los mencionados centiles con muestras comprehensivas y representativas de la muestra de interés (Hanson et al., 2012).

En cualquier caso, resulta imprescindible tener en cuenta la terminología habitual de aquellos a los que dirigimos nuestra evaluación. Así pues, se afirma que en contextos jurídicos el uso de conceptos estadísticos puede resultar menos comprensible (por ejemplo, tasa base o percentil), y aspectos para muchos de nosotros equivalentes como la frecuencia (1 de cada 4) o la probabili-

dad (25%) pueden ser susceptibles a sesgos e impresiones que afectan al proceso (Slovic et al., 2000). Asimismo, se considera imprescindible que los usuarios finales de la comunicación del riesgo (abogados, jueces, policías) estén implicados desde el principio en el desarrollo de cualquier sistema categorial (Monahan y Steadman, 1996), lo que permitirá la comprensión de los términos empleados al final del proceso.

Las principales conclusiones de los estudios que han prestado atención al formato de comunicación del riesgo podrían resumirse de la siguiente forma:

- El formato de presentación mejor valorado tiende a ser aquel que incluye la identificación de los factores de riesgo específicos del sujeto y las intervenciones recomendadas para reducir el riesgo (Heilbrun, 1997; Heilbrun et al., 2000, 2004).
- La escala numérica en la que se puede reflejar el resultado influye en la percepción del riesgo, atribuyéndose un riesgo mayor en escalas con rangos mayores (por ejemplo, 10-100 frente 1-10) (Slovic et al., 2000).
- Las escalas de frecuencia (*1 de cada 10 sujetos similares a tu caso vuelven a reincidir en los primeros meses de libertad*) producen estimaciones de riesgo más conservadoras que las escalas probabilísticas (*se estima que sujetos similares a tu caso tienen un 10% de probabilidad de reincidir en los primeros meses de libertad*), proponiéndose con mayor probabilidad el mantenimiento de la medida restrictiva (Monahan et al., 2002; Slovic et al., 2000).
- La utilización de etiquetas como *bajo, medio o alto* parece no tener un gran consenso entre los profesionales (Grann y Pallvik, 2002; Hilton, Carter et al., 2008), y el uso de descripciones no numéricas no ayuda en la comunicación (Hilton, Carter et al., 2008).

7. EL INFORME EN EVALUACIÓN DEL RIESGO

Pese a la poca atención que ha recibido el proceso específico de comunicación del riesgo, se considera que es una parte esencial del método (Scurich y John, 2012). Los destinatarios de la comunicación son variados, pudiendo incluir a la propia víctima, a cuerpos de seguridad, al personal del ámbito jurídico o penitenciario y a cualquier otro profesional que pueda intervenir con los implicados, como los servicios sociales. Aunque parezca un aspecto muy elemental y poco relevante, la eficacia de todo el procedimiento, y la capacidad de prevenir futuras agresiones, depende de la comunicación que hagamos del riesgo.

Al igual que con otras técnicas de evaluación forense, como las relacionadas con la imputabilidad o la credibilidad, la valoración del riesgo puede ser objeto de un informe pericial (Muñoz y López-Ossorio, 2016; Pujol, Mohino y Gómez-Durán, 2014), aunque esta técnica esté poco extendida en el contexto hispanohablante. Debido a la urgencia que rodea a las circunstancias en las que se aplican estos procedimientos, la evaluación del riesgo suele transmitirse de forma oral (entre profesionales, a los implicados, a los encargados de la gestión), de forma escrita (en informes profesionales o como resultado de una herramienta informatizada) o en forma de alerta (bien como indicativo numérico asociado a una medida o bien como señal de necesidad de intervención o reevaluación, urgencia de intervención, etc.). Sin embargo, en aquellas circunstancias en las que sea de interés y aplicable un informe escrito, es necesario señalar algunos contenidos mínimos a abordar, de modo que lo señalado sea útil, replicable, informativo y esté justificado desde el punto de vista técnico. Las implicaciones de este tipo de evaluaciones obliga a los peritos a aplicar la máxima rigurosidad científica (Muñoz y López-Ossorio, 2016).

Como ya hemos visto, existen formatos de comunicación preferidos para distintos contextos o profesionales. Se afirma que la orientación predictiva será preferible en el contexto jurídico y policial, mientras que la orientada a la gestión lo será

en contextos en los que se controla de forma más cercana al agresor (Heilbrun, 1997). Un informe escrito puede contener ambas orientaciones, a fin de que sea de la mayor utilidad para los distintos interlocutores o posibles destinatarios (incluidos otros profesionales que deban reevaluar el caso). Por otro lado, las consecuencias de los informes son distintas según el contexto al que estén destinados. En el contexto judicial afectan especialmente al evaluado (aunque la seguridad de la víctima también esté en juego) y en el contexto policial afectan a la protección de la víctima, por no intervenir en la mayoría de los casos con el agresor (Martínez, 2014). La percepción del profesional sobre la interpretación del informe o incluso la probabilidad de error influirá en las estimaciones emitidas (véase Herrero, 2012).

Todo informe forense debe contener la metodología empleada (técnicas de evaluación), los resultados obtenidos y la respuesta a la consulta que lo ha motivado. Su principal objetivo no es llegar a una conclusión jurídica, determinando por ejemplo, la culpabilidad de un imputado; su meta es aportar información al tribunal o jurado que debe llegar a un veredicto. En el caso de la imputabilidad, habitual en la evaluación de delinquentes, el informe pericial tiene como objetivo aportar una evaluación psicológica que establezca la relación de causalidad entre una determinada y posible sintomatología y la comisión de un delito, con el objetivo último de que el que juzga pueda considerar la apreciación de eximentes o atenuantes. El informe no debe establecer si el sujeto es imputable o no, solo si lo evaluado es compatible con la hipótesis de partida (afectación de capacidad de comprender y de actuar conforme a dicho entendimiento, por ejemplo). En los casos en los que se valora la credibilidad de una víctima, el objetivo último tampoco es determinar la culpabilidad de alguien o si los hechos existieron, sino informar sobre la compatibilidad de lo narrado con la posible ocurrencia de unos hechos y confirmar la presencia o no de la sintomatología argumentada por el evaluado (que a su vez sea compatible con los hechos denunciados).

Menos frecuente, pero posible, es la solicitud de un informe pericial sobre el riesgo de un delincuente (solicitado habitualmente en términos de *peligrosidad*). Su objetivo puede ser, entre otros, el establecimiento de medidas de seguridad, propuestas de tratamiento o medidas de protección para la víctima. En el contexto jurídico, puede ser una herramienta de utilidad que aporte información al juez o tribunal sobre cómo proceder con un determinado caso. En el contexto español, por ejemplo, se han editado guías o protocolos destinados a la valoración médico-forense urgente en violencia contra la pareja (Ministerio de Justicia, 2011), destinadas a la recomendación de medidas de protección para las mujeres víctimas y, por tanto, la gestión del riesgo. Sin embargo, en ellas no se especifica el formato de un informe pericial sobre la temática.

Muñoz y López-Ossorio (2016) consideran necesario conocer la situación actual de la evaluación del riesgo de violencia (herramientas, propiedades, errores, etc.) para poder hacer un análisis crítico de las periciales. Asimismo, señalan una serie de requisitos que debería cumplir un informe psicológico sobre el riesgo de violencia:

1. Se sugiere la valoración del caso por parte de dos peritos para mejorar la eficacia del pronóstico.
2. El informe debería recoger la cualificación y experiencia de los peritos referentes a la evaluación del riesgo.
3. El informe debe recoger los pasos seguidos en la evaluación:

- Identificar la guía seleccionada y su adecuación para el objetivo de evaluación.
- Señalar las propiedades de la herramienta y su validación en nuestro contexto u otros contextos.
- Señalar la información manejada para la evaluación, fuentes de información, indicadores considerados para codificar los factores, relevancia dada a los mismos, etc.

- Describir el proceso seguido para llegar a la conclusión sobre el riesgo.

Hilton, Harris y Rice (2010) indican que la comunicación de una valoración del riesgo debe contener un resumen de los factores de riesgo, las pruebas a partir de las cuales se ha valorado el ítem, así como las fuentes de información utilizadas. Los autores utilizan la regla de las «5W» para recordar cada uno de los pilares del proceso que deben estar contenidos en el informe: *Who* (sujeto de la evaluación), *What* (qué entendemos por reincidencia, la probabilidad de ocurrencia de qué en concreto: por ejemplo, violencia física), *Where* (en qué contexto: por ejemplo, en la pareja), *When* (período de tiempo: en las herramientas actuariales es el seguimiento realizado a la muestra de referencia y en las de juicio profesional el estimado por el evaluador —generalmente un plazo corto—) y *Why* (información a partir de la cual se hace la valoración). Junto a estos cinco pilares, un aspecto muy relevante sería el «cómo». Este sexto elemento hace referencia a indicar en el informe cómo se puede gestionar el riesgo, ya descrito en el apartado 5.

Kropp (2008) propuso una serie de recomendaciones básicas para los profesionales que, en todo caso, deberán adecuarse al contexto en el que se realiza la valoración y para el que se destina el informe (jurídico-forense, clínico, policial, etc.):

1. El profesional debe presentar el riesgo de forma clara, concisa y con pruebas adecuadas.
2. Cuando sea posible, el riesgo debe ser comunicado a la víctima, lo que puede facilitar la toma de precauciones y la protección frente a factores de riesgo específicos.
3. Las opiniones sobre el riesgo deben estar debidamente fundamentadas y acompañadas de las limitaciones en la evaluación (como puede ser la ausencia de fuentes de información).

Además, el informe debe resolver las siguientes cuestiones (Watt, 2012):

- *Resumen:* se debe resumir el resultado de todo el proceso, indicando el grado de intervención que requiere el caso.
- *Daño físico grave:* se debe indicar la posibilidad de que exista un riesgo de violencia con peligro para la vida.
- *Inmediatez:* se debería acotar la temporalidad de la estimación del riesgo, señalando si es necesaria una intervención urgente.
- *Revisión del caso:* por último, dentro del marco temporal ya indicado se ha de señalar una fecha aproximada para la próxima revisión del caso (cuándo se considera necesario reevaluar el riesgo) o qué detonantes pueden indicar la necesidad de una revisión de emergencia del caso. En el caso de menores, este plazo deberá ser mucho más breve que en adultos debido a las características y cambios evolutivos.

El informe escrito debe contener todos los puntos que hemos abordado en este capítulo; aspectos

relativos al proceso de evaluación y la metodología, a la herramienta, al caso, a los factores de riesgo, a las estimaciones referentes al potencial violento, a la explicación del caso y a las recomendaciones destinadas a reducir el riesgo o minimizar las consecuencias de la violencia. Junto a estos apartados, el informe debe poner de manifiesto aquellas limitaciones que se han producido en la evaluación con el fin de prevenir atribuciones inadecuadas o estimaciones parciales. Ello puede facilitar reevaluaciones, por ejemplo, en el caso de disponerse de nueva información. En el anexo 1 se presenta una propuesta con posibles fragmentos de aquellos apartados más relevantes que deberían contener un informe pericial sobre riesgo de violencia. Tan solo se trata de un listado de apartados simplificado. Cada profesional deberá elaborar un informe completo, con el estilo habitual del contexto forense (antecedentes, procedimiento, capacidades del evaluado, etc.), en el que se deberán incorporar los apartados y comentarios específicos de la evaluación del riesgo de violencia.

PARTE TERCERA

**Principales herramientas
disponibles**

INTRODUCCIÓN DE LA PARTE TERCERA

Las revisiones más recientes ya han puesto de manifiesto la amplia proliferación de herramientas para la evaluación del riesgo (Singh y Fazel, 2010). Es tal la magnitud de instrumentos, más de 200 comercializados y otros 200 pertenecientes a instituciones (Singh, Desmarais, Hurducas et al., 2014), que explicarlos en este manual resultaría inviable y poco práctico.

Pese al gran crecimiento del material disponible sobre evaluación del riesgo en la última década, hay que señalar que, en muchos casos, la información sobre fiabilidad, validez o base empírica de algunos instrumentos es muy escasa o inexistente (Campbell, French et al., 2009), lo que supone un riesgo para los profesionales que las aplican.

Distintos manuales anglosajones sobre evaluación del riesgo tratan de agrupar, organizar y simplificar el volumen de material disponible (véase Otto y Douglas, 2010). Entre estos objetivos se encuentra la clasificación de las herramientas, así como de sus principales resultados sobre eficacia con datos explicados en el capítulo 5 como las AUC. Sirva como ejemplo de este es-

fuerzo el manual de Mills et al. (2011), cuyo objetivo es ayudar a los profesionales que deben proceder con una evaluación del riesgo y, más aún, deben testificar como peritos en procesos judiciales (algo frecuente en EEUU y Canadá). En el contexto español existen algunas revisiones sobre las principales herramientas disponibles para la predicción (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010), así como las específicas de interés para el contexto forense juvenil (Wenger y Andrés-Pueyo, 2016a).

A continuación nos detendremos en las principales herramientas disponibles, bien por su uso internacional habitual o por su desarrollo en español. La agrupación de las mismas corresponderá a bloques temáticos de evaluación que pueden orientar al evaluador en su elección. En concreto, se abordarán el riesgo de violencia inespecífica en adultos (capítulo 8), la violencia de pareja (capítulo 9), la violencia sexual en adultos (capítulo 10), la violencia juvenil (capítulo 11) y otros tipos de violencia (capítulo 12). El capítulo 13 lo dedicaremos a las particularidades de la evaluación del riesgo de violencia en mujeres.

Tal como se ha presentado en los capítulos anteriores, existen distintos tipos de violencia, que se pueden clasificar según su objetivo o tipo de víctima. Nos referimos a violencia general o inespecífica cuando la conducta violenta no está dirigida a objetivos específicos como la pareja o la comisión de conductas sexuales. Bajo este tipo de evaluaciones se incluye a delincuentes violentos (excluidos los valorados como delincuentes sexuales o agresores de pareja) o a sujetos con trastornos mentales en los que se sospecha que exista riesgo de conducta violenta. Por tanto, el motivo de la evaluación es la sospecha de riesgo de violencia o la valoración y gestión del riesgo de reincidencia de violencia general. Además, como veremos en el capítulo 12, formas de violencia como el acoso, los crímenes de honor, la violencia laboral o incluso el extremismo o la radicalización cuentan con herramientas específicas para su evaluación.

El principal referente en este ámbito, contando con un amplio volumen de investigación, es la HCR-20. Sin embargo, existen otras herramientas de interés diseñadas para evaluar distintos aspectos en personas violentas o con trastorno mental (como la START) o que ofrecen una alternativa metodológica (como la VRAG, que es actuarial). Las específicas para menores (SAVRY, YLS/CMI, EARL-20B, EARL-21G o START:AV) se analizarán en el capítulo 11. Aunque es habitual incluir las escalas para evaluar la psicopatía en esta sección (PCL-R, PCL:SV o

PCL:YV), en esta ocasión no las describiremos, por no tratarse realmente de herramientas para la predicción de la violencia o reincidencia, sino para la evaluación de un constructo, eso sí, relacionado en parte con la delincuencia.

1. HCR-20

La *Historical Clinical Risk Management-20* —HCR-20— es la guía de juicio estructurado para la evaluación del riesgo de violencia más utilizada a nivel mundial (Singh, Desmarais, Hurdacas et al., 2014). Su primera versión se publicó en 1995 (Webster et al., 1995) y, como hemos explicado en la revisión histórica, provino de la escisión entre el método actuarial (que dio paso a la VRAG) y el de juicio estructurado, presentados de forma conjunta, por última vez, en el conocido como *Libro rosa* (Webster et al., 1994). En 1996 se habían publicado cuatro artículos sobre su aplicación, lo que junto a los comentarios de profesionales permitió a sus autores publicar en 1997 la segunda versión (Webster, Douglas, Eaves y Hart, 1997), la cual ha alcanzado reconocimiento mundial y ha sido adaptada a numerosos idiomas, incluido el español, con una versión en España (Hilterman y Andrés-Pueyo, 2005) y otra en Argentina (Folino, 2003). En la actualidad está disponible su tercera versión (Douglas et al., 2013), que ha incorporado todos los avances en la materia, mejorando el proceso de evalua-

ción y la concreción de los ítems, tal como veremos más tarde.

El propio nombre de la herramienta hace alusión a su estructura, con ítems históricos (H), clínicos (C) y de gestión del riesgo (R, de *risk management*). El objetivo básico de la HCR-20 es la evaluación del riesgo de violencia interpersonal inespecífica en población psiquiátrica, pacientes institucionalizados y presos. Cuenta con un amplio soporte empírico (Douglas y Reeves, 2010), así como con numerosas referencias sobre su capacidad predictiva y validez convergente en distintas muestras (de ambos sexos) y contextos clínicos y forenses. El volumen de trabajos es tal que sería imposible revisarlo en esta sección. De hecho, el lector interesado puede consultar una revisión periódica dirigida por uno de los autores de la HCR-20, con cientos de trabajos con la herramienta, titulada *HCR-20 Violence Risk Assessment Scheme: Overview and Annotated Bibliography* (Douglas, Shaffer et al., 2014).

La investigación en general indica que la HCR-20 tiene una buena capacidad predictiva de la violencia en distintas muestras, aunque los valores del AUC varían mucho (Mills et al., 2011), entre 0,56 (Gray et al., 2004), que sería una mejora mínima respecto al azar, y 0,88 (de Vogel y de Ruiter, 2005), que sería una predicción muy buena. Una limitación de muchos de estos estudios es el formato de corrección utilizado. Aunque, como hemos dicho, la HCR-20 es una guía de juicio estructurado, en ediciones y traducciones previas a la versión 3 se habían incluido en las hojas de respuesta puntuaciones para responder a los ítems (2 = presente; 1 = parcialmente presente; 0 = ausente), puntuaciones que han sido utilizadas en los estudios. En general, la capacidad predictiva se ha demostrado superior al utilizar las categorías de riesgo (bajo, medio o alto) frente a las puntuaciones (Douglas y Reeves, 2010).

Las temáticas en la que se ha aplicado la HCR-20 son muy variadas. Entre las muchas disponibles, encontramos pacientes con discapacidad intelectual (Gray, Fitzgerald, Taylor, MacCulloch y Snowden, 2007), análisis de dife-

rencias étnicas (Fujii, Tokioka, Lichon y Hishinuma, 2005), delincuentes no clínicos (Neves, Abrunhosa y Palma-Oliveira, 2011) y principalmente análisis de muestras psiquiátricas (Ho, Thomson y Darjee, 2009; Ho et al., 2013; Langton, Hogue, Daffern, Mannion y Howells, 2009; Telles, Folino y Taborda, 2012; Tengström et al., 2006).

Su uso en mujeres ha proporcionado resultados inconsistentes (de Vogel y de Ruiter, 2005; Garcia-Mansilla et al., 2011; Nicholls, Ogloff y Douglas, 2004; Warren et al., 2005). Por ejemplo, de Vogel y de Ruiter (2005) encontraron que no se daban diferencias en la puntuación media entre hombres y mujeres, mientras que la predicción en ellas no era mejor que el azar (AUC = 0,59) frente a la buena predicción en ellos (AUC = 0,88). Por tanto, la necesidad de atender a posibles diferencias de género ha impulsado la publicación de un manual adicional, *Female Additional Manual (FAM)*, de Vogel, de Vries-Robbé et al., 2012), destinado a complementar la evaluación del riesgo con la HCR-20 en mujeres (véase capítulo 13).

Algunos de los resultados obtenidos con adaptaciones de la HCR-20 en contextos hispanohablantes son los siguientes:

- En España, la puntuación total y en especial la escala clínica mostraron una buena correlación con la violencia a corto plazo (hasta 0,50), y las puntuaciones sobre la media incrementaban el riesgo de violencia hasta cuatro veces (Arbach y Andrés-Pueyo, 2007). También en contexto psiquiátrico, tanto la HCR-20 (AUC: 0,69-0,77) como la PCL:SV (0,63-0,70) son buenos predictores de violencia, en especial las variables clínicas (Arbach, Andrés-Pueyo, Pomarol y Gomar, 2011). En contexto psiquiátrico penitenciario se han encontrado mayores puntuaciones en el total de la HCR-20 y la escala H en pacientes con trastorno de la conducta (complicaciones y delincuencia acumuladas antes de los 15), así como mayores puntuaciones en la PCL:SV (Sánchez-SanSegundo, Ferrer-

Cascales, Herranz-Bellido, Pastor-Bravo y Hodgins, 2014).

- En Colombia, Tapias-Saldaña (2011) encontró que, al aplicar la SVR-20 y la HCR-20 en una muestra de delinquentes comunes y sexuales, la HCR-20 no marcaba diferencias entre ambos grupos, con ausencia de factores históricos en ambos. Al no haber historial clínico, solo resultó útil la SVR-20 para diferenciar ambos tipos de delinquentes. Pese a las limitaciones de la muestra y las dificultades en el acceso a información necesaria para la aplicación de las herramientas, se señaló la posible necesidad de buscar factores de riesgo culturalmente específicos.
- En Chile, León-Mayer, Cortés y Folino (2014) aplicaron la adaptación argentina de la herramienta en muestra penitenciaria, obteniendo una puntuación media de 21 (de 40 que se podía obtener al aplicar procedimientos cuantitativos), puntuando especialmente en la escala histórica. Según el juicio de los profesionales, el 54% tenía un riesgo alto de reincidencia.
- En Argentina, al analizar un estudio en desarrollo desde 2001 sobre la capacidad predictiva de la HCR-20, la PCL-R y la VRAG, se señaló la poca eficacia predictiva de estas herramientas (Folino, 2015). La herramienta con mejor capacidad predictiva fue la VRAG, alcanzando un AUC de 0,65 que puede ser considerada baja. Además, la PCL-R mostró poca utilidad, concluyéndose que es necesario buscar factores específicos de cada cultura con el fin de mejorar las capacidades y utilidad de los instrumentos.

Tal como se muestra en la tabla 8.1, la HCR-20^{V3} (al igual que la versión anterior) está formada por 20 ítems, divididos en tres escalas: 10 ítems históricos (H), cinco clínicos (C) y cinco de gestión del riesgo (R). La tercera versión ha sufrido una serie de modificaciones que comentaremos a continuación.

1.1. Avances en la HCR-20^{V3}

Tal como se ha mencionado, la tercera versión de la herramienta se publicó en 2013. En 2008 se iniciaron los trabajos con borradores de la escala, valorando cuestiones como la extensión, el contenido de los ítems y las alternativas de respuesta. Principalmente, las valoraciones de versiones piloto se desarrollaron en Holanda, Alemania, Suecia y Noruega. Tras numerosos seminarios y aplicaciones piloto, la tercera versión se publicó habiendo analizado su fiabilidad, validez concurrente y capacidad predictiva. En 2014 se publicó un monográfico en la revista *International Journal of Forensic Mental Health* sobre la HCR-20^{V3}, abordando su desarrollo (Douglas, Hart et al., 2014), su fiabilidad interjueces (Douglas y Belfrage, 2014), su validez (Strub, Douglas y Nicholls, 2014) o su aplicación en Alemania (Kötter et al., 2014), Reino Unido (Doyle et al., 2014) y Holanda (de Vogel, van den Broek y de Vries Robbé, 2014).

Los principales cambios que se han producido en esta última versión incluyen: 1) una mayor atención a la formulación del caso; 2) la valoración de la relevancia del ítem; 3) la propuesta al evaluador de indicadores para cada ítem; 4) la valoración final de distintos riesgos, así como de su inminencia y gravedad; 5) la inclusión de subítems; y 6) el hecho de que el uso de la PCL-R ya no sea necesario (posiblemente uno de los cambios más llamativos).

Frente a ítems demasiado genéricos o ambiguos, la HCR-20^{V3} ha incluido dos respuestas: 1) los más genéricos se han dividido en subítems (como el ítem H8 desajuste infantil, que pasa a ser Experiencias traumáticas, con la división de *8a Victimización y trauma a lo largo de la vida* y *8b Experiencias adversas en la crianza*); y 2) el de actitudes negativas se ha acotado mejor, haciendo ahora alusión a la ideación o intentos de violencia (C2). Frente a la posible redundancia entre ítems, se ha optado por aunar e incluir subítems. Este ha sido el procedimiento para los antiguos ítems H7 (psicopatía) y H9 (trastorno de la personalidad), que ahora pasan a ser el ítem *H7: Trastorno de la personalidad* (7a. Antisocial, psicopático o disocial

TABLA 8.1
Ítems que componen la HCR-20^{V3} (Douglas et al., 2013)

Históricos (pasado)	Clínicos (reciente)
H1. Violencia: a) De niño (12 años o menos). b) De adolescente (13-17). c) De adulto (18 años o más). H2. Otra conducta antisocial: a) De niño (12 años o menos). b) De adolescente (13-17). c) De adulto (18 años o más). H3. Relaciones: a) De pareja. b) No de pareja. H4. Trabajo. H5. Consumo de sustancias. H6. Trastorno mental grave: a) T. psicótico. b) T. estado de ánimo grave. c) Otro trastorno mental grave. H7. Trastorno de la personalidad: a) Antisocial, psicopático o disocial. b) Otro. H8. Experiencias traumáticas: a) Victimización/trauma. b) Experiencias de crianza extremas. H9. Actitudes violentas. H10. Respuesta al tratamiento o la supervisión.	C1. <i>Insight</i> : a) Trastorno mental. b) Riesgo de violencia. c) Necesidad de tratamiento. C2. Ideación o intenciones violentas. C3. Síntomas de trastorno mental grave. a) Trastorno psicótico. b) T. estado de ánimo grave. c) Otro trastorno mental grave. C4. Inestabilidad: a) Afectiva. b) Conductual. c) Cognitiva. C5. Respuesta al tratamiento o la supervisión: a) Adherencia. b) Responsividad.
	Gestión (futuro)
	R1. Servicios profesionales y planes. R2. Condiciones de vida. R3. Apoyo personal. R4. Respuesta al tratamiento o la supervisión: a) Adherencia. b) Responsividad. R5. Estrés o afrontamiento.

Adaptación española: Arbach y Andrés-Pueyo (2016).

y 7b. Otro). Para ítems inespecíficos, como el H1 (Violencia previa), se ha añadido la valoración de distintas etapas vitales: de niño (12 o menos), de adolescente (13-17) y de adulto (18 o más).

Como ya se ha mencionado a lo largo del manual, la HCR-20^{V3} describe el proceso de aplicación del juicio profesional estructurado en siete pasos: 1) obtención de información, 2) presencia de factores, 3) relevancia de los factores, 4) formulación del caso, 5) desarrollo de escenarios, 6) gestión del riesgo y 7) opinión final.

2. VRAG

La *Violence Risk Appraisal Guide* —VRAG— (Harris et al., 1993) ha sido la competidora directa de la HCR-20, siendo ambas las dos caras de la moneda en la evaluación del riesgo: la primera el estandarte de la evaluación actuarial y la segunda el del juicio profesional estructurado.

La VRAG es un instrumento actuarial, desarrollado en una muestra de 618 hombres delincuentes con trastorno mental a los que se hizo un

seguimiento medio cercano a los 7 años (Harris et al., 1993). La muestra procedía del este de Canadá, concretamente de Ontario, de un contexto psiquiátrico-forense, y tuvo una tasa base de reincidencia para dicho período del 37%. La herramienta está compuesta por los 12 ítems que se muestran en la tabla 8.2 (resultado de los análisis de regresión logística desarrollados al aplicar los 50 ítems iniciales en la muestra de reincidentes). Cada ítem tiene un valor ponderado que puede ser positivo o negativo según la respuesta. Las puntuaciones de la VRAG pueden ir desde -26 a +38, y en la VRAG-R de -34 a +46.

En muchos de los estudios sobre eficacia predictiva ha sido constante la aplicación de ambas herramientas en la búsqueda de la mejor de ellas (por ejemplo, Coid et al., 2011; Douglas, Yeomans y Boer, 2005; Folino, 2015; Folino, Marenco, Marchiano y Ascazibar, 2004; Grann, Belfra-

ge y Tengström, 2000; Gray et al., 2007; Ho et al., 2009; Reimann y Nussbaum, 2011; Snowden, Gray y Taylor, 2010; Tengström, 2001; Verbrugghe, Goodman-Delahunty y Frize, 2011).

La capacidad predictiva en la muestra original fue de un AUC = 0,76. Los resultados sobre su capacidad predictiva en trabajos posteriores también han mostrado valores elevados. Singh et al. (2011) calcularon el tercer AUC más grande (0,74) en la revisión de nueve herramientas, quedando por debajo de dos herramientas para la violencia sexual (SVR-20 y SORAG). Campbell, French et al. (2009) también describieron una predicción superior a la de la HCR-20 y el LSI-R. Mills et al. (2011) revisaron 13 estudios, encontrando un rango AUC entre 0,60 (Kroner y Mills, 2001) y 0,70 (Douglas et al., 2005), en estudios independientes, y 0,80 en un estudio de los propios autores (Harris, Rice y Cormier, 2002).

TABLA 8.2
Ítems de la VRAG y la VRAG-R (Harris et al., 2015)

VRAG	VRAG-R
1. Vivir con los dos padres a los 16 años.	=
2. Desajuste en escuela primaria.	=
3. Historia de problemas con el alcohol.	=
4. Situación matrimonial en el momento del delito actual*.	=
5. Puntuación en historial delictivo para delitos no violentos antes del delito actual (índice Corminer-Lang).	=
6. Fracaso en libertad condicional.	=
7. Edad en el delito actual.	=
8. Lesiones a la víctima del delito actual.	
9. Víctima femenina.	8. Puntuación en historial delictivo para delitos violentos antes del delito actual (índice Corminer-Lang).
10. Cumple criterios DSM-III para cualquier trastorno de la personalidad.	9. Número de ingresos (de más de un día) en instituciones penitenciarias (incluida justicia juvenil) por delitos previos al actual.
11. Cumple criterios DSM-III para el diagnóstico de esquizofrenia.	10. Trastorno de conducta (antes de los 15).
12. Puntuación en la PCL-R.	11. Historial de violencia sexual.
	12. Antisocial (faceta 4 de la PCL-R).

* Actual, en referencia al *index offense* (motivo de la evaluación); = aunque el ítem se mantiene, las puntuaciones de sus respuestas (valor ponderado) se han modificado (véase Harris et al., 2015).

Al igual que el resto de herramientas, la VRAG ha sido desarrollada en muestra masculina. Su aplicación en mujeres ha mostrado una baja capacidad predictiva. En un seguimiento prospectivo de ocho años, que incluía 59 mujeres, no se encontraron diferencias en puntuaciones entre las reincidentes y las no reincidentes (Harris et al., 2002). Una adaptación de los autores (Harris et al., 2004) sí mostró resultados positivos también en ellas.

Con el mismo funcionamiento, la VRAG ha dado lugar a dos herramientas para tipos específicos de violencia: la DVRAG (para violencia de pareja) y el SORAG (para violencia sexual). En la actualidad está disponible la versión revisada, VRAG-R (Harris, Rice, Quinsey y Cormier, 2015).

La herramienta ha sido aplicada en el contexto español (Ballesteros, Graña y Andreu, 2006), pero no consta una adaptación oficial ni más referencias.

3. LSI-R

El *Level of Service Inventory-Revised*—LSI-R— (Andrews y Bonta, 1995, 2000) es un protocolo actuarial compuesto por 54 ítems, diseñado para valorar el riesgo de reincidencia general en delinquentes adultos. Aunque no se trata de una herramienta para la valoración del riesgo de violencia, su uso extendido y su referencia habitual en el ámbito temático hace que resulte de interés una breve descripción.

Siguiendo el modelo RNR, trata de ofrecer al profesional un criterio sobre el nivel de intervención requerido. Por tanto, tiene un enfoque centrado en la gestión del riesgo de reincidencia general. Los 54 factores de riesgo se agrupan en diez escalas: 1) historial delictivo; 2) educación y empleo; 3) situación económica; 4) familia y matrimonio; 5) alojamiento; 6) ocio y entretenimiento; 7) amistades; 8) problemas con el alcohol y otras drogas; 9) emocional y personal; y 10) actitudes. Los ítems se codifican como presentes (1) o ausentes (0), y la puntuación de cada escala y del total de la herramienta corresponde a un sumatorio de los ítems presentes. Algunos factores

dinámicos incluyen respuestas del 0 al 3, siendo 0 una situación de riesgo y 3 una situación positiva (Andrews, Bonta y Wormith, 2010).

La herramienta ha sido utilizada en numerosos estudios con distintos tipos de muestras. Por ejemplo, en agresores sexuales sin capacidad predictiva de la reincidencia (Ragusa-Salerno, Ostermann y Thomas, 2013), en mujeres, con utilidad a pesar de las diferencias en la relevancia de los ítems (Holtfreter y Cupp, 2007; Manchak, Skeem, Douglas y Siranosian, 2009; Smith, Cullen y Latessa, 2009), o en agresores de pareja con una predicción acertada de solo el 66% (Hendricks, Werner, Shipway y Turinetti, 2006).

Singh et al. (2011), comparando 9 de las herramientas utilizadas de forma más habitual a nivel internacional, ubicaron al LSI-R en penúltimo lugar según su AUC media (0,67), solo por encima de la PCL-R (AUC = 0,66). Olver, Stockdale y Wormith (2014), en una revisión de 30 años de uso de la gama de herramientas LSI, encontraron que el LSI-R obtenía los peores resultados en capacidad predictiva, aunque para muestras canadienses sí era adecuada. Por el contrario, Campbell, French et al. (2009) le atribuyeron resultados comparables a los de VRAG y HCR-20. Mills et al. (2011) revisaron 12 estudios, con un rango de AUC entre 0,55 (Fass, Heilbrun, DeMatteo y Fretz, 2008) y 0,73 (Manchak, Skeem y Douglas, 2008), y correlaciones con la reincidencia penitenciaria elevadas (hasta 0,53).

Aunque hay publicado un trabajo que aplica el LSI-R en España, en muestra penitenciaria, para predecir la reincidencia general y violenta en 811 internos (Graña, Andreu, Silva, Pozuelo y Ruiz, 2014), e incluso es percibida como la herramienta de mayor utilidad en el contexto español según Arbach et al. (2015), no se ha podido localizar una adaptación oficial ni pruebas de su validación.

4. START

La *Short-Term Assessment of Risk and Treatability*—START— (Webster et al., 2004, 2009) es una guía de juicio estructurado para la valoración

y gestión del riesgo de violencia vinculado a trastornos mentales, abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. Su principal aportación es que los 20 ítems que componen el instrumento (véase tabla 8.3) son valorados al mismo tiempo como factores de riesgo —*vulnerabilidades*— o factores de protección —*fortalezas*— (por ejemplo, habilidades sociales, estado emocional, adherencia a las normas, recursos materiales, tratabilidad, etc.). También aborda siete dominios o tipos de riesgo: violencia hacia otros, autolesión, suicidio, salida no autorizada, abuso de sustancias, autonegligencia (o abandono) y victimización.

Es una herramienta de especial interés en ámbitos donde la gestión del riesgo se puede desarrollar a través de programas de tratamiento (véanse, por ejemplo, Braithwaite, Charette, Crocker y Reyes, Crocker et al., 2011; Gray et al., 2011; Kroppan et al., 2011, 2010; Chu, Thomas,

Ogloff y Daffern, 2011; Nicholls, Brink, Desmarais, Webster y Martin, 2006; Nonstad et al., 2010).

Los trabajos iniciales con la START mostraron una consistencia interna de 0,87 y una capacidad predictiva adecuada para distintos objetivos. Chu et al. (2011) han demostrado la utilidad en la predicción, en muestra psiquiátrica internada, tanto de los factores de riesgo (AUC = 0,78 para la violencia interpersonal y AUC = 0,77 para las amenazas) como de los de protección (AUC = 0,75 para la violencia interpersonal y AUC = 0,64 para las amenazas, este último no significativo), con una puntuación media de 23,1 en los primeros y 8,5 en los segundos. Además, al revisar trabajos previos señalaron una capacidad predictiva (AUC) de los factores de riesgo entre 0,63 y 0,79 para la violencia interpersonal y entre 0,66 y 0,83 para las amenazas.

Pese al interés de la propuesta, la investigación con la herramienta es aún limitada y no se ha podido localizar ninguna publicación con su aplicación en contexto hispanohablante.

TABLA 8.3
Factores de la START
(Webster et al., 2006)

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1. | Habilidades sociales. |
| 2. | Relaciones. |
| 3. | Ocupación. |
| 4. | Ocio. |
| 5. | Autocuidado. |
| 6. | Estado mental. |
| 7. | Estado emocional. |
| 8. | Consumo de drogas. |
| 9. | Control de los impulsos. |
| 10. | Desencadenantes externos. |
| 11. | Soporte social. |
| 12. | Recursos materiales. |
| 13. | Actitudes. |
| 14. | Adherencia a la medicación. |
| 15. | Adherencia a las normas. |
| 16. | Conducta. |
| 17. | <i>Insight</i> . |
| 18. | Planes. |
| 19. | Afrontamiento. |
| 20. | Tratabilidad. |

NOTA: los factores son considerados a la vez como posibles factores de riesgo o de protección en el mismo caso.

5. SAPROF

El *Structured Assessment of Protective Factors for violence risk* —SAPROF— (de Vogel et al., 2009, 2012) fue el primer instrumento diseñado específicamente para evaluar factores protectores. Como ya se ha comentado a lo largo del manual, surgió como propuesta para una evaluación del riesgo más completa, atendiendo así no solo a los factores negativos del caso sino también a aquellas dimensiones que pueden hacer que la probabilidad de conducta violenta se reduzca (véase, por ejemplo, de Vogel et al., 2011). Está pensado para ser aplicado como un complemento a herramientas como la HCR-20, centradas únicamente en factores de riesgo. Está compuesto por 17 factores que deben reducir el riesgo de violencia en un caso. Por tanto, pueden ser considerados objetivos a incrementar dentro de un plan de gestión. La codificación de los mismos contempla su presencia en los últimos seis meses, excepto para el ítem 1 (inteligencia) que conside-

ra evaluaciones en los últimos 6 años, el ítem 2 (apego seguro en la infancia) que tiene en cuenta toda la infancia, y el ítem 5 (autocontrol) que tiene en cuenta los últimos 12 meses.

En el primer estudio de validación del instrumento —con un diseño retrospectivo— (de Vries-Robbé et al., 2011) se describió una buena capacidad predictiva de la no reincidencia a un año (AUC = 0,85), empeorando a los dos años (AUC = 0,80) y a los tres años (AUC = 0,74). La fiabilidad interjueces de la puntuación total también fue alta (0,88). La capacidad predictiva fue mejor en todos los momentos para el SAPROF que para la HCR-20, señalando, por tanto, el valor de la evaluación de los factores protectores. Trabajos recientes han analizado su utilidad en la predicción del riesgo de reincidencia sexual, con resultados inconsistentes. Yoon et al. (2016) des-

criben una mala capacidad predictiva del desistimiento en reincidencia sexual, con valores AUC en torno a 0,6, señalándose que los ítems predicen mejor la reincidencia o la violencia general que la sexual. Otros trabajos, sin embargo, señalan una buena capacidad predictiva en delincuentes sexuales (de Vries Robbe, de Vogel, Koster y Bogaerts, 2015).

Aunque la consideración de los factores de protección se ha afianzado en el ámbito de la evaluación del riesgo (hemos visto, por ejemplo, cómo la START valora las dos opciones en todos sus ítems), la investigación aún es limitada y la combinación de ambos tipos de factores en una estimación concreta del riesgo es imprecisa. La herramienta está disponible en español (véase tabla 8.4), pero se carece aún de publicaciones sobre su uso.

TABLA 8.4
Factores de protección del SAPROF (de Vogel et al., 2012)

Factores internos	Factores motivacionales
1. Inteligencia. 2. Apego seguro en la infancia. 3. Empatía. 4. Capacidad para enfrentar dificultades. 5. Autocontrol.	6. Trabajo. 7. Actividades de ocio. 8. Gestión financiera. 9. Motivación hacia el tratamiento. 10. Actitudes hacia la autoridad. 11. Objetivos vitales. 12. Medicación.
Factores externos	
13. Red social. 14. Relaciones íntimas. 15. Atención profesional. 16. Condiciones de convivencia. 17. Control externo.	

Adaptación española: Hilterman, Poch y Venegas-Cardenas (2011); <http://www.saprof.com/>.

La violencia contra la pareja es el tipo de violencia sobre el que más se ha incrementado la atención pública y académica en la última década, en especial en el contexto español. Es por ello que, en lo referente a la valoración del riesgo, las herramientas disponibles son numerosas y se han multiplicado, en búsqueda de alternativas a las distintas demandas que han ido surgiendo. Servicios de justicia y policiales, servicios sociales y sanitarios, han sido los principales demandantes de estas técnicas, y ello explica el desarrollo de numerosos protocolos dirigidos a los distintos usuarios y contextos.

Cabe señalar que, pese al gran desarrollo de herramientas para valorar el riesgo de violencia de pareja, poco se ha avanzado respecto a los factores de riesgo, y la mayoría de los protocolos propuestos comparte un elevado porcentaje de ítems. Tomando como punto de partida los 20 ítems de la SARA, de las herramientas presentadas la primera en publicarse es el formato de evaluación centrada en el agresor (el DA valora el riesgo a partir de la víctima). En la tabla 9.1 se describe el solapamiento de ítems que se da entre los distintos protocolos.

La evolución en el desarrollo de protocolos para valorar el riesgo de violencia contra la pa-

reja ha incorporado ítems relacionados con la vulnerabilidad de la víctima, algo que parece mejorar la predicción de la violencia (Belfrage y Strand, 2008). Este ha sido el caso de la segunda versión del B-SAFER, la EPV-R, la RVD-Bcn y la versión 3 de la SARA. Todos estos ítems no estaban presentes en versiones previas de algunas herramientas como la SARA y el B-SAFER, tal como se presenta en la tabla 9.1. Pese a ello, características propias del agresor han sido las que mayor relación con el riesgo de reincidencia han demostrado (Kingsnorth, 2006; Tollefson y Gross, 2006). En la SARA, por ejemplo, los factores que más incrementan el riesgo de reincidencia son los quebrantamientos, los trastornos de la personalidad y distorsiones como la minimización y la negación (Grann y Wedin, 2002). En la EPV-R, los ítems más relacionados con el riesgo grave son las conductas controladoras o de celos, el consumo abusivo de alcohol/drogas o la falta de empatía, referentes a características propias del agresor (Echeburúa et al., 2010).

A continuación revisaremos las principales herramientas de uso habitual en la valoración del riesgo de violencia de pareja, incluyendo dos de creación en el contexto español.

TABLA 9.1
Similitudes entre herramientas para valorar el riesgo de violencia de pareja

SARA	SARA-V3	B-SAFER v.1*	ODARA	EPV-R	RVD-Bcn
1. Violencia anterior contra familiares.	P5		≈ 1		2
2. Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no familiares.	P5		2, 10	13	
3. Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares.	P5	4	4	≈3	5
4. Problemas recientes en la relación de pareja.	P1	7			
5. Problemas recientes de empleo/trabajo.	P3	8			
6. Víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia y/o adolescencia.	P4				
7. Consumo/abuso reciente de drogas.	P8	9	11	14	10
8. Ideas/intentos de suicidio y/o homicidio recientes.	P9				13
9. Síntomas psicóticos y/o maníacos recientes.	P6	10		15	11
10. Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad conductual.	P7	10		15	11
11. Violencia física anterior.	N3	1		≈4	≈4
12. Violencia sexual y/o ataques de celos en el pasado.	N4			10	≈14
13. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el pasado.	N2	≈2			6
14. Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones.	N6,7	3		6	9
15. Violaciones e incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento.	N8	4	4		5
16. Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja.	P10	5		≈17	
17. Actitudes que apoyan o consienten la violencia contra la pareja.	P10	5		≈17	
18. Violencia sexual grave.	N3,4			10	1
19. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles.	N2		≈5		6
20. Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento.	N8	4	4		5
<i>Ítems no cubiertos por la SARA</i>	N1, P2 y V1-6	6	3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14	1, 2, 5, 9, 16, 18, 19 y 20	3, 7, 8, 12, 15 y 16

NOTA: ≈, comparable.

* El B-SAFER v2 incluye cinco factores de vulnerabilidad de la víctima ausentes en la SARA.

1. DA

La *Danger Assessment* —DA— (Campbell, 1986; Campbell, Webster y Glass, 2009) fue posiblemente el primer intento por estimar el potencial riesgo de violencia letal en relaciones de pareja, bien como riesgo de que una mujer fuese asesinada por su pareja o bien como riesgo de que la víctima matase a su agresor. Junto a esta particularidad, su principal diferencia respecto a otros modelos analizados en este manual es que la herramienta está diseñada como un autoinforme de la propia víctima, centrándose, además, no en el riesgo de violencia de pareja en sentido amplio sino en el homicidio. La primera versión estaba compuesta por 15 ítems (Campbell, 1995) y la versión más reciente por 20 (Campbell, Webster et al., 2009).

La herramienta está organizada en dos apartados. Un autoinforme sobre el calendario del último año, en el que la víctima debe indicar la frecuencia y gravedad de la violencia padecida según la siguiente pauta: *señale las fechas aproximadas durante el último año en las que sufrió abusos o agresiones por parte de su pareja o expareja. Describa cómo fue de grave la agresión según el siguiente criterio (en caso de coincidir varios tipos, se escoge el número más alto): 1) bofetadas o empujones sin lesión ni dolor prolongado; 2) puñetazos, patadas, arañazos, quemaduras, cortes con lesiones y/o dolor prolongado; 3) palizas, contusiones graves, quemaduras o fracturas; 4) amenazas de uso de arma, lesiones en la cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes; 5) uso de armas o heridas por arma.* El segundo bloque corresponde a los ítems que se describen en la tabla 9.2, a los que la víctima debe responder Sí o No.

TABLA 9.2

Factores de riesgo del DA en formato pregunta para la víctima (Campbell, Webster et al., 2009)

1. ¿Ha aumentado la violencia física, en severidad o frecuencia, en el último año?
2. ¿Tiene él algún arma?
3. ¿Le ha dejado usted, después de vivir juntos, en el último año?
 - 3a. [Si nunca ha vivido con él, señálelo aquí ____].
4. ¿Está él en paro (desempleado, sin trabajo) actualmente?
5. ¿Ha usado algún arma contra usted o le ha amenazado con algún arma? [en caso afirmativo, ¿fue con una pistola?].
6. ¿Le ha amenazado con matarla?
7. ¿Ha evitado ser arrestado por violencia doméstica?
8. ¿Tiene usted algún niño/hijo que no es de él?
9. ¿Le ha forzado a mantener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba?
10. ¿Ha intentado alguna vez estrangularla?
11. ¿Toma él drogas? Por ejemplo, anfetaminas, cocaína, heroína, etc.
12. ¿Es alcohólico o tiene problemas con el alcohol?
13. ¿Le controla la mayoría de sus actividades diarias? Por ejemplo, le dice con quién puede hacer amistades, cuándo puede ver a su familia, cuánto dinero puede usar/gastar, o cuándo puede coger el coche? [si lo intenta, pero usted no le deja, señálelo aquí ____].
14. ¿Es celoso con usted constante y violentamente? (por ejemplo, dice «si no puedo tenerte, nadie podrá»).
15. ¿Le ha golpeado alguna vez estando embarazada? [si no ha estado nunca embarazada de él, señálelo aquí ____].
16. ¿Alguna vez él ha amenazado con suicidarse o lo ha intentado?
17. ¿Amenaza él con hacer daño a sus hijos?
18. ¿Cree usted que es capaz de matarla?
19. ¿La persigue o espía, le deja notas amenazantes o mensajes en el contestador, destruye sus cosas o propiedades, o le llama cuando usted no quiere?
20. ¿Alguna vez ha amenazado usted con suicidarse o lo ha intentado?

Traducción: Aguar-Fernández (<http://www.dangerassessment.org>).

La herramienta dispone de criterios de puntuación y baremos para los niveles de riesgo. Aplicando el algoritmo de corrección, el rango de puntuación es de -3 a 37. El proceso de corrección es el siguiente: 1) número total de respuestas afirmativas; suma 4 puntos por cada respuesta afirmativa a las preguntas 2 y 3; suma 3 puntos por la respuesta afirmativa a la pregunta 4; suma 2 puntos por cada respuesta afirmativa a las preguntas 5, 6 y 7; suma 1 punto por cada respuesta afirmativa a las preguntas 8 y 9; resta 3 puntos si se ha marcado el punto 3a. Los baremos para los niveles de riesgo son los siguientes: menos de 8 puntos, riesgo variable; entre 8 y 13 puntos, aumento del riesgo; entre 14 y 17 puntos, riesgo grave; y 18 puntos o más, riesgo extremo.

Además de estar diseñada para ser aplicada como entrevista o autoinforme de la víctima, el resultado también está orientado a la gestión conforme a los niveles de riesgo anteriormente señalados: 1) menos de 8: asegurarse de informar a la víctima de que el nivel de riesgo puede cambiar de forma rápida; entre 8 y 13: avisar a la víctima sobre el riesgo y los planes de seguridad, consultar con jueces y recomendar el nivel alto de supervisión; entre 14 y 17: misma recomendación que en el nivel anterior; 18 o más: advertir sobre el peligro grave, avisar a la justicia penal, recomendar fianzas o condenas más altas y el máximo seguimiento en libertad condicional.

La herramienta sigue el modelo de explicación del homicidio de pareja desarrollado por la propia autora, considerándolo predecible con variables como la violencia previa, los celos, la ruptura de pareja, el acoso, los trastornos mentales o el acceso a armas (Campbell, 2012; Campbell y Glass, 2009; Campbell et al., 2003; Campbell, Webster et al., 2009).

Los estudios han utilizado versiones muy dispares e incluso parciales. Por ejemplo, Heckert y Gondolf (2004) obtuvieron un AUC = 0,70 simulando la aplicación de algunos de los ítems. En la comparación de tentativas de homicidio con controles que solo habían agredido se encontró que el DA diferenciaba los grupos con un AUC = 0,916. Los sujetos con tentativas de homicidio

se ubicaban con mucha más probabilidad en las categorías de riesgo más altas comparados con los controles (Campbell, Webster et al., 2009). Se han propuesto versiones para inmigrantes —DA-I— (con 15 ítems originales y 11 específicos) con resultados satisfactorios, con un AUC = 0,85 para la violencia grave, significativamente mejor que el AUC = 0,65 obtenida en la muestra con la versión original (Messing, Amanor-Boadu, Cavanaugh, Glass y Campbell, 2013). También se ha adaptado para su uso en mujeres en relaciones homosexuales —DA-R—, con una predicción significativa en un seguimiento de un mes (Glass et al., 2008).

De media, la revisión de estudios estima en un AUC = 0,618 la capacidad predictiva del DA (Messing y Thaller, 2013). Una de las revisiones más extensas hasta la fecha, sobre la capacidad predictiva de herramientas para valorar el riesgo de violencia de pareja (Nicholls, Pritchard, Reeves y Hilterman, 2013), señala una consistencia interna entre 0,72 y 0,84 y AUC que van desde 0,56 (Hilton et al., 2004) hasta 0,92 (Campbell, Webster et al., 2009). Los valores más altos corresponden a trabajos de los propios autores de la herramienta, confirmándose el hábito señalado por Singh, Grann et al. (2013) en relación al sesgo del autor.

La herramienta también ha recibido algunas críticas, señalándose, por ejemplo, que sobreestima el riesgo de violencia letal frente a otras como el B-SAFER o la ODARA (Storey y Hart, 2014). La DA clasificaba como de riesgo alto (letal) al 72% de la muestra, algo improbable y que a su vez hace inviable la gestión del riesgo.

En conjunto, pese a ser una de las herramientas más antiguas, la investigación sobre sus propiedades es muy limitada, siendo la mayoría de la versión de 15 ítems y los referentes a la última versión hechos con la propia muestra con la que se creó (Storey y Hart, 2014). La investigación sobre la herramienta presenta, además, algunas limitaciones importantes (Nicholls et al., 2013): en muchos casos se desconoce la versión de la herramienta que se ha utilizado; pocos trabajos hacen alusión al uso o utilidad del calendario;

pese a haber sido creada para predecir el homicidio de pareja, en la mayoría de los casos se usa para predecir cualquier reincidencia en violencia de pareja.

En la actualidad hay una versión de *screening* de 11 ítems (Messing, Campbell, Sullivan Wilson, Brown y Patchell, 2015). La herramienta ha sido traducida al español por Aguar-Fernández (disponible en <http://www.dangerassessment.org>), pero se carece de estudios de validación.

2. SARA

La *Spousal Assault Risk Assessment guide* —SARA— es la herramienta más conocida a nivel mundial para la evaluación del riesgo de violencia en la pareja. Fue pionera en el ámbito del juicio profesional estructurado, surgiendo en los inicios del modelo de predicción junto a la ya analizada HCR-20. Siguiendo el mismo formato que sus coetáneas, la HCR-20 y la SVR-20, las versiones 1 y 2 de la SARA (Kropp et al., 1995) están compuestas por 20 factores de riesgo. La versión 3 (Kropp y Hart, 2016), como veremos, ha modificado esta estructura y está compuesta por 24 factores (véase tabla 9.3).

Como herramienta de juicio estructurado, parte de la codificación de los ítems como presentes, parcialmente presentes (o dudosos) y ausentes. La versión 2 de la herramienta, la que más se ha utilizado hasta la fecha y que es la adaptada al español, incluía la opción de marcar hasta 3 ítems como críticos (un ítem crítico puede justificar la consideración del caso como de riesgo alto). Con la versión 2, además, los autores hicieron una excepción en las herramientas de juicio profesional estructurado, proponiendo la corrección numérica y ofreciendo puntuaciones centiles (Kropp et al., 1999), tal como hemos presentado en el capítulo 7, apartado 6.3. Las puntuaciones se establecieron con 638 agresores de pareja presos y 1.671 en libertad condicional (Kropp y Hart, 2000; Kropp y Gibas, 2010). El estudio de validación (Kropp y Hart, 2000) mostró que las puntuaciones de la herramienta diferenciaban entre delin-

cuentes con y sin historia de violencia de pareja, y entre agresores de pareja reincidentes y no reincidentes. Las tablas de clasificación permiten comparar la puntuación total de nuestro sujeto respecto a la muestra penitenciaria, la muestra en libertad condicional o la muestra global (a partir de 20 puntos sobre 40, el sujeto puede ser etiquetado como de riesgo alto), así como comparar el caso según el número de factores presentes (a partir de ocho factores presentes se señala que el caso puede ser etiquetado como de riesgo alto). Al margen de la posible utilidad de los criterios numéricos para ayudar al profesional en la toma de decisiones, también contemplan la posibilidad de que el criterio numérico no coincida con el criterio del profesional. Así pues, si la discrepancia consiste en considerar de riesgo alto a un caso con pocos factores presentes, el profesional deberá explicar por qué se ha dado tanto peso a esos pocos factores. Por el contrario, si con muchos factores se considera el caso de riesgo bajo, se deberá explicar por qué tienen tan poca relevancia tantos factores.

La versión 3 (Kropp y Hart, 2016) ha modificado su contenido tanto en extensión (de 20 ha pasado a 24 ítems) como en temáticas incluidas. La principal diferencia respecto a versiones previas es la inclusión de seis factores de vulnerabilidad de la víctima, fruto de las evidencias relativas a la relevancia de dichas variables obtenidas, por ejemplo, con el B-SAFER (Belfrage y Strand, 2008; Kropp et al., 2010) y en la bibliografía en general (Bowen, 2011). La herramienta también ha modificado el formato de codificación de los ítems (pues además del presente, posible y ausente, añade la codificación de «omitido») y añade dos plazos temporales para la codificación: reciente (último año) y pasado. Por último, incorpora la codificación de la relevancia de cada ítem, que, como hemos visto, es fundamental para la formulación y gestión del caso (véanse apartados 3 y 5 del capítulo 7). El criterio señalado en la guía para esta valoración es la consideración de la medida en la que el factor de riesgo es importante para la implementación de medidas de gestión (incrementa el riesgo, reduce la utilidad de la protección, etc.).

La utilización de ambas versiones requiere el acceso a distintas fuentes de información (como registros delictivos o informes psicológicos), y la versión 3 requiere información específica de la víctima. La versión 2, además, tiene un problema con el posible solapamiento de los ítems, ya que algunos, pese a tener nombres similares, hacen alusión a temas o plazos temporales diferentes. Por ejemplo, el ítem 3 (violación de medidas) hace alusión a medidas por cuestiones distintas a la violencia de pareja; en el 15, los quebrantamientos o incumplimientos hacen referencia a la violencia de pareja, pero en el pasado; y en el 20, los quebrantamientos son en violencia de pareja pero solo en el delito actual (*index offense*). Este hecho hizo que el análisis factorial de la herramienta permitiera crear una versión breve, para uso policial, llamada B-SAFER (que se explica en el siguiente punto).

La herramienta ha sido utilizada en numerosos estudios del contexto anglosajón. Entre estos estudios, Belfrage et al. (2012) encontraron una mejor predicción de la puntuación ($AUC = 0,63$) que de las categorías ($AUC = 0,57$), y Grann y Wedin (2002) que el AUC mejora con la ampliación del seguimiento, con un 0,52 al año y un 0,65 a los cinco años. Sin embargo, Kropp y Gibbs (2010) señalaron que la mayoría de estudios de validación no han utilizado la herramienta conforme a las instrucciones originales, bien por hacer correcciones numéricas o por no disponer de información para muchos de los ítems. Ellos separaron las propiedades encontradas en estudios con aplicación correcta y aquellos que no habían seguido la recomendación. En los primeros encontraron AUC entre 0,52 y 0,70; en los segundos, entre 0,54 y 0,65. La SARA ha sido utilizada también en mujeres (Simmons, Lehmann y Cobb, 2008; Simmons, Lehmann y Cobb, 2009), encontrando una heterogeneidad entre las agresoras como en los varones y algunas mujeres con muchos de los factores de riesgo de la herramienta.

En revisiones sobre validez de los instrumentos para la evaluación del riesgo de violencia de pareja, se le atribuye un AUC media de 0,68 pro-

veniente de seis estudios (Messing y Thaller, 2013). Hilterman et al. (2014) también describen AUC entre 0,52 y 0,70, esta última en un estudio de los propios autores (Kropp y Hart, 2000). Por tanto, se puede decir que, respecto a la capacidad predictiva medida con el AUC , los valores son bajos. Helmus y Bourgon (2011) hicieron una revisión sobre 15 años de aplicación de la herramienta, calculando un rango de AUC entre 0,59 y 0,77 (promedio de 0,63).

En España, la SARA es de uso habitual en contextos penitenciarios, servicios de atención a la víctima o tratamiento de agresores. El primer trabajo con la traducción al español fue el de Andrés-Pueyo, López y Álvarez (2008), un estudio retrospectivo en el que se revisaron expedientes judiciales e informes del equipo de asesoramiento técnico penal para comparar el riesgo en casos de violencia grave y menos grave. Se obtuvo una puntuación media de 19,58, la valoración global ofreció una clasificación correcta de los reincidentes del 85% (sensibilidad) y de los no reincidentes del 72% (especificidad), y la probabilidad de reincidencia fue 6 veces superior en aquellos que puntuaban por encima de la media. De este estudio se derivó el punto de corte no formal de 19 para estimar la reincidencia.

Lila, Oliver, Lorenzo y Catalá (2013) utilizaron la SARA para predecir la reincidencia en agresores en tratamiento en la comunidad. Obtuvieron una puntuación total media de 6,23, y con la valoración global el 73,2% correspondía al riesgo bajo, el 27,5% al medio y el 1,1% al alto. Para el análisis cualitativo, la participación comunicatoria y el apoyo formal eran las variables más relacionadas con la valoración hecha, variables ausentes en la SARA. La herramienta también ha sido utilizada como medida de cambio terapéutico (Lila, Oliver, Galiana y Gracia, 2013). Recientemente, Llor-Esteban, García-Jiménez, Ruiz-Hernández y Godoy-Fernández (2016) han utilizado la herramienta para clasificar a agresores de pareja en prisión y en tratamiento comunitario en tres subtipos: *borderline*/disfóricos (riesgo alto); antisociales de nivel bajo (riesgo medio) y agresores limitados a la familia (riesgo bajo) (véase Amor,

TABLA 9.3
Factores de riesgo en la SARA (Kropp et al., 1999) y la SARA-V3 (Kropp y Hart, 2016)

SARA	SARA-V3
Historial delictivo 1. Violencia anterior contra familiares. 2. Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no-familiares. 3. Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares. Ajuste psicológico 4. Problemas recientes en la relación de pareja. 5. Problemas recientes de empleo/trabajo. 6. Víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia y/o adolescencia. 7. Consumo/abuso reciente de drogas. 8. Ideas/intentos de suicidio y/o homicidio recientes. 9. Síntomas psicóticos y/o maníacos recientes. 10. Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad conductual. Historia de violencia contra la pareja 11. Violencia física anterior. 12. Violencia sexual y/o ataques de celos en el pasado. 13. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el pasado. 14. Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones. 15. Violaciones e incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento. 16. Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja. 17. Actitudes que apoyan o consienten la violencia contra la pareja. Agresión actual (que motiva la valoración) 18. Violencia sexual grave. 19. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles. 20. Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento.	Naturaleza de la violencia de pareja 1. Intimidación. 2. Amenazas. 3. Daño físico. 4. Violencia sexual. 5. Violencia de pareja grave. 6. Violencia de pareja crónica. 7. Escalada. 8. Quebrantamientos relacionados con la violencia de pareja. Factores de riesgo del agresor 1. Relaciones de pareja. 2. Relaciones distintas a las de pareja. 3. Trabajo y dinero. 4. Trauma y victimización. 5. Conducta antisocial general. 6. Trastorno mental grave. 7. Trastorno de la personalidad. 8. Abuso de sustancias. 9. Ideación suicida/violenta. 10. Pensamientos distorsionados sobre violencia de pareja. Factores de vulnerabilidad de la víctima 1. Limitaciones sobre seguridad. 2. Limitaciones sobre independencia. 3. Recursos interpersonales. 4. Recursos comunitarios. 5. Actitudes y conductas. 6. Salud mental.

SARA: adaptación española Andrés-Pueyo y López (2005). SARA-V3: adaptación no disponible.

Echeburúa y Loinaz, 2009; Loinaz, Echeburúa y Torrubia, 2010, para profundizar en la investigación sobre tipologías).

Pese a este uso, son escasas las referencias a la validez o capacidad predictiva de la versión española. Existe también una adaptación en Argentina (Folino, 2004).

3. B-SAFER

El *Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk* —B-SAFER— (Kropp y Hart, 2004; Kropp, Hart y Belfrage, 2005) se creó con el objetivo de ofrecer una herramienta breve y de uso sencillo para cuerpos policiales, en los que se carece de cierta información y de tiempo (Kropp, 2008; Kropp et al., 2005). Además, se buscaba superar las limitaciones encontradas en la SARA, referentes al solapamiento de ítems y, por ende, codificación de un único factor de riesgo en distintos ítems.

El análisis factorial de la SARA indicaba la existencia de asociación entre las puntuaciones en los 20 ítems y siete posibles factores (compuestos por distintos ítems): historia de violencia en la pareja, violencia en la pareja que haga peligrar la vida, escalada en la violencia contra la pareja, actitudes mantenedoras de la violencia de pareja, conducta antisocial general, desobediencia de órdenes judiciales (quebrantamientos) y trastorno mental (Kropp y Hart, 2004). En 2002 se puso a prueba una versión policial de la SARA que llevó a la conclusión de que algunos de los ítems contenían información redundante y otros ítems eran difíciles de responder en el contexto policial. A raíz de esto, se diseñó el B-SAFER para poner a prueba diez factores de riesgo en estudios piloto en Canadá y Suecia.

La versión 1 está compuesta por 10 ítems divididos en dos secciones: agresión a la pareja y ajuste psicológico. La versión 2 (Kropp et al., 2010) incluye estos mismos ítems, más cinco pertenecientes a la vulnerabilidad de la víctima (véase tabla 9.4). Los ítems se codifican como presentes (sí), parcialmente presentes (?) o ausentes

(no), para el presente (últimas cuatro semanas) y el pasado (período anterior). Los autores no proponen puntos de corte en sus guías, siguiendo las directrices del juicio estructurado.

La herramienta ha sido aplicada en distintos estudios en Suecia. Por un lado, se ha vinculado su uso con la aplicación de órdenes de alejamiento en los casos de riesgo alto, principalmente con diferencias en los ítems de historia de violencia (Strand, 2012). Belfrage y Strand (2012) encontraron una relación inversa entre el riesgo y la reincidencia. Los sujetos de riesgo alto reincidían menos que los de riesgo bajo, pero la variable que mediaba en la relación era la gestión policial: los casos de mayor riesgo recibían una gestión inmediata, mientras que los demás no recibían tanta atención. Además, encontraron que las variables de vulnerabilidad de las víctimas correlacionaban con el riesgo asignado por los policías. También en Suecia, Storey et al. (2014) encontraron que tanto la puntuación total ($AUC = 0,70$) como las valoraciones globales hechas por los policías ($AUC = 0,69$) predecían la reincidencia. Detectaron una reducción de la reincidencia en los casos de riesgo alto, pero un incremento en los de riesgo bajo debido a la gestión aplicada (posiblemente por el exceso de intervención en los últimos). También analizaron la estabilidad de las puntuaciones de riesgo tras la reincidencia, encontrando una estabilidad significativa ($ICC = 0,76$) y un cambio en la categoría de riesgo, incrementándose en especial la categoría de riesgo alto. La relación de la puntuación total con la reincidencia fue de $r_{bp} = 0,29$ y la puntuación media de los reincidentes (11,36) fue significativamente mayor que la de los no reincidentes (8,27). Los niveles de riesgo también correlacionaban con la reincidencia de forma significativa, $r_{bp} = 0,25$, y la reincidencia también variaba significativamente entre niveles de riesgo: 10% en el bajo, 25% en el moderado y 45% en el alto. El B-SAFER también ha sido utilizado en mujeres por la policía de Suecia (Storey y Strand, 2013).

Au et al. (2008), con la adaptación de la herramienta en China, encontraron que discriminaba entre agresores y controles (clasificación correcta

TABLA 9.4
Ítems del B-SAFER v1 y v2
 (Kropp et al., 2005 y Kropp et al., 2010)

B-SAFER v2	B-SAFER v1	Bloque I. Agresión a la pareja 1. Conducta violenta. 2. Amenazas (pensamientos violentos). 3. Escalada de violencia. 4. Quebrantamientos. 5. Actitudes violentas.
		Bloque II. Ajuste psicológico 6. Delincuencia general. 7. Problemas en relaciones íntimas. 8. Problemas laborales. 9. Problemas toxicológicos. 10. Problemas mentales.
		Bloque III. Vulnerabilidad de la víctima 11. Actitudes o comportamientos inconsistentes. 12. Miedo extremo al agresor. 13. Soporte o recursos inadecuados. 14. Situación de vida insegura. 15. Problemas de salud.

del 91 % de los agresores y del 100 % de los no agresores) y que la puntuación total correlaciona con las escalas de agresión psicológica y agresión física de la CTS-2 (validez convergente).

Uno de los objetivos abordados con la herramienta ha sido la identificación de tipologías de agresores (véase Amor et al., 2009; Loinaz et al., 2010). En Holanda, Thijssen y de Ruiter (2011) transformaron las puntuaciones de los ítems del B-SAFER en las dimensiones de clasificación propuestas por Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) del siguiente modo: *severidad de la violencia* (ítem 1), *generalidad de la violencia* (ítem 6) y *psicopatología/trastornos de la personalidad* (ítems 9 y 10). En otra muestra holandesa, de 154 agresores de pareja voluntarios, Serie, van Tilburg, van Dam y de Ruiter (2015) clasificaron a los sujetos en cuatro subtipos: antisociales de nivel bajo, limitados a la familia, con psicopatología y violentos en general. Se propuso la evaluación

del riesgo como paso para la recepción inicial de los agresores, tanto para estimar su riesgo de reincidencia como para adecuar el tratamiento. Por último, Petersson, Strand y Selenius (2016) clasificaron en *antisociales* o *limitados a la familia* una muestra de agresores de pareja evaluados por la policía en Suecia, a partir de la respuesta al ítem «delincuencia general». Los sujetos del subtipo *antisocial* presentaban un riesgo significativamente mayor que los *limitados a la pareja* (con significativamente más presencia de todos los factores de riesgo excepto del 1, agresiones físicas). En los agresores *antisociales*, las amenazas y la escalada estaban muy relacionadas con el riesgo de violencia grave. En el grupo *limitado a la pareja*, el factor vinculado a un mayor riesgo era el de actitudes violentas.

En el contexto español, la primera versión del B-SAFER se ha utilizado para predecir la reincidencia penitenciaria, así como para clasificar ti-

pológicamente a los agresores (Loinaz, 2014b). En ambos casos la herramienta mostró buenos resultados. La predicción de la reincidencia ofreció un AUC = 0,76 (100% de sensibilidad y 63% de especificidad con un punto de corte ≥ 13 , lo que implica muchos faltos positivos). La capacidad para clasificar a los agresores también fue buena, con un AUC = 0,83 (mejor clasificación de los normalizados, 91%, que de los antisociales, 69%).

4. ODARA

La *Ontario Domestic Assault Risk Assessment* —ODARA— (Hilton et al., 2004) es una herramienta actuarial para la valoración policial del riesgo de violencia de pareja. Se trata de una herramienta breve compuesta por 13 ítems de respuesta dicotómica (véase tabla 9.5), cuya guía de aplicación está pensada para la obtención de la información en la entrevista con la víctima (en cada ítem se sugieren posibles preguntas a hacer, por parte de los policías, para poder obtener la información) y para la comunicación del riesgo a la víctima.

Las variables fueron seleccionadas mediante regresión logística, eligiendo entre las que tenían mayor capacidad predictiva de todas las codificadas por la policía y puestas a prueba en un estudio de seguimiento de 589 casos (se seleccionaron en cada paso solo las que incrementaban la predicción). Esto dio lugar a los 13 ítems, y, pese a que cada variable tenía una relación diferente con la reincidencia, decidieron no asignar pesos numéricos. Además, los autores decidieron no dejar espacio para que el profesional incluyera cualquier otro ítem, por haber encontrado, en el caso de la VARAG, que este aporte del evaluador no incrementaba la capacidad predictiva (Hilton, Harris y Rice, 2010).

La ODARA tiene un rango de puntuación de 0-13 y en la muestra de creación se obtuvo un riesgo medio de 2,14. Los ítems tienen una fiabilidad interjueces de 0,95 (Hilton et al., 2004). La incorporación de la PCL-R a la ODARA y la modifica-

ción del sistema de corrección ha dado como resultado la *Domestic Violence Risk Appraisal Guide* —DVRAG— (Hilton, Harris, Rice, Houghton y Eke, 2008).

El número de factores presentes en la ODARA se usó para comparar puntuaciones entre reincidentes y no reincidentes (Hilton et al., 2004), así como para calcular el porcentaje de reincidencia según el número de factores (Hilton y Harris, 2009; Hilton, Harris et al., 2008; Hilton et al., 2004). Este procedimiento es el que facilitó ofrecer los resultados de la herramienta en dos formatos (véase tabla 7.4): 1) probabilidad de reincidencia (por ejemplo, el 20% de los agresores que puntúa 2 en la ODARA vuelve a agredir a la pareja en un plazo de cinco años); y 2) riesgo relativo (por ejemplo, siete de cada diez agresores puntúa 3 o menos en la ODARA).

La mayor parte de las validaciones del instrumento se han desarrollado por los propios autores (Hilton y Harris, 2009; Hilton, Harris et al., 2008), obteniendo AUC entre 0,72 y 0,80. La revisión de Hiltermann et al. (2014) sobre las propiedades de herramientas para VCP señala que los seis estudios utilizados para calcular la validez de la ODARA (con AUC entre 0,64-0,77) habían sido publicados por los propios autores, lo cual limita la representatividad del dato. Messing y Thaller (2013), sin embargo, al calcular un AUC media de 0,67, incluyeron en su estimación cinco estudios, de los cuales uno era independiente. Se trata del estudio de Rettenberger y Eher (2013), en el que se validó la ODARA y la DVRAG en una muestra de 66 agresores dados de alta de una prisión de alta seguridad en Austria, condenados por un delito sexual contra su pareja o expareja. En este caso se obtuvo un AUC = 0,71 para la predicción de la reincidencia en un seguimiento medio de 66 meses. También concluyeron que la suma de la PCL-R a la ODARA no aportaba ningún beneficio en la validez predictiva.

Puesto que la ODARA es una herramienta diseñada para uso policial, Hilton, Harris, Popham y Lang (2010) la aplicaron en 150 agresores de pareja en prisión, para ver la medida en la que era igualmente útil en un seguimiento medio de

TABLA 9.5
Ítems y codificación de la ODARA y la DVRAG (Hilton, Harris y Rice, 2010)

ODARA	Ítem	DVRAG		
0-1	1. Antecedentes de violencia doméstica en registros policiales (contra una pareja o hijo/a).	-1	0	+5
0-1	2. Antecedentes de violencia no-doméstica en registros policiales (contra cualquier persona distinta a la pareja o hijo/a).	-1		+5
0-1	3. Condena previa de 30 días o más.	-1		+2
0-1	4. Fracasos previos en libertad condicional, bajo fianza, órdenes de alejamiento, etc.	-1		+2
0-1	5. Amenaza de dañar o matar a cualquier persona durante el incidente que motiva la evaluación.		0	+1
0-1	6. Privación de la libertad (retención) de la víctima durante el incidente que motiva la evaluación.		0	+1
0-1	7. Preocupación de la víctima por una agresión futura.		0	+2
0-1	8. Más de un hijo común con el agresor.	-1		+1
0-1	9. La víctima tiene un hijo biológico de una pareja anterior.	-1	0	+2
0-1	10. Violencia contra otros (cualquier persona que no sea la pareja o los hijos de ella).		0	+8
0-1	11. Más de un indicador de abuso de sustancias.	-2		+2
0-1	12. Agresión a la víctima cuando estaba embarazada.		0	+5
0-1	13. La víctima tiene al menos una de las siguientes limitaciones: niños, sin teléfono, sin acceso al transporte, aislamiento geográfico, consumo o problemas con el alcohol u otras drogas.	-1	0	+4
NA	14. Psicopatía.	-1	0	+1 +6

NA = no aplicable.

cinco años. La media de puntuación fue 5,81 y obtuvo un AUC = 0,638. Los ítems más relacionados fueron la violencia previa y las amenazas en el delito base. Incluso para la reincidencia general, la ODARA funcionó igual que el LSI (0,685 vs. 0,697, respectivamente). Eke, Hilton, Harris, Rice y Houghton (2011) analizaron retrospectivamente 30 homicidios de pareja y llegaron a la conclusión de que los incidentes podrían haber sido predichos con el riesgo obtenido en la ODARA, pues todos se ubicaban en las categorías más altas.

Hilton y Eke (2016) confirmaron que muchos agresores de pareja no se especializan en este tipo de violencia y encontraron que las puntuaciones de la ODARA predecían la reincidencia en violencia de pareja (AUC = 0,67), el acoso (AUC = 0,78), la agresión sexual (AUC = 0,67) y los delitos no violentos (AUC = 0,74). Recientemente, se ha utilizado la versión en alemán en Suiza para calcular la validez convergente con una nueva herramienta, obteniéndose una predicción significativa (AUC = 0,73) de la reincidencia en un seguimiento de tres meses (Gerth, Rosse-

gger, Singh y Endrass, 2015). También se ha propuesto y analizado la utilidad de un sistema de formación online (Hilton y Ham, 2015), y ha sido aplicada en mujeres agresoras con una buena capacidad predictiva de la reincidencia ($AUC = 0,72$; Hilton, Popham, Lang y Harris, 2014).

No hay disponible ninguna traducción oficial al español de la herramienta, ni se ha podido localizar ninguna publicación en el contexto hispanohablante.

5. HERRAMIENTAS CREADAS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

5.1. EPV-R

La EPV puede considerarse la primera herramienta para la evaluación del riesgo de violencia de pareja diseñada en el contexto español sobre la que se han publicado trabajos empíricos. En una primera fase se partió de 58 ítems y se intentó diferenciar 269 casos de violencia grave (con homicidios o tentativas, empleo de armas u objetos peligrosos o producción de lesiones) y 812 casos de violencia menos grave (sujetos denunciados que no cumplían los criterios anteriores) (Echeburúa, Fernández-Montalvo y de Corral, 2008). En una etapa posterior, el número de ítems se redujo, seleccionando aquellos con mayor capacidad predictiva, quedando un total de 20 que se agruparon en cinco apartados: datos personales, situación de la relación de pareja, tipo de violencia, perfil del agresor y vulnerabilidad de la víctima (Echeburúa, Fernández-Montalvo, de Corral y López-Goñi, 2009).

En su revisión empírica (Echeburúa, Amor, Loinaz y de Corral, 2010), de la que surgió la EPV-R, se analizó la aplicación real en 450 casos evaluados por la Ertzaintza (policía autónoma del País Vasco). La herramienta fue corregida para hacer frente a los principales problemas derivados de su aplicación: dudas en la aplicación de algunos ítems, riesgo final en caso de ítems omitidos y puntos de corte ajustados.

El enfoque de la EPV-R es actuarial, pues el resultado del riesgo se deduce de la suma y ponderación de ítems, aunque su objetivo principal es la aplicación de distintas medidas de gestión del riesgo a partir de los niveles de riesgo estimados (véase tabla 7.3). A diferencia de otras herramientas actuariales, el riesgo no se estima en formato de probabilidad de reincidencia, sino que se gestiona en función de su gravedad.

A nivel metodológico, una de sus principales limitaciones es la ausencia de resultados sobre validez predictiva de la reincidencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el estudio de este aspecto resulta complicado, al existir una intervención policial sobre los casos. En el estudio de revisión se encontró una capacidad moderada para diferenciar las agresiones graves de las no graves ($AUC = 0,69$) y una buena fiabilidad interjueces ($r = 0,73$).

La EPV-R está compuesta por 20 factores de riesgo (tres de los cuales hacen referencia a la vulnerabilidad de la víctima), cuyo valor está ponderado según su relación con la violencia grave, pudiendo valer 1, 2 o 3 puntos. Por tanto, la presencia del factor de riesgo tendrá uno de estos valores y su ausencia supondrá un 0, tal como se muestra en la tabla 9.6.

El nivel de riesgo final se establece en tres niveles (aunque la Ertzaintza, en su práctica diaria, utiliza los 4 que se han presentado en la tabla 7.3). Estos niveles de riesgo tienen puntuaciones asociadas: riesgo bajo 0-9, riesgo medio 10-23, y riesgo alto 24-40. La herramienta permite prorratear la puntuación, para evitar que la ausencia de información afecte a la protección de la víctima. Se acepta un máximo de 12 omisiones, en seis de los ítems de discriminación alta (valorados con un 3). El proceso de aplicación del prorrateo se puede consultar en Echeburúa et al. (2010).

La herramienta fue incluida en 2011 en el *Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género*, aunque fuera de la práctica profesional (forense y policial) aún es escasa su aplicación.

TABLA 9.6
Ítems de la EPV-R (Echeburúa et al., 2010)

Factor de riesgo	Valor
1. Datos personales	
1. Procedencia extranjera del agresor o de la víctima.	0 o 1
2. Situación de la relación de pareja	
2. Separación reciente o en trámites de separación.	0 o 1
3. Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la orden de alejamiento.	0 o 2
3. Tipo de violencia	
4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones.	0 o 2
5. Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares.	0 o 2
6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en el último mes.	0 o 3
7. Amenazas graves o de muerte en el último mes.	0 o 3
8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo.	0 o 3
9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves.	0 o 3
10. Agresiones sexuales en la relación de pareja.	0 o 2
4. Perfil del agresor	
11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja.	0 o 3
12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior.	0 o 2
13. Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, compañeros de trabajo, etc.).	0 o 3
14. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas.	0 o 3
15. Antecedentes de enfermedad mental, con abandono de tratamientos psiquiátricos o psicológicos.	0 o 1
16. Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento.	0 o 3
17. Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la víctima.	0 o 3
5. Vulnerabilidad de la víctima	
18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes.	0 o 3
19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al agresor.	0 o 3
20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o dependencia.	0 o 2

5.2. RVD-Bcn

La RVD-Bcn se publicó en 2011 por el *Círculo Barcelona contra la violencia contra las mujeres* (Álvarez et al., 2011). Surgió como necesidad de un circuito dedicado a la prevención, detección y atención integral de las mujeres víctimas de vio-

lencia de pareja. En su desarrollo se obtuvo información de 216 mujeres usuarias de este servicio, a las que se hizo un seguimiento hasta 6 meses después de la primera entrevista (Arbach y Andrés-Pueyo, 2014).

Está compuesta por 16 factores de riesgo, incluido uno de vulnerabilidad de la víctima y otro sobre

su percepción de situación de riesgo (véase tabla 9.7). No se permiten valoraciones del riesgo con más de siete ítems omitidos. Al igual que la EPV-R, utiliza puntos de corte para establecer los tres niveles de riesgo: riesgo bajo, 1-7 respuestas afirmativas; riesgo medio, 8-9 respuestas afirmativas; riesgo alto, 10-16 respuestas afirmativas. Se recomienda que la puntuación numérica sea orientativa y el profesional aplique su juicio para estimar el riesgo final del caso.

En su estudio de creación se obtuvo una fiabilidad interjueces media de 0,72; el análisis de la fiabilidad interna hizo que se eliminara un ítem y se fusionaran otros tres hasta alcanzar un valor de

$\alpha = 0,71$. La media de los sujetos en el RVD-Bcn fue de 8,4, con una correlación significativa con la reincidencia en violencia física a tres ($r = 0,19$) y seis meses ($r = 0,22$). Las amenazas ($r = 0,26$), la violencia psicológica ($r = 0,16$) y el acoso ($r = 0,17$) también estuvieron relacionados con la puntuación de la herramienta. Respecto a la capacidad predictiva, la violencia física obtuvo el AUC más grande (0,72) y las demás formas de violencia valores más pobres según el plazo de seguimiento a tres o seis meses (Arbach y Andrés-Pueyo, 2014).

La herramienta es de acceso gratuito en Internet.

TABLA 9.7
Factores de riesgo del RVD-Bcn (Álvarez et al., 2011)

Historia de conducta violenta de la pareja o expareja	
1.	Agresiones o violencia física y/o sexual en los últimos 18 meses hacia la mujer o hacia parejas anteriores.
2.	Agresiones o violencia hacia terceras personas, sean familiares (hijos/hijas u otras) o no.
3.	Agresiones a la mujer cuando estaba embarazada.
4.	Antecedentes policiales/judiciales de violencia hacia la pareja/ex pareja (pareja actual u otras parejas en episodios anteriores).
5.	El agresor ha roto medidas judiciales de protección de la mujer.
Amenazas y/o abusos graves contra la mujer	
6.	La mujer ha recibido amenazas graves y creíbles, y/o con uso de armas, respecto a su integridad física.
7.	La mujer ha sufrido un abuso emocional y verbal grave en los últimos seis meses.
Circunstancias agravantes	
8.	La mujer comunica al presunto agresor la voluntad de separarse, o hace menos de seis meses que se ha producido la separación.
9.	Incremento, en los últimos seis meses, de la frecuencia o gravedad de los episodios de violencia.
10.	El presunto agresor abusa de drogas y/o alcohol.
11.	Diagnóstico o historia de trastorno mental severo del presunto agresor.
12.	Tenencia o fácil acceso a armas por parte del presunto agresor.
13.	Intentos o ideas de suicidio por parte del presunto agresor.
14.	Control extremo de los actos de la mujer por celos o similar.
Factores de vulnerabilidad de la mujer	
15.	Aislamiento social y/o falta de recursos personales de la mujer, y/o la mujer justifica la violencia ejercida por el presunto agresor, y/o presencia de hijos/hijas menores y/o dependientes de la mujer.
Percepción de la situación de riesgo por parte de la mujer	
16.	La mujer cree que el presunto agresor es capaz de matarla personalmente o a través de terceras personas.

Violencia sexual 10

La violencia sexual ha suscitado un gran interés en el contexto criminológico, en el penal y en la sociedad en conjunto. Pese a la gran alarma social que suscitan estos agresores, en especial su puesta en libertad tras el paso por prisión, su reincidencia oficial en violencia sexual (delitos conocidos) tiende a ser baja, entre un 9% y 20% (Hanson y Morton-Bourgon, 2009; Helmus et al., 2013; Herrero, 2013), inferior a la de otros tipos de agresores como los de pareja (véase Loinaz, 2011).

El material sobre evaluación del riesgo y tratamiento de delincuentes sexuales es muy extenso (por ejemplo, Beech, Craig y Browne, 2009; Craig, Browne y Beech, 2008; Phenix y Hoberman, 2016), incluso se dispone de manuales específicos para agresoras (Duncan, 2010; Gannon y Cortoni, 2010). Asimismo, son numerosas las herramientas disponibles para valorar el riesgo de violencia sexual, tanto en jóvenes como en adultos, principalmente de tipo actuarial. Asimismo, distintos trabajos han revisado y comparado las propiedades de estas herramientas, tratando de identificar la más precisa de ellas (Barbaree, Langton y Peacock, 2006; Barbaree, Seto, Langton y Peacock, 2001; Hanson y Morton-Bourgon, 2009; Hanson y Thornton, 2000; Harris et al., 2003; Hempel, Buck, Cima y van Marle, 2013; Rettenberger, Matthes, Boer y Eher, 2010; Smid, Kamphuis, Wever y Van Beek, 2014; Tully et al., 2013).

A continuación haremos un breve repaso de los principales instrumentos para la evaluación del riesgo de violencia sexual en adultos. Las herra-

mientas ERASOR, J-SOAP-II y J-SORRAT-II se describirán en el capítulo 11, junto a otras propuestas para la evaluación de muestras juveniles.

1. SVR-20

El *Sexual Violence Risk-20* —SVR-20— (Boer et al., 1997) fue la primera propuesta de evaluación del riesgo de violencia sexual con juicio profesional estructurado. Como su nombre indica, el instrumento está compuesto por 20 factores de riesgo (véase tabla 10.1), divididos en tres bloques: ajuste psicosocial (11 ítems), delitos sexuales (7 ítems) y planes futuros (2 ítems). El ítem 3 incluye la psicopatía, evaluada con herramientas como la PLC-R. Los factores de riesgo se codifican como presentes (sí), parcialmente presentes (?) o ausentes (no). Para aquellos presentes, se solicita la valoración del cambio reciente (último año u otro plazo según el marco temporal de nuestra evaluación), estimando si ha empeorado (+ = aumento), sigue igual (0 = sin cambio) o ha mejorado (– = reducción).

El resultado final de la herramienta equivale al juicio del profesional (bajo, medio o alto), pues no se plantea un sumatorio de ítems. Para la investigación se han usado respuestas de 0-1-2, obteniéndose un rango de puntuación 0-40. Para un nivel de riesgo bajo se recomiendan reevaluaciones cada seis o 12 meses o cuando existan cambios importantes en la situación del caso.

TABLA 10.1

Factores de riesgo del SVR-20 (Boer et al., 1997)

Ajuste psicosocial
- Desviación sexual. - Víctima de abuso en la infancia. - Psicopatía. - Trastorno mental grave. - Problemas relacionados con el consumo de sustancias. - Ideación suicida u homicida. - Problemas en relaciones de pareja. - Problemas de empleo. - Antecedentes de delitos violentos NO sexuales. - Antecedentes de delitos NO violentos. - Fracaso en las medidas de supervisión.
Delitos sexuales
- Frecuencia elevada de delitos sexuales. - Tipología múltiple de delitos sexuales. - Daño físico a la víctima del delito sexual. - Uso de armas o amenazas de muerte durante el delito sexual. - Progresión en la frecuencia o gravedad de los delitos sexuales. - Minimización extrema o negación. - Actitudes que apoyan o justifican los delitos sexuales.
Planes de futuro
- Carencia de planes de futuro realistas. - Actitud negativa hacia la intervención.

Adaptación española: Martínez, Hilterman y Andrés Pueyo (2005).

Para riesgos moderados, se recomiendan plazos entre dos semanas y dos meses; y para riesgos altos, entre semanalmente y cada mes (Boer et al., 1997).

Tanto el SVR-20 como el RSVP (que veremos a continuación) parten de un concepto amplio de violencia sexual, en naturaleza, gravedad, inminencia, frecuencia y probabilidad. Ambos van más allá de los términos probabilísticos de las herramientas actuariales, y buscan ayudar a pensar en qué tipo de violencia cometerá el evaluado,

contra qué tipo de víctimas, bajo qué circunstancias y con qué consecuencias (Hart y Boer, 2010).

Su objetivo es evaluar el riesgo de violencia sexual en personas condenadas por delitos sexuales o con sospecha de ello. Aunque no se señala explícitamente en la guía, existen algunas precauciones sobre su uso (Hart y Boer, 2010):

- *Adecuada*: para varones mayores de 18 años, con delito sexual conocido o sospechado.
- *Cautela*: con menores entre 16 y 17 años o mujeres (la investigación es limitada).
- *No recomendada*: para niños ni adolescentes jóvenes menores de 16.

Además, debemos recordar las siguientes limitaciones, válidas para todas las herramientas de juicio estructurado, pero específicas del SVR-20 y del RSVP (Boer et al., 1997; Hart y Boer, 2010):

- **NO** valen para determinar si alguien ha cometido un delito sexual.
- **NO** valen para determinar si alguien se ajusta al perfil de agresor sexual.
- **NO** son aplicables para valorar el riesgo de violencia no sexual.
- **NO** calculan una probabilidad absoluta de reincidencia.
- **NO** informan sobre el riesgo de la víctima, sino sobre el riesgo de reincidencia del agresor.

El SVR-20 ha sido utilizado en numerosos estudios. Rettenberger, Boer y Eher (2011) analizaron la capacidad predictiva de la puntuación total, los 20 factores de riesgo y las tres escalas en 493 agresores sexuales puestos en libertad del sistema penitenciario austríaco. La puntuación total del SVR-20 alcanzó un AUC = 0,72 para la reincidencia sexual en el total de la muestra, un AUC = 0,71 para el grupo de violadores ($n = 221$) y un AUC = 0,77 para el grupo de pederastas ($n = 249$). Respecto a las puntuaciones totales, encontraron una *odds ratio* de 1,1, lo que significa que, por cada punto de más en el SVR-20, se

incrementa un 11% la probabilidad de reincidencia. La escala de ajuste psicológico resultó ser de mayor importancia para la predicción que la historia de violencia o los planes de futuro. También se confirmó la mejor predicción de la violencia sexual frente a la delincuencia general. En algunos casos se ha encontrado que varios ítems del SVR-20 no están relacionados con la reincidencia sexual, como la negación del delito (Dempster y Hart, 2002; Rettenberger et al., 2011).

Respecto a la comparación entre herramientas, Singh et al. (2011) calcularon un AUC medio de 0,78, estando en el número uno de las herramientas analizadas la SORAG y la Static-99. Tully et al. (2013) revisaron nueve herramientas específicas para la violencia sexual y calcularon un AUC medio de 0,70 (rango 0,59-0,83). Usando el criterio de Rice y Harris (2005) para un AUC grande ($\geq 0,71$), dos de los cinco estudios incluidos en la revisión obtuvieron este resultado. Hanson y Morton-Bourgon (2009) obtuvieron un AUC medio de 0,68 para la violencia sexual y 0,61 para cualquier tipo de reincidencia violenta analizando diez trabajos con un total de 1.699 casos. Además, comprobaron que la suma de ítems y el nivel de riesgo asignado por el profesional obtenían una capacidad predictiva comparable. También se ha confirmado su validez concurrente con herramientas como la Static-99 y la SORAG (Hart y Boer, 2010). Según la revisión de Smid et al. (2014), la capacidad predictiva de la reincidencia sexual del SVR-20 sería baja.

En España, se ha utilizado para predecir la reincidencia en un grupo de 163 agresores sexuales tras su paso por prisión, consiguiendo una predicción de la reincidencia del 70% (sensibilidad) y de la no reincidencia del 79% (especificidad), con un AUC = 0,83 (Pérez, Redondo, Martínez, García-Forero y Andrés-Pueyo, 2008). También se ha publicado un estudio de caso, con un interesante análisis cualitativo del riesgo (Defez y Cuquerella, 2014). Nguyen y Andrés-Pueyo (2016) han desarrollado recientemente un estudio de predicción de la reincidencia penitenciaria en 126 agresores sexuales, a los que se hizo el seguimiento durante 2,5 años de media (con un 2,4%

de reincidencia sexual). El SVR-20 tuvo una buena capacidad predictiva de la reincidencia general, pero no de la sexual, y el Static-99 sin embargo sí predijo bien ambos tipos de reincidencia.

2. RSVF

El *Risk for Sexual Violence Protocol*—RSVP—(Hart et al., 2003) puede ser considerado una evolución en las guías de juicio estructurado, pues introdujo muchos de los conceptos y aspectos que se abordaban en la metodología de manera informal. En este protocolo comenzó a plasmarse la dirección principal que guía la metodología en la actualidad, que no es otra que la evaluación orientada en la gestión del riesgo. Asimismo, introdujo el desarrollo de escenarios dentro de la valoración. Esta nueva línea de actuación se plasma de forma muy clara en la descripción de los seis pasos en la evaluación, frente a los tres que se indicaban en el SVR-20. Estos serían los siguientes:

1. Recopilar información, guiado por el manual.
2. Codificar la presencia de ítems, junto al marco temporal: presente y pasado (más de un año).
3. Valorar la relevancia de cada ítem para el futuro: no relevante, posible o relevante.
4. Describir escenarios posibles futuros teniendo en cuenta la información del paso 1, la presencia de los factores del paso 2 y la relevancia para el futuro del paso 3.
5. Proponer estrategias de gestión del riesgo.
6. Documentar el riesgo final del caso.

El protocolo está compuesto por 22 ítems (véase tabla 10.2), organizados en cinco secciones: historial de violencia sexual (5 ítems), ajuste psicológico (5 ítems), trastorno mental (5 ítems), ajuste social (4 ítems) y gestión del riesgo (3 ítems). En el ítem 12 se incluye la valoración de la psicopatía a través de la PCL-R o equivalente. El RSVP incluye varios ítems que no están

TABLA 10.2

Factores de riesgo del RSVP (Hart et al., 2003)

Historial de violencia sexual
1. Cronicidad de la violencia sexual. 2. Variedad de la violencia sexual. 3. Escalada en la violencia sexual. 4. Coerción física en la violencia sexual. 5. Coerción psicológica en la violencia sexual.
Ajuste psicológico
6. Minimización extrema o negación de la violencia sexual. 7. Actitudes que apoyan o justifican la violencia sexual. 8. Problemas de autoconciencia. 9. Problemas con el estrés o su afrontamiento. 10. Problemas derivados de abusos en la infancia.
Trastorno mental
11. Desviación sexual. 12. Trastorno de la personalidad psicopático. 13. Trastorno mental grave. 14. Problemas derivados del consumo de drogas. 15. Ideación violenta o suicida.
Adaptación social
16. Problemas en relaciones de pareja. 17. Problemas en relaciones distintas a las de pareja. 18. Problemas laborales. 19. Delincuencia no sexual.
Gestión
20. Problemas de planificación. 21. Problemas con el tratamiento. 22. Problemas con la supervisión.

Adaptación española: Loinaz et al. (2016).

presentes en el SVR-20, lo que lo hace más complejo de aplicar, pero a la vez ofrece una información más detallada del sujeto. Estos factores son: la cronicidad de la violencia (aunque podría equivaler a «frecuencia elevada» del SVR-20), la coerción psicológica, los problemas de autoconciencia, los problemas de estrés o afrontamiento y los

problemas en relaciones que no sean de pareja. En función de nuestro objetivo y disponibilidad temporal, el RSVP nos ofrecerá más información orientada a la gestión que el SVR-20 (Logan, 2016).

Al igual que el SVR-20, la población a la que está dirigido son varones, mayores de 18 años, con historial de violencia sexual conocido o sospechado. También puede ser utilizado en adolescentes entre 16 y 17 años y con mujeres, aunque en ambos casos con cautela. Su uso está menos extendido que el del SVR-20. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado protagonismo debido a su mejor adecuación al modelo de juicio estructurado y por estar más orientado a la gestión.

Sutherland et al. (2012) hicieron un estudio experimental para valorar específicamente la fiabilidad interjueces en seis casos preparados para tal efecto. Descubrieron que la coincidencia en codificaciones y opiniones era menor en los evaluadores menos formados; también se daba menor coincidencia en los casos más complicados, pero en conjunto la fiabilidad interjueces era adecuada. Además, se dio un buen acuerdo en el nivel de riesgo global, así como en la recomendación de gestión. Está disponible un manual de casos en el que, además, se comparan resultados posibles aplicando otras herramientas (Yates y Kingston, 2007; Hart y Logan, 2011) hicieron una formulación de caso con el RSVP en la que se compara la evaluación con la que se haría con el Static-99.

La adaptación española se publicó en 2016 (Loinaz, Nguyen, Navarro y Andrés-Pueyo, 2016), pero aún se carece de estudios que hayan aplicado la herramienta.

3. RRASOR

La *Rapid Risk Assessment for Sex Offense Recidivism* —RRASOR— (Hanson, 1997) fue una de las primeras herramientas actuariales para la predicción de la reincidencia sexual, derivada del metaanálisis de factores de riesgo relacionados con la reincidencia. Está compuesta por cuatro

ítems: 1) detención previa por delito sexual; 2) edad en la comisión del delito; 3) selección de víctimas masculinas; y 4) cualquier víctima sin relación con el agresor. En estudios de validación ha obtenido AUC entre 0,55 y 0,77 (Mills et al., 2011). Como veremos a continuación, la herramienta sirvió de base para el desarrollo del Static-99.

4. STATIC-99

El Static-99 (Hanson y Thornton, 1999) surgió a partir de dos escalas existentes de los propios autores: la RRASOR (citada en el punto anterior) y la SACJ (*Structured Anchored Clinical Judgment*, Grubin, 1998). Como resultado, el Static-99 obtuvo una predicción mejor que las de las otras herramientas, con un AUC = 0,71 (Hanson y Thornton, 2000).

Se trata de una herramienta actuarial compuesta por 10 ítems estáticos (véase tabla 10.3). La selección de los ítems se fundamenta puramente en su predicción de la reincidencia. Los ítems se suman con valores ponderados y la puntuación total va desde -3 a +12. Con las puntuaciones se puede categorizar al sujeto en los siguientes riesgos (Anderson y Hanson, 2010): bajo (de -3 a +1), moderado-bajo (2-3), moderado-alto (4-5) y alto (6 o más). Estos valores, además, se vinculan a probabilidades de reincidencia a cinco, diez y quince años (por ejemplo, con 2 puntos: 9% a cinco años, 13% a diez años y 16% a quince años), así como a probabilidades de reincidencia según la edad de la puesta en libertad del agresor sexual (por ejemplo, riesgo moderado-alto: 24,6% de reincidencia para libertad entre 18 y 24,9 años; 24,3% entre 25 y 39,9 años; 13,8% entre 40 y 49,9 años; 19,4% entre 50 y 59,9 años; y 4,8% para 60 o más años) (Mills et al., 2011).

Está diseñado para estimar el riesgo potencial a largo plazo y, puesto que no incluye ítems dinámicos, no debería utilizarse para orientar un tratamiento ni como medida de cambio. Pese a ello, es la herramienta más utilizada en el contexto anglosajón (Hanson y Morton-Bourgon, 2009).

TABLA 10.3

*Factores de riesgo que componen el Static-99
(Hanson y Thornton, 1999)*

Información sociodemográfica	
1.	Edad en el momento de la excarcelación.
2.	Convivencia con una pareja al menos durante dos años.
Historial delictivo oficial	
3.	Condenas de tipo no sexual en el delito base.
4.	Condenas previas no sexuales.
5.	Delitos sexuales previos.
6.	Condenas previas.
7.	Condenas por delitos sexuales sin contacto.
Víctimas	
8.	Víctimas extrafamiliares.
9.	Víctimas desconocidas.
10.	Víctimas del sexo masculino.

Traducción al español: Nguyen y Andrés-Pueyo (2016).

La revisión del Static-99 dio lugar al Static-2002 (Hanson y Thornton, 2003), que está compuesto por 14 ítems agrupados en cinco subescalas.

Puesto que la herramienta está compuesta por factores estáticos, Hanson, Harris, Helmus y Thornton (2014) analizaron la medida en la que los delincuentes sexuales categorizados como de riesgo alto mantenían dicho nivel. Con un seguimiento de 20 años y una muestra agregada de 7.749 agresores sexuales provenientes de 21 estudios, hicieron un análisis de supervivencia para estimar la reincidencia anual. La conclusión fue que la reincidencia era mayor en los primeros años en libertad y se reducía conforme más tiempo pasaban en libertad, lo cual tiene implicaciones para la prevención y gestión del riesgo, en especial en los primeros años tras la excarcelación. Esta relación era especialmente cierta para los sujetos categorizados como de riesgo alto, quienes reducían la reincidencia anual de un 7% los primeros años a un 1% transcurridos diez años en libertad. Los sujetos de riesgo bajo, sin

embargo, mantenían la cifra de reincidencia estable. Desde el punto de vista actuarial, el riesgo se reducía a la mitad cada cinco años en libertad.

La capacidad predictiva del Static-99 para la reincidencia sexual es moderada, con AUC entre 0,54 y 0,76 (Mills et al., 2011). Hanson y Morton-Bourgon (2009) analizaron resultados de la herramienta en 63 muestras diferentes (con un total de 20.010 casos), concluyendo que era de las mejores para predecir la reincidencia sexual. Sin embargo, en la revisión de Singh et al. (2011) el Static-99 quedaba antepenúltimo entre nueve herramientas, con un AUC = 0,70 de media, siendo la última de las tres específicas para la violencia sexual. Además, pese a que algunos resultados señalan buenos valores AUC (en especial los propios de los autores, con valores que superan el 0,90), también se ha encontrado que el Static-99 sobreestima la probabilidad de reincidencia (Berlin et al., 2003; Craig, Browne y Stringer, 2004). También se ha señalado que el Static puede ser utilizado en casos raros, incorporando a la opinión final otros factores que, como veremos a continuación, pueden ser dinámicos y presentes en otras herramientas (Anderson y Hanson, 2010).

En la actualidad están disponibles las versiones revisadas del Static-99R y del Static-2002R, en las que se ha modificado el valor ponderado de la edad (Helmus, Hanson, Thornton, Babchishin y Harris, 2012; Helmus, Thornton, Hanson y Babchishin, 2011). El material de ambas herramientas puede descargarse gratuitamente en www.static99.org.

En España, Nguyen y Andrés-Pueyo (2016) obtuvieron buenos resultados para la predicción de la reincidencia sexual. Al margen de este estudio no se han encontrado más referencias en español, por lo que la utilidad de la herramienta se deberá poner a prueba.

Stable y Acute

Con el objetivo de mejorar la evaluación de los agresores sexuales, el equipo de autores del *Static* creó un listado de factores de riesgo estables y agu-

dos. Los factores estables eran aquellos factores dinámicos que correspondían a áreas de la vida del delincuente afectadas de forma crónica antes de la comisión del delito (por ejemplo, durante más de seis meses). En este bloque se incluyen patrones de pensamiento, sentimientos, etc. Los factores agudos son también dinámicos, pero aparecen de forma inmediatamente previa a la agresión (por ejemplo, un mes antes o menos). Son áreas de cambio muy rápido, como las pertenecientes al ambiente del sujeto. La lista de factores estables y agudos dio lugar al *Sex Offender Needs Assessment Rating*—SONAR— (Hanson y Harris, 2001), que derivaría en dos nuevas herramientas: *Stable-2000* y *Acute-2000* (Anderson y Hanson, 2010).

Stable-2000/2007 es una herramienta actuarial compuesta por 16 ítems. Siguiendo el mismo funcionamiento que el Static, los sujetos pueden ser categorizados según su puntuación en tres niveles de riesgo: bajo (0-3), moderado (4-11) y alto (12 o más). El Acute-2000/2007 incluye siete factores de riesgo: acceso a víctimas, crisis emocional, crisis en apoyos sociales, hostilidad, abuso de sustancias, preocupación sexual y rechazo a la supervisión. Se codifican como 0 (sin problema), 1 (posible problema), 2 (sí) y 3 (intervenir ahora). Esta última categoría implica la detección del profesional de un riesgo que requiere una intervención inmediata (Phenix y Epperson, 2016).

En el proceso de validación de ambas herramientas se aplicó el Static-99 una vez, el Stable-2000 cada seis meses y el Acute-2000 en cada reunión de supervisión del caso en una muestra de 1.000 delincuentes sexuales, a los que se hizo el seguimiento durante 43 meses de media. Ambas herramientas fueron revisadas modificando baremos y criterios, dando lugar al Stable-2007 y al Acute-2007. Distintos estudios de los autores demostraron que las predicciones eran mejor que con la sola aplicación del Stable-99, pasando, por ejemplo, de una predicción con un AUC = 0,77 solo con el Static-99 a un AUC = 0,81 añadiendo el Stable-2007. Las tres herramientas han mostrado capacidad predictiva de los delitos sexuales: Static-99 AUC = 0,74; Stable-2007 AUC = 0,67; Acute-2007 AUC = 0,74 (Mills et al., 2011).

5. SORAG

La *Sex Offender Risk Appraisal Guide* —SORAG— forma parte de una misma familia de herramientas actuariales, encabezada por la VRAG para la violencia inespecífica y la ODARA y la DVRAG para violencia de pareja, todas ellas del mismo equipo de autores (Harris et al., 2015; Hilton, Harris y Rice, 2010; Quinsey et al., 1998, 2005).

La SORAG es una herramienta actuarial de 14 ítems (véase tabla 10.4) para la predicción de la reincidencia en hombres que han agredido sexualmente con contacto físico. La herramienta surgió tras comprobar con el uso de la VRAG que la reincidencia en delincuentes sexuales era mayor a la estimada, por lo que podían existir factores de riesgo específicos para estas muestras. Por ello, se eliminaron dos ítems que no incrementaban la validez predictiva (víctima femenina en el delito base y lesiones a la víctima en el delito base) y se añadieron cuatro que sí lo hacían: historial de delitos violentos (presente en la VRAG-R), condenas por delitos sexuales previos, historia de delitos sexuales contra niñas menores de 14 años y preferencia sexual desviada en un test falométrico (Rice, Harris y Hilton, 2010). Se calcularon las puntuaciones y propiedades en una muestra de 288 agresores sexuales, creando nueve categorías de riesgo vinculadas a probabilidades de reincidencia, calculadas con una tasa de reincidencia del 42% en siete años en la muestra de creación.

Mills et al. (2011), tomando como referencia siete estudios, presentan AUC entre 0,58 y 0,77 para la violencia sexual y entre 0,69 y 0,77 para los delitos violentos. Singh et al. (2011) calcularon un AUC medio de 0,75, siendo la segunda en el ranking de nueve herramientas revisadas. El análisis de sus propiedades indica una buena fiabilidad interjueces (entre 0,90 y 0,96) y una mayor validez convergente con herramientas destinadas a predecir la violencia en general que la sexual (Vincent, Maney y Hart, 2009).

No se ha encontrado ninguna adaptación o aplicación de la herramienta en contexto hispanohablante.

TABLA 10.4

Factores de riesgo de la SORAG
(Quinsey et al., 1998)

1. Vivir con los dos padres biológicos a los 16 años.
2. Desajuste en la escuela primaria.
3. Historia de problemas con el alcohol.
4. Situación matrimonial (no haber estado casado nunca).
5. Puntuación en historial delictivo para delitos no violentos antes del delito actual (índice Cormier-Lang).
6. Puntuación en historial delictivo para delitos violentos antes del delito actual (índice Cormier-Lang).
7. Condenas por delitos sexuales previos.
8. Historia de delitos sexuales contra niñas menores de 14 años.
9. Fracaso en libertad condicional.
10. Edad en el delito actual.
11. Cumple criterios DSM-III para cualquier trastorno de la personalidad.
12. Cumple criterios DSM-III para el diagnóstico de esquizofrenia.
13. Preferencia sexual desviada en un test falométrico.
14. Puntuación en la PCL-R.

6. RM2000

La *Risk Matrix 2000* (Thornton et al., 2003) es una herramienta actuarial breve, destinada a la evaluación tanto de la reincidencia sexual como violenta en delincuentes sexuales. Existen tres escalas: la *S*, para la violencia sexual; la *V*, para la reincidencia violenta; y la *C*, que es la combinación de ambas. En su creación se presentó como una herramienta más sencilla de aplicar que el Static-99 y la SORAG, pero con una capacidad predictiva comparable, con valores AUC entre 0,74 y 0,81.

La escala de violencia sexual se aplica en dos pasos (véase tabla 10.5). En primer lugar se valoran los ítems edad, delitos sexuales y otros delitos, dando un resultado entre 0 y 6 que se categoriza en cuatro niveles de riesgo: bajo (0), medio (1-2), alto (3-4) y muy alto (5-6). En una segunda

TABLA 10.5
Factores en el RM2000

Factor de riesgo		Codificación	
Edad		18-24 = 2 25-34 = 1 >34 = 0	
Delitos sexuales		1 = 0 2 = 1 3-4 = 2 ≥5 = 3	
Otros delitos		4 o menos = 0 5 o más = 1	
Niveles de riesgo			
0 = bajo	1-2 = medio	3-4 = alto	5-6 = muy alto
Agravantes			
— Víctima de la violencia sexual varón. — Víctima de la violencia sexual desconocida. — Soltero (nunca casado). — Delito sexual sin contacto.			

fase se valoran cuatro circunstancias agravantes: víctima de la violencia sexual varón, víctima de la violencia sexual desconocida, soltero (nunca casado) y delito sexual sin contacto. Si hay un agravante el riesgo se mantiene; si hay dos o tres se sube una categoría el nivel de riesgo; si hay cuatro agravantes se sube dos categorías el nivel de riesgo.

Craig, Beech y Browne (2006) hicieron una validación de la RM2000 y la compararon con el SVR-20 y el Static-99. De las tres herramientas, la que mejor predijo la violencia sexual fue la RM2000 (0,60 en dos años, 0,68 en 5 años y 0,59 en 10 años). El Static-99 y el SVR-20 predijeron mejor la reincidencia violenta que la sexual (el Static: 0,57, 0,59 y 0,52; y el SVR-20: 0,46, 0,48 y 0,51 para los mismos plazos temporales). Craig

et al. (2004) encontraron que puntuaban más en la RM2000 delincuentes con víctimas adultas comparados con los que tenían víctimas menores.

Pese a su obvia simplicidad y posibilidad de producir muchos errores en las estimaciones, estando compuesta además por variables estáticas que no van a permitir ninguna intervención, la herramienta ha sido utilizada en distintos estudios y ofrece un AUC medio de 0,67, con valores entre 0,58-0,76 (Mills et al., 2011; Tully et al., 2013), lo cual no lo diferencia de otras herramientas. Debido a esta característica estable y limitada, algunos autores señalan la necesidad de valorar factores dinámicos en caso de detectar un sujeto de riesgo alto en la RM2000 (Craig y Beech, 2009).

La violencia juvenil ha cobrado una gran atención en los últimos años. Pese a que en los orígenes de la predicción en criminología los estudios trataban de predecir qué jóvenes podían convertirse en adultos delincuentes (por ejemplo, Glueck y Glueck, 1950; Weeks, 1943), en la época moderna la evaluación del riesgo de violencia en menores había sido un tema secundario. Mientras que el desarrollo de herramientas para adultos experimentaba un crecimiento exponencial, tanto en número de instrumentos disponibles como en temáticas concretas, para el caso de los menores la proporción de estudios era inferior al 20 % (Viljoen, Cruise, Nicholls, Desmarais y Webster, 2012), y menos del 10 % de las herramientas estaban diseñadas para estas muestras. Otra limitación del ámbito ha sido el predominio de muestras masculinas y el estudio de la delincuencia general (Conroy, 2012), con un gran vacío de material y opciones limitadas para tipos concretos de violencia.

El interés por la evaluación del riesgo en muestras juveniles se ha incrementado, y en la actualidad se dispone de manuales específicos para estas muestras (por ejemplo, Borum y Verhaagen, 2006; Hoge y Andrews, 2009), listados de herramientas de interés para el contexto forense (por ejemplo, Wenger y Andrés-Pueyo, 2016a) y algunas revisiones de las propiedades psicométricas de las principales herramientas para la evaluación del riesgo (por ejemplo, Viljoen, Elkovitch y Ullman, 2008; Viljoen, Gray y Barone, 2016),

ofreciendo directrices de gran utilidad para profesionales que deben decidir cuál de ellas utilizar.

En este capítulo presentaremos las herramientas más conocidas para menores, para delincuencia o violencia general (SAVRY, EARL-20B, EARL-21G, START:AV y YLS/CMI), para violencia sexual (ERASOR, J-SOAP-II, J-SORRAT-II) y para los factores de protección (SAPROF-YV).

1. SAVRY

El *Structured Assessment of Violence Risk in Youth*—SAVRY— (Borum et al., 2006) es uno de los instrumentos para la evaluación del riesgo de violencia juvenil más populares. Es el equivalente a la HCR-20 para uso en menores. Está compuesto por 24 factores de riesgo (diez históricos, seis sociales/contextuales y ocho individuales/clínicos) y seis de protección (véase tabla 11.1). Los factores de riesgo se codifican como *bajo*, *moderado* o *alto*, siendo equivalentes a ausente, parcialmente presente o que no sea grave, y presente o que cause deterioro, respectivamente. Los factores de protección se codifican como presentes o ausentes. Al tratarse de una guía de juicio estructurado, el propósito es alcanzar una conclusión cualitativa, pese a que en la investigación sea habitual el uso de puntuaciones totales.

Distintos trabajos han comparado las predicciones del SAVRY con las del YLS/CMI (por ejemplo, Chu, Goh y Chong, 2016; Hilterman et al., 2014;

TABLA 11.1
Factores de riesgo y de protección del SAVRY

Factores de riesgo históricos	Factores de riesgo individuales
1. Violencia previa. 2. Historia de actos delictivos no violentos. 3. Inicio temprano de la violencia. 4. Seguimiento en el pasado/fracaso de intervenciones anteriores. 5. Intentos de autolesión o de suicidio anteriores. 6. Exposición a violencia en el hogar. 7. Historia de maltrato infantil. 8. Delincuencia de los padres o cuidadores. 9. Separación temprana de los padres o cuidadores. 10. Bajo rendimiento en la escuela.	16. Actitudes negativas. 17. Asunción de riesgos/Impulsividad. 18. Problemas de consumo de sustancias. 19. Problemas con el manejo del enfado. 20. Bajo nivel de empatía/remordimiento. 21. Problemas de concentración/hiperactividad. 22. Baja colaboración en las intervenciones. 23. Bajo interés/Compromiso escolar.
Factores de riesgo sociales/contextuales	Factores de protección
11. Delincuencia en el grupo de iguales. 12. Rechazo del grupo de iguales. 13. Estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades. 14. Escasa habilidad de los padres para educar. 15. Falta de apoyo personal/social de otros adultos. 16. Entorno marginal.	1. Implicación prosocial. 2. Apoyo social fuerte. 3. Fuertes vínculos y lazos con al menos un adulto prosocial. 4. Actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad. 5. Fuerte compromiso con la escuela. 6. Perseverancia como rasgo de personalidad.

Adaptación española: Vallés y Hilterman (2.ª edición, 2011).

Schmidt, Campbell y Houlding, 2011; Urquhart y Viljoen, 2014). Asimismo, Olver et al. (2009) hicieron un metaanálisis sobre las propiedades de estas mismas tres herramientas encontrando rangos de AUC entre 0,64 y 0,78 y correlaciones (valores de r) entre 0,23 y 0,48, considerándose una capacidad predictiva moderada. Por su parte, Singh et al. (2011), en una revisión sistemática, señalaron que el SAVRY ofrecía un AUC media de 0,71 y que en su ranking con predicciones positivas y predicciones negativas ofrecía los mejores resultados.

Son numerosos los estudios a nivel internacional que señalan la utilidad de la herramienta, con un funcionamiento similar en chicas y chicos (Penney, Lee y Moretti, 2010), y buena capacidad predictiva de la violencia dentro de instituciones en menores con problemas graves (Gammelgård, Koivisto, Eronen y Kaltiala-Hei-

no, 2008) o con el aporte de los factores de protección en la predicción de la reincidencia general (Lodewijks, Doreleijers, de Ruiter y Borum, 2008). Respecto a la utilidad de los formatos de corrección, los resultados son contradictorios. Existen trabajos a favor del uso de las categorías nominales (Gammelgård et al., 2008), y otros que señalan una mayor capacidad predictiva de las puntuaciones totales (Hilterman et al., 2014).

En el contexto español, la herramienta ha mostrado una buena capacidad predictiva (AUC = 0,75 para la reincidencia violenta y AUC = 0,71 para la reincidencia general), aunque similar a la del YLS/CMI (Hilterman et al., 2014). Las puntuaciones ofrecieron mejores resultados que el juicio profesional (categorías asignadas por los profesionales; resumen del

riesgo). En cualquier caso, las predicciones fueron mejores con el uso de herramientas que con el uso del ojo clínico (que alcanzó valores entre 0,61-0,63 para la reincidencia violenta y de 0,58-0,61 para la general). Los factores protectores no mostraron ningún aporte en la predicción. Sin embargo, hay que señalar que se trató del autoinforme de la violencia por parte de los propios menores en una entrevista de seguimiento un año después de la evaluación.

2. YLS/CMI

El *Youth Level of Service/Case Management Inventory* —YLS/CMI— (Hoge et al., 2002), y su revisión YLS/CMI 2.0 (Hoge y Andrews, 2011), es un inventario derivado del *Level of Service Inventory-Revised* —LSI-R— para su aplicación en menores de edad (desde los 12 hasta los 18 años). Se trata de una herramienta actuarial destinada a la gestión del riesgo. Está compuesta por 42 ítems, organizados en ocho bloques: 1) delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; 2) pautas educativas; 3) educación formal/empleo; 4) relación con el grupo de iguales; 5) consumo de sustancias; 6) ocio/diversión; 7) personalidad/conducta; y 8) actitudes, valores y creencias. Hay factores estáticos y dinámicos, siendo estos últimos el objetivo de la intervención propuesta. Los ítems se codifican como presentes (1) o ausentes (0), y los niveles de riesgo se clasifican conforme a puntos de corte: bajo (0-8), moderado (9-22), alto (23-34) o muy alto (35-42).

Su procedimiento de aplicación es algo más complejo que el de otras guías y puede resumirse en seis pasos: 1) evaluación de factores de riesgo y de protección; 2) resumen del riesgo (sumatorios); 3) consideración de otras necesidades (hasta 53 más); 4) consideración del riesgo por parte del profesional (en formato *enfoque actuarial ajustado*, que permite al profesional modificar el riesgo clasificado numéricamente en el paso 2 [véase capítulo 7, apartado 6]); 5) indicación del nivel de intervención requerido; y 6) propuesta del plan de gestión del riesgo.

La versión 2.0. tiene la misma estructura y contenido, aunque ha cambiado algunas normas de interpretación (p. ej., para chicas y chicos) (Viljoen, Gray et al., 2016). La investigación sobre las propiedades de la herramienta hace alusión mayoritariamente a la versión inicial. Los metaanálisis sobre herramientas para la evaluación del riesgo en menores infractores han descrito rangos de capacidad predictiva (AUC) entre 0,57 y 0,75 (Schwalbe, 2007) y 0,50 y 0,79 (Olver et al., 2009). Pese a estos rangos tan amplios (con valores bajos similares al azar), se afirma que tiene una capacidad predictiva consistente, tanto para la predicción de la reincidencia violenta como para la no violenta. Aunque la versión inicial no diferenciaba baremos para chicos y chicas, la utilidad de la herramienta era comparable entre sexos (Olver et al., 2009; Schwalbe, 2008). Recientemente, Olver et al. (2014) han revisado 30 años de aplicación de la gama de herramientas *Level of Service Inventory*, concluyendo que, junto al LSI-R, el YLS/CMI cuenta con el mayor número de estudios y que los mayores tamaños del efecto en la predicción (correlaciones biseriales) se dan en Canadá y, en conjunto, mejor para la reincidencia general ($r = 0,28$) que para la violenta ($r = 0,23$).

La herramienta ha sido aplicada y adaptada en distintos contextos hispanohablantes (véase Wenger y Andrés-Pueyo, 2016a). En España ha mostrado resultados similares al SAVRY, con un AUC = 0,73 para la reincidencia violenta y 0,71 para la reincidencia general (Hilterman et al., 2014). También se han descrito mayores puntuaciones en reincidentes en general, pero no en violentos (Graña, Garrido y González, 2007) y un AUC de 0,71 para la reincidencia general, con mejor detección de los reincidentes (80 % de aciertos) que de los no reincidentes (60 % de aciertos) (Graña, Garrido y González, 2008). En algunos casos se le ha denominado IGI-J (Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes). En Chile se ha aplicado en el análisis de trayectorias delictivas (Pérez-Luco, Lagos y Báez, 2012) y se ha denominado Inventario de Riesgos y Necesidades Criminogénicas (IRNC).

3. START:AV

La *Short-Term Assessment of Risk and Treatability* —START— ha sido uno de los aportes recientes en el ámbito de la evaluación del riesgo, superando la distinción entre factores de riesgo y de protección, al considerar los mismos ítems en ambas direcciones (el mismo factor puede ser de riesgo, de protección o incluso tener ambas consideraciones según a qué nos refiramos) (véase Webster, Nicholls, Martin, Desmarais y Brink, 2006). Como hemos señalado en la descripción del instrumento para adultos, es una herramienta de juicio profesional estructurado centrada en el tratamiento.

La versión para adolescentes, START:AV (Nicholls et al., 2010; Viljoen, Nicholls, Cruise, Desmarais y Webster, 2014), está compuesta por 24 factores dinámicos (véase tabla 11.2), organizados en tres dimensiones (1-12 personales, 13-20 relaciones/ambiente y 21-24 respuesta a la intervención) y valorados como vulnerabilidades (riesgo) o fortalezas (protección). Los factores son codificados para los últimos tres meses, en una escala de tres niveles: bajo, moderado o alto. Un mismo ítem puede ser de riesgo y de protección (por ejemplo, algunas relaciones con pares antisociales —riesgo— y otras con pares proso-

ciales —protección—). En Viljoen, Nicholls et al. (2016) los autores ofrecen una revisión minuciosa de la justificación de los ítems incluidos en la START:AV.

La herramienta está diseñada para valorar el riesgo en jóvenes de ambos sexos, entre 13 y 18 años. En comparación con las demás herramientas para menores, es la única que incluye ocho objetivos distintos de evaluación: violencia, delincuencia no violenta, abuso de sustancias, huida (por ejemplo, de un centro), suicidio, autolesión no suicida, victimización y autonegligencia (abandono respecto a la salud especialmente). El profesional codifica tanto la historia de estos problemas (pasado o reciente) como el nivel de riesgo futuro para cada uno de ellos (bajo, moderado o alto). Es una herramienta especialmente útil para detectar el riesgo a corto plazo y se recomienda la reevaluación del caso cada tres meses aproximadamente.

Pese a tratarse de una propuesta reciente (la versión piloto comenzó a aplicarse en 2010), la evidencia empírica en su apoyo es considerable y el modelo se ajusta a la lógica del juicio profesional estructurado orientado a la gestión del caso y dando relevancia a la consideración de los factores de riesgo y las fortalezas del sujeto. En su aplicación piloto, en 250 chicos y 41 chicas, se encontró que el hecho de disponer de 23 factores

TABLA 11.2
Factores de la START:AV (Viljoen et al., 2014)

Personales	Relaciones y ambiente	Respuesta a la intervención
1. Escuela/trabajo.	13a. Relación con cuidadores y otros adultos.	21. <i>Insight</i> .
2. Ocio.	13b. Relación con pares.	22. Planes.
3. Consumo de drogas.	14a. Soporte social de cuidadores y otros adultos.	23. Adherencia a la medicación.
4. Adherencia a normas.	14b. Soporte social de pares.	24. Tratabilidad.
5. Conducta.	15. Estilo parental.	
6. Autocuidado.	16. Funcionamiento parental.	
7. Afrontamiento (<i>coping</i>).	17. Pares.	
8. Control de los impulsos.	18. Recursos materiales.	
9. Estado mental/cognitivo.	19. Comunidad.	
10. Estado emocional.	20. Desencadenantes externos.	
11. Actitudes.		
12. Habilidades sociales.		

que puedan ser de riesgo y de protección incrementa la detección de fortalezas, en comparación con muestras similares de menores internos evaluadas con el SAVRY, que solo incluye seis factores de protección (Desmarais, Sellers et al., 2012). También se detectaron mayores niveles de riesgo para la violencia, el consumo de drogas y la delincuencia general, posiblemente como reflejo de una mayor preocupación por parte de los profesionales de justicia juvenil respecto a la amenaza a terceros o la seguridad pública. El estudio también mostró la utilidad y aplicabilidad de la herramienta en ambos sexos, aunque no se analizó su capacidad predictiva.

En esta búsqueda de evaluación basada en la evidencia, la herramienta ha sido sometida a propuestas de corrección y mejora por parte de profesionales de Reino Unido, quienes ensalzaron beneficios como la dinamicidad de sus ítems y la consideración tanto de aspectos de riesgo como de protección al mismo tiempo. Entre las pegas, señalaron la dificultad de diferenciar de forma clara la codificación de los ítems (0-1-2), la doble puntuación en casos confusos de riesgo o protección, la duración de la aplicación (45 minutos) y la formulación del riesgo para la que se solicitaba más formación (Sher y Gralton, 2014). Por otro lado, Singh, Desmarais, Sellers et al. (2014) analizaron la medida en la que la aplicación de la START:AV se vinculaba con la gestión. Siguiendo el modelo RNR (véase capítulo 4, apartado 2.3), la conclusión fue que la adherencia era parcial: las intervenciones estaban más ajustadas a los factores protectores y no tanto a los de riesgo. Los autores concluían señalando la relevancia de considerar los factores de protección en el desarrollo de los tratamientos y los planes de gestión, ajustando mejor los programas para superar la aplicación de intervenciones de talla única.

Viljoen, Beneteau et al. (2012) analizaron las propiedades psicométricas de la herramienta e hicieron un seguimiento de tres meses. La consistencia interna (α) fue de 0,89 y la fiabilidad interjueces de 0,86 para vulnerabilidades y 0,92 para los factores de riesgo. Encontraron una capacidad predictiva moderada, con un AUC para la pun-

tuación del riesgo de 0,70 para la violencia y para los delitos no violentos. La puntuación en factores de protección estaba relacionada de forma negativa y también tenía una capacidad predictiva media con un AUC de 0,73 para violencia y de 0,68 para delitos no violentos. Además, analizaron la validez convergente con el SAVRY, con correlaciones de 0,83 entre puntuaciones totales de riesgo y de 0,80 para los factores de protección.

4. EARL-20B Y EARL-21G

Las *Early Assessment Risk Lists* son otra de las contribuciones canadienses al juicio profesional estructurado. Tienen en cuenta la perspectiva de género, pues existe la EARL-20B para chicos (*Early Assessment Risk List for Boys*; Augimeri et al., 1998; Augimeri, Koegl, Webster y Levene, 2001) y la EARL-21G para chicas (*Early Assessment Risk List for Girls*; Levene et al., 2001). Ambas herramientas se diseñaron para su uso en menores entre seis y 12 años. Surgieron para la identificación y gestión clínica del riesgo de violencia para el programa de prevención SNAP® (*Stop Now And Plan*), destinado a problemas de conducta violenta en niñas y niños, implicando a los padres en la educación y control de los menores (Augimeri, Walsh, Woods y Jiang, 2012).

El contenido está organizado en tres dimensiones (véase tabla 11.3): *familia*, referente a los cuidados recibidos por el menor; *menor*, centrada en los factores de riesgo personales del evaluado; y *responsividad*, centrada en la voluntad y capacidad de respuesta al tratamiento tanto del menor como de la familia. Las dos escalas solo se diferencian en tres ítems, dos específicos para las chicas (interacción cuidador/hija y desarrollo sexual) y uno fusionado en ellas (contacto con la autoridad, que se incluye bajo la conducta antisocial).

El formato de codificación de los ítems es: 0 ausente, 1 parcialmente presente y 2 presente. La puntuación de las distintas dimensiones se suma para obtener una puntuación total. También incluye la clasificación del riesgo por el profesional (bajo, medio o alto), con independencia

TABLA 11.3
Factores de riesgo de las EARL-20B y EARL-21G

EARL-20B	EARL-21G
Familia	
1. Circunstancias familiares. 2. Continuidad del cuidador. 3. Apoyos. 4. Estresores. 5. Estilo de crianza. 6. Valores/conductas antisociales.	1. Circunstancias familiares. 2. Continuidad del cuidador. 3. Apoyos. 4. Estresores. 5. Estilo de crianza. 6. Interacción cuidador/hija. 7. Valores/conductas antisociales.
Menor	
7. Problemas del desarrollo. 8. Problemas de conducta de inicio temprano. 9. Abuso, negligencia, trauma. 10. Hiperactividad, impulsividad, déficit de atención. 11. Simpatía. 12. Socialización con pares. 13. Rendimiento escolar. 14. Tipo de barrio. 15. Contacto con la autoridad (por mala conducta). 16. Actitudes antisociales. 17. Conducta antisocial. 18. Estrategias de afrontamiento.	8. Problemas del desarrollo. 9. Problemas de conducta de inicio temprano. 10. Abuso, negligencia, trauma. 11. Hiperactividad, impulsividad, déficit de atención. 12. Simpatía. 13. Socialización con pares. 14. Rendimiento escolar. 15. Tipo de barrio. 16. Desarrollo sexual. 17. Actitudes antisociales. 18. Conducta antisocial. 19. Estrategias de afrontamiento.
Responsividad	
19. Responsividad de la familia. 20. Responsividad del niño.	20. Responsividad de la familia. 21. Responsividad de la niña.

de la puntuación total. Las puntuaciones elevadas en ambas herramientas se han relacionado con la actividad delictiva temprana (Augimeri et al., 2012). Con la validación sueca de la EARL-20B se encontró una buena fiabilidad interjueces (Enebrink, Långström, Hultén y Gumpert, 2006) y un incremento en la validez de predicciones clínicas sobre problemas conductuales y agresiones en seguimientos a 30 meses, con informes de los padres y profesores de los chicos (Enebrink, Långström y Gumpert, 2006).

Aunque hay disponible un trabajo escrito en español en el que se utilizan las herramientas (Enebrink, Högström, Forster y Ghaderi, 2014),

no se ha encontrado ninguna adaptación al español publicada ni aplicaciones en contexto hispanohablante.

5. **SAPROF:YV**

La versión del SAPROF para adolescentes (*Structured Assessment of Protective Factors for violence risk-Youth Version*, de Vries Robbé et al., 2015) es una herramienta creada específicamente para población juvenil y está compuesta por 16 factores dinámicos distintos a los de la versión adulta (véase tabla 11.4). Está organizada en

TABLA 11.4
Factores de protección del SAPROF-YV (de Vries Robbé et al., 2015)

Factores de resiliencia	Factores de motivación
1. Competencia social. 2. <i>Coping</i> . 3. Autocontrol. 4. Perseverancia.	5. Orientación hacia el futuro. 6. Motivación hacia el tratamiento. 7. Actitud respecto a acuerdos y condiciones. 8. Medicación. 9. Escuela/trabajo. 10. Actividades de ocio.
Factores de relación	Factores externos
11. Padres/cuidadores. 12. Pares. 13. Otras relaciones de apoyo.	14. Ambiente pedagógico. 15. Atención profesional. 16. Medidas judiciales.

Adaptación española: Hilterman, Venegas-Cardenas y Poch (2015).

cuatro bloques: resiliencia, motivación, relación y factores externos. Su objetivo es complementar las herramientas para la valoración del riesgo en esta población (tipo SAVRY, aunque esta ya incluya seis factores de protección), para equilibrar la valoración del sujeto considerando riesgos y fortalezas. La codificación de los factores se realiza para los próximos seis meses. La valoración final es una combinación entre el nivel de factores de protección valorado con el SAPROF-YV (bajo, bajo-moderado, moderado, moderado-alto, alto) y el nivel de riesgo valorado con una herramienta específica para el riesgo.

Pese al interés de la propuesta, debido a su novedad, aún no se han podido localizar investigaciones que la hayan utilizado. Está disponible la adaptación española, realizada por Hilterman, Venegas-Cardenas y Poch (véase www.saprof.com).

6. VIOLENCIA SEXUAL JUVENIL

6.1. ERASOR

La *Estimate of Risk of Adolescent Sex Offense Recidivism*—ERASOR— (Worling, 2004) es una guía de juicio estructurado diseñada para valorar

el riesgo de reincidencia en violencia sexual en jóvenes, entre 12 y 18 años, que ya han cometido algún tipo de violencia sexual. Está compuesta por 25 factores de riesgo, 16 dinámicos y nueve estáticos, agrupados en cinco secciones (véase tabla 11.5): 1) intereses, actitudes y conductas sexuales; 2) historia de agresiones sexuales; 3) funcionamiento psicosocial; 4) funcionamiento familiar y del entorno; y 5) tratamiento. Cada ítem se codifica como presente, posible o parcialmente presente, no presente y desconocido. Respecto a la codificación numérica, se han utilizado distintos criterios, aunque el propio autor propuso el criterio habitual: 2 puntos para ítems presentes, 1 para los parcialmente presentes y 0 para los ausentes o desconocidos (Worling, 2004). Está pensada para estimaciones a corto plazo, máximo un año, teniendo en cuenta que la población a la que está destinada está sometida a cambios rápidos y frecuentes.

En un seguimiento de siete años y medio se encontró que ni la ERASOR, ni el YLS/CMI, ni la PCL:YV, ni el Static-99 predecían de forma significativa la reincidencia, posiblemente debido a la ya comentada dinamicidad del riesgo en muestras juveniles (Viljoen, Elkovitch, Scalora y Ullman, 2009). Las AUC del ERASOR fueron

TABLA 11.5
Factores de riesgo del ERASOR (Worling, 2004)

Intereses, actitudes y conductas sexuales
1. Intereses sexuales desviados (niño/as más jóvenes, violencia o ambos). 2. Intereses sexuales obsesivos/preocupación por pensamientos sexuales. 3. Actitudes de apoyo a los delitos sexuales. 4. Falta de interés por cambiar las actitudes e intereses sexuales desviados.
Historia de agresiones sexuales
5. Alguna vez ha delinquido sexualmente contra dos o más víctimas. 6. Alguna vez ha delinquido contra la misma víctima dos o más veces. 7. Sanciones previas al delito sexual provenientes de un adulto. 8. Amenazas o uso de violencia excesiva o armas durante el delito sexual. 9. Alguna vez ha delinquido sexualmente contra un niño. 10. Alguna vez ha delinquido sexualmente contra un/a desconocido/a. 11. Elección indiscriminada de víctimas. 12. Alguna vez ha delinquido sexualmente contra una víctima masculina. 13. Diferentes tipos de conducta sexual delictiva.
Funcionamiento psicosocial
14. Orientación interpersonal antisocial. 15. Carencia de relaciones íntimas con pares/aislamiento social. 16. Influencias y asociaciones negativas con pares. 17. Agresión interpersonal. 18. Reciente escalada de ira o de sentimiento negativo. 19. Pobre autorregulación del afecto y el comportamiento (impulsividad).
Funcionamiento familiar y del entorno
20. Entorno familiar de alto estrés. 21. Relaciones adolescente-padres problemáticas/rechazo parental. 22. Los padres no apoyan el tratamiento específico posterior al delito sexual. 23. Entorno que facilita oportunidades de reincidencia sexual.
Tratamiento
24. Ausencia de desarrollo o práctica de planes/estrategias realistas de prevención. 25. Tratamiento específico para la delincuencia sexual incompleto.

Adaptación española: Venegas-Cardenas, Sánchez, Hilterman y Siria (2013).

malas tanto para la puntuación como para las etiquetas y para todas las formas de reincidencia (sexual 0,60 y 0,64; violenta 0,56 y 0,54).

Worling, Bookalam y Litteljohn (2012) también concluyeron que las categorías asignadas por

el profesional se relacionaban poco con la reincidencia ($AUC = 0,61$), mientras que la predicción del sumatorio era mejor ($AUC = 0,72$). Partiendo de un estudio previo (Worling, 2004), propusieron puntos de corte para la puntuación total: 0-25

riesgo bajo; 26-33 riesgo moderado, y 34 o más riesgo alto. Estos puntos de corte mejoraron la predicción, con un AUC = 0,65. Hicieron lo mismo para el sumatorio de factores presentes: bajo (0-10 factores), moderado (11-14 factores) y alto (15 o más factores), obteniendo un AUC = 0,71. Para predicciones a corto plazo (seguimientos inferiores a los dos años), la predicción del juicio profesional ascendía a 0,81, la de la puntuación total a 0,93 y la del número de ítems presentes a 0,90. Para ese mismo período, los puntos de corte propuestos ofrecieron un AUC = 0,86 para el sumatorio y AUC = 0,89 para la presencia de factores, mejorando por tanto las predicciones. En un estudio de seguimiento (Worling y Langton, 2015), la capacidad predictiva de la violencia sexual fue mejor con la corrección como sumatorio (AUC = 0,77 para reincidencia sexual; AUC = 0,59 para reincidencia no sexual) que con la corrección por categorías (AUC = 0,63 para reincidencia sexual; AUC = 0,59 para reincidencia no sexual). La predicción empeoró en los 63 casos en los que el seguimiento fue superior al año (sumatorio AUC = 0,74 para violencia sexual y AUC = 0,52 para violencia no sexual; categorías AUC = 0,62 para violencia sexual y AUC = 0,42 para violencia no sexual).

En un metaanálisis, Viljoen, Mordell et al. (2012) calcularon un AUC medio de 0,66 para la reincidencia sexual y de 0,59 para la reincidencia general, tanto del juicio estructurado (conclusión final del profesional) como de la puntuación total de la escala. Zeng, Chu, Koh y Teoh (2015) utilizaron el ERASOR y el YLS/CMI para establecer tipologías de delincuentes sexuales juveniles, y encontraron que el riesgo era mayor en los que cometían otros delitos además de los sexuales. Entre jóvenes agresores de niños y los que no agreden niños la única diferencia fue en el ítem «presencia de agresiones sexuales previas», mayor en los agresores de niños, por la posible facilidad de agredir a este tipo de víctimas.

Pese a alguna excepción (por ejemplo, Viljoen, Mordell et al., 2012; Zeng, Chu y Lee, 2015), los estudios tienden a concluir que el ERASOR predice de forma significativa la reincidencia sexual,

en especial la codificación con el uso de puntuaciones, aunque el conjunto de revisiones muestran valores AUC moderados o bajos tanto para reincidencia sexual como para la no sexual (cerca o inferiores a 0,70) (Hempel, Buck, Cima et al., 2013; Viljoen, Gray et al., 2016; Viljoen, Mordell et al., 2012).

6.2. J-SOAP-II

El *Juvenile Sex Offender Assessment Protocol* —J-SOAP-II— (Prentky y Righthand, 2003) es un protocolo de 28 ítems, diseñado para la valoración del riesgo de violencia sexual en varones entre 12 y 18 años con historia de violencia sexual. Los factores de riesgo estáticos están organizados en dos bloques: Impulso sexual/Preocupación (8 ítems) e Impulsividad/Conducta antisocial (8 ítems). Los factores dinámicos se dividen en la Escala de intervención (7 ítems) y la Escala de estabilidad y ajuste comunitario (5 ítems). En la tabla 11.6 se muestran los factores de riesgo. Su manual original es de acceso gratuito en Internet.

Los ítems se codifican como ausentes (0), parcialmente presentes (1) y presentes (2). Se propone calcular una puntuación total sumando todos los ítems y una proporción relativa de riesgo en cada escala dividiendo la puntuación por el número de factores de la escala (por ejemplo, 8 puntos en la escala con ocho factores = 8 puntos de 16 posibles = 50% de presencia de riesgo en la escala). Aunque fue diseñada con la idea de ser una herramienta actuarial (Prentky, Harris, Frizzell y Righthand, 2000), en su manual de uso se señala que por falta de muestra no se ofrecen probabilidades de reincidencia y tampoco puntos de corte.

Es una herramienta ampliamente utilizada y de la que se acumula un gran volumen de investigación. Por ejemplo, hay análisis confirmando su estructura factorial, así como su validez convergente con el YLS/CMI (Righthand et al., 2005). Respecto a su capacidad predictiva, los estudios son dispares. En una muestra de 169 agresores sexuales en tratamiento no predijo la violencia sexual, al igual que tampoco lo hicieron el SAVRY

TABLA 11.6
Factores de riesgo del J-SOAP-II
(Prentky y Righthand, 2003)

Ítems estáticos
Escala de impulso sexual/preocupación 1. Cargos previos por delitos sexuales. 2. Número de víctimas de la violencia sexual. 3. Víctima infantil masculina. 4. Duración de la historia de delitos sexuales. 5. Grado de planificación en los delitos sexuales. 6. Agresión sexualizada. 7. Impulso excesivo o preocupación por el impulso sexual. 8. Historia de victimización sexual.
Escala de impulsividad/conducta antisocial 9. Consistencia de los cuidadores. 10. Ira generalizada. 11. Problemas de conducta en la escuela. 12. Historia de problemas de conducta. 13. Conducta antisocial juvenil. 14. Condenas o arrestos antes de los 16 años. 15. Versatilidad delictiva. 16. Historia de agresiones físicas o exposición a la violencia en la familia.
Ítems dinámicos
Escala de intervención 17. Aceptación de la responsabilidad por los delitos. 18. Motivación intrínseca para el cambio. 19. Comprensión de los factores de riesgo. 20. Empatía. 21. Remordimientos y culpabilidad. 22. Distorsiones cognitivas. 23. Calidad de las relaciones con pares.
Escala de estabilidad y ajuste comunitario 24. Gestión de los impulsos y deseos sexuales. 25. Gestión de la ira. 26. Estabilidad de la situación de vida. 27. Estabilidad en la escuela. 28. Pruebas de sistemas de apoyo positivos.

y el J-SORRAT-II (Viljoen, Scalora et al., 2008). En otro caso, se encontró una buena capacidad

predictiva tanto de la reincidencia general (AUC = 0,76) como de la sexual (AUC = 0,78), con mejor funcionamiento de las escalas dinámicas (Martínez, Flores y Rosenfeld, 2007).

La herramienta se ha utilizado en contextos terapéuticos para asignar intensidades de intervención (Rehfuss et al., 2013). Viljoen et al. (2015) encontraron que el J-SOAP-II era sensible al cambio terapéutico, pero que este cambio, sin embargo, no se relacionaba con una reducción de la reincidencia, salvo en la escala *Tratamiento*. Peor aún, la mejora en la escala de *Estabilidad y ajuste comunitario* se relacionó con una mayor reincidencia sexual y general. Este fallo en la relación entre mejora del riesgo y reducción en la reincidencia se dio también en el SAVRY, lo que podría indicar que ambas herramientas no incluyen factores dinámicos relevantes relacionados con la reincidencia en delincuentes sexuales juveniles. La predicción no fue acertada ni en los plazos cortos (por ejemplo, un año) ni en los largos (hasta ocho años).

En su metaanálisis, Viljoen, Mordell et al. (2012) encontraron un AUC media de 0,67 para la reincidencia sexual y de 0,66 para la reincidencia general con la puntuación total de la escala. La escala que mejor predeciría la violencia sexual es la de *Estabilidad y ajuste comunitario*. En estudios que comparaban en la misma muestra el J-SOAP-II con la ERASOR, la predicción de la violencia sexual resultaba mejor en la segunda herramienta (0,62 vs. 0,68) y la predicción de la reincidencia general en la primera (0,69 vs. 0,61). Pese a discrepancias entre estudios y AUC moderadas/bajas, la predicción de la reincidencia sexual en jóvenes alcanzaría valores comparables a la predicción en adultos.

Respecto a sus propiedades generales, Fanniff y Letourneau (2012) diferenciaron el funcionamiento de las cuatro escalas, concluyendo que la que más estaba relacionada con la reincidencia sexual era la 3 (escala de intervención) y que la 2 (impulsividad/conducta antisocial) lo hacía con la delincuencia general. La escala 1 (impulso sexual/preocupación), sorprendentemente, mostraba poca relación con la reincidencia sexual. En

conjunto, le atribuyeron una buena fiabilidad interjueces, peor para la escala Estabilidad y ajuste comunitario; validez convergente con el SAVRY y el J-SORRAT-II; resultados mixtos sobre su validez predictiva (con AUC tendentes a bajas) y ausencia de estudios en chicas por haber sido diseñado para chicos (Viljoen, Gray et al., 2016). Por tanto, con los trabajos revisados se puede afirmar que la investigación es inconsistente e incluso contradictoria.

6.3. J-SORRAT-II

La *Juvenile Sexual Offense Recidivism Risk Assessment Tool-II* —J-SORRAT-II— (Epperson, Ralston, Fowers y DeWitt, 2005) es una herramienta actuarial de 12 ítems, diseñada para predecir la violencia sexual en varones entre los 12 y los 18 años. Los 6 primeros ítems hacen referencia a la conducta sexual delictiva (por ejemplo, número de víctimas) y requieren la presencia de cargos. Los otros seis factores hacen alusión a características no relacionadas con la delincuencia sexual (victimización, respuesta al tratamiento, etc.). La guía de corrección, disponible de forma gratuita en Internet, ofrece al usuario ejemplos concretos para la codificación de cada ítem. Su uso está mucho menos extendido que el

de las dos anteriores herramientas y los resultados aún son inconsistentes.

En la muestra de creación se obtuvo una capacidad predictiva muy buena ($AUC = 0,89$), tanto para la reincidencia en cualquier delito sexual como para la violencia sexual (Epperson y Ralston, 2015). Las puntuaciones en la escala se vincularon a probabilidades de reincidencia. Por ejemplo, en la muestra de desarrollo, a partir de diez puntos, de los 21 posibles, la probabilidad es superior al 50%. En dicha muestra, aproximadamente el 70% de los jóvenes puntuaba entre 0 y 4. Sin embargo, en la muestra de validación la capacidad predictiva empeoró ($AUC = 0,65$) y no se confirmaron estos baremos, lo cual pone de manifiesto la dificultad de aplicar herramientas actuariales en muestras distintas a las de su creación.

En trabajos de los autores se describen AUC entre 0,65 y 0,70 (Ralston, Epperson y Edwards, 2016; Ralston, Sarkar, Philipp y Epperson, 2015). En un trabajo independiente con 169 jóvenes delincuentes sexuales, también de EEUU, Viljoen, Scalora et al. (2008) encontraron que la puntuación de la J-SORRAT-II no predecía de forma significativa la reincidencia ($AUC = 0,59$ para la violencia sexual y $AUC = 0,58$ para la violencia no sexual). En el metaanálisis de Viljoen, Mordell et al. (2012) se le atribuye un AUC media de 0,64 para la reincidencia sexual.

Otros tipos de violencia 12

Tal como se ha descrito en capítulos previos, la variedad de herramientas disponibles ha crecido exponencialmente en los últimos años y cada día disponemos de más herramientas para valorar distintas formas de violencia. Junto a las herramientas presentadas para abordar la violencia general, la de pareja, la sexual y la juvenil, existen otras mucho más concretas para formas de violencia menos prevalentes. A continuación abordaremos la evaluación del riesgo en casos de terrorismo o radicalización, en el acoso, en la violencia en el contexto laboral y en los crímenes de honor.

1. TERRORISMO, EXTREMISMO Y RADICALIZACIÓN

En la última década, el hito histórico supuesto por los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ha quedado ensombrecido por la proliferación de ataques terroristas en occidente y la extensión del terrorismo yihadista en países del propio oriente medio (como Siria o Irak). La inestabilidad política de estos países, unida al poder de las redes sociales, ha sido el caldo de cultivo propicio para la propagación de una ideología radical y terrorista, tanto en tierras de oriente como en occidente. Sin embargo, pese a que la gran alarma mundial está centrada en actos de tipo islamista,

la evaluación del riesgo de terrorismo, extremismo y radicalización no solo se centra en este tipo de ataques.

Además de estos atentados terroristas vinculados al yihadismo, bajo el término violencia extremista se incluye a otro tipo de personas entre las que se encuentran grupos separatistas, ideologías políticas como la extrema derecha e incluso algunos defensores de derechos (animales, naturales, etc.), entre otros (Egan et al., 2016). Se trata de extremistas violentos, radicales políticos y terroristas en general, que emplean la violencia con fines políticos o con el deseo de tener resultados en ese ámbito, aunque no todos busquen inducir miedo en toda la población (Pressman y Flockton, 2012). Sin embargo, también encontramos delincuentes oportunistas y sujetos buscadores de sensaciones. En algunos casos, pueden pertenecer a grupos organizados; en otros, son sujetos solitarios que siguen una doctrina existente o creada por ellos mismos. La mayoría no presenta un trastorno mental, pero algunos cometen ataques motivados por algún desequilibrio (Meloy, Harbmeyer y Guldemann, 2015).

Por tanto, nos podemos enfrentar a actos terroristas cometidos por los denominados lobos solitarios, sujetos que actúan de forma independiente siguiendo las pautas o directrices de un movimiento ubicado a gran distancia geográficamente, o incluso ideado por ellos mismos, aunque sin el amparo material o logístico de un gru-

po o comando terrorista. Este último caso sería el perfil, por ejemplo, de Anders Breivik (véase Jacobsen y Maier-Katkin, 2015; Meloy, Habermeyer, et al., 2015; Tietze, 2014). Junto a terroristas solitarios, podemos encontrar pequeños grupos formados habitualmente por familiares (hermanos principalmente), que componen células radicalizadas que actúan de forma independiente o en varios actos terroristas coordinados. Este sería el perfil de los terroristas implicados en algunos de los ataques ocurridos en occidente en los últimos años, como los hermanos Tsarnaev (que atentaron con explosivos en la maratón de Boston el 15 de abril de 2013, causando la muerte de 3 personas e hiriendo a 264) o los hermanos Kouachi (asaltantes del semanario satírico *Charlie Hebdo*, el 7 de enero de 2015, en el que murieron 12 personas).

Atendiendo a esta situación de creciente alarma, la primera cuestión que surgió fue si las aproximaciones a la evaluación del riesgo de violencia podrían ser generalizadas a la evaluación del riesgo de terrorismo o radicalización. Por un lado, las características descritas para los terroristas tienden a diferir de lo descrito para delincuentes violentos. Los rasgos más habituales son ser varón, joven, con un nivel educativo superior a los pares del contexto del que provienen, sin trastornos mentales y generalmente libres de antecedentes por otros delitos (Monahan, 2012). Por tanto, las principales dimensiones utilizadas en la evaluación del riesgo de otros tipos de violencia (historial delictivo, estilo de vida, trastornos y abuso de sustancias) no resultarían de utilidad en el caso de los terroristas. La esencia del terrorista es que es una persona «normal», con pleno control de su conducta, y que su ideología le lleva a excusar y justificar los hechos más atroces por su supuesto servicio a un bien superior (Pressman y Flockton, 2014). Por otro lado, para la evaluación del riesgo de terroristas, la metodología actuarial parece imposible de aplicar, debido a las pequeñas muestras, y las guías de juicio profesional estructurado parecen la alternativa de elección (Monahan, 2012).

En la evaluación del riesgo en terroristas, los objetivos son dos (Pressman y Flockton, 2012): 1) evaluar el riesgo de que un sujeto cometa actos de violencia ideológicamente motivados (cuando esté en libertad), y 2) utilizar la información para desarrollar estrategias de lucha contra el terrorismo y programas para intervenir sobre el sujeto mientras permanezca bajo custodia. Para este objetivo, con independencia de las alarmas terroristas de los servicios de seguridad de cada país, han surgido algunas herramientas que siguen la línea de las ya explicadas en capítulos previos. A continuación comentaremos brevemente tres de ellas: VERA, TRAP-18 y ERG 22+. Existen otras propuestas, más recientes, como la IVP —*Identifying Vulnerable People guidance*— (Egan et al., 2016) o la MLG —*Multi-level Guidelines for the Assessment and Management of Group-Based Violence*— (Cook et al., 2013) que aún están pendientes de más desarrollo.

1.1. VERA

El *Violent Extremism Risk Assessment* —VERA— es posiblemente el primer protocolo propuesto para la evaluación el riesgo de terrorismo. Se creó en Canadá en 2009 (Pressman, 2009), siguiendo las directrices vigentes respecto a guías de juicio estructurado. En 2010 fue revisado con el *feedback* de profesionales y en la actualidad está disponible el VERA-2 (Pressman y Flockton, 2012). El punto de partida de la propuesta era que los factores de riesgo incluidos en las herramientas para la predicción de la violencia en general no mostraban utilidad en muestras de terroristas. Por ejemplo, menos de un tercio de los factores de riesgo presentes en la HCR-20 eran aplicables (Pressman, 2009).

El VERA-2 está compuesto por 31 ítems, organizados en 5 secciones, tal como se muestra en la tabla 12.1:

1. *Creencias y actitudes*: dirigidas hacia personas, objetos e incluso otras ideologías. Puede ser la base para el extremismo, aun-

- que no es una condición ni necesaria ni suficiente para valorar el riesgo de violencia. Correspondería a la ideología del sujeto.
2. *Contexto e intención:* incluye la intención consciente de actuar y engloba contextos culturales y sociales, como contactos personales, familia y amigos que puedan apoyar la activación de la intención de actuar. Creer en una ideología sin tener la intención de actuar de forma violenta para lograr objetivos reduce el riesgo. La ideología y la intención de actuar son precursores de la violencia extremista.
 3. *Historia y capacidad:* se analiza la capacidad del sujeto de planificar y llevar a la acción las ideas. Se consideran la experiencia, el entrenamiento, la trayectoria, etc.
 4. *Compromiso y motivación:* se intenta distinguir líderes de seguidores. Los líderes son capaces de reunir sujetos alienados y frustrados en búsqueda de acción, ofrecen un mensaje unificado e identifican al enemigo común. Los indicadores de esta sección valoran posibles motivos para la violencia, bien como líder, ideólogo, seguidor, delincuente oportunista o buscador de sensaciones.
 5. *Factores de protección:* son variables que facilitan que el sujeto abandone la ideología o su radicalización, mitigando los factores de riesgo.

TABLA 12.1
Ítems del VERA-2 (Pressman y Flockton, 2012)

Creencias y actitudes
1. Compromiso con una ideología que justifica la violencia. 2. Percepción de ser víctima de injusticias. 3. Deshumanización/demonización de los objetivos identificados como causa de la injusticia. 4. Rechazo de la sociedad y de los valores democráticos. 5. Sentimientos de odio, frustración, persecución y alienación. 6. Hostilidad hacia la identidad nacional colectiva. 7. Falta de empatía o comprensión fuera del propio grupo.
Contexto e intención
8. Buscador, consumidor o creador de materiales extremistas violentos. 9. Identificación de un objetivo (persona, lugar o grupo) en respuesta a la injusticia percibida. 10. Contacto personal con extremistas violentos. 11. Ira y expresión de la intención de actuar de forma violenta. 12. Deseo expreso de morir como mártir por la causa. 13. Intención expresa de planificar o preparar una acción violenta. 14. Susceptibilidad a la influencia, la autoridad o el adoctrinamiento.
Historia y capacidad
15. Exposición temprana a una ideología militante pro-violencia. 16. Red (familia o amigos) que participan en acciones violentas. 17. Antecedentes penales por violencia. 18. Entrenamiento táctico, paramilitar o en explosivos. 19. Formación en ideología extremista. 20. Acceso a fondos, recursos o capacidad organizativa.

TABLA 12.1. (continuación)

Compromiso y motivación
21. Glorificación de la violencia. 22. Impulsado por el oportunismo. 23. Compromiso con el grupo, ideología grupal. 24. Impulsado por imperativo moral, superioridad moral. 25. Impulsado por la emoción, la aventura.
Factores de protección
26. Reinterpretación de la ideología menos rígida. 27. Rechazo de la violencia para obtener objetivos. 28. Cambio de visión del enemigo. 29. Participación en programas contra la violencia o de desradicalización. 30. Apoyo comunitario para la no violencia. 31. Apoyo familiar para la no violencia.

Uno de los motivos para crear herramientas específicas para terroristas y extremistas es que, como ya hemos comentado, no comparten las mismas características que otros sujetos violentos. Los trabajos con la herramienta y con otras guías de juicio estructurado, como la HCR-20, han demostrado la utilidad del uso de factores de riesgo propios (Pressman, 2009). Aunque el VERA-2 está diseñado para su uso con terroristas, se puede aplicar a todo el espectro de extremistas dispuestos a utilizar la violencia con fines políticos, religiosos o de otro tipo. Lo que tienen en común estos extremistas es la convicción de que su violencia está moralmente justificada para lograr sus objetivos ideológicos o políticos. Su principal foco de atención son los extremistas y terroristas en prisión, con el objetivo de valorar el riesgo y gestionar la seguridad.

Los autores recomiendan su uso junto a otras medidas estandarizadas (por ejemplo, medidas psicométricas), así como otras herramientas para la valoración del riesgo de otras formas de violencia. También advierten sobre la necesidad de tener cautela en su aplicación en casos bajo investigación (por las fuerzas de seguridad, por ejemplo). Aún hay poca investigación sobre su uso. Se ha descrito una concordancia interjueces del 85%

en una aplicación a cinco casos (Beardsley y Beech, 2013), aunque se carece de estudios sobre validez predictiva (al igual que ocurre con las demás herramientas para la misma temática).

1.2. TRAP-18

El *Terrorist Radicalization Assessment Protocol-18* —TRAP-18— (véase Meloy, Roshdi et al., 2015) es una de las propuestas más recientes en el ámbito de la evaluación del riesgo y que, además, responde a una creciente demanda de seguridad tanto de la sociedad como de los gobiernos frente al terrorismo. Se trata de un protocolo compuesto por 18 ítems, 8 conductas de alerta próximas en el tiempo (que pueden indicar una aceleración del riesgo de violencia dirigida) y 10 distanciadas en el tiempo (distales). La descripción de estos factores se presenta en la tabla 12.2.

Se trata de un protocolo aún en desarrollo, del que recientemente se han publicado resultados sobre su aplicación en 22 terroristas que habían actuado en Europa (7 pertenecientes a células independientes y 15 actuando en solitario) (Meloy, Roshdi et al., 2015). En dicho estudio se obtuvo una fiabilidad interjueces media de 0,895.

TABLA 12.2

Factores de riesgo del TRAP-18 (Meloy y Gill, 2016; Meloy, Hoffmann, Guldemann y James, 2012)

Factores distales	
1.	Agravio personal y ultraje moral.
2.	Enmarcado por una ideología.
3.	Fracaso en la afiliación a un grupo extremista.
4.	Dependencia de comunidades virtuales.
5.	Frustración de los objetivos ocupacionales (académicos o laborales).
6.	Cambios en pensamientos y emociones: ideas raras, simplistas, imposición de ideas a otros.
7.	Fracaso en relaciones de pareja.
8.	Trastorno mental: historia de trastorno grave o presencia en la actualidad.
9.	Creatividad e innovación: hace alusión a lo excepcional del ataque terrorista, innovador y que pueda ser imitado por otros.
10.	Historia de violencia: existencia de historial de delitos violentos.
Factores proximales: Conductas de alarma	
1.	Trayectoria conductual alarmante: investigación, búsqueda, planificación, preparación o implementación del ataque (incluye manuales de explosivos, entrenamiento en algún procedimiento, compilar armas).
2.	Fijación: preocupación patológica por una persona o causa, acompañada de deterioro de la vida social y ocupacional (incluye intensificación o cambio de ideas religiosas o políticas).
3.	Identificación: deseo de pertenencia a un comando o grupo (incluye reclamar formar parte de un grupo, leer su propaganda o seguir a otros lobos solitarios).
4.	Agresión novel: violencia sin ninguna relación con el objetivo y con la que se cree que el sujeto pone a prueba su capacidad de actuar de forma violenta.
5.	Explosión de energía: incremento en la frecuencia o variedad de conductas vinculadas a la violencia dirigida.
6.	Difusión: comunicación a un tercero de la intención de cometer el ataque (incluye manifiestos, cartas públicas...).
7.	Último recurso: el sujeto no puede controlarse más y cree que no tiene otra alternativa que atacar (vinculado a desesperación, pérdida o anticipación de pérdida; incluye actividades como cierre de cuentas, pago de deudas, etc.).
8.	Amenaza comunicada directamente.

No se encontraron diferencias entre células terroristas y terroristas solitarios, salvo el hecho de que los primeros tenían más historial violento.

También se ha utilizado en un estudio con 111 terroristas de los denominados «lobos solitarios», provenientes del trabajo de Gill (2015), diferenciando entre islamistas y extremistas de derecha, así como entre aquellos que habían cometido el ataque y los que solo lo habían planificado (Meloy y Gill, 2016). Los atacantes consumados tenían más fijación, eran más creativos e innovadores y contaban con más historia de fracaso en relaciones de pareja. Los planificados pero no consumados, por ejemplo, tenían más actividad

en redes sociales (lo que posiblemente había facilitado su detección). Esta variable, además, se vincularía con el fracaso en la consumación del ataque. También se ha señalado que los lobos solitarios presentan más variables distales (Meloy y Yakeley, 2014).

Hasta la fecha no se ha analizado su capacidad predictiva ni la capacidad discriminante (para comparar sujetos terroristas y no terroristas). Pese a ello, se recomienda que los casos que generen preocupación deberían ser valorados en primer lugar según las variables proximales. En caso de ausencia de estas variables, se deberían buscar características distales. Las variables dis-

tales implicarían seguimiento del caso, mientras que las señales de alarma (variables proximales) deberían implicar la gestión activa del caso (Meloy, Roshdi et al., 2015). Meloy ha analizado de forma específica la difusión (Meloy y O'Toole, 2011) y la identificación (Meloy, Mohandie, Knoll y Hoffmann, 2015) en el ámbito de la evaluación del riesgo de violencia, aunque no sea de forma exclusiva para el terrorismo o la radicalización.

1.3. ERG 22+

El *Structured Professional Guidelines for Assessing Risk of Extremist Offending* —ERG 22+— (Lloyd y Dean, 2015) es un protocolo en uso desde 2011 por el *National Offender Management Service*, en Inglaterra y Gales, para la gestión de delincuentes extremistas. Antes de estar disponible, todos los terroristas eran considerados de riesgo alto, lo que dificultaba la gestión de recursos. Por tanto, existía la necesidad de crear una metodología para evaluar el riesgo. A nivel conceptual, etiqueta como delito extremista cualquier delito relacionado con un grupo, causa o ideología que propaga visiones y acciones extremistas y que justifica el uso de la violencia y otras actividades ilegales para conseguir los objetivos. No solo se trata de sujetos con ideologías, también hay motivaciones oportunistas o delictivas. Por otro lado, la radicalización se describe como un proceso y un resultado que no está presente en todos los extremistas. En su lugar, se usa «implicación» como proceso por el que las personas se ven implicadas o se identifican con un grupo, causa o ideología extremista.

El ERG 22+ está compuesto por 22 ítems organizados en tres dimensiones (el símbolo «+» señala la posibilidad de incorporar cualquier otra variable que se considere de interés): *implicación* (refleja compromiso con una ideología, grupo o causa), *intención* (implica estar preparado para actuar conforme a la propia mentalidad, incluyendo qué hacer y con qué objetivo) y

capacidad (supone tener recursos personales o económicos y conocimientos, etc.). Los factores de riesgo no se derivan de un análisis estadístico, sino de diferencias conceptuales entre estar implicado, tener la intención de actuar y tener la capacidad. En la tabla 12.3 se presentan los factores de riesgo que componen el ERG 22+. La escala se centra en el sujeto, pero también identifica el rol familiar y de los amigos en el apoyo del delito, el de grupos que controlan al sujeto o el acceso a una red que pueda facilitar el entrenamiento o la financiación.

Se trata de un listado de variables derivadas de la revisión de la literatura sobre extremismo, aunque hasta la fecha carece de evidencias empíricas sobre su utilidad o la relación del contenido con la reincidencia (Silke, 2014). El protocolo solo lo aplican profesionales cualificados y acreditados con dos días de formación en la herramienta. Los autores señalan las dificultades de valorar algunas cuestiones como la capacidad predictiva (Lloyd y Dean, 2015). Es importante saber qué queremos estimar, pues con pocos recursos y poca planificación se pueden cometer atentados con gran impacto. Por otro lado, no todos los factores son relevantes para todos los sujetos y pueden jugar distintos roles. Por esto mismo, los ítems del EGR 22+ no se suman, sino que se valoran cualitativamente. Más factores no significan más riesgo, sino una narración de la historia del riesgo del sujeto. Los factores, además, son dinámicos, excepto el de historial delictivo.

Respecto a las herramientas presentadas anteriormente, el ERG 22+ se centra en la realidad del Reino Unido y el perfil de los terroristas y extremistas allí detenidos. El ERG 22+ busca analizar la ruta y los motivos en condenados por extremismo, y comprender cómo se han implicado en estas conductas para lograr que cesen en su actividad. En el ERG 22+, a diferencia del VERA-2, no hay alusión a la violencia, pues la mayoría de los condenados por terrorismo en Reino Unido no tienen historia de violencia, sino que en general están condenados por contribuir o apoyar actos extremistas. El VERA-2, sin em-

TABLA 12.3
Factores de riesgo del ERG 22+ (Lloyd y Dean, 2015)

Implicación
1. Necesidad de reparar una injusticia y agravio expreso. 2. Necesidad de defenderse contra amenazas. 3. Necesidad de identidad, significado o pertenencia. 4. Necesidad de estatus. 5. Necesidad de emoción, compañerismo o aventura. 6. Necesidad de dominar. 7. Susceptibilidad al adoctrinamiento. 8. Motivación política/moral. 9. Participación oportunista. 10. Familiares o amigos que apoyan el extremismo. 11. Períodos de transición. 12. Grupo de influencia y control. 13. Salud mental.
Intención
1. Exceso de identificación con un grupo o causa. 2. Pensamiento «nosotros» y «ellos». 3. Deshumanización del enemigo. 4. Actitudes que justifican el delito. 5. Medios dañinos para conseguir objetivos. 6. Objetivos finales dañinos.
Capacidad
1. Conocimientos, habilidades y competencias. 2. Acceso a redes, financiación y equipo. 3. Antecedentes penales.

bargo, parte de una revisión de factores internacionales y trata de ser útil en cualquier contexto. Ambas herramientas parten del modelo de juicio estructurado, comparten factores y las dimensiones intención y capacidad.

Pese a que pueda haber validez convergente, por contener factores de riesgo similares, aún no se ha analizado la validez predictiva, por las dificultades propias de la temática: muchos cumplen condenas muy largas, y los que salen en libertad muchas veces dejan de actuar de forma visible por estar ya identificados por los cuerpos de seguridad, aunque ideológicamente sigan siendo iguales.

2. ACOSO

El acoso es una problemática ambigua sobre la que las respuestas legales y académicas han sido muy dispares en los últimos años. Como ejemplo, en 2009 entró en vigor en Italia una ley específica contra el *stalking* (ley n° 38 de 2009, que introduce el art. 612bis en el código penal), término inglés que traducimos por acoso y que hace alusión a distintas conductas de tipo persecutorio o de acecho. La pena se ve agravada en caso de que el acoso se cometa contra una pareja o expareja, o si se utilizan medios informáticos o telemáticos. También si la víctima es me-

nor, mujer embarazada o se utilizan armas. En España, la Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código Penal, introdujo en 2015 el delito de acoso dentro del capítulo de delitos contra la libertad (hasta ahora existían las coacciones, las amenazas y el acoso sexual). En el artículo 172ter se castigan aquellas conductas insistentes y reiteradas, no clasificables como coacciones o amenazas, que menoscaban la libertad de la víctima. Se incluye la vigilancia o búsqueda de cercanía física, el establecimiento o intento de establecer contacto por cualquier medio, el uso de datos personales o atentar contra la libertad o el patrimonio.

El acoso como forma de violencia difiere de otros tipos de violencia en varios aspectos (Kropp, Hart, Lyon y Storey, 2011): en primer lugar, es un tipo de violencia especialmente dirigido (el objetivo es concreto y conocido por el agresor); en segundo lugar, el acoso puede ser peligroso de forma indirecta o subjetiva (conductas inofensivas para unos pueden generar un gran miedo en el acosado, debido al contexto en el que se producen); por último, el acoso, como otros tipos de violencia, como la de pareja o el abuso infantil, puede persistir en el tiempo.

Las complejidades y variedades del acoso hacen que la valoración de su riesgo y su gestión sean un objetivo complicado para distintos profesionales. Entre las cuestiones a las que se debe hacer frente estarían las siguientes (Kropp et al., 2011): ¿qué acosadores son más propensos a seguir acechando a la víctima?, ¿quién tendrá una escalada, pasando de simples comunicaciones no deseadas a una agresión, o de una agresión a otra con riesgo de muerte?, ¿quién puede ser gestionado de forma segura en la comunidad?, ¿qué acosadores son adecuados para tratamientos concretos? Además, en el acoso, la conducta de la víctima tiene un impacto relevante en el riesgo. Tanto el SAM como el SRP, las dos herramientas que explicaremos a continuación, incluyen factores de la víctima, como la conducta inconsistente o respuestas poco claras al acosador.

2.1. SAM

El *Guidelines for Stalking Assessment and Management* —SAM— (Kropp et al., 2008) sigue la misma dinámica que otras herramientas de juicio estructurado desarrolladas por sus mismos autores, como SARA, SVR-20 y RSVP. El SAM está compuesto por 30 factores de riesgo, divididos en tres dominios con 10 factores cada uno (véase tabla 12.4): naturaleza de acoso, factores del agresor y vulnerabilidad de la víctima.

La herramienta se creó entre 2001 y 2008, con una revisión de la bibliografía sobre acoso y otras formas de violencia, como la de pareja, y aplicaciones piloto en distintos momentos y contextos. Está diseñada para su aplicación por profesionales de la salud mental, del ámbito penal o por cuerpos de seguridad, en casos de acosadores mayores de edad, con independencia del sexo u orientación sexual (Kropp et al., 2011). Valora la presencia de los factores de riesgo en la actualidad (en el patrón de acoso actual) y en el pasado (período previo al acoso actual). También incluye la codificación de la relevancia de cada factor presente para la reincidencia futura. El resultado final se orienta a la valoración del riesgo de reincidencia en el acoso, el riesgo de daño físico grave para la víctima, el miedo razonable de la víctima y el requerimiento de intervención inmediata.

Existen, al menos, cuatro trabajos en los que se aplica la herramienta y se ofrecen datos sobre su utilidad. Belfrage y Strand (2009) pusieron a prueba el SAM en 153 varones evaluados por la policía en Suecia, concluyendo que era de fácil aplicación y que existía una alta correlación entre el número de factores presentes y la opinión final de los policías. El número de ítems ausentes resultó mayor para los pertenecientes al acosador (hasta un 16 %) que para los propios de la víctima (hasta un 4 %). El 90 % de los casos fueron considerados de riesgo medio o alto, pero solo en un 2 % se estimaba una violencia grave. El acoso era mayoritariamente a exparejas, y muchos de los casos graves que llegaban al equipo

TABLA 12.4
Factores de riesgo del SAM (Kropp et al., 2008)

Naturaleza del acoso	Factores de riesgo del agresor	Factores de vulnerabilidad de la víctima
N1. Habla sobre la víctima. N2. Comunicaciones con la víctima. N3. Acercarse a la víctima. N4. Contacto directo con la víctima. N5. Intimida a la víctima. N6. Amenaza a la víctima. N7. Violencia física hacia la víctima. N8. Persistencia del acoso. N9. Escalada del acoso. N10. El acoso implica quebrantamientos de la supervisión.	P1. Enfadado. P2. Obsesionado. P3. Irracional. P4. Falta de arrepentimiento. P5. Estilo de vida antisocial. P6. Problemas en relaciones de pareja. P7. Problemas en relaciones distintas a las de pareja. P8. Angustiado. P9. Problemas de consumo de sustancias. P10. Problemas laborales y económicos.	V1. Conductas inconsistentes hacia el acosador. V2. Actitudes inconsistentes hacia el acosador. V3. Acceso inadecuado a recursos. V4. Situación de vida insegura. V5. Problemas relacionados con el cuidado de personas dependientes. V6. Problemas en relaciones de pareja. V7. Problemas en relaciones distintas a las de pareja. V8. Angustiada. V9. Problemas de consumo de sustancias. V10. Problemas laborales y económicos.

policial habían sido valorados con el B-SAFER y no con el SAM, lo que afecta a los resultados. La media total de factores presentes (parcial o totalmente) fue de 17 y la puntuación media de la escala de 11,8.

Storey, Hart, Meloy y Reavis (2009) analizaron la relación entre psicopatía (medida con la PCL:SV) y el acoso en 62 casos. Aunque la psicopatía era menor en acosadores que en otras muestras forenses (solo un caso alcanzaba el punto de corte 18), las puntuaciones de ambas herramientas correlacionaban de forma positiva y significativa, en especial para el bloque de factores de riesgo del agresor del SAM ($r = 0,51$). También calcularon la fiabilidad interjueces, obteniendo un 0,77 para la naturaleza del acoso, un 0,68 para los factores del acosador y un 0,63 para los de la víctima.

Kropp et al. (2011) aplicaron la herramienta en 109 casos en Canadá, junto a la PCL:SV y la VRAG. Encontraron poca fiabilidad interjueces, en especial respecto a la información de la

víctima, muchas veces no disponible en contextos forenses en los que se valora agresores. Se dio una mayor correlación entre el SAM y la PCL:SV que con la VRAG. Foellmi, Rosenfeld y Galietta (2016) han analizado recientemente la capacidad predictiva de la herramienta, aplicando también la PCL:SV y los ítems *naturaleza del acoso* y *factores del acosador* en un seguimiento medio de 2,5 años. Los factores de la víctima se excluyeron debido a la ausencia de información fiable. Respecto a la fiabilidad interjueces, la escala de naturaleza del acoso obtuvo un 0,64 y la escala del agresor un 0,88. Ni la puntuación del SAM ni la codificación del nivel de riesgo por parte del profesional mostraron diferencias entre reincidentes y no reincidentes. Al analizar el tiempo en riesgo, las puntuaciones mayores sí se relacionaron con una reincidencia más rápida.

En Cook et al. (2014) podemos encontrar la aplicación del SAM, junto al B-SAFER v2, en un caso de violencia de pareja grave.

2.2. SRP

El *Stalking Risk Profile* —SRP— (MacKenzie et al., 2009) surgió como necesidad de sus autores en la evaluación del riesgo de acosadores en Australia, donde desde 2002 utilizaban para tal fin el LSI-R y la HCR-20, ninguna de las dos herramientas específica o adecuada para valorar aspectos como la persistencia en el acoso sin violencia física, la existencia de relación entre víctima y agresor o la presencia de riesgo con independencia de factores vinculados a la delincuencia común (McEwan, Pathé y Ogloff, 2011).

Se trata de una guía de juicio estructurado, creada a partir de la revisión de la bibliografía, la experiencia clínica con acosadores y víctimas y la investigación general en evaluación del riesgo de violencia. Está diseñada para ser utilizada en sujetos mayores de 18 años, que están implicados o han estado implicados en conductas de acoso (McEwan et al., 2016). El SRP diferencia distintos resultados de interés con distintos factores de riesgo, identifica aspectos que pueden resultar en una afectación psicosocial del acosador (y, por tanto, pueden incrementar el riesgo) y también parte del hecho de que no todos los acosadores son iguales, que pueden tener distintas motivaciones y diferenciarse en factores personales, clínicos y delictivos (McEwan et al., 2011). En lugar de considerar el tipo de acosador como el factor de riesgo en sí, cada tipo de acosador tiene distintos factores de riesgo a valorar.

Los cinco tipos de acosador considerados son (McEwan et al., 2016):

- *El pretendiente incompetente*: busca amistad o relaciones sentimentales con desconocidos o conocidos. El acercamiento es intrusivo, muchas veces motivado por soledad o excitación.
- *El buscador de intimidad*: acosa a conocidos o desconocidos con los que cree que tiene una relación sentimental, a menudo resultado de un trastorno mental. Puede ir acompañado de delirios referentes a la co-

rrespondencia de la víctima o a que esta inevitablemente terminará amándole si insiste.

- *El rechazado*: acosa tras la ruptura de una relación próxima, con parejas o amigos. La motivación es el deseo de reconciliación o venganza. No suele presentar trastorno mental.
- *El resentido*: acosa a conocidos o desconocidos que considera que le han utilizado de alguna manera. Busca venganza como forma de recuperar el poder y el control sobre la víctima. Es frecuente la presencia de rasgos de personalidad paranoide e incluso psicosis.
- *El depredador*: acosa a conocidos o desconocidos para obtener una satisfacción sexual, frecuentemente de tipo delictivo. No suelen tener un trastorno mental, aunque puede haber presencia de parafilias, consumo de drogas, trastorno de la personalidad o depresión.

El SRP incluye distintos dominios o resultados a valorar:

- *Persistencia*: posibilidad de que la persona que actualmente está acosando continúe haciéndolo. Incluye doce factores de riesgo comunes para todos los tipos de acosador.
- *Recurrencia (con la misma o distinta víctima)*: posibilidad de que alguien que ha cesado en su acoso lo retome en un futuro, bien con la misma víctima o con una víctima diferente. La recurrencia para distinta víctima incluye 4 factores de riesgo generales y entre 2 y 4 factores diferentes según el tipo de acosador. Para la recurrencia con la misma víctima, la escala no se aplica ni en el tipo pretendiente incompetente ni en el tipo depredador, y para los demás subtipos se aplican entre 2 y 4 factores.
- *Violencia relacionada con el acoso*: posibilidad de que un sujeto que está acosando en la actualidad se implique en violencia física contra la víctima de acoso o perso-

nas de su entorno. Posee doce factores de riesgo generales para todos los acosadores, entre 2 y 5 específicos según el tipo de acosador, y 5 señales de alarma raras pero que describen situaciones preocupantes (por ejemplo, ideación homicida).

- *Daño psicosocial al acosador*: aborda la posibilidad de que el acosador sufra afectación psicosocial por su conducta de acoso. La escala se evalúa igual en todos los acosadores, con once ítems.

Por tanto, en total hay 81 factores de riesgo, y dependiendo del tipo de acoso se valorarán entre 32 y 40 ítems. El formato de respuesta es el estándar (ausente, posible o parcialmente presente y presente) y las valoraciones se hacen para un plazo de 4 a 6 meses.

La valoración del riesgo con la SRP requiere delimitar de forma clara el tipo de acosador, la relación con la víctima, los objetivos (conductas o problemas) de interés, la inminencia y gravedad de los problemas y los factores de riesgo relevantes. El resultado final no es un sumatorio de factores, al igual que ocurre en el resto de guías de juicio estructurado. La presencia de algunos factores, especialmente si son señales de alarma, supondrán la consideración del caso como de riesgo alto y su seguimiento para reducir el riesgo de violencia. Los evaluadores considerarán la probabilidad de ocurrencia del resultado valorado según los factores de riesgo presentes y su relevancia, así como el nivel de daño vinculado a ese resultado. El posible daño también requiere la consideración de la trayectoria de la víctima respecto al acoso o factores de vulnerabilidad. La conclusión sobre el riesgo (bajo, medio o alto) indicará la necesidad de intervención. La comunicación del riesgo la proponen en formato formulación (véase capítulo 7, apartado 3), señalando por qué la persona presenta un tipo y nivel de riesgo determinado y qué medidas de gestión podrían resultar útiles para controlar ese riesgo. Al igual que en el SVR-20, se propone la consideración de cambios en el tiempo en los factores («+») para el caso de mejoras en el factor de riesgo, «-» en el

caso de empeoramiento o incremento del riesgo, y «0» para señalar que no ha habido cambio).

De momento, solo está disponible un estudio que describe sus propiedades (McEwan et al., 2016), encontrándose una capacidad predictiva en general baja. Las AUC para el seguimiento total oscilaron entre 0,66 y 0,73 y para los 6 meses entre 0,53 y 0,75. Los acosadores de mayor riesgo reincidieron más y más rápido. Respecto a la fiabilidad interjueces, la mayor coincidencia se dio para la escala *persistencia* (0,90), seguida de la *violencia* (0,89), la *recurrencia con distinta víctima* (0,76), el *daño psicológico para el acosador* (0,74) y la *recurrencia con la misma víctima* (0,70).

El mismo equipo de autores ha propuesto la *Screening Assessment for Stalking and Harassment* (SASH), de la cual aún no hay disponibles publicaciones.

3. VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

La violencia en el ámbito laboral es otra temática en la evaluación del riesgo que se ha desarrollado en el contexto anglosajón pero que de momento no ha suscitado mucho interés en el contexto hispanohablante. El interés general se ha centrado en el denominado *mobbing* o acoso laboral, sobre el cual también ha existido investigación en el contexto español (por ejemplo, Olmedo y González, 2006) y en el acoso por razón de sexo. Sin embargo, la evaluación del riesgo en el contexto laboral va más allá de este acoso y contempla otras formas de violencia, principalmente ataques dirigidos que incluyen violencia física. En la violencia laboral, incluido el *mobbing*, se contemplan tres pilares: acosador, víctima y organización (que favorece o permite el acoso). Gimeno, Grandío y Marqués (2012) analizaron precisamente esta influencia de las prácticas organizativas en el desarrollo de conductas violentas en el contexto laboral. Una de las herramientas de evaluación del riesgo que mencionaremos a continuación se ha centrado en valorar el contexto laboral, mientras que las otras se han centrado en el agresor.

En el contexto anglosajón, la violencia en el ámbito laboral se describe como un tipo de violencia dirigido (*targeted*) e incluye los homicidios (siendo más frecuentes los que se deben a atracos y no los que se consideran violencia laboral), agresiones sexuales, robos y agresiones, que dependiendo de la motivación y la relación entre víctima y agresor se incluirán bajo esta etiqueta (White, 2013). Esta violencia se define como la decisión consciente de dañar o matar objetivos identificados en el lugar de trabajo, siendo un tipo de violencia intencional y planeada. En Estados Unidos estos homicidios suponen en torno al 25 % de los homicidios producidos en el contexto laboral. En Barling, Dupré y Kelloway (2009) se puede encontrar una revisión sobre distintos hallazgos vinculados a la violencia en el contexto laboral, como los factores de riesgo, características o tipos de violencia.

Algunas de las herramientas disponibles para este tipo de violencia son la WRA-20, la ERA-20 y la WAVR-21.

3.1. WRA-20

La *Workplace Risk Assessment-20* —WRA-20— (Bloom et al., 2000) está diseñada para valorar específicamente los factores relacionados con el ambiente y contexto laboral. Ayuda a evaluar el riesgo e intervenir para reducir los factores de riesgo detectados. Está dividida en cinco dimensiones: situación (por ejemplo, existencia de quejas), prevención (por ejemplo, programa de asistencia a empleados), comunicación (por ejemplo, informar sobre eventos), capacidad de respuesta y ambiente (por ejemplo, estilo de gestión) (Stock, 2007).

3.2. ERA-20

La *Employee Risk Assessment-20* —ERA-20— (Bloom et al., 2002) se centra en 20 factores de riesgo individuales relacionados con esta violencia. Evalúa cuatro dimensiones del potencial

agresor: historial (por ejemplo, intentos de suicidio), variables clínicas (por ejemplo, abuso de sustancias), actitudes (por ejemplo, descontento) y situación (por ejemplo, despido) (Stock, 2007). Pese a ser las precursoras de la evaluación del riesgo en el contexto laboral, ni la ERA-20 ni la WRA-20 cuentan con publicaciones sobre su aplicación (Stock, 2007; Webster, Haque y Hucker, 2014).

3.3. WAVR-21

El desarrollo de la *Workplace Assessment of Violence Risk* —WAVR-21— (White y Meloy, 2010) se inició en 2004 como respuesta a los incidentes violentos acontecidos en contextos laborales y frente a la ausencia de desarrollo en las primeras propuestas (ERA-20 y WRA-20) (véase Meloy, White y Hart, 2013). Su principal objetivo es la predicción del homicidio en contexto laboral. En segundo lugar, tiene el objetivo de evaluar conductas más amplias como el acoso, conductas airadas, amenazas o *mobbing*. También se incluye en el objetivo de evaluación a estudiantes mayores de 18 años (en campus universitarios básicamente).

La WAVR-21 está compuesta por 19 factores de riesgo, un factor protector y un factor propio de la organización, tal como se muestra en la tabla 12.5. Los primeros cinco factores se consideran señales de alarma, por ser fuertes precursores de ataques. Los ítems se codifican como ausentes, presentes o prominentes, según la definición descrita para cada uno en la guía de usuario. Al igual que en otras guías de juicio estructurado, el profesional debe valorar la relevancia de los factores presentes para hacer una formulación del riesgo con el objetivo final de gestionarlo. Aunque la implicación en este tipo de violencia es superior en varones, la herramienta puede ser utilizada con mujeres (White, 2013).

Los resultados disponibles señalan una buena consistencia interjueces para el sumatorio final del nivel de riesgo (0,67), pero pobre para la opinión final (tres categorías: bajo, moderado y alto

TABLA 12.5
Factores del WAVR-21 (White y Meloy, 2010)

1. Motivos para la violencia.	12. Problemas de ira.
2. Ideas homicidas, fantasías o preocupaciones violentas.	13. Depresión y tendencias suicidas.
3. Intenciones violentas y expresión de amenazas.	14. Paranoia y otros síntomas psicóticos.
4. Habilidad en el uso y acceso a armas.	15. Abuso de sustancias.
5. Planificación y preparación previa al ataque.	16. Aislamiento.
6. Acoso o comportamiento amenazante.	17. Historia de violencia, delincuencia y conflictos.
7. Problemas de trabajo actuales.	18. Violencia de pareja o doméstica.
8. Apego extremo al trabajo.	19. Factores situacionales y organizacionales contribuyentes a la violencia.
9. Pérdida, estresantes personales y afrontamiento negativo.	20. Estabilizadores y amortiguadores de la violencia.
10. Sentimiento de derechos (narcisista) y otros rasgos negativos.	21. Impacto en la organización de las amenazas reales o percibidas.
11. Falta de conciencia e irresponsabilidad.	

o inminente) sobre el riesgo en el trabajo (0,58) y para el riesgo de daño físico grave (0,57) (Meloy et al., 2013). La WAVR-21 es la herramienta para la valoración del riesgo en contexto laboral con más desarrollo en la actualidad, e incluso cuenta con un sistema de aplicación online (<http://www.wavr21.com>). Sin embargo, a diferencia de otros tipos de violencia, es un tema aún poco investigado.

4. CRÍMENES DE HONOR

Los denominados crímenes de honor, o violencia por motivos de honor, son la forma menos común de violencia en occidente para la que se ha desarrollado una herramienta para la valoración del riesgo. Los crímenes de honor hacen referencia, generalmente, a agresiones letales a mujeres de la familia —mayoritariamente hijas de los agresores, seguidas de mujeres o exmujeres—, aunque puede incluir a varones que se considera que también han ofendido a la familia (Belfrage, Strand, Ekman y Hasselborg, 2012), motivados por una supuesta ofensa al honor (conducta percibida como inmoral por la familia o la comunidad) que debe ser restituida mediante este castigo violento.

Aunque debido a la globalización se dan casos de este tipo por todo el mundo, como patrón cultural lo ubicamos en países de Oriente Medio (por ejemplo, Irán o Siria) y el sur de Asia (por ejemplo, Pakistán o India). Algunas conductas consideradas ofensivas en estas culturas son, por ejemplo, los matrimonios o relaciones de una hija sin contar con el visto bueno de los progenitores, el rechazo a matrimonios pactados entre familias, la infidelidad, la homosexualidad (en especial masculina) e incluso en algunos casos ser víctima de una violación. Bajo esta etiqueta se incluye el homicidio, la violación, ataques con ácido, el encierro e incluso el aborto forzado, entre otras formas de agresión motivadas por el honor. También se pueden incluir bajo esta etiqueta los matrimonios forzados. La violencia con motivos de honor muchas veces se entremezcla con la violencia de pareja, pues la cuestión del «honor» puede ser utilizada contra la víctima, obligándola a permanecer en una relación violenta (Payton, 2014).

Estas agresiones están respaldadas culturalmente y forman parte de la tradición, e incluso la comunidad puede participar en el crimen (véase Roberts, Campbell y Lloyd, 2014, para la revisión de tipos, motivos y análisis de este tipo de agresio-

nes). Sin embargo, cabe señalar que no están justificadas en ninguna religión, y en muchos de los países en los que se practican son castigadas por la ley. Además, algunos de estos asesinatos se cometen con víctimas de doble nacionalidad cuando estas viajan a sus países de origen familiar.

4.1. PATRIARCH

La PATRIARCH (Kropp, Belfrage y Hart, 2013) es una herramienta diseñada exclusivamente para la valoración del riesgo de los denominados crímenes de honor. Su creación comenzó en 2005, como necesidad para valorar el riesgo de este tipo de crímenes, tras una serie de acontecimientos sucedidos en Suecia en los que las autoridades implicadas no habían valorado la situación de forma adecuada (véanse algunos de estos casos en Belfrage y Ekman, 2013).

Se trata de una guía de juicio estructurado, que sigue una estructura y funcionamiento simi-

lares a los ya mencionados en capítulos previos; de hecho, se creó a partir de herramientas como el SAM y el B-SAFER, diseñadas por el mismo equipo de autores. Puede ser aplicada tanto en hombres como en mujeres mayores de 18 años. Está compuesta por 15 factores de riesgo divididos en tres bloques (véase tabla 12.6: cinco factores sobre la naturaleza de la violencia, cinco factores del agresor y cinco factores de vulnerabilidad de la víctima). El sistema de codificación es el habitual (presente, parcialmente presente y ausente) y, al igual que otras herramientas, incluye la codificación para el presente (últimas cuatro semanas) y el pasado. También se codifica la relevancia de los factores, bien porque motiven la violencia o porque compliquen la gestión.

Los factores de la víctima se derivan de los del B-SAFER v2. Respecto al agresor, estas agresiones son planificadas y cometidas muchas veces por más de un sujeto, incluyendo, por ejemplo, a varios miembros de la familia o la comunidad. En el caso de agresores solitarios, actúan por

TABLA 12.6
Factores de riesgo de la PATRIARCH (Kropp et al., 2013)

Naturaleza de la violencia	Agresor	Vulnerabilidad de la víctima
1. Amenazas o pensamientos violentos graves (por parte de la familia/agresor).	6. Actitudes que apoyan la violencia de honor (creencias subculturales de la familia o el agresor que justifican o minimizan el control o la violencia contra la víctima).	11. Conductas o actitudes inconsistentes (contactos, mensajes ambiguos, minimización, etc.).
2. Agresiones (consumadas o intentadas, por parte de la familia o el agresor).	7. Alto grado de insultos.	12. Miedo extremo (que interfiere con la capacidad de autoprotección, impide la separación de la familia o el agresor o incluye preocupación por terceros que dependen de ella).
3. Agresiones con motivación de honor (alguien de la familia o el agresor ha cometido previamente alguna agresión con motivos de honor).	8. Originario de una zona con conocidos valores subculturales (que apoyan la violencia de honor, los matrimonios forzados, la mutilación genital, etc.).	13. Acceso inadecuado a recursos (conocimiento, habilidad o motivación para acceder a protección, pocas habilidades sociales, etc.).
4. Matrimonios o compromisos pactados (por parte de la familia o el agresor respecto a la víctima).	9. Ausencia de integración cultural (de la familia o el agresor).	14. Situación de vida insegura (trabajo, hogar, no disponibilidad de servicios de protección, etc.).
5. Escalada en la violencia.	10. Problemas psicosociales de la familia o el agresor (económicos, salud física o mental).	15. Problemas personales.

pensamientos muy irracionales y suelen tener más problemas personales (Belfrage y Ekman, 2013).

Se debe considerar la situación por la cual se está evaluando el caso (matrimonio forzado, infidelidad, pareja «inadecuada», orientación sexual «inadecuada», venganza, mutilación genital, etc.) y concluir sobre la inminencia del riesgo, el riesgo a largo plazo y el riesgo de violencia letal (Kropp et al., 2013). Uno de los factores de riesgo señalado como más relevante es la presencia de un matrimonio forzado, por ser tanto en sí mismo un tipo de violencia de honor como por ser precursor de otras agresiones (Belfrage y Ekman, 2013).

Belfrage y Ekman (2013) y Belfrage, Strand, Ekman et al. (2012) analizaron el desarrollo de la herramienta y su aplicación a lo largo de seis años en Suecia, en un total de 56 casos (la versión utilizada incluía diez factores de vulnerabilidad de la víctima, a diferencia de los cinco presentes en la versión final). La herramienta se mostró de fácil aplicación y con pocos ítems omitidos (el omitido con más frecuencia fue el 4, agresiones previas con motivación de honor). Entre los resultados se señaló que el riesgo tendía a ser mayor en los casos en los que la víctima era la hija, en especial para la violencia letal (75% de los casos en los que se valoró como alto este riesgo).

4.2. DASH

El *Domestic Abuse, Stalking and Honour based violence* —DASH— (Richards, 2009) es un listado creado en Reino Unido que incluye la violencia doméstica, el acoso y la violencia con motivos de honor. Su versión principal está compuesta por 27 preguntas: ocho referentes al problema actual (miedo, sentimiento de aislamiento, ideación suicida, separación o intento de separación del agresor, etc.); cuatro referentes a posibles hijos o personas dependientes (embarazada o habiendo dado a luz en los últimos 18 meses, hijos u otros dependientes en el hogar, daño a hijos o dependientes, amenazas a hijos o dependientes); diez referentes

a la historia de violencia doméstica (incremento en frecuencia o en gravedad, el agresor controla, vigila o es celoso, ha utilizado algún arma, ha amenazado con matar, ha intentado ahogarte, etc.); y cinco referentes al agresor (problemas económicos, problemas con las drogas, intentos de suicidio, quebrantamiento de órdenes o acuerdos y presencia de historial policial o penal).

El ítem 8 evalúa el acoso preguntando a la víctima si el supuesto agresor le escribe, llama, contacta o sigue constantemente, o si le acosa. En caso afirmativo, se presentan once cuestiones vinculadas al acoso, como el miedo de la víctima, las amenazas o las agresiones previas. La respuesta afirmativa a la pregunta 20, referente a la presencia de otras personas que le hayan amenazado o a las que tenga miedo, da lugar a diez preguntas específicas de la violencia con motivos de honor: aislamiento, miedo a viajar al extranjero, pensar que se tiene una relación no aprobada por la familia o miedo a que le obliguen a casarse sin su beneplácito, etc.

Se concluye con tres niveles de riesgo basados en el sistema OASys, desarrollado para el sistema penitenciario y correccional británico: estándar (sin probabilidad de daño), medio (factores de riesgo presentes que indican que el agresor tiene el potencial de causar daño, pero es improbable que lo haga en las circunstancias actuales) y alto (se han identificado factores de riesgo de daño grave con amenaza para la vida). Respecto a la gestión, se propone el uso del modelo denominado RARA: *remove risk* (eliminar el riesgo: p. ej., deteniendo al agresor); *avoid the risk* (evitar el riesgo: p. ej., realojando a la víctima); *reduce the risk* (reducir el riesgo con planes de seguridad para la víctima, órdenes de protección, etc.); y *accept the risk* (aceptar el riesgo con reevaluaciones e intervenciones de distintos servicios de evaluación y gestión del riesgo).

En la web www.dashriskchecklist.co.uk está disponible distinta información sobre el instrumento, e incluso hay una versión, denominada V-DASH, pensada para ser aplicada como autoevaluación de la víctima y tras la que se recomiendan servicios de ayuda a la víctima que responda de forma afirmativa a los ítems.

Pese a no tratarse de un tipo concreto, la violencia cometida por mujeres es un tema complejo del que conviene describir algunas particularidades en este manual. Como en cualquier otro ámbito, la atención prestada a esta cuestión en el contexto anglosajón es muy superior a la prestada en países de habla hispana, y los manuales específicos proliferan aportando un gran volumen de conocimiento sobre tipos de violencia, causas, tratamientos o evaluación de mujeres delincuentes (Conradi y Geffner, 2012; Chesney-Lind y Pasko, 2013; Chesney-Lind y Shelden, 2014; Freiburger y Marcum, 2016; Gannon y Cortoni, 2010; Gavin y Porter, 2015; Russell, 2013; Van Wormer, 2010).

Una de las asignaturas pendientes en el ámbito de la violencia, y en concreto en la valoración del riesgo, es la descripción de muestras distintas a las clásicamente utilizadas. La revisión de la bibliografía sobre delincuencia femenina pone de manifiesto las muchas limitaciones existentes y las complicaciones a las que se han de enfrentar los profesionales que trabajan con esta población a la hora de evaluar el riesgo o proponer un tratamiento (para profundizar en la temática, véase Loinaz, 2014a; 2016). Por ello, en este último capítulo presentaremos algunas de las indicaciones existentes en materia de evaluación del riesgo en mujeres, analizando si son aplicables las herramientas disponibles y qué resultados hay al respecto.

1. ¿SON APLICABLES EN MUJERES LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA VALORAR EL RIESGO?

Casi la totalidad de la investigación sobre evaluación del riesgo de violencia se ha desarrollado con muestras masculinas, existiendo una especial escasez de estudios sobre factores de riesgo en mujeres (Penney, Lee y Moretti, 2010). Tal es el problema que, habitualmente, surge la duda de si los métodos disponibles, bien sean herramientas actuariales o guías de juicio estructurado, son igualmente aplicables al caso de mujeres agresoras. Para responder a esta cuestión, García-Mansilla, Rosenfeld y Nicholls (2009) llevaron a cabo una revisión alcanzando las siguientes conclusiones: los resultados referentes al juicio clínico indicaban que, en general, la predicción era mala, por la tendencia de los profesionales a subestimar el potencial violento de las mujeres; respecto a las guías de juicio estructurado, los estudios eran discrepantes, aunque en conjunto la capacidad predictiva no era mucho peor en ellas; y en el caso de las herramientas actuariales, se carecía de información suficiente para sacar conclusiones.

De los estudios disponibles en el caso de la violencia juvenil, por ejemplo, se deduce que las escalas pueden ser igualmente precisas en su predicción en chicos y chicas (Coid et al., 2009; Penney et al., 2010; Schwalbe, 2008; Smith et al.,

2009). En una revisión sistemática reciente, sobre evaluación del riesgo de violencia inespecífica en mujeres (Geraghty y Woodhams, 2015), se ponía de manifiesto las limitaciones aún existentes y cómo a partir de los resultados disponibles no se podía ni recomendar ni desaconsejar la adopción de enfoques de género en la materia. Una hipótesis habitual es la existencia de factores de riesgo comunes, pero que se manifiestan de forma diferente entre sexos.

En el momento actual no existen herramientas para la evaluación del riesgo diseñadas exclusivamente a partir de la investigación con mujeres, aunque sí algunas versiones que incluyen ítems específicos para ellas, como la EARL-21G (véase capítulo 11, apartado 4) o un complemento específico de la HCR-20 para mujeres, el FAM (que describiremos en el epígrafe 2.5). Así pues, la valoración del potencial riesgo de violencia en mujeres tiende a estar fundamentada en los resultados provenientes de la investigación con hombres. Propuestas más recientes tanto para adultos como adolescentes, como la START (véanse capítulo 8, apartado 4, y capítulo 11, apartado 3) o el SAPROF (véase capítulo 8, apartado 5, y capítulo 11, apartado 5), se han creado contemplando su aplicación también en mujeres.

En los últimos años la investigación sobre riesgo en mujeres se ha incrementado significativamente. A continuación describiremos algunos de los estudios realizados en distintos tipos de violencia.

2. VIOLENCIA INESPECÍFICA Y DELINCUENCIA GENERAL

2.1. HCR-20

Un gran número de investigaciones han analizado la eficacia de la HCR-20 en mujeres. Strand y Belfrage (2001) compararon las puntuaciones en 63 mujeres y 85 hombres en psiquiátricos forenses de Suecia. Las mujeres presentaban factores de riesgo comparables a los de los hombres, aunque existían diferencias en el tipo de violencia que ejercían. Pese a no compa-

rar la capacidad predictiva entre sexos, la conclusión fue que la HCR-20 podía utilizarse con mujeres. Por otro lado, Nicholls et al. (2004) analizaron la capacidad predictiva de la herramienta en 147 hombres y 95 mujeres en contexto psiquiátrico de Canadá, encontrando que los niveles de riesgo eran inferiores en ellas, pero la capacidad predictiva similar para distintos objetivos (cualquier violencia, cualquier delito o solo delito violento). Resultados parecidos encontraron de Vogel y de Ruiter (2005), con 42 mujeres y 42 hombres en Holanda, con una eficacia semejante para la predicción por niveles de riesgo (bajo, medio y alto) pero peor en mujeres para la puntuación total.

Con datos provenientes del estudio MacArthur (véase capítulo 2, apartado 1) (García-Mansilla et al., 2011), compararon la validez predictiva en 827 pacientes psiquiátricos de EEUU, de los cuales 350 eran mujeres. Los resultados indicaron que la herramienta era algo mejor para predecir la violencia futura en hombres, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Ningún dato demostró que la herramienta no pudiera ser utilizada en la evaluación de mujeres o que debiera ser adaptada a estas, aunque sí variaba la frecuencia con la que están presentes los distintos factores de riesgo. Sin embargo, en un trabajo en Alemania se señaló la poca utilidad predictiva de la HCR-20 (posiblemente debido a la baja reincidencia en delito violento) frente a una capacidad moderada de la VRAG (Eisenbarth, Osterheider, Nedopil y Stadtland, 2012).

Un análisis retrospectivo reciente, de incidentes violentos en 100 hombres y 24 mujeres imputables institucionalizados, analizaba la utilidad de la última versión de la herramienta, la HCR-20V3 (Green et al., 2016). En el seguimiento medio de 15 meses, el 42 % de los hombres y el 54 % de las mujeres actuaron de forma violenta. El estudio encontró mayor coincidencia entre profesionales (fiabilidad interjueces) en la valoración de los varones. A nivel numérico, hombres y mujeres tenían un número similar de factores de riesgo, pero la relación entre la puntuación y la violencia era mayor en los hombres.

2.2. LSI-R

El LSI-R ha sido ampliamente utilizado en mujeres delincuentes. La revisión de 20 años de su aplicación sugirió que la herramienta funciona con mujeres con estilos delictivos de «tipo masculino» (en concreto los perfiles de mayor reincidencia), pero no con aquellas que siguen «rutas femeninas», proponiéndose la incorporación de variables con perspectiva de género (Holtfreter y Cupp, 2007). Por su parte, el metaanálisis de Smith et al. (2009), con una muestra acumulada de 14.737 mujeres, concluyó que la herramienta tiene una capacidad predictiva de la reincidencia similar entre sexos. En conjunto, los estudios avalan la utilidad en mujeres, aunque señalan diferencias respecto a los factores más predictores (Davidson, 2009; Manchak et al., 2009). Además, aunque el nivel de riesgo medido con la puntuación total puede ser similar entre hombres y mujeres en contexto penitenciario, se dan diferencias en las áreas de necesidad criminógena, donde ellos destacan en el historial delictivo y ellas en problemas familiares, problemas interpersonales y emocionales (Palmer y Hollin, 2007). Andrews et al. (2012) concluyeron que, a grandes rasgos, la influencia de los factores de riesgo sobre la reincidencia es similar en ambos sexos, existiendo una especificidad de género mínima. En general, y tras 30 años de estudios con la gama de herramientas de los autores del LSI (como el YLS/CMI que abordaremos a continuación), se puede concluir que no existen diferencias de género en la capacidad predictiva de los factores que las componen (Olver et al., 2014).

2.3. YLS/CMI

La herramienta ha sido utilizada en distintas muestras con resultados inconsistentes. Bechtel, Lowenkamp y Latessa (2007) hicieron un seguimiento medio de 3,4 años a 598 chicas y 3.884 chicos de EEUU (comparando también cuestiones raciales). En conjunto, los resultados mostraron una relación no significativa entre la puntuación

de la herramienta y la reincidencia en mujeres. Con un objetivo similar, Onifade, Davidson y Campbell (2009) evaluaron a 274 chicas y 694 chicos. La media en ellas fue de 12,1 puntos y la de ellos de 10,6. Entre los etiquetados como de riesgo alto, el 8 % de ellas reincidió frente al 16 % de ellos. En el seguimiento de dos años, los reincidentes puntuaron más que los no reincidentes en todos los grupos. La clasificación fue correcta en el 75 % de las mujeres blancas y en el 69 % de las afroamericanas. Vitopoulos, Peterson-Badali y Skilling (2012) también confirmaron una mayor puntuación en ellas que en ellos (16,3 vs. 14), mientras que no se daban casi diferencias respecto a las recomendaciones de intervención por parte de los profesionales. En otro seguimiento, durante 7 años de media, a 93 chicos y 74 chicas canadienses (con análisis de la reincidencia incluso en la edad adulta) tampoco se encontraron diferencias significativas en la capacidad predictiva de la herramienta (Olver, Stockdale y Wong, 2012). Recientemente, con una muestra de 453 chicas y 1.267 chicos delincuentes en EEUU, se ha confirmado que, pese a puntuar ellas significativamente más que ellos (16,61 vs. 15,37), en el seguimiento de dos años reincidían significativamente menos (37,3 % vs. 50 %) (Anderson et al., 2016). Por ello, la capacidad predictiva de la herramienta resultó peor en ellas (AUC = 0,565 vs. 0,623).

2.4. VRAG

La VRAG también se ha utilizado en mujeres, con resultados dispares. Sus propios autores, en un seguimiento de 8 años a 59 mujeres, no encontraron diferencias en puntuaciones entre las reincidentes y las no reincidentes (Harris et al., 2002). Posteriormente, con una versión modificada para utilizarla en hombres y mujeres del estudio MacArthur, encontraron una buena capacidad predictiva de la violencia grave tras el alta hospitalaria sin diferencias entre sexos (Harris et al., 2004). Con una muestra alemana de 80 mujeres delincuentes, a las que se hizo un seguimiento

medio de 8 años, Eisenbarth et al. (2012) compararon la capacidad predictiva de la PCL-R, la HCR-20 y la VRAG. Un 31% de las mujeres reincidió, pero solo un 5 % ($n = 4$) lo hizo en delitos violentos. La VRAG obtuvo la mejor capacidad predictiva de la reincidencia general ($AUC = 0,72$), seguida de la PLC-R ($AUC = 0,60$). La predicción de la HCR-20 no fue significativa ($AUC = 0,59$), pero hay que señalar que no se analizó la predicción de la reincidencia violenta, posiblemente por la baja prevalencia de esta. Coid et al. (2009) compararon el funcionamiento de distintas herramientas en una muestra penitenciaria de 304 mujeres y 1.353 hombres en Inglaterra y Gales, con una reincidencia del 8,2 % y del 13,3 % respectivamente en un seguimiento medio de 2 años. Las mujeres puntuaron significativamente menos que los hombres en la VRAG y su capacidad predictiva fue mejor en ellos ($AUC = 0,70$ vs. $0,65$). La conclusión fue que herramientas actuariales y de juicio profesional (como la HCR-20) producían resultados similares, pero funcionaban algo mejor en hombres. En muestra penitenciaria, Hastings, Krishnan, Tangney y Stuewig (2011) encontraron una puntuación significativamente mayor en hombres (8,5 vs. 4,8). En ellas, la escala no correlacionó con el mal comportamiento institucional, y en el seguimiento de un año con autoinforme de conductas a 83 mujeres y 207 hombres la capacidad predictiva también fue significativamente peor en ellas.

2.5. SAVRY

El SAVRY está diseñado para su uso en adolescentes de ambos sexos entre 12 y 18 años. Pese a ello, la predominancia de muestras masculinas, incluso en las fuentes de las que surge la herramienta, ha promovido la comparación de su eficacia entre sexos. Gammelgård et al. (2008) compararon 120 chicos y 88 chicas en contexto psiquiátrico general y forense en Finlandia. Las chicas puntuaron significativamente menos que los chicos, y el 24 % de ellas frente al 32 % de ellos fueron clasificados como de riesgo alto. En

el seguimiento a 6 meses, la predicción fue igualmente buena en ambos sexos ($AUC = 0,71$ en ellos y $0,72$ en ellas). En el mismo contexto, Gammelgård, Weizmann-Henelius, Koivisto, Eronen y Kaltiala-Heino (2011) analizaron 135 chicos y 96 chicas. En este caso, el 25 % de ellas frente al 35 % de ellos fueron clasificados como de riesgo alto, y el 22 % de ellas y el 24 % de ellos se implicaron en conductas violentas. La relación entre el nivel de riesgo y la conducta violenta fue mayor en ellas, aunque sin diferencias significativas. Penney et al. (2010) compararon 80 chicos y 64 chicas, concluyendo que, en conjunto, la herramienta era igualmente útil en ambos, con una capacidad predictiva de las distintas correcciones comparable entre sexos ($AUC = 0,59-0,75$ en ellos vs. $0,56-0,72$ en ellas para la violencia).

Meyers y Schmidt (2008) también confirmaron una utilidad comparable en delincuentes juveniles de ambos sexos (80 chicos y 41 chicas), en un seguimiento de 1 y 3 años. La reincidencia violenta en los casos etiquetados como riesgo elevado era muy superior a la de los niveles medio y bajo en ambos casos, en especial en el seguimiento a 3 años (reincidencia del 60 % en ellas y del 57 % en ellos en este nivel de riesgo). La capacidad predictiva de la reincidencia violenta fue igualmente alta ($AUC = 0,78$ en ellos y $0,80$ en ellas) en el seguimiento a 3 años, e igualmente moderada para la reincidencia al año ($AUC = 0,66$ en ellos y $0,68$ en ellas). Lodewijks, de Ruiter y Doreleijers (2008) compararon las diferencias en la predicción de la reincidencia en un seguimiento de 18 meses tras el tratamiento a 35 chicas y 47 chicos delincuentes. En este caso, la predicción también fue algo mejor para las chicas ($AUC = 0,85$ vs. $0,82$), aunque en ellas se daban más falsos positivos. También se ha descrito un peor funcionamiento en ellas. Por ejemplo, Schmidt et al. (2011), en un seguimiento de 10 años (incluida la edad adulta) en el que compararon el funcionamiento del YLS/CMI, la PCL:YV y el SAVRY, concluyeron que la predicción de la reincidencia violenta de las tres herramientas era peor en ellas. En el caso concreto del SAVRY, el AUC en ellas fue de $0,57$, mientras que en ellos fue de $0,78$.

2.6. FAM

En el ámbito de la evaluación del riesgo en mujeres merece especial atención el FAM —*Female Additional Manual*— (de Vogel, de Vries-Robbé et al., 2012), un complemento de la HCR-20 diseñado específicamente para su uso en mujeres, así como las investigaciones en la materia de su equipo desarrollador (véase de Vogel y de Vries-Robbé, 2013). El FAM es un manual con una serie de pautas de aplicación e ítems adicionales a la HCR-20 (versiones 2 y 3) derivadas de la investigación aplicada en mujeres en psiquiátricos forenses de Holanda.

Debido a la similitud en factores de riesgo entre hombres y mujeres no se desarrolló una herramienta nueva, sino que se incorporaron nuevas consideraciones o factores complementarios a la herramienta original, tal como se muestra en la tabla 13.1. Los complementos incluyen cinco instrucciones adicionales para ítems históricos de la HCR-20 y nueve factores de riesgo específicos

para mujeres (cinco históricos, dos clínicos y dos de gestión). La valoración final incluye el riesgo de violencia hacia otros, hacia uno mismo, el riesgo de victimización y el riesgo de conducta delictiva no violenta. La capacidad predictiva del FAM es especialmente buena para la violencia intrainstitucional durante el tratamiento, y en particular con conductas autodestructivas. La herramienta puede descargarse de forma gratuita en su versión en inglés desde <http://www.violencebywomen.com>.

En un trabajo reciente, de Vogel, Stam, Bouman, Ter Horst y Lancel (2016) demostraban las diferencias existentes entre 275 mujeres y 275 hombres provenientes de contexto psiquiátrico forense. En concreto, se resaltó una mayor prevalencia de victimización en ellas, más psicopatología, más fallos en intervenciones y mayor propensión a agredir a conocidos (incluyendo a compañeros de institución). En consecuencia, se demostraron diferencias en el tipo de violencia cometido por mujeres, así como en sus variables personales, y una mayor puntuación en los factores específicos del FAM.

TABLA 13.1

Ítems o pautas adicionales a la HCR-20 presentes en el FAM (de Vogel et al., 2012)

Ítems históricos (Historia de problemas con...)	
H7	Trastorno de la personalidad: <i>pautas adicionales a la HCR-20^{V3}</i> .
	a) Antisocial o psicopático (menor punto de corte en la PCL-R para mujeres). b) Otro trastorno de la personalidad: 1. Clúster B (excepto antisocial/psicopático) o rasgos de suspicacia. 2. Otro trastorno de la personalidad.
H8	Experiencias traumáticas: <i>pautas adicionales a la HCR-20^{V3}</i> .
	a) Victimización/trauma. 1. Durante la infancia. 2. Tras la infancia. b) Pobre crianza/cuidado.
H11	Prostitución.
H12	Dificultades en la crianza.
H13	Embarazo a temprana edad.
H14	Tendencias suicidas/autolesión.

TABLA 13.1. (continuación)

Ítems clínicos (problemas recientes con...)	
C6	Conducta encubierta/manipuladora.
C7	Baja autoestima.
Ítems de gestión del riesgo (problemas futuros con...)	
R6	Problemas de responsabilidad en el cuidado de niños.
R7	Relaciones de pareja problemáticas.

3. VIOLENCIA DE PAREJA

Pese a la gran controversia existente respecto a cuestiones como la defensa propia o la bidireccionalidad (véase Loinaz, 2014a), distintos estudios han analizado la media en que los factores de riesgo descritos habitualmente en agresores de pareja son igualmente representativos de las agresoras. Respecto a las motivaciones para agredir, la conclusión general es que las motivaciones en ambos sexos son similares (Langhinrichsen-Rohling, McCullars y Misra, 2012; Shorey, Meltzer y Cornelius, 2010). Bair-Merritt et al. (2010) revisaron 23 estudios, concluyendo que los sentimientos de ira relacionados con la búsqueda de la atención de la pareja, así como la autodefensa y la venganza, son los principales argumentos esgrimidos por ellas. Respecto a factores de riesgo, los rasgos de personalidad límite (Hughes, Stuart, Gordon y Moore, 2007) o el consumo de drogas (Busch y Rosenberg, 2004) también son compartidos por hombres y mujeres agresores de pareja. Además, factores como la dominancia o los celos, el ajuste marital y los síntomas depresivos son predictores de la violencia en ambos sexos (O’Leary, Smith Slep y O’Leary, 2007). Por ello, la principal teoría y justificación para el uso de las herramientas disponibles es que los factores de riesgo y los motivos para agredir son comunes y, por tanto, agresores y agresoras pueden ser evaluados del mismo modo.

En el caso de la VCP, se han publicado trabajos tanto con guías de juicio estructurado (B-SAFER y SARA) como con herramientas actuales (ODARA y DA).

3.1. B-SAFER

Storey y Strand (2013) analizaron el riesgo de violencia de pareja en una muestra de 52 mujeres de Suecia utilizando la segunda versión del B-SAFER, y encontraron menor presencia de factores de riesgo en mujeres detenidas, comparando una muestra anterior de varones (Belfrage y Strand, 2008), indicativo de un menor riesgo en ellas, de un sesgo en la evaluación de los profesionales o de la necesidad de factores distintos para evaluar mujeres. De hecho, los niveles de riesgo finales eran similares a los de varones con más factores, sugiriendo la posible consideración por parte de los policías de factores distintos a los presentes en la herramienta. Las mismas autoras ya habían encontrado que el riesgo estimado tiende a ser bajo, bien por la percepción policial en casos de víctimas masculinas o porque las herramientas diseñadas para evaluar hombres hacen que se pasen por alto factores de riesgo relevantes en mujeres (Storey y Strand, 2012). La conclusión de ambos trabajos es que es necesario incorporar nuevos ítems para mujeres, pues con herramientas diseñadas para evaluar hombres se pueden pasar por alto factores de riesgo relevantes en ellas.

3.2. SARA

Stewart, Gabora, Allegri y Slavin-Stewart (2014) analizaron 58 agresoras de pareja del sistema correccional canadiense. Entre los resultados encontraron que el 6,9 % de ellas podían ser etiquetadas como de riesgo alto, el 29,3 % de riesgo medio y el 63,8 % de riesgo bajo. Estos porcentajes diferían de los provenientes de varones del mismo contexto, clasificados el 14,3 % como de riesgo alto, el 39,9 % de riesgo medio y el 31,6 % de riesgo bajo. Los autores señalaban que algunos ítems contribuían poco a la violencia en ellas, como las distorsiones o actitudes, mientras que otros, como la victimización, estaban sobrerrepresentados. Por otro lado, se ha señalado que algunas mujeres muestran un elevado riesgo de violencia medido con la SARA, resultados que sugerirían que hombres y mujeres agresoras no son tan diferentes respecto a sus factores de riesgo y que la herramienta puede ser igualmente útil en ellas (Simmons et al., 2008; Simmons et al., 2009). En cualquier caso, ninguno de los trabajos encontrados ha abordado la validez predictiva del instrumento en ellas.

3.3. ODARA

Solo se ha encontrado un artículo en el que se aplique la ODARA en muestra femenina. Los autores de la herramienta utilizaron la versión original, junto a algunas modificaciones específicas para mujeres, en un seguimiento medio de 9 años a 30 presas por violencia de pareja (Hilton et al., 2014). Un 23 % de ellas reincidió y se obtuvo una puntuación media en la ODARA de 5,71. Encontraron que la puntuación correlacionaba positivamente con la reincidencia (con un $AUC = 0,724$), aunque no de forma significativa, y que la capacidad predictiva de los ítems originales y de modificaciones para mujeres presentaban una capacidad similar. Aunque la reincidencia del 23 % era inferior a la esperada conforme a las normas de corrección propuestas para muestras masculinas, los resultados sugieren que

la herramienta podría ser útil y que no es necesaria una específica para mujeres.

3.4. DA

Glass et al. (2008) adaptaron la herramienta y la aplicaron a una muestra de mujeres víctimas en relaciones homosexuales, manteniendo 8 de los 20 ítems originales e incluyendo 10 nuevos (lo que modifica sustancialmente la herramienta). Los nuevos ítems predijeron la violencia en un seguimiento de un mes, identificándolos como factores propios de la violencia femenina. La modificación de la herramienta impide comparar los resultados entre su versión original y la versión para mujeres.

4. VIOLENCIA SEXUAL

La cifra de delincuentes sexuales femeninas es muy baja y su reincidencia oficial inferior al 3 % (Cortoni, Hanson y Coache, 2010), lo cual dificulta de manera casi insuperable la predicción de la violencia. Asimismo, las limitaciones de las muestras dificultan la constatación de factores de riesgo relevantes (Vess, 2011). Precisamente las incertidumbres sobre la etiología y los factores de riesgo precipitantes de la agresión sexual femenina han dificultado la creación de herramientas específicas y la propuesta de programas de tratamiento (Duncan, 2010). Las herramientas desarrolladas para agresores sexuales masculinos no han sido validadas en muestras femeninas (Gavin y Porter, 2015) y, pese a ello, tienden a utilizarse, algo considerado inapropiado, por partir de tasas de reincidencia masculinas que sobreestiman el riesgo en ellas (en el caso de herramientas actuariales, como la Static-99) y por incluir ítems seleccionados por su interés en muestras masculinas (Cortoni, 2010). Miller, Turner y Henderson (2009), por ejemplo, utilizaron la Static-99 en mujeres, concluyendo que pueden presentar un riesgo de reincidencia parecido al de los hombres (puntuación media inferior en un punto), aunque no se pueda afirmar que prediga la reincidencia en ellas.

Como alternativas de evaluación se ha sugerido el uso del RSVP para mujeres adultas, por la inclusión de factores de riesgo de interés, como las experiencias de victimización en la infancia, problemas en relaciones, activación sexual relacionada con menores o problemas de estrés y afrontamiento, y el ERASOR para agresoras adolescentes (Logan, 2008). Pese a estas sugerencias, se carece de estudios sobre su aplicación.

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA VALORAR EL RIESGO DE VIOLENCIA EN MUJERES

Hemos visto cómo algunas herramientas, pese a ser diseñadas a partir de muestras masculinas, han sido puestas a prueba en mujeres o recomendadas para su uso en ellas. Sin embargo, una constante en algunos estudios es la poca prevalencia de mujeres agresoras, o su eliminación de los estudios, por no cumplir con los criterios deseados. En ocasiones, durante el desarrollo de la herramienta las muestras femeninas son consideradas escasas o son descartadas por posibles inconvenientes. Por ejemplo, en el desarrollo del B-SAFER en Suecia, del total de 651 casos analizados por la policía el 11 % (54) fueron mujeres (Belfrage, 2008). Sin embargo, se optó por eliminarlas al considerar que existían incertidumbres sobre su verdadero papel de agresoras (una hipótesis era que los agresores cruzaban denuncias falsas). En sucesivos estudios, las mujeres fueron eliminadas por el mismo motivo (Belfrage y Strand, 2008) o por ser un porcentaje muy pequeño (1 %) (Belfrage y Strand, 2012; Strand, 2012). Estas limitaciones en los estudios son uno de los problemas a los que se debe hacer frente y que afectan directamente a la práctica diaria de profesionales, como los policías (Storey y Strand, 2012), que pueden tener dudas sobre cómo atender aquellos casos que se salen del estereotipo hombre-agresor/mujer-víctima.

Pese a los resultados generalmente positivos, la necesidad de tener cautela está aún vigente, pues los autores recuerdan que la predicción del

principal objetivo, la violencia física, suele ser peor para las mujeres (Nicholls et al., 2004). La fiabilidad de las medidas puede verse afectada por la menor probabilidad de detectar la violencia ejercida por ellas, especialmente cuando el estudio toma como fuente estadísticas oficiales (García-Mansilla et al., 2009), pues se afirma que la cifra negra de violencia en las mujeres es mayor (agresiones que no son detectadas oficialmente). Igualmente, las bajas tasas base de reincidencia afectan a los resultados sobre la capacidad predictiva de las escalas (Coid et al., 2009) y, por ello, a la aparente utilidad. Una cuestión no analizada, hasta la fecha, es la utilidad preventiva de estas evaluaciones (con la gestión del riesgo o adecuación de los tratamientos).

Respecto a los evaluadores, se afirma que presentan muchas limitaciones a la hora de valorar el riesgo de violencia en mujeres. La estimación del riesgo suele ser mala, principalmente porque se subestima el riesgo real, tanto de agresiones leves como de graves, al influir aspectos como la menor prevalencia de violencia femenina en la sociedad y una menor visibilidad de la violencia femenina al ocurrir mayoritariamente en el ámbito familiar (Skeem et al., 2005). Sin embargo, en contextos psiquiátricos, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres en prevalencia de conductas violentas son prácticamente inexistentes (Robbins, Monahan y Silver, 2003).

Recordemos que el juicio profesional estructurado permite incorporar en la valoración del riesgo factores que no estén presentes en las herramientas, pero que el profesional considere relevantes a la hora de formular el riesgo y hacer una propuesta de gestión. Por tanto, pese a que muchas herramientas no se han creado con o para muestras femeninas, los resultados positivos derivados de su aplicación, junto a la posibilidad de adaptar la evaluación a las variables específicas de cada caso, hace que en la práctica sea posible su utilización en mujeres y sea preferible su elección frente a herramientas actuariales. Cuando los resultados sobre capacidad predictiva son malos, la explicación no solo puede estar en la utilidad de la herramienta, sino también en la

reincidencia en la muestra analizada. Las cifras oficiales de reincidencia femenina señalan valores muy bajos, lo cual afecta directamente a los resultados de predicción. Junto a estas indicaciones, resulta necesario seguir de cerca la investigación en la que se aplica este tipo de herramientas en mujeres para conocer no solo su funcionamiento desde el punto de vista predictivo, sino la prevalencia de las variables, las dificultades en la codificación de los factores y posibles diferencias cualitativas.

Aunque diversos estudios no encuentran diferencias significativas en la capacidad predictiva de las herramientas de juicio clínico estructurado

(Coid et al., 2009; Garcia-Mansilla et al., 2009), algunos autores mantienen la necesidad de adaptar los protocolos (de Vogel y de Vries-Robbé, 2013; Emeka y Sorensen, 2009) y proponen herramientas específicas o complementos a las ya disponibles, como el *Women's Risk/Needs Assessment* (WRNA; Van Voorhis, Wright, Salisbury y Bauman, 2010) o el FAM (de Vogel, de Vries-Robbé et al., 2012; de Vogel, de Vries-Robbé, van Kalmthout y Place, 2014). La comparación de valoraciones del riesgo con perspectiva de género y valoraciones con herramientas estándar permitirá conocer mejor la adecuación de cada postura en los próximos años.

ANEXO

Apartados del informe pericial sobre riesgo de violencia

[elaborado a partir de las propuestas de Cook et al. (2014) y Hart y Logan (2011)]

Antes de comenzar, recordamos al lector que a continuación se presenta un listado simplificado de aquellos apartados que se consideran de interés en la elaboración de un informe pericial sobre evaluación del riesgo de violencia. El texto no corresponde a un informe en el que simplemente haya que incluir la información del caso, y tampoco implica que el profesional no pueda incorporar aquellas secciones que considere oportunas, así como modificar el orden o la estructura.

PRESENTACIÓN

Generalidades introductorias del informe

Motivo y objetivo del informe:

- Señalar petición realizada, por quién, etc.
- Objetivo del informe o pericial. Por ejemplo: «El objeto del informe era el de examinar a [nombre del/de la evaluado/a] para valorar [Señalar objetivo: peligrosidad, recomendación de tratamiento, etc.].

METODOLOGÍA

Metodología de la evaluación

- Procedimiento y evaluadores participantes (cualificación y experiencia en la materia de los peritos).

- Fuentes de información consultadas: entrevistas realizadas, información psicométrica, etc. Riqueza, variedad, fiabilidad, etc.
- Herramienta/s utilizada/s para la valoración del riesgo y otras adicionales: motivo de elección, pertinencia, indicadores de validez o fiabilidad, utilización en casos como el evaluado, etc.
- Respecto a la herramienta para la valoración del riesgo, se deberá señalar de qué tipo es (actuarial o de juicio estructurado), la utilización de puntos de referencia, el tipo de resultados que ofrece (probabilidades, centiles, categorías, tipos de violencia valorados, etc.).
- Procedimiento de aplicación de la evaluación y, en caso de ser posible, indicadores sobre la fiabilidad interjueces en la valoración de factores y/o en el resultado.

SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO

Resultados sobre el riesgo

El análisis del caso con [herramienta] pone de manifiesto la presencia de [número o expresión referente a los factores de riesgo: diversos, varios, numerosos, pocos, etc.] factores de riesgo, y cuántos [cuáles o todos] son relevantes para la conducta problemática del caso [se puede especificar el tipo concreto de violencia] y tienen implicaciones para la gestión del riesgo.

La presencia de dichos factores se fundamenta en [alusión a las fuentes de información que justifican la presencia de los factores].

A continuación se describen en detalle las áreas implicadas [estas pueden variar según la herramienta utilizada]:

- *Respecto a la historia de violencia:* se describe tanto la presencia como las características de la violencia previa cometida por el agresor; por ejemplo, si ha usado un tipo de violencia específico, grave, etc., si ha habido reiteración, escalada, etc.
- *Respecto al funcionamiento psicológico:* aquí se describirán los factores de riesgo relevantes pertenecientes a la esfera psicológica del caso: distorsiones, actitudes, trastornos, control de los impulsos, etc.
- *Respecto al ajuste social:* se describirán aquellos factores relacionados con la esfera social que supongan un problema en el caso: tipo de relaciones, problemas concretos en función de la herramienta empleada o tipo de violencia evaluada. Incluye aislamiento o aspectos que faciliten la reincidencia.
- *Respecto a su tratabilidad o funcionamiento en intervenciones previas:* este apartado se abordará en caso de que la herramienta evalúe esta faceta del sujeto y cuando sea aplicable al caso; por ejemplo, su adherencia a intervenciones previas, planes de futuro, etc. De aquí podremos hacer deducciones de cara a posibles recomendaciones de tratamiento.

FORMULACIÓN

Basándonos en estos resultados, podemos hacer la siguiente formulación del riesgo de [tipo de violencia] en [nombre del caso].

Los factores de riesgo pueden ser agrupados en [grandes causas primarias que reflejan las principales áreas problemáticas del sujeto: estrés, hábitos delictivos, parafilia, disputas legales con

la pareja, etc.], siendo el de mayor relevancia [señalar el principal gran factor que explica la violencia del sujeto].

Se ha podido identificar como **motivador/es** de la [tipo de violencia] la/s siguiente/s variable/s [indicar variable/s: celos, dinero, control, expresión de ira, etc.]. Este apartado nos permitirá explicar la función que cumple la violencia. En caso de no haber sido posible, se señalará que «no se ha podido identificar ningún factor motivador de la violencia».

Además, [indicar variable/s] tiene/n un **efecto desinhibidor** [añadir cualquier explicación relevante sobre el modo en que desinhibe/n al sujeto] y [indicar variable/s] tiene/n un **efecto desestabilizador** [añadir cualquier explicación relevante sobre el proceso de desestabilización].

- En esta sección se pueden incluir aspectos como el alcohol, el estrés, la presión social, el impulso sexual desviado, etc.
- Se pueden identificar los factores predisponentes, precipitantes, perpetuadores o protectores.
- En caso de existir un modelo teórico se podrá señalar la congruencia con nuestra formulación.

ESCENARIOS

Atendiendo a los factores de riesgo evaluados y al análisis de la trayectoria delictiva de [Caso], se pueden plantear las siguientes hipótesis de futuro o escenarios.

En un escenario favorable

- El sujeto puede... [describir el tipo de conducta o situación posible].
- Gravedad de la violencia estimada.
- Inminencia de la violencia o del escenario estimado.
- Frecuencia o duración del escenario o tipo de violencia.
- Probabilidad de ocurrencia del escenario o situación.

En un escenario desfavorable

[Señalar los mismos aspectos que en el escenario anterior]:

- Se pueden señalar entre 2 y 5 escenarios.
- Todos han de ser plausibles y resultar de utilidad para el análisis del caso.
- De los escenarios se derivarán las medidas de gestión.

GESTIÓN

Dada la valoración anterior, la presencia de los factores de riesgo señalados, su conexión en la formulación del riesgo y los posibles escenarios en los que el sujeto podrá actuar de forma violenta en un futuro cercano, se proponen las siguientes medidas, ajustadas al nivel de riesgo y destinadas a reducir la posibilidad de ocurrencia de la violencia o minimizar sus consecuencias en caso de ocurrencia.

[Seleccionar las que sean pertinentes]:

- Se recomienda monitorizar [revisiones, llamadas, reuniones] para detectar las señales de empeoramiento del caso.
- Podría beneficiarse de [intervención/tratamiento] para modificar [factores o situaciones de riesgo señaladas previamente].
- Es necesario establecer [posible medida de control para el evaluado o la víctima] para evitar que la situación de riesgo proyectada (escenario) ocurra.
- La víctima (en caso de ser un tipo de violencia dirigida en el que tengamos identificada a la víctima) se podría beneficiar de los siguientes planes de seguridad [formación, habilidades, planes de respuesta o autoprotección, servicios de ayuda, modificaciones espaciales del entorno laboral o vivienda, modificación de rutinas, etc.].

CONCLUSIÓN

Tras la evaluación de caso y la aplicación de [herramienta/s] se considera que [caso] presenta un **riesgo de violencia** [tipo] bajo/moderado/alto/etc. [según las opciones que ofrezca la herramienta], que requiere un **nivel de intervención** [rutinario/medio/urgente].

La probabilidad de que el sujeto **escale en su violencia** o de que la violencia pueda suponer un **riesgo grave para la víctima** es bajo/moderado/alto.

Esta opinión está fundamentada en la información disponible, la experiencia del evaluador y la mejor metodología disponible en la actualidad. Algunas circunstancias [eventos, variables] podrían modificar esta conclusión, por lo que se recomienda una reevaluación del caso en [más o menos tiempo en función del riesgo estimado y la situación del caso].

Señalar si:

- Las conclusiones están limitadas por... (ausencia de información, poca fiabilidad de alguna fuente, datos limitados sobre casos como el evaluado, etc.).
- La evaluación nos ha permitido detectar otros riesgos distintos al solicitado (otro tipo de violencia, otro tipo de víctima, etc.). Se puede recomendar la evaluación de este riesgo.
- El resumen final puede manifestarse con un titular siguiendo la regla de las «5W»: *who* (sujeto de la evaluación), *what* (qué entendemos por reincidencia, la probabilidad de ocurrencia de qué en concreto: por ejemplo, violencia física), *where* (en qué contexto, como en la pareja), *when* (período de tiempo: en las herramientas es el seguimiento realizado a la muestra de referencia) y *why* (información a partir de la cual se hace la valoración). A esto añadiremos la propuesta de gestión.

Referencias bibliográficas

- Aadland, R. L. y Schag, D. S. (1984). The assessment of continued threat to the community in a mentally ill offender program. *Journal of Criminal Justice*, 12 (1), 81-86. doi: 10.1016/0047-2352(84)90008-4.
- Aedo, S., Pavlov, S. y Clavero, F. (2010). Riesgo relativo y Odds ratio. ¿Qué son y cómo se interpretan? *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 5(1), 51-54.
- Ægisdóttir, S., White, M. J., Spengler, P. M., Maugherman, A. S., Anderson, L. A., Cook, R. S., ... y Rush, J. D. (2006). The meta-analysis of clinical judgment project: Fifty-six years of accumulated research on clinical versus statistical prediction. *The Counseling Psychologist*, 34(3), 341-382. doi: 10.1177/0011000005285875.
- Allen, R. M. (1942). A review of parole prediction literature. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 32(5), 548-554.
- Allnutt, S. H., Ogloff, J. R. P., Adams, J., O'Driscoll, C., Daffern, M., Carroll, A., ... y Chaplow, D. (2013). Managing aggression and violence: The clinician's role in contemporary mental health care. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 47(8), 728-726. doi: 10.1177/0004867413484368.
- Álvarez, M., Andrés-Pueyo, A., Augé, M., Choy, A., Fernández-Rodríguez, R., Fernández-Velasco, C., ... y Serratusell, L. (2011). *Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja (RVD-Bcn)*. Barcelona, España: Circuito Barcelona Contra la Violencia hacia las Mujeres.
- American Psychiatric Association (1982). Barefoot v. Estelle, Director, Texas Department of Corrections, U.S. Supreme Court, N°. 82-6080. Prediction of long-term dangerousness in capital punishment cases in Texas. Recuperado el 27/11/2013 de http://www.psychiatry.org/File%20Library/Learn/Archives/amicus_1982_barefoot.pdf.
- American Psychiatric Association (1983). Brief for the American Psychiatric Association as amicus curiae in Support of Petitioner. En Barefoot vs. Estelle, N.º 82-6080, 463 U.S. 880 (1983). Recuperado el 27/11/2013 de www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/amicus/82-6080.pdf.
- Amor, P. J., Echeburúa, E. y Loinaz, I. (2009). ¿Se puede establecer una clasificación tipológica de los hombres violentos contra su pareja? *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 9(3), 519-539.
- Anderson, D. y Hanson, R. K. (2010). Static-99: An actuarial tool to assess risk of sexual and violent recidivism among sexual offenders. En R. K. Otto y K. S. Douglas (eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 251-267). Nueva York, NY: Routledge.
- Anderson, V. R., Davidson, W. S., Barnes, A. R., Campbell, C. A., Petersen, J. L. y Onifade, E. (2016). The differential predictive validity of the Youth Level of Service/Case Management Inventory: the role of gender. *Psychology, Crime & Law*, 22(7), 666-677. doi: 10.1080/1068316X.2016.1174861.
- Andrés-Pueyo, A. (2009). La predicción de la violencia contra la pareja. En E. Echeburúa, J. Fernández-Montalvo y P. de Corral (eds.), *Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. Instrumentos de evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección* (pp. 21-55). Valencia, España: Centro Reina Sofía.
- Andrés-Pueyo, A. (2013). Peligrosidad criminal: análisis crítico de un concepto polisémico. En E. Demetrio y M. Maroto (eds.), *Neurociencias y derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la*

- culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad (pp. 483-504). Buenos Aires, Argentina: Edisofer.
- Andrés-Pueyo, A. y Arbach, K. (2014). Peligrosidad y valoración del riesgo de violencia en contextos forenses. En E. García-López (Ed.), *Manual de Psicopatología Forense: Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia* (pp. 505-525). México, DF: Manual Moderno.
- Andrés-Pueyo, A. y Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: Instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. *Psicothema*, 22(3), 403-409.
- Andrés-Pueyo, A. y Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. *Papeles del Psicólogo*, 28(3), 157-173.
- Andrés-Pueyo, A., López, S. y Álvarez, E. (2008). Valoración del riesgo de violencia contra la pareja por medio de la SARA. *Papeles del Psicólogo*, 29, 107-122.
- Andreu, J. M., Peña, M. E. y Graña, J. L. (2002). Adaptación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Agresión. *Psicothema*, 14(2), 476-482.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (1995). *The Level of Service Inventory-Revised*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2000). *The Level of Service-Inventory-Revised*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct* (5.^a ed.). New Providence, NJ: LexisNexis.
- Andrews, D. A., Bonta, J. y Wormith, J. S. (2006). The recent past and near future of risk and/or need assessment. *Crime & Delinquency*, 52(1), 7-27. doi: 10.1177/0011128705281756.
- Andrews, D. A., Bonta, J. y Wormith, J. S. (2010). The Level of Service (LS) assessment of adults and older adolescents. En R. K. Otto y K. S. Douglas (eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 199-225). Nueva York, NY: Routledge.
- Andrews, D. A., Bonta, J. y Wormith, J. S. (2011). The Risk-Need-Responsivity (RNR) model: Does adding the Good Lives Model contribute to effective crime prevention? *Criminal Justice and Behavior*, 38(7), 735-755. doi: 10.1177/0093854811406356.
- Andrews, D. A., Guzzo, L., Raynor, P., Rowe, R. C., Rettinger, L. J., Brews, A. y Wormith, J. S. (2012). Are the major Risk/Need factors predictive of both female and male reoffending?: A test with the eight domains of the Level of Service/Case Management Inventory. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 56(1), 113-133. doi: 10.1177/0306624x10395716.
- Arbach, K. y Andrés-Pueyo, A. (2007). Valoración del riesgo de violencia en enfermos mentales con el HCR-20. *Papeles del Psicólogo*, 28(3), 174-186.
- Arbach, K. y Andrés-Pueyo, A. (2014). Evaluación del riesgo de violencia contra la pareja: Validación y eficacia predictiva del RVD-Bcn. En E. García-López (ed.), *Manual de Psicopatología Forense: Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia* (pp. 477-504). México, DF: Manual Moderno.
- Arbach, K., Andrés-Pueyo, A., Pomarol, E. y Gomar, J. (2011). Predicting violence in psychiatric inpatients: A prospective study with the HCR-20 violence risk assessment scheme. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 22(2), 203-222. doi: 10.1080/14789949.2010.530290.
- Arbach, K., Desmarais, S. L., Hurdugas, C., Condemarin, C., Dean, K., Doyle, M., ... y Singh, J. P. (2015). La práctica de la evaluación del riesgo de violencia en España. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63(3), 357-366. doi: 10.15446/revfacmed.v63n3.48225.
- Arce, R. y Fariña, F. (2014). Práctica de la prueba psicológica-forense: El Sistema de Evaluación Global (SEG). En E. C. Chan, C. Estrada, F. J. Rodríguez y S. Viveros (eds.), *Aportaciones a la psicología jurídica y forense desde Iberoamérica* (pp. 47-61). México, DF: Manual Moderno.
- Arce, R., Fariña, F., Carballal, A. y Novo, M. (2009). Creación y validación de un protocolo de evaluación forense de las secuelas psicológicas de la violencia de género. *Psicothema*, 21(2), 241-247.
- Armaza, E. J. (2013). *El tratamiento penal del delincente imputable peligroso*. Granada, España: Comares.
- Au, A., Cheung, G., Kropp, R., Yuk-Chung, C., Lam, G. L. T. y Sung, P. (2008). A preliminary validation of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) in Hong Kong. *Journal of Family Violence*, 23(8), 727-735. doi: 10.1007/s10896-008-9198-z.

- Augimeri, L. K., Koegl, C., Webster, C. y Levene, K. (1998). *Early assessment risk list for boys, EARL-20B* (Version 1). Toronto, Canadá: Earls court Child and Family Centre.
- Augimeri, L. K., Koegl, C. J., Webster, C. D. y Levene, K. (2001). *Early assessment risk list for boys: EARL-20B (Version 2)*. Toronto, Canadá: Child Development Institute.
- Augimeri, L., Walsh, M., Woods, S. y Jiang, D. (2012). Risk assessment and clinical risk management for young antisocial children: The forgotten group. *Universitas Psychologica*, 11(4), 1147-1156. doi: 10.11144/1147.
- Bair-Merritt, M. H., Crowne, S. S., Thompson, D. A., Sibinga, E., Trent, M. y Campbell, J. (2010). Why do women use intimate partner violence? A systematic review of women's motivations. *Trauma Violence & Abuse*, 11(4), 178-189. doi: 10.1177/1524838010379003.
- Ballesteros, A., Graña, J. L. y Andreu, J. M. (2006). Valoración actuarial del riesgo de violencia en centros penitenciarios. *Psicopatología Clínica Legal y Forense*, 6, 103-118.
- Barbaree, H. E., Langton, C. M. y Peacock, E. J. (2006). Different actuarial risk measures produce different risk rankings for sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 18(4), 423-440. doi: 10.1177/107906320601800408.
- Barbaree, H. E., Seto, M. C., Langton, C. M. y Peacock, E. J. (2001). Evaluating the predictive accuracy of six risk assessment instruments for adult sex offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 28(4), 490-521. doi: 10.1177/009385480102800406.
- Barling, J., Dupré, K. E. y Kelloway, E. K. (2009). Predicting workplace aggression and violence. *Annual Review of Psychology*, 60(1), 671-692. doi: 10.1146/annurev.psych.60.110707.163629.
- Barnett, G. y Mann, R. E. (2013). Empathy deficits and sexual offending: A model of obstacles to empathy. *Aggression and Violent Behavior*, 18(2), 228-239. doi: 10.1016/j.avb.2012.11.010.
- Beardsley, N. L. y Beech, A. R. (2013). Applying the violent extremist risk assessment (VERA) to a sample of terrorist case studies. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 5(1), 4-15. doi:10.1108/17596591311290713.
- Bechtel, K., Lowenkamp, C. T. y Latessa, E. (2007). Assessing the Risk of Re-Offending for Juvenile Offenders Using the Youth Level of Service/Case Management Inventory. *Journal of Offender Rehabilitation*, 45(3-4), 85-108. doi: 10.1300/J076v45n03_04.
- Beech, A. R., Craig, L. A. y Browne, K. D. (eds.) (2009). *Assessment and treatment of sex offenders: A handbook*. Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Belfrage, H. (2008). Police-based structured spousal violence risk assessment: The process of creating a police version of the SARA. En A. C. Baldry y F. W. Winkel (eds.), *Intimate partner violence prevention and intervention: The risk assessment and management approach* (pp. 33-44). Hauppauge, NY: Nova Science.
- Belfrage, H. y Ekman, L. (2013). Threat assessment of targeted honor-based violence. En J. R. Meloy y J. Hoffmann (eds.), *International Handbook of Threat Assessment*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Belfrage, H. y Strand, S. (2008). Structured spousal violence risk assessment: Combining risk factors and victim vulnerability factors. *International Journal of Forensic Mental Health*, 7(1), 39-46. doi: 10.1080/14999013.2008.9914402.
- Belfrage, H. y Strand, S. (2009). Validation of the Stalking Assessment and Management checklist (SAM) in law enforcement: A prospective study of 153 cases of stalking in two Swedish police counties. *International Journal of Police Science & Management*, 11(1), 67-76. doi: 10.1350/ijps.2009.11.1.110.
- Belfrage, H. y Strand, S. (2012). Measuring the outcome of structured spousal violence risk assessments using the B-SAFER: Risk in relation to recidivism and intervention. *Behavioral Sciences & the Law*, 30(4), 420-430. doi: 10.1002/bsl.2019.
- Belfrage, H., Strand, S., Ekman, L. y Hasselborg, A.-K. (2012). Assessing risk of patriarchal violence with honour as a motive: Six years experience using the PATRIARCH checklist. *International Journal of Police Science & Management*, 14 (1), 20-29. doi: 10.1350/ijps.2012.14.1.250.
- Belfrage, H., Strand, S., Storey, J. E., Gibas, A. L., Kropp, P. R. y Hart, S. D. (2012). Assessment and management of risk for intimate partner violence by police officers using the Spousal Assault Risk Assessment guide. *Law and Human Behavior*, 36(1), 60-67. doi: 10.1037/h0093948.
- Benavides-Gélvez, R. E., Escobar-Córdoba, F. y Molina-Ojeda, V. (2014). Valoración del riesgo de vio-

- lencia en urgencias psiquiátricas. *Universitas Médica*, 55(3), 297-310.
- Berlin, F. S., Galbreath, N. W., Geary, B. y McGlone, G. (2003). The use of actuarials at civil commitment hearings to predict the likelihood of future sexual violence. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 15(4), 377-382. doi: 10.1177/107906320301500412.
- Berrington, E. y Honkatukia, P. (2002). An evil monster and a poor thing: Female violence in the media. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 3(1), 50-72. doi: 10.1080/140438502762467209.
- Birkley, E. L. y Eckhardt, C. I. (2015). Anger, hostility, internalizing negative emotions, and intimate partner violence perpetration: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 37, 40-56. doi: 10.1016/j.cpr.2015.01.002.
- Bloom, H., Eisen, R. S., Pollock, N. y Webster, C. D. (2000). *WRA-20, Workplace Risk Assessment: a guide for evaluating violence potential. Version 1*. Toronto, Canadá: workplace.calm inc.
- Bloom, H., Webster, C. D. y Eisen, R. (2002). *ERA-20, Employee Risk Assessment: a guide for evaluating potential workplace violence perpetrators*. Toronto, Canadá: workplace.calm.
- Bloom, H., Webster, C. D., Hucker, S. y De Freitas, K. (2005). The canadian contribution to violence risk assessment: History and implications for current psychiatric practice. *Canadian Journal of Psychiatry*, 50(1), 3-11. doi: 10.1177/070674370505000103.
- Blumstein, A., Cohen, J., Roth, J. A. y Visher, C. A. (1986). *Criminal Careers and «Career Criminals»*. Washington, DC: National Academy of Sciences.
- Boer, D. P., Hart, S. D., Kropp, P. R. y Webster, C. D. (1997). *Manual for the Sexual Violence Risk-20: Professional guidelines for assessing risk of sexual violence*. Vancouver, Canadá: Mental Health, Law, and Policy Institute.
- Borum, R. y Verhaagen, D. A. (2006). *Assessing and managing violence risk in juveniles*. Nueva York, NY: Guilford.
- Borum, R., Bartel, P. y Forth, A. (2006). *Manual for the Structured Assessment for Violence Risk in Youth (SAVRY)*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Bowen, E. (2011). An overview of partner violence risk assessment and the potential role of female victim risk appraisals. *Aggression and Violent Behavior*, 16(3), 214-226. doi: 10.1016/j.avb.2011.02.007.
- Brown, A. S., Gray, N. S. y Snowden, R. J. (2009). Implicit measurement of sexual associations in child sex abusers: Role of victim type and denial. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 21(2), 166-180. doi: 10.1177/1079063209332234.
- Burgess, E. W. (1928). Is prediction feasible in social work? An inquiry based upon a sociological study of parole records. *Social Forces*, 7(1), 533-545.
- Buruma, Y. (2004). Risk assessment and criminal law: Closing the gap between criminal law and criminology. En G. Bruinsma, H. Elffers y J. de Keijser (eds.), *Punishment, places and perpetrators. Developments in criminology and criminal justice research* (pp. 41-61). Portland, OR: Willan Publishing.
- Busch, A. L. y Rosenberg, M. S. (2004). Comparing women and men arrested for domestic violence: A preliminary report. *Journal of Family Violence*, 19(1), 49-57. doi: 10.1023/B:JOFV.0000011582.05558.2e.
- Buss, A. H. (1961). *The psychology of aggression*. Nueva York, NY: Wiley.
- Buss, A. H. y Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. *Journal of Consulting Psychology*, 21(4), 343-349.
- Buss, A. H. y Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63(3), 452-459. doi: 10.1037/0022-3514.63.3.452.
- Campbell, J. C. (1986). Nursing assessment of risk of homicide for battered women. *Advances in Nursing Science*, 8(4), 36-51.
- Campbell, J. C. (2004). Helping women understand their risk in situations of intimate partner violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 19(12), 1464-1477. doi: 10.1177/0886260504269698.
- Campbell, J. C. (2012). Risk factors for intimate partner homicide: The importance of Margo Wilson's Foundational research. *Homicide Studies*, 16(4), 438-444. doi: 10.1177/1088767912463208.
- Campbell, J. C. (ed.). (1995). *Assessing dangerousness. Violence by sexual offenders, batterers, and child abusers*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Campbell, J. C. y Glass, N. (2009). Safety planning, danger, and lethality assessment. En C. E. Mitchell y D. Anglin (eds.), *Intimate partner violence. A health-based perspective* (pp. 319-334). Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.

- Campbell, J. C., Webster, D. W. y Glass, N. (2009). The Danger Assessment: Validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(4), 653-674. doi: 10.1177/0886260508317180.
- Campbell, J. C., Webster, D., Koziol-McLain, J., Block, C., Campbell, D., Curry, M. A., ... y Laughon, K. (2003). Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study. *American Journal of Public Health*, 93(7), 1089-1097. doi: 10.2105/AJPH.93.7.1089.
- Campbell, M. A., French, S. y Gendreau, P. (2009). The prediction of violence in adult offenders: A meta-analytic comparison of instruments and methods of assessment. *Criminal Justice and Behavior*, 36(6), 567-590. doi: 10.1177/0093854809333610.
- Cantera, L. M. y Blanch, J. M. (2010). Percepción social de la violencia en la pareja desde los estereotipos de género. *Intervención Psicosocial*, 19(2), 121-127.
- Carney, F. J. (1967). Predicting recidivism in a medium security correctional institution. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 58(3), 338-348.
- Carrasco, M. A. (2006). Evaluación de la conducta agresiva. *Acción Psicológica*, 4(2), 67-81.
- Carroll, J. S. (1977). Judgments of recidivism risk: Conflicts between clinical strategies and base-rate information. *Law and Human Behavior*, 1(2), 191-198. doi: 10.1007/BF01053438.
- Caruso, M. V. (2014). *El delincuente imputable y peligroso. Cuestiones de Política Criminal*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Chesney-Lind, M. y Pasko, L. (2013). *The female offender: girls, women, and crime* (3.^a ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Chesney-Lind, M. y Shelden, R. G. (2014). *Girls, delinquency, and juvenile justice* (4.^a ed.). Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Chu, C. M., Goh, M. L. y Chong, D. (2016). The predictive validity of SAVRY ratings for assessing youth offenders in Singapore: a comparison with YLS/CMI ratings. *Criminal Justice and Behavior*, 43(6), 793-810. doi: 10.1177/0093854815616842.
- Ciardha, C. Ó. y Gormley, M. (2012). Using a pictorial-modified stroop task to explore the sexual interests of sexual offenders against children. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 24(2), 175-197. doi: 10.1177/1079063211407079.
- Cocozza, J. J. y Steadman, H. J. (1974). Some refinements in the measurement and prediction of dangerous behavior. *American Journal of Psychiatry*, 131(9), 1012-1014. doi: 10.1176/ajp.131.9.1012.
- Cocozza, J. J. y Steadman, H. J. (1978). Prediction in psychiatry: an example of misplaced confidence in experts. *Social Problems*, 25(3), 265-276. doi: 10.2307/800064.
- Cohen, M. L., Groth, A. N. y Siegel, R. (1978). The clinical prediction of dangerousness. *Crime & Delinquency*, 24(1), 28-39. doi: 10.1177/001112877802400103.
- Coid, J. W., Yang, M., Ullrich, S., Zhang, T., Sizmur, S., Farrington, D. y Rogers, R. (2011). Most items in structured risk assessment instruments do not predict violence. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 22(1), 3-21. doi: 10.1080/14789949.2010.495990.
- Coid, J., Yang, M., Ullrich, S., Zhang, T., Sizmur, S., Roberts, C., ... y Rogers, R. D. (2009). Gender differences in structured risk assessment: comparing the accuracy of five instruments. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 77(2), 337-348. doi: 10.1037/a0015155.
- Conradi, L. M. y Geffner, R. (eds.). (2012). *Female offenders of intimate partner violence: current controversies, research and treatment approaches*. Nueva York, NY: Routledge.
- Conroy, M. A. (2012). Assessing juveniles for risk of violence. En E. L. Grigorenko (ed.), *Handbook of juvenile forensic psychology and psychiatry* (pp. 227-238). Nueva York, NY: Springer.
- Conroy, M. A. y Murrie, D. C. (2007). *Forensic assessment of violence risk: a guide for risk assessment and risk management*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Cook, A. N., Hart, S. D. y Kropp, P. R. (2013). *Multi-Level Guidelines for the assessment and management of group-based violence [Draft]*. Burnaby, Canadá: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.
- Cook, A. N., Murray, A. A., Amat, G. y Hart, S. D. (2014). Using structured professional judgment guidelines in threat assessment and management: presentation, analysis, and formulation of a case of serial intimate partner violence. *Journal of Threat Assessment and Management*, 1(2), 67-86. doi: 10.1037/tam0000011.
- Cooke, D. J. y Johnstone, L. (2010). Somewhere over the rainbow: improving violence risk management

- in institutional settings. *International Journal of Forensic Mental Health*, 9(3), 150-158. doi: 10.1080/14999013.2010.526463.
- Cooley, E. J. (1928). Prediction. A scientific aid to social work. *Social Forces*, 7(1), 550-553.
- Cortoni, F. (2010). The assessment of female sexual offenders. En T. A. Gannon y F. Cortoni (eds.), *Female sexual offenders: theory, assessment and treatment*. Oxford, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Cortoni, F., Hanson, R. K. y Coache, M. È. (2010). The recidivism rates of female sexual offenders are low: a meta-analysis. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 22(4), 387-401. doi: 10.1177/1079063210372142.
- Costanzo, M. y Krauss, D. (2012). *Forensic and legal psychology. Psychological science applied to law*. Nueva York, NY: Worth Publishers.
- Council of Europe (2014). *Dangerous offenders-Recommendation CM/Rec(2014) 3 and explanatory memorandum*. Strasbourg, Francia: Council of Europe.
- Craig, L. A. y Beech, A. (2009). Best practice in conducting actuarial risk assessments with adult sexual offenders. *Journal of Sexual Aggression*, 15(2), 193-211. doi: 10.1080/13552600902867847.
- Craig, L. A., Beech, A. y Browne, K. D. (2006). Cross-validation of the risk matrix 2000 sexual and violent scales. *Journal of Interpersonal Violence*, 21(5), 612-633. doi: 10.1177/0886260506286876.
- Craig, L. A., Browne, K. D. y Beech, A. R. (2008). *Assessing risk in sex offenders: a practitioner's guide*. Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Craig, L. A., Browne, K. D. y Stringer, L. (2004). Comparing sex offender risk assessment measures on a UK sample. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 48(1), 7-27. doi: 10.1177/0306624x03257243.
- Craig, M. M. y Glick, S. J. (1963). Ten years' experience with the Glueck social prediction table. *Crime & Delinquency*, 9(3), 249-261. doi: 10.1177/001112876300900305.
- Cuenca, M. L., Graña, J. L. y Redondo, N. (2015). Differences in the prevalence of partner aggression according to the Revised Conflict Tactics Scale: Individual and dyadic report. *Psicología Conductual*, 23(1), 127-140.
- Cueto, C. (2014). La orden europea de protección. Su transposición en el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea. *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 21 (enero-junio).
- Dahlberg, L. L., Toal, S. B., Swahn, M. y Behrens, C. B. (2005). *Measuring violence-related attitudes, behaviors, and influences among youths: a compendium of assessment tools* (2ª ed.). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.
- Davidson, J. T. (2009). *Female offenders and risk assessment: hidden in plain sight*. El Paso, TX: LFB Scholarly Publishing LLC.
- De Ruiter, C. y Nicholls, T. L. (2011). Protective factors in forensic mental health: a new frontier. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(3), 160-170. doi: 10.1080/14999013.2011.600602.
- De Vogel, V. y De Ruiter, C. (2005). The HCR-20 in personality disordered female offenders: a comparison with a matched sample of males. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 12(3), 226-240. doi: 10.1002/cpp.452.
- De Vogel, V. y De Vries-Robbé, M. (2013). Working with women: towards a more gender-sensitive violence risk assessment. En C. Logan y L. Johnstone (eds.), *Managing clinical risk: A guide to effective practice*. Nueva York, NY: Routledge.
- De Vogel, V., De Ruiter, C., Bouman, Y. y De Vries-Robbé, M. (2009). *SAPROF. Guidelines for the assessment of protective factors for violence risk. English Version*. Utrecht, Holanda: Forum Educatief.
- De Vogel, V., De Ruiter, C., Bouman, Y. y De Vries-Robbé, M. (2012). *SAPROF. Guidelines for the assessment of protective factors for violence risk. Second edition*. Utrecht, Holanda: Forum Educatief.
- De Vogel, V., De Vries-Robbé, M., De Ruiter, C. y Bouman, Y. H. A. (2011). Assessing protective factors in forensic psychiatric practice: introducing the SAPROF. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(3), 171-177. doi: 10.1080/14999013.2011.600230.
- De Vogel, V., De Vries-Robbé, M., Van Kalmthout, W. y Place, C. (2012). *Female Additional Manual (FAM): Additional guidelines to the HCR-20 for assessing risk for violence in women*. Utrecht, Holanda: Van der Hoeven Stichting.
- De Vogel, V., De Vries-Robbé, M., Van Kalmthout, W. y Place, C. (2014). *Female Additional Manual: additional guidelines to the HCR-20v3 for assessing risk*

- for violence in women. Utrecht, Holanda: Van der Hoeven Stichting.
- De Vogel, V., Stam, J., Bouman, Y. H. A., Ter Horst, P. y Lancel, M. (2016). Violent women: a multicentre study into gender differences in forensic psychiatric patients. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 27(2), 145-168. doi: 10.1080/14789949.2015.1102312.
- De Vogel, V., Van den Broek, E. y De Vries Robbé, M. (2014). The use of the HCR-20V3 in Dutch forensic psychiatric practice. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 109-121. doi: 10.1080/14999013.2014.906518.
- De Vries-Robbé, M., De Vogel, V. y De Spa, E. (2011). Protective factors for violence risk in forensic psychiatric patients: a retrospective validation study of the SAPROF. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(3), 178-186. doi: 10.1080/14999013.2011.600232.
- De Vries Robbé, M., De Vogel, V., Koster, K. y Boogaerts, S. (2015). Assessing protective factors for sexually violent offending with the SAPROF. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 27, 51-70. doi:10.1177/1079063214550168.
- De Vries Robbé, M., Geers, M., Stapel, M., Hilterman, E. y de Vogel, V. (2015). *Structured Assessment of Protective Factors for violence risk-Youth Version (SAPROF-YV)*. Utrecht, Holanda: Van der Hoeven Kliniek.
- Defez, F. J. y Cuquerella, Á. (2014). Evaluación del riesgo de reincidencia en un caso de violencia sexual mediante el Sexual Violence Risk-20. *Revista Española de Medicina Legal*, 40(2), 72-75. doi: 10.1016/j.rem.l.2013.06.007.
- Delisi, M., Vaughn, M. G., Beaver, K. M. y Wright, J. P. (2010). The Hannibal Lecter myth: psychopathy and verbal intelligence in the MacArthur violence risk assessment study. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 32(2), 169-177. doi: 10.1007/s10862-009-9147-z.
- DeMatteo, D., Batastini, A., Foster, E. y Hunt, E. (2010). Individualizing risk assessment: balancing idiographic and nomothetic data. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 10(4), 360-371. doi: 10.1080/15228932.2010.481244.
- Demetrio, E. y Maroto, M. (eds.) (2013). *Neurociencias y derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad*. Buenos Aires, Argentina: Edisofer.
- Dempster, R. J. y Hart, S. D. (2002). The relative utility of fixed and variable risk factors in discriminating sexual recidivists and nonrecidivists. *Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14(2), 121-138.
- Dershowitz, A. M. (1968). Psychiatry in the legal process: a knife that cuts both ways. *Judicature*, 51(10), 370-377.
- Dershowitz, A. M. (1970). The law of dangerousness: some fictions about predictions. *Journal of Legal Education*, 23(1), 24-47. doi: 10.2307/42892038.
- Desmarais, S. L., Nicholls, T. L., Wilson, C. M. y Brink, J. (2012). Using dynamic risk and protective factors to predict inpatient aggression: reliability and validity of START assessments. *Psychological Assessment*, 24(3), 685-700. doi: 10.1037/a0026668.
- Desmarais, S. L., Sellers, B. G., Viljoen, J. L., Cruise, K. R., Nicholls, T. L. y Dvoskin, J. A. (2012). Pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV assessments in secure juvenile correctional facilities. *International Journal of Forensic Mental Health*, 11(3), 150-164. doi: 10.1080/14999013.2012.737405.
- Diamond, B. L. (1974). The psychiatric prediction of dangerousness. *University of Pennsylvania Law Review*, 123, 439-452.
- DoH (2007). *Best practice in managing risk: principles and guidance for best practice in the assessment and management of risk to self and others in mental health services*. Inglaterra: Department of Health, National Risk Management Programme.
- Dolores, J. C. y Redding, R. E. (2009). The effects of different forms of risk communication on judicial decision making. *International Journal of Forensic Mental Health*, 8(2), 142-146. doi: 10.1080/14999010903199407.
- Douglas, K. S. y Belfrage, H. (2014). Interrater reliability and concurrent validity of the HCR-20 version 3. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 130-139. doi: 10.1080/14999013.2014.908429.
- Douglas, K. S. y Reeves, K. A. (2010). Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20). Violence risk assessment scheme: rationale, application, and empirical overview. En R. K. Otto y K. S. Douglas (eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 147-185). Nueva York, NY: Routledge/Taylor & Francis.

- Douglas, K. S., Guy, L. S. y Hart, S. D. (2009). Psychosis as a risk factor for violence to others: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 135(5), 679-706. doi: 10.1037/a0016311.
- Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D. y Belfrage, H. (2013). *HCR-20 (v3): Assessing risk for violence*. Vancouver, Canadá: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.
- Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., Belfrage, H., Guy, L. S. y Wilson, C. M. (2014). Historical-Clinical-Risk Management-20, Version 3 (HCR-20V3): development and overview. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 93-108. doi: 10.1080/14999013.2014.906519.
- Douglas, K. S., Shaffer, C., Blanchard, A. J. E., Guy, L. S., Reeves, K. y Weir, J. (2014). *HCR-20 violence risk assessment scheme: overview and annotated bibliography*. Burnaby, Canadá: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.
- Douglas, K. S., Yeomans, M. y Boer, D. P. (2005). Comparative validity analysis of multiple measures of violence risk in a sample of criminal offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 32(5), 479-510. doi: 10.1177/0093854805278411.
- Doyle, M. y Dolan, M. (2002). Violence risk assessment: combining actuarial and clinical information to structure clinical judgements for the formulation and management of risk. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 9(6), 649-657. doi: 10.1046/j.1365-2850.2002.00535.x.
- Doyle, M., Power, L. A., Coid, J., Kallis, C., Ullrich, S. y Shaw, J. (2014). Predicting post-discharge community violence in England and Wales using the HCR-20V3. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 140-147. doi: 10.1080/14999013.2014.906517.
- Duncan, K. A. (2010). *Female sexual predators: Understanding them to protect our children and youths*. Santa Barbara, CA: Praeger.
- Dutile, F. N. y Foust, C. H. (eds.) (1985). *The prediction of criminal violence*. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
- Dutton, D. G. y Karakanta, C. (2013). Depression as a risk marker for aggression: a critical review. *Aggression and Violent Behavior*, 18(2), 310-319. doi: 10.1016/j.avb.2012.12.002.
- Dutton, D. G. y Kropp, P. R. (2000). A review of domestic violence risk instruments. *Trauma, Violence, & Abuse*, 1(2), 171-181. doi: 10.1177/1524838000001002004.
- Dutton, D. G. y White, K. R. (2012). Attachment insecurity and intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 17(5), 475-481. doi: 10.1016/j.avb.2012.07.003.
- Echeburúa, E. y Loinaz, I. (2011). Violencia y trastornos mentales. En P. García, M. Bethencourt, E. Sola, A. Martín y E. Armas (eds.), *Violencia y Psicología Comunitaria. Aspectos psicosociales, clínicos y legales* (pp. 1-22). Granada, España: Comares.
- Echeburúa, E., Amor, P. J., Loinaz, I. y de Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja-Revisada-(EPV-R). *Psicothema*, 22(4), 1054-1060.
- Echeburúa, E., Fernández-Montalvo, J. y de Corral, P. (2008). ¿Hay diferencias entre la violencia grave y la violencia menos grave contra la pareja?: un análisis comparativo. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 8, 355-382.
- Echeburúa, E., Fernández-Montalvo, J., de Corral, P. y López-Goñi, J. J. (2009). Assessing risk markers in intimate partner femicide and severe violence: a new assessment instrument. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(6), 925-939. doi: 10.1177/0886260508319370.
- Eckhardt, C. I., Samper, R., Suhr, L. y Holtzworth-Munroe, A. (2012). Implicit attitudes toward violence among male perpetrators of intimate partner violence: a preliminary investigation. *Journal of Interpersonal Violence*, 27(3), 471-491. doi: 10.1177/0886260511421677.
- Edwards, S. S. M. (1986). Neither bad nor mad: The female violent offender reassessed. *Women's Studies International Forum*, 9(1), 79-87. doi: 10.1016/0277-5395(86)90079-8.
- Egan, V., Cole, J., Cole, B., Alison, L., Alison, E., Waring, S. y Elntib, S. (2016). Can you identify violent extremists using a screening checklist and open-source intelligence alone? *Journal of Threat Assessment and Management*, 3(1), 21-36. doi: 10.1037/tam0000058.
- Eisenbarth, H., Osterheider, M., Nedopil, N. y Stadtland, C. (2012). Recidivism in female offenders: PCL-R lifestyle factor and VRAG show predictive validity in a German sample. *Behavioral Sciences and the Law*, 30(5), 575-584. doi: 10.1002/bsl.2013.
- Eke, A. W., Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E. y Houghton, R. E. (2011). Intimate partner homicide: risk assessment and prospects for prediction.

- Journal of Family Violence*, 26(3), 211-216. doi: 10.1007/s10896-010-9356-y.
- Ellis, L., Beaver, K. M. y Wright, J. (2009). *Handbook of crime correlates*. San Diego, CA: Academic Press.
- Elwood, R. W. (2016). Defining probability in sex offender risk assessment. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 60(16), 1928-1941. doi: 10.1177/0306624x15587912.
- Emeka, T. Q. y Sorensen, J. R. (2009). Female juvenile risk: is there a need for gendered assessment instruments? *Youth Violence and Juvenile Justice*, 7(4), 313-330. doi: 10.1177/1541204009334083.
- Enebrink, P., Högström, J., Forster, M. y Ghaderi, A. (2014). Entrenamiento conductual de los padres basado en internet: un estudio controlado aleatorizado. *RET: Revista de Toxicomanías*, 71, 13-27.
- Enebrink, P., Långström, N. y Gumpert, C. H. (2006). Predicting aggressive and disruptive behavior in referred 6 to 12 year old boys: prospective validation of the EARL-20B risk/needs checklist. *Assessment*, 13(3), 356-367. doi: 10.1177/1073191106290649.
- Enebrink, P., Långström, N., Hultén, A. y Gumpert, C. H. (2006). Swedish validation of the Early Assessment Risk List for Boys (EARL-20B), a decision aid for use with children presenting with conduct-disordered behaviour. *Nordic Journal of Psychiatry*, 60(6), 438-446. doi: 10.1080/08039480601021795.
- Epperson, D. L. y Ralston, C. A. (2015). Development and validation of the Juvenile Sexual Offense Recidivism Risk Assessment Tool-II. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 27(6), 529-558. doi: 10.1177/1079063213514452.
- Epperson, D. L., Ralston, C. A., Fowers, D. y DeWitt, J. (2005). *Juvenile Sexual Offense Recidivism Risk Assessment Tool- II (JSORRAT- II)*. Utah State Juvenile Justice Services.
- Esbec, E. (2003). Valoración de la peligrosidad criminal (riesgo-violencia) en psicología forense: aproximación conceptual e histórica. *Psicopatología Clínica Legal y Forense*, 3(2), 45-64.
- Fanniff, A. M. y Letourneau, E. J. (2012). Another piece of the puzzle: psychometric properties of the J-SOAP-II. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 24(4), 378-408. doi: 10.1177/1079063211431842.
- Farrington, D. P. (2003). Key results from the first forty years of the Cambridge Study in Delinquent Development. En T. P. Thornberry y M. D. Krohn (eds.), *Taking Stock of Delinquency* (pp. 137-183). Nueva York, NY: Springer.
- Farrington, D. P. y Tarling, R. (eds.) (1985). *Prediction in criminology*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Farrington, D. P., Piquero, A. R. y Jennings, W. G. (2013). *Offending from childhood to late middle age. Recent results from the Cambridge study in delinquent development*. Nueva York, NY: Springer Science+Business Media.
- Farrow, K., Kelly, G. y Wilkinson, B. (2007). *Offenders in focus. Risk, responsivity and diversity*. Bristol, Inglaterra: The Policy Press.
- Fass, T. L., Heilbrun, K., DeMatteo, D. y Fretz, R. (2008). The LSI-R and the Compas: Validation data on two risk-needs tools. *Criminal Justice and Behavior*, 35(9), 1095-1108. doi: 10.1177/0093854808320497.
- Fazel, S. y Bjørkly, S. (2016). Methodological considerations in risk assessment research. En J. P. Singh, S. Bjørkly y S. Fazel (eds.), *International perspectives on violence risk assessment* (pp. 16-25). Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Feindler, E. L., Rathus, J. H. y Silver, L. B. (2003). *Assessment of family violence: a handbook for researchers and practitioners*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock 'n' roll)* (3.^a ed.). Los Angeles, CA: SAGE.
- Foellmi, M. C., Rosenfeld, B. y Galietta, M. (2016). Assessing risk for recidivism in individuals convicted of stalking offenses: Predictive validity of the guidelines for stalking assessment and management. *Criminal Justice and Behavior*, 43(5), 600-616. doi: 10.1177/0093854815610612.
- Folino, J. O. (2003). *Evaluación de riesgo de violencia HCR-20. Versión en español, adaptada y comentada*. La Plata, Argentina: Interfase Forense.
- Folino, J. O. (2004). *Guía para la evaluación del riesgo de violencia conyugal —SARA—*. Versión en español adaptada y comentada. La Plata, Argentina: Interfase Forense.
- Folino, J. O. (2015). Predictive efficacy of violence risk assessment instruments in Latin-America. *The Eu-*

- ropean Journal of Psychology Applied to Legal Context, 7(2), 51-58 doi: 10.1016/j.ejpal.2014.11.006.
- Folino, J. O., Marengo, C. M., Marchiano, S. E. y Ascazibar, M. (2004). The risk assessment program and the court of penal execution in the province of Buenos Aires, Argentina. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 48(1), 49-58. doi: 10.1177/0306624x03257526.
- Forth, A. E., Kosson, D. S. y Hare, R. D. (1996). *Psychopathy checklist: Youth Version*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Frantzen, D., Miguel, C. S. y Kwak, D. H. (2011). Predicting case conviction and domestic violence recidivism: Measuring the deterrent effects of conviction and protection order violations. *Violence and Victims*, 26(4), 395-409. doi: 10.1891/0886-6708.26.4.395.
- Freiburger, T. L. y Marcum, C. D. (eds.) (2016). *Women in the criminal justice system: Tracking the journey of females and crime*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Fujii, D. E. M., Tokioka, A. B., Lichton, A. I. y Hishinuma, E. (2005). Ethnic differences in prediction of violence risk with the HCR-20 among psychiatric inpatients. *Psychiatric Services*, 56(6), 711-716. doi: 10.1176/appi.ps.56.6.711.
- Gallardo-Pujol, D., Kramp, U., García-Forero, C., Pérez-Ramírez, M. y Andrés-Pueyo, A. (2006). Assessing aggressiveness quickly and efficiently: The Spanish adaptation of Aggression Questionnaire-Refined version. *European Psychiatry*, 21, 487-494. doi: 10.1016/j.eurpsy.2006.02.002.
- Gammelgård, M., Koivisto, A.-M., Eronen, M. y Kaltiala-Heino, R. (2008). The predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) among institutionalised adolescents. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 19(3), 352-370. doi: 10.1080/14789940802114475.
- Gammelgård, M., Weizmann-Henelius, G., Koivisto, A.-M., Eronen, M. y Kaltiala-Heino, R. (2011). Gender differences in violence risk profiles. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 23(1), 76-94. doi: 10.1080/14789949.2011.639898.
- Gannon, T. A. y Cortoni, F. (eds.) (2010). *Female sexual offenders: Theory, assessment and treatment*. Oxford, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- García-Forero, C., Gallardo-Pujol, D., Maydeu-Olivares, A. y Andrés-Pueyo, A. (2009). Disentangling impulsiveness, aggressiveness and impulsive aggression: an empirical approach using self-report measures. *Psychiatry Research*, 168(1), 40-49. doi: 10.1016/j.psychres.2008.04.002.
- García-Mansilla, A., Rosenfeld, B. y Cruise, K. R. (2011). Violence risk assessment and women: Predictive accuracy of the HCR-20 in a civil psychiatric sample. *Behavioral Sciences & the Law*, 29(5), 623-633. doi: 10.1002/Bsl.1005.
- García-Mansilla, A., Rosenfeld, B. y Nicholls, T. L. (2009). Risk assessment: Are current methods applicable to women? *International Journal of Forensic Mental Health*, 8(1), 50-61. doi: 10.1080/14999010903014747.
- Gavin, H. y Porter, T. (2015). *Female Aggression*. Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Geraghty, K. A. y Woodhams, J. (2015). The predictive validity of risk assessment tools for female offenders: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 21, 25-38. doi:1016/j.avb.2015.01.002.
- Gerth, J., Rossegger, A., Singh, J. P. y Endrass, J. (2015). Assessing the risk of severe intimate partner violence: Validating the DyRiAS in Switzerland. *Archives of Forensic Psychology*, 1(2), 1-15.
- Gill, P. (2015). *Lone actor terrorists: A behavioural analysis*. Nueva York, NY: Routledge.
- Gimeno, M. Á., Grandío, A. y Marqués, A. I. (2012). Prácticas organizativas saludables frente a la violencia en el trabajo. Estudio de su incidencia. *Contabilidad y Negocios*, 7(13), 43-58.
- Glaser, D. (1962). Prediction tables as accounting devices for judges and parole boards. *Crime & Delinquency*, 8(3), 239-258. doi: 10.1177/001112876200800303.
- Glass, N., Perrin, N., Hanson, G., Bloom, T., Gardner, E. y Campbell, J. C. (2008). Risk for reassault in abusive female same-sex relationships. *American Journal of Public Health*, 98(6), 1021-1027. doi: 10.2105/ajph.2007.117770.
- Glueck, E. (1956). Status of Glueck prediction studies. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 47(1), 18-32.
- Glueck, E. (1963). Toward further improving the identification of delinquents. *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 54(2), 178-180.
- Glueck, E. (1958). Predictive devices and the individualization of justice. *Law and Contemporary Problems*, 23(3), 461-476.

- Glueck, S. y Glueck, E. (1929). Predictability in the administration of criminal justice. *Harvard Law Review*, 42(3), 297-329.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1930). *500 Criminal Careers*. Nueva York, NY: Knopf.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1934a). *Five Hundred Delinquent Women*. Nueva York, NY: Knopf.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1934b). *One thousand juvenile delinquents*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1950). *Unraveling juvenile delinquency*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1956). Early detection of future delinquents. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Political Science*, 54(2), 174-182.
- Goldstein, J. y Katz, J. (1960). Dangerousness and mental illness some observations on the decision to release persons acquitted by reason of insanity. *Yale Law Journal*, 225-239.
- Goldstein, N. E. S., James, H. M. y Folino, J. O. (2015). Tópicos actuales de la investigación internacional sobre riesgo de violencia. *Revista Criminalidad*, 57(1), 27-43.
- Gorunescu, F. (2011). *Data mining: Concepts, models and techniques*, vol. 12. Berlín, Alemania: Springer.
- Grann, M. y Pallvik, A. (2002). An empirical investigation of written risk communication in forensic psychiatric evaluations. *Psychology, Crime & Law*, 8(1), 113-130. doi: 10.1080/10683160208401812.
- Grann, M. y Wedin, I. (2002). Risk factors for recidivism among spousal assault and spousal homicide offenders. *Psychology, Crime & Law*, 8(1), 5-23. doi: 10.1080/10683160290000860.
- Grann, M., Belfrage, H. y Tengström, A. (2000). Actuarial assessment of risk for violence: Predictive validity of the VRAG and the historical part of the HCR-20. *Criminal Justice and Behavior*, 27(1), 97-114. doi: 10.1177/0093854800027001006.
- Graña, J. L. y Cuenca, M. L. (2014). Prevalence of psychological and physical intimate partner aggression in Madrid (Spain): A dyadic analysis. *Psicothema*, 26(3), 343-348. doi: 0.7334/psicothema2013.262.
- Graña, J. L., Andreu, J. M., Peña, M. E. y Rodríguez-Biezma, M. J. (2013). Validez factorial y fiabilidad de la «escala de tácticas para el conflicto revisada» (revised Conflict Tactics Scales, CTS2) en población adulta española. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 21(3), 525-544.
- Graña, J. L., Andreu, J. M., Silva, T., Pozuelo, F. y Ruiz, A. (2014). Evaluación de las propiedades psicométricas del LSI-R en una muestra penitenciaria. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 14, 7-23.
- Graña, J. L., Garrido, V. y González, L. (2007). Evaluación de las características delictivas de menores infractores de la comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. *Psicopatología Clínica Legal y Forense*, 7(1), 7-18.
- Graña, J. L., Garrido, V. y González, L. (2008). *Reincidencia delictiva en menores infractores de la comunidad de Madrid: evaluación, características delictivas y modelos de predicción*. Madrid, España: Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.
- Gray, N. S., Fitzgerald, S., Taylor, J., MacCulloch, M. J. y Snowden, R. J. (2007). Predicting future reconviction in offenders with intellectual disabilities: The predictive efficacy of VRAG, PCL:SV, and the HCR-20. *Psychological Assessment*, 19(4), 474-479. doi: 10.1037/1040-3590.19.4.474.
- Gray, N. S., Snowden, R. J., MacCulloch, S., Phillips, H., Taylor, J. y MacCulloch, M. J. (2004). Relative efficacy of criminological, clinical, and personality measures of future risk of offending in mentally disordered offenders: comparative study of HCR-20, PCL:SV, and OGRS. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(3), 523-530. doi: 10.1037/0022-006X.72.3.523.
- Green, D., Schneider, M., Griswold, H., Belfi, B., Herrera, M. y DeBlasi, A. (2016). A comparison of the HCR-20V3 among male and female insanity acquittees: A retrospective file study. *International Journal of Forensic Mental Health*, 15(1), 48-64. doi: 10.1080/14999013.2015.1134726.
- Greig, D. N. (2001). *Neither bad nor mad. The competing discourses of psychiatry, law and politics*. Londres, Inglaterra: Jessica Kingsley Publishers.
- Hakeem, M. (1945a). Glueck method of parole prediction applied to 1,861 cases of burglars. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 36(2), 87-97.
- Hakeem, M. (1945b). Prediction of criminality. *Federal Probation*, 9, 31-38.
- Hakeem, M. (1948). The validity of the Burgess method of parole prediction. *American Journal of Sociology*, 53(5), 376-386.

- Hall, H. V. (1982). Dangerousness predictions and the maligned forensic professional: Suggestions for detecting distortion of true basal violence. *Criminal Justice and Behavior*, 9(1), 3-12. doi: 10.1177/0093854882009001001.
- Hanson, R. K. (1997). *The development of a brief actuarial risk scale for sexual offence recidivism*. Ottawa, Canadá: Department of the Solicitor General of Canada.
- Hanson, R. K. y Harris, A. J. R. (2001). A structured approach to evaluating change among sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 13(2), 105-122. doi: 10.1177/107906320101300204.
- Hanson, R. K. y Morton-Bourgon, K. E. (2009). The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies. *Psychological Assessment*, 21(1), 1-21. doi: 10.1037/a0014421.
- Hanson, R. K. y Thornton, D. (1999). *Static-99: Improving Actuarial Risk Assessments for Sex Offenders*. User Report 99-02. Ottawa, Canadá: Department of the Solicitor General of Canada.
- Hanson, R. K. y Thornton, D. (2000). Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales. *Law and Human Behavior*, 24(1), 119-136. doi: 10.1023/a:1005482921333.
- Hanson, R. K. y Thornton, D. (2003). *Notes on the development of Static-2002 (Corrections Research User Report 2003-01)*. Ottawa, Canadá: Department of the Solicitor General of Canada.
- Hanson, R. K., Harris, A. J. R., Helmus, L. y Thornton, D. (2014). High-risk sex offenders may not be high risk forever. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(15), 2792-2813. doi: 10.1177/0886260514526062.
- Hanson, R. K., Lloyd, C. D., Helmus, L. y Thornton, D. (2012). Developing non-arbitrary metrics for risk communication: Percentile ranks for the Static-99/R and Static-2002/R sexual offender risk tools. *International Journal of Forensic Mental Health*, 11(1), 9-23. doi: 10.1080/14999013.2012.667511.
- Hare, R. D. (1991). *The hare psychopathy checklist-revised (PCL-R)*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Harris, A. y Lurigio, A. J. (2007). Mental illness and violence: A brief review of research and assessment strategies. *Aggression and Violent Behavior*, 12(5), 542-551. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2007.02.008>.
- Harris, G. T. y Rice, M. E. (2007). Characterizing the value of actuarial violence risk assessments. *Criminal Justice and Behavior*, 34(12), 1638-1658. doi: 10.1177/0093854807307029.
- Harris, G. T., Rice, M. E. y Camilleri, J. A. (2004). Applying a forensic actuarial assessment (the Violence Risk Appraisal Guide) to nonforensic patients. *Journal of Interpersonal Violence*, 19(9), 1063-1074. doi: 10.1177/0886260504268004.
- Harris, G. T., Rice, M. E. y Cormier, C. A. (2002). Prospective replication of the Violence Risk Appraisal Guide in predicting violent recidivism among forensic patients. *Law and Human Behavior*, 26, 377-395. doi: 10.1023/A:1016347320889.
- Harris, G. T., Rice, M. E. y Quinsey, V. L. (1993). Violent recidivism of mentally disordered offenders: The development of a statistical prediction instrument. *Criminal Justice and Behavior*, 20(4), 315-335. doi: 10.1177/0093854893020004001.
- Harris, G. T., Rice, M. E., Quinsey, V. L. y Cormier, C. A. (2015). *Violent offenders: Appraising and managing risk* (3.^a ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
- Harris, G. T., Rice, M. E., Quinsey, V. L., Lalumière, M. L., Boer, D. y Lang, C. (2003). A multisite comparison of actuarial risk instruments for sex offenders. *Psychological Assessment*, 15(3), 413-425. doi: 10.1037/1040-3590.15.3.413.
- Harris, S. T. y Picchioni, M. M. (2013). A review of the role of empathy in violence risk in mental disorders. *Aggression and Violent Behavior*, 18(2), 335-342. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2012.12.003>.
- Harrison, K. (2011). *Dangerousness, risk and the governance of serious sexual and violent offenders*. Londres, Inglaterra: Routledge.
- Hart, H. (1923). Predicting parole success. *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, 14(3), 405-413.
- Hart, S. D. (2003). Actuarial risk assessment: commentary on Berlin et al. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 15(4), 383-388.
- Hart, S. D. (2008). Preventing violence: The role of risk assessment and management. En A. C. Baldry y F. W. Winkel (eds.), *Intimate partner violence prevention and intervention: The risk assessment and management approach* (pp. 7-18). Hauppauge, NY: Nova Science.

- Hart, S. D. y Boer, D. P. (2010). Structured professional judgment guidelines for sexual violence risk assessment: The Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) and Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP). En R. K. Otto y K. S. Douglas (ed.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 269-294). Nueva York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
- Hart, S. D. y Cooke, D. J. (2013). Another look at the (im-)precision of individual risk estimates made using actuarial risk assessment instruments. *Behavioral Sciences & the Law*, 31(1), 81-102. doi: 10.1002/bsl.2049.
- Hart, S. D. y Logan, C. (2011). Formulation of violence risk using evidence-based assessments: The structured professional judgment approach. En P. Sturmey y M. McMurran (eds.), *Forensic case formulation*. Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Hart, S. D., Cox, D. N. y Hare, R. D. (1995). *The Hare Psychopathy Checklist: Screening Version*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Hart, S. D., Kropp, P. R., Laws, D. R., Klaver, J., Logan, C. y Watt, K. A. (2003). *The Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP): Structured professional guidelines for assessing risk of sexual violence*. Burnaby, Canadá: Mental Health, Law, & Policy Institute, Simon Fraser University.
- Hart, S. D., Michie, C. y Cooke, D. J. (2007). Precision of actuarial risk assessment instruments: evaluating the 'margins of error' of group vs. individual predictions of violence. *The British journal of psychiatry. Supplement*, 49, s60-s65. doi: 10.1192/bjp.190.5.s60.
- Hart, S. D., Sturmey, P., Logan, C. y McMurran, M. (2011). Forensic case formulation. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(2), 118-126. doi: 10.1080/14999013.2011.577137.
- Hastings, M. E., Krishnan, S., Tangney, J. P. y Stuewig, J. (2011). Predictive and Incremental validity of the Violence Risk Appraisal Guide Scores with male and female jail inmates. *Psychological Assessment*, 23(1), 174-183. doi: 10.1037/a0021290.
- Healy, W. (1913). Present day aims and methods in studying the offender. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 4(2), 204-211.
- Heckert, D. A. y Gondolf, E. W. (2004). Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting repeat reassault. *Journal of Interpersonal Violence*, 19(7), 778-800. doi: 10.1177/0886260504265619.
- Heilbrun, K. (1997). Prediction versus management models relevant to risk assessment: The importance of legal decision-making context. *Law and Human Behavior*, 21(4), 347-359. doi: 10.1023/A:1024851017947.
- Heilbrun, K. (2009). *Evaluation for risk of violence in adults*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Heilbrun, K., Dvoskin, J., Hart, S. y McNiel, D. (1999). Violence risk communication: Implications for research, policy, and practice. *Health, Risk & Society*, 1(1), 91-105. doi: 10.1080/13698579908407009.
- Heilbrun, K., O'Neill, M. L., Stevens, T. N., Strohmman, L. K., Bowman, Q. y Lo, Y.-W. (2004). Assessing normative approaches to communicating violence risk: A national survey of psychologists. *Behavioral Sciences & the Law*, 22(2), 187-196. doi: 10.1002/bsl.570.
- Heilbrun, K., O'Neill, M., Strohmman, L., Bowman, Q. y Philipson, J. (2000). Expert approaches to communicating violence risk. *Law and Human Behavior*, 24(1), 137-148. doi: 10.1023/a:1005435005404.
- Heiler, M. S. (1969). The mentally ill offender: The question of dangerousness. *The Prison Journal*, 49(1), 6-12. doi: 10.1177/003288556904900102.
- Helmus, L. y Bourgon, G. (2011). Taking stock of 15 years of research on the Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA): A critical review. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(1), 64-75. doi: 10.1080/14999013.2010.551709.
- Helmus, L., Hanson, R. K., Thornton, D., Babchishin, K. M. y Harris, A. J. R. (2012). Absolute recidivism rates predicted by Static-99R and Static-2002R sex offender risk assessment tools vary across samples: A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 39(9), 1148-1171. doi: 10.1177/0093854812443648.
- Helmus, L., Thornton, D., Hanson, R. K. y Babchishin, K. M. (2011). Improving the predictive accuracy of Static-99 and Static-2002 with older sex offenders: Revised age weights. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 4(1), 64-101. doi: 10.1177/1079063211409951.
- Hempel, I. S., Buck, N. M. L., Goethals, K. R. y Van Marle, H. J. C. (2013). Unraveling sexual associations in contact and noncontact child sex offenders using the Single Category – Implicit Association Test. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 25(5), 444-460. doi: 10.1177/1079063212464660.

- Hempel, I., Buck, N., Cima, M. y Van Marle, H. (2013). Review of risk assessment instruments for juvenile sex offenders: What is next? *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(2), 208-228. doi: 10.1177/0306624x11428315.
- Hendricks, B., Werner, T., Shipway, L. y Turinetti, G. J. (2006). Recidivism among spousal abusers. *Journal of Interpersonal Violence*, 21(6), 703-716. doi: 10.1177/0886260506287310.
- Herrero, O. (2012). ¿Quién teme a los falsos negativos? Algunas reflexiones sobre el campo de la evaluación del riesgo de reincidencia. *Boletín de la Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias*, 27, 27-38.
- Herrero, O. (2013). ¿Por qué no reincide la mayoría de los agresores sexuales? *Anuario de Psicología Jurídica*, 23(1), 71-77. doi: 10.5093/aj2013a11.
- Hiday, V. A. y Markell, S. J. (1980). Components of dangerousness: Legal standards in civil commitment. *International Journal of Law and Psychiatry*, 3(4), 405-419. doi: 10.1016/0160-2527(80)90025-4.
- Hilterman, E. y Andrés-Pueyo, A. (2005). *Guía para la valoración del riesgo de violencia HCR-20*. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
- Hilterman, E., Nicholls, T. L. y van Nieuwenhuizen, C. (2014). Predictive validity of risk assessments in juvenile offenders: Comparing the SAVRY, PCL:YV, and YLS/CMI with unstructured clinical assessments. *Assessment*, 21(3), 324-339. doi: 10.1177/1073191113498113.
- Hilton, N. Z. y Eke, A. W. (2016). Non-specialization of criminal careers among intimate partner violence offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 43(10), 1347-1363. doi: 10.1177/0093854816637886.
- Hilton, N. Z. y Ham, E. (2015). Cost-effectiveness of electronic training in domestic violence risk assessment: ODARA 101. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(6), 1065-1073. doi: 10.1177/0886260514539762.
- Hilton, N. Z. y Harris, G. T. (2009). How nonrecidivism affects predictive accuracy evidence from a cross-validation of the Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA). *Journal of Interpersonal Violence*, 24(2), 326-337. doi: 10.1177/0886260508316478.
- Hilton, N. Z., Carter, A. M., Harris, G. T. y Sharpe, A. J. B. (2008). Does using nonnumerical terms to describe risk aid violence risk communication?: Clinician agreement and decision making. *Journal of Interpersonal Violence*, 23(2), 171-188. doi: 10.1177/0886260507309337.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T. y Rice, M. E. (2006). Sixty-six years of research on the clinical versus actuarial prediction of violence. *The Counseling Psychologist*, 34(3), 400-409. doi: 10.1177/0011000005285877.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T. y Rice, M. E. (2010). *Risk assessment for domestically violent men. Tools for criminal justice, offender intervention and victim services*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Popham, S. y Lang, C. (2010). Risk assessment among incarcerated male domestic violence offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 37(8), 815-832. doi: 10.1177/0093854810368937.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rawson, K. y Beach, C. A. (2005). Communicating violence risk information to forensic decision makers. *Criminal Justice and Behavior*, 32(1), 97-116. doi: 10.1177/0093854804270630.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R. E. y Eke, A. W. (2008). An indepth actuarial assessment for wife assault recidivism: The Domestic Violence Risk Appraisal Guide. *Law and Human Behavior*, 32(2), 150-163. doi: 10.1007/s10979-007-9088-6.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Lang, C., Cormier, C. A. y Lines, K. J. (2004). A brief actuarial assessment for the prediction of wife assault recidivism: The Ontario Domestic Assault Risk Assessment. *Psychological Assessment*, 16(3), 267-275. doi: 10.1037/1040-3590.16.3.267.
- Hilton, N. Z., Popham, S., Lang, C. y Harris, G. T. (2014). Preliminary validation of the ODARA for female intimate partner violence offenders. *Partner Abuse*, 5(2), 189-203. doi: 10.1891/1946-6560.5.2.189.
- Hinton, J. W. (ed.) (1983). *Dangerousness: Problems of assessment and prediction*. Herts, Inglaterra: George Allen & Unwin.
- Ho, H., Thomson, L. y Darjee, R. (2009). Violence risk assessment: The use of the PCL:SV, HCR-20, and VRAG to predict violence in mentally disordered offenders discharged from a medium secure unit in Scotland. *The Journal of Forensic Psychiatry*

- & *Psychology*, 20(4), 523-541. doi: 10.1080/14789940802638358.
- Ho, R. M. Y., Lau, J. S. F., Cheung, H. H. K., Lai, T. T. S., Tam, V. F. L., Chan, W. L., ... y Yan, C. K. (2013). Evaluation of a model of violence risk assessment (HCR-20) among adult patients discharged from a gazetted psychiatric hospital in Hong Kong. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 24(4), 479-495. doi: 10.1080/14789949.2013.809467.
- Hodges, H. y Heilbrun, K. (2009). Psychopathy as a predictor of instrumental violence among civil psychiatric patients. *International Journal of Forensic Mental Health*, 8(2), 131-141. doi: 10.1080/14999010903199373.
- Hoge, R. D. y Andrews, D. A. (2009). *Evaluation for risk of violence in juveniles*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Hoge, R. D. y Andrews, D. A. (2011). *Youth level of service/case management inventory 2.0 (YLS/CMI 2.0). User's Manual*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Hoge, R. D., Andrews, D. A. y Leschied, A. (2002). *Youth level of service/case management inventory: YLS/CMI manual*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Holtfreter, K. y Cupp, R. (2007). Gender and risk assessment: The empirical status of the LSI-R for women. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 23(4), 363-382. doi: 10.1177/1043986207309436.
- Holtzworth-Munroe, A. y Stuart, G. L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. *Psychological Bulletin*, 116(3), 476-497. doi: 10.1037//0033-2909.116.3.476.
- Huff, R. L. (1936). Is parole prediction a science? *Journal of Criminal Law and Criminology*, 27(2), 207-213.
- Hughes, F. M., Stuart, G. L., Gordon, K. C. y Moore, T. M. (2007). Predicting the use of aggressive conflict tactics in a sample of women arrested for domestic violence. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(2), 155-176. doi: 10.1177/0265407507075406.
- Hurducas, C. C., Singh, J. P., de Ruiter, C. y Petrila, J. (2014). Violence risk assessment tools: A systematic review of surveys. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(3), 181-192. doi: 10.1080/14999013.2014.942923.
- Jacobsen, C. y Maier-Katkin, D. (2015). Breivik's sanity: Terrorism, mass murder, and the insanity defense. *Human Rights Quarterly*, 37(1), 137-152.
- Jenkins, R. L., Hart, H. H., Sperling, P. I. y Axelrad, S. (1942). Prediction of parole success: inclusion of psychiatric criteria. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 33(1), 38-46.
- Jolliffe, D. y Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 9(5), 441-476. doi: 10.1016/j.avb.2003.03.001.
- Kanters, T., Hornsvelt, R. H. J., Nunes, K. L., Huijding, J., Zwets, A. J., Snowden, R. J., ... y Van Marle, H. J. C. (2016). Are child abusers sexually attracted to submissiveness? Assessment of sex-related cognition with the Implicit Association Test. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 28(5), 448-468. doi: 10.1177/1079063214544330.
- Kemshall, H. (2003). *Understanding risk in criminal justice*. Maidenhead, Inglaterra: Open University Press.
- Kemshall, H. (2008). *Understanding the community management of high risk offenders*. Maidenhead, Inglaterra: Open University Press.
- Kingsnorth, R. (2006). Intimate partner violence: Predictors of recidivism in a sample of arrestees. *Violence Against Women*, 12(10), 917-935. doi: 10.1177/1077801206293081.
- Kötter, S., von Franqué, F., Bolzmacher, M., Eucker, S., Holzinger, B. y Müller-Isberner, R. (2014). The HCR-20V3 in Germany. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 122-129. doi: 10.1080/14999013.2014.911784.
- Kozol, H. L., Boucher, R. J. y Garofalo, R. F. (1972). The diagnosis and treatment of dangerousness. *Crime & Delinquency*, 18(4), 371-392. doi: 10.1177/00112877201800407.
- Krauss, D., McCabe, J. y McFadden, S. (2009). Limited expertise and experts: Problems with the continued use of future dangerousness in capital sentencing. En R. Schopp, R. Wiener, B. Bornstein y S. Wilborn (eds.), *Mental disorders and criminal law, responsibility punishment, and competency* (pp. 135-158). Nueva York, NY: Springer.
- Kroner, D. G. y Mills, J. F. (2001). The accuracy of five risk appraisal instruments in predicting institutional misconduct and new convictions. *Criminal Justice and Behavior*, 28(4), 471-489. doi: 10.1177/009385480102800405.

- Kropp, P. R. (2004). Some questions regarding Spousal Assault Risk Assessment. *Violence Against Women*, 10(6), 676-697. doi: 10.1177/1077801204265019.
- Kropp, P. R. (2008). Development of the spousal assault risk assessment guide (SARA) and the brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER). En A. C. Baldry y F. W. Winkel (eds.), *Intimate partner violence prevention and intervention: The risk assessment and management approach* (pp. 19-31). Hauppauge, NY: Nova Science.
- Kropp, P. R. y Hart, S. D. (2000). The spousal assault risk assessment (SARA) guide: Reliability and validity in adult male offenders. *Law and Human Behavior*, 24(1), 101-118. doi: 10.1023/A:1005430904495.
- Kropp, P. R. y Hart, S. D. (2004). *The development of the brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER): A tool for criminal justice professionals*. Vancouver, Canadá: Department of Justice Canada.
- Kropp, P. R. y Hart, S. D. (2016). *SARA-V3. User manual for the version 3 of the spousal assault risk assessment guide*. Vancouver, Canadá: Proactive Resolutions.
- Kropp, P. R., Belfrage, H. y Hart, S. D. (2013). *Assessment of risk for honour violence (Patriarch). User manual*. Vancouver, Canadá: ProActive ReSolutions.
- Kropp, P. R., Hart, S. D. y Belfrage, H. (2005). *Brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER): User manual*. Vancouver, Canadá: Proactive Resolutions.
- Kropp, P. R., Hart, S. D. y Belfrage, H. (2010). *Brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER): User manual* (2.^a ed). Vancouver, Canadá: Proactive Resolutions.
- Kropp, P. R., Hart, S. D. y Lyon, D. R. (2008). *Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM). User manual*. Vancouver, Canadá: ProActive ReSolutions Inc.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., Lyon, D. R. y Storey, J. E. (2011). The development and validation of the guidelines for stalking assessment and management. *Behavioral Sciences & the Law*, 29(2), 302-316. doi: 10.1002/bsl.978.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., Webster, C. D. y Eaves, D. (1995). *Manual for the spousal assault risk assessment guide* (2.^a ed.). Vancouver, Canadá: British Columbia Institute on Family Violence.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., Webster, C. D. y Eaves, D. (1999). *Spousal assault risk assessment guide (SARA)*. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Kropp, P. R. y Gibas, A. (2010). The spousal assault assessment guide (SARA). En R. K. Otto y K. S. Douglas (eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 227-250). Nueva York, NY: Routledge.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. y Lozano, R. (eds.). (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.
- Krzanowski, W. J. y Hand, D. J. (2009). *ROC curves for continuous data*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Kwartner, P. P., Lyons, P. M. y Boccaccini, M. T. (2006). Judges' risk communication preferences in risk for future violence cases. *International Journal of Forensic Mental Health*, 5(2), 185-194. doi: 10.1080/14999013.2006.10471242.
- Landa-Gorostiza, J.-M. (ed.) (2014). *Delincuentes peligrosos*. Madrid: Trotta.
- Langhinrichsen-Rohling, J., McCullars, A. y Misra, T. A. (2012). Motivations for men and women's intimate partner violence perpetration: A comprehensive review. *Partner Abuse*, 3(4), 429-468. doi: 10.1891/1946-6560.3.4.429.
- Langton, C. M., Hogue, T. E., Daffern, M., Mannion, A. y Howells, K. (2009). Prediction of institutional aggression among personality disordered forensic patients using actuarial and structured clinical risk assessment tools: prospective evaluation of the HCR-20, VRS, Static-99, and Risk Matrix 2000. *Psychology, Crime & Law*, 15(7), 635-659. doi: 10.1080/10683160802516224.
- Lanne, W. F. (1935). Parole prediction as science. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 26(3), 377-400.
- Larrauri, E. (2007). *Criminología crítica y violencia de género*. Madrid, España: Trotta.
- Laune, F. F. (1935). Technique for developing criteria of parolability. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 26(1), 41-45.
- León-Mayer, E., Cortés, M. S. y Folino, J. (2014). Descripción multidimensional de la población carcelaria chilena. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 13(1), 68-81.
- Levene, K. S., Augimeri, L. K., Pepler, D. J., Walsh, M. M., Webster, C. D. y Koegl, C. J. (2001). *Early assessment risk list for girls, EARL-21G (Version*

- I.). Toronto, Canadá: Earls Court Child and Family Centre.
- Levinson, R. M. y York, M. Z. (1974). The attribution of «dangerousness» in mental health evaluations. *Journal of health and social behavior*, 15(4), 328-335. doi: 10.2307/2137093.
- Lewis, G. y Doyle, M. (2009). Risk formulation: What are we doing and why? *International Journal of Forensic Mental Health*, 8(4), 286-292. doi: 10.1080/14999011003635696.
- Lila, M., Oliver, A., Galiana, L. y Gracia, E. (2013). Predicting success indicators of an intervention programme for convicted intimate-partner violence offenders: the Contexto Programme. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 5(1), 73-95.
- Lila, M., Oliver, A., Lorenzo, M. V. y Catalá, A. (2013). Valoración del riesgo de reincidencia en violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: importancia del apoyo social. *Revista de Psicología Social*, 28(2), 225-236.
- Lindgren, M. y Bandhold, H. (2009). *Scenario Planning. The link between future and strategy (Revised and updated edition)*. Hampshire, Inglaterra: Palgrave Macmillan.
- Llor-Esteban, B., García-Jiménez, J. J., Ruiz-Hernández, J. A. y Godoy-Fernández, C. (2016). Profile of partner aggressors as a function of risk of recidivism. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 16(01), 39-46.
- Lloyd, M. y Dean, C. (2015). The development of structured guidelines for assessing risk in extremist offenders. *Journal of Threat Assessment and Management*, 2(1), 40-52. doi: 10.1037/tam0000035.
- Lodewijks, H. P. B., de Ruiter, C. y Doreleijers, T. A. H. (2008). Gender Differences in Violent Outcome and Risk Assessment in Adolescent Offenders After Residential Treatment. *International Journal of Forensic Mental Health*, 7(2), 133-146. doi: 10.1080/14999013.2008.9914410.
- Lodewijks, H. P. B., Doreleijers, T. A. H., de Ruiter, C. y Borum, R. (2008). Predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) during residential treatment. *International Journal of Law and Psychiatry*, 31(3), 263-271. doi: 10.1016/j.ijlp.2008.04.009.
- Loftus, A. P. T. (1974). Predicting recidivism using the Glueck social prediction scale with male first offender delinquents. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 7(1), 31-43. doi: 10.1177/000486587400700105.
- Logan, C. (2008). Sexual deviance in females: Psychopathology and theory. En D. R. Laws y W. T. O'Donohue (eds.), *Sexual deviance: Theory, assessment, and treatment* (pp. 486-507). Nueva York, NY: Guilford.
- Logan, C. (2014). The HCR-20 Version 3: A case study in risk formulation. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 172-180. doi: 10.1080/14999013.2014.906516.
- Logan, C. (2016). Structured professional judgment: applications to sexual offender risk assessment and management. En A. Phenix y M. H. Hoberman (eds.), *Sexual Offending: Predisposing Antecedents, Assessments and Management* (pp. 571-588). Nueva York, NY: Springer.
- Logan, C., Nathan, R. y Brown, A. (2011). Formulation in clinical risk assessment and management. En R. Whittington y C. Logan (eds.), *Self-harm and violence* (pp. 187-204). Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Loinaz, I. (2011). Clasificación de agresores de pareja en prisión. Implicaciones terapéuticas y de gestión del riesgo. En VV.AA., *Intervención con agresores de violencia de género* (pp. 153-276). Barcelona, España: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.
- Loinaz, I. (2013a). Carrera delictiva y reincidencia en agresores de pareja en prisión. En R. E. Castillejos y C. C. Alonso (eds.), *Violencia de género y justicia* (pp. 647-676). Santiago de Compostela, España: Universidad de Santiago de Compostela.
- Loinaz, I. (2013b). Psicopatología y delincuencia. En M. Ortiz-Tallo (ed.), *Psicopatología Clínica* (páginas 153-165). Madrid, España: Pirámide.
- Loinaz, I. (2014a). Mujeres delincuentes violentas. *Psychosocial Intervention*, 23(3), 187-198. doi: 10.1016/j.psi.2014.05.001.
- Loinaz, I. (2014b). Typologies, risk and recidivism in partner-violent men with the B-SAFER: a pilot study. *Psychology, Crime & Law*, 20(2), 183-198. doi: 10.1080/1068316x.2013.770854.
- Loinaz, I. (2016). Cuando «el» delincuente es «ella»: intervención con mujeres violentas. *Anuario de psicología jurídica*, 26, 41-50. doi: 10.1016/j.apj.2016.04.006.

- Loinaz, I., Echeburúa, E. e Irureta, M. (2011). Trastornos mentales como factor de riesgo de victimización violenta. *Behavioral Psychology / Psicología Conductual*, 19(2), 421-438.
- Loinaz, I., Echeburúa, E. y Torrubia, R. (2010). Tipología de agresores contra la pareja en prisión. *Psicothema*, 22(1), 106-111.
- Loinaz, I., Echeburúa, E., Ortiz-Tallo, M. y Amor, P. J. (2012). Propiedades psicométricas de la Conflict Tactics Scales (CTS-2) en una muestra española de agresores de pareja. *Psicothema*, 24(1), 142-148.
- Loinaz, I., Nguyen, T., Navarro, J. C. y Andrés-Pueyo, A. (2016). *RSVP: Protocolo para la valoración del riesgo de violencia sexual*. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
- López-Ossorio, J. J., González-Álvarez, J. L. y Andrés-Pueyo, A. (2016). Eficacia predictiva de la valoración policial del riesgo de la violencia de género. *Psychosocial Intervention*, 25(1), 1-7. doi: 10.1016/j.psi.2015.10.002.
- Luque, M. E., Ferrer, M. y Capdevila, M. (2005). *La reincidència penitenciària a Catalunya*. Barcelona, España: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.
- MacKenzie, R. D., McEwan, T. E., Pathé, M. T., James, D. V., Ogloff, J. R. P. y Mullen, P. E. (2009). *Stalking risk profile: Guidelines for the assessment and management of stalkers*. Melbourne, Australia: StalkInc & Centre for Forensic Behavioural Science, Monash University.
- MacLeod, J. F., Grove, P. G. y Farrington, D. P. (2012). *Explaining criminal careers. Implications for justice policy*. Croydon, Inglaterra: Oxford University Press.
- Maibom, H. (2008). The Mad, the Bad, and the Psychopath. *Neuroethics*, 1(3), 167-184. doi: 10.1007/s12152-008-9013-9.
- Manchak, S. M., Skeem, J. L. y Douglas, K. S. (2008). Utility of the revised Level of Service Inventory (LSI-R) in predicting recidivism after long-term incarceration. *Law and Human Behavior*, 32(6), 477-488. doi: 10.1007/s10979-007-9118-4.
- Manchak, S. M., Skeem, J. L., Douglas, K. S. y Siranosian, M. (2009). Does gender moderate the predictive utility of the Level of Service Inventory-Revised (LSI-R) for serious violent offenders? *Criminal Justice and Behavior*, 36(5), 425-442. doi: 10.1177/0093854809333058.
- Martelli, A. (2014). *Models of scenario building and planning: Facing uncertainty and complexity*. Hampshire, Inglaterra: Palgrave Macmillan.
- Martínez, L. (2014). La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad: consecuencias para la dogmática de las medidas de seguridad. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 21(4), 1-77.
- Martínez, M., Hilterman, E. y Andrés Pueyo, A. (2005). *SVR-20 Manual de Valoración del Riesgo de Violencia Sexual*. Barcelona, España: Servicio de publicaciones de la Universidad de Barcelona.
- Martínez, R., Flores, J. y Rosenfeld, B. (2007). Validity of the juvenile sex offender assessment protocol-II (J-SOAP-II) in a sample of urban minority youth. *Criminal Justice and Behavior*, 34(10), 1284-1295. doi: 10.1177/0093854807301791.
- McCue, M. L. (2008). *Domestic violence: A reference handbook* (2.^a ed.). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- McCusker, P. J. (2007). Issues regarding the clinical use of the Classification of Violence Risk (COVR) assessment instrument. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 51(6), 676-685. doi: 10.1177/0306624x07299227.
- McEwan, T. E., Pathé, M. y Ogloff, J. R. P. (2011). Advances in stalking risk assessment. *Behavioral Sciences & the Law*, 29(2), 180-201. doi: 10.1002/bsl.973.
- McEwan, T. E., Shea, D. E., Daffern, M., MacKenzie, R. D., Ogloff, J. R. P. y Mullen, P. E. (2016). The reliability and predictive validity of the Stalking Risk Profile. *Assessmen*, en prensa. doi: 10.1177/1073191116653470.
- McMurran, M. y Howard, R. C. (eds.) (2009). *Personality, personality disorder and violence*. Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Meehl, P. E. (1954). *Clinical versus statistical prediction: A theoretical analysis and a review of the evidence*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.
- Megargee, E. I. (1976). The prediction of dangerous behavior. *Criminal Justice and Behavior*, 3(1), 3-22. doi: 10.1177/009385487600300101.
- Meloy, J. R. y Gill, P. (2016). The lone-actor terrorist and the TRAP-18. *Journal of Threat Assessment and Management*, 3(1), 37-52. doi: 10.1037/tam0000061.
- Meloy, J. R. y O'Toole, M. E. (2011). The concept of Leakage in threat assessment. *Behavioral Sciences & the Law*, 29(4), 513-527. doi: 10.1002/bsl.986.

- Meloy, J. R. y Yakeley, J. (2014). The violent true believer as a «Lone Wolf» – psychoanalytic perspectives on terrorism. *Behavioral Sciences & the Law*, 32(3), 347-365. doi: 10.1002/bsl.2109.
- Meloy, J. R., Habermeyer, E. y Guldemann, A. (2015). The warning behaviors of Anders Breivik. *Journal of Threat Assessment and Management*, 2(3-4), 164-175. doi: 10.1037/tam0000037.
- Meloy, J. R., Hoffmann, J., Guldemann, A. y James, D. (2012). The role of warning behaviors in threat assessment: An exploration and suggested typology. *Behavioral Sciences & the Law*, 30(3), 256-279. doi: 10.1002/bsl.999.
- Meloy, J. R., Mohandie, K., Knoll, J. L. y Hoffmann, J. (2015). The concept of Identification in threat assessment. *Behavioral Sciences & the Law*, 33(2-3), 213-237. doi: 10.1002/bsl.2166.
- Meloy, J. R., Roshdi, K., Glaz-Ocik, J. y Hoffmann, J. (2015). Investigating the individual terrorist in Europe. *Journal of Threat Assessment and Management*, 2(3-4), 140-152. doi: 10.1037/tam0000036.
- Meloy, J. R., White, S. G. y Hart, S. (2013). Workplace assessment of targeted violence risk: The development and reliability of the WAVR-21. *Journal of Forensic Sciences*, 58(5), 1353-1358. doi: 10.1111/1556-4029.12196.
- Menzies, R. J., Webster, C. D. y Sepejak, D. S. (1985). The dimensions of dangerousness: Evaluating the accuracy of psychometric predictions of violence among forensic patients. *Law and Human Behavior*, 9(1), 49-70. doi: 10.1007/bf01044289.
- Mesnikoff, A. M. y Lauterbach, C. G. (1975). The association of violent dangerous behavior with psychiatric disorders: A review of the research literature. *Journal of Psychiatry & Law*, 3, 415-446.
- Messing, J. T. y Thaller, J. (2013). The average predictive validity of intimate partner violence risk assessment instruments. *Journal of Interpersonal Violence*, 28(7), 1537-1558. doi: 10.1177/0886260512468250.
- Messing, J. T., Amanor-Boadu, Y., Cavanaugh, C. E., Glass, N. y Campbell, J. C. (2013). Culturally competent intimate partner violence risk assessment: Adapting the Danger Assessment for immigrant women. *Social Work Research*, 37(3), 263-275.
- Messing, J. T., Campbell, J., Sullivan Wilson, J., Brown, S. y Patchell, B. (2015). The Lethality Screen: The predictive validity of an intimate partner violence risk assessment for use by first responders. *Journal of Interpersonal Violence*, en prensa. doi: 10.1177/0886260515585540.
- Meyers, J. R. y Schmidt, F. (2008). Predictive validity of the Structured Assessment for Violence Risk in Youth (SAVRY) with juvenile offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 35(3), 344-355. doi: 10.1177/0093854807311972.
- Miguel-Tobal, J. J., Casado, M. I., Cano-Vindel, A. y Spielberger, C. D. (2001). *Inventario de expresión de ira estado-rasgo: STAXI-2*. Madrid, España: TEA.
- Miller, H. A. (2006). *Inventory of Offender Risk, Needs, and Strengths (IORNIS): Professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Miller, H. A., Turner, K. y Henderson, C. E. (2009). Psychopathology of sex offenders: A comparison of males and females using latent profile analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 36(8), 778-792. doi: 10.1177/0093854809336400.
- Miller, M. y Morris, N. (1988). Predictions of dangerousness: An argument for limited use. *Violence and Victims*, 3(4), 263-283.
- Miller, S. J., Dinitz, S. y Conrad, J. P. (1982). *Careers of the violent: The dangerous offender and Criminal Justice*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Mills, J. F., Kroner, D. G. y Morgan, R. D. (2011). *Clinician's guide to violence risk assessment*. Nueva York, NY: The Guilford Press.
- Ministerio de Justicia (2011). *Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género*. Madrid, España: Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica.
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674-701.
- Moffitt, T. E. (2003). Life-course-persistent and adolescence-limited antisocial behavior: A 10-year research review and a research agenda. En B. B. Lahey, T. E. Moffitt y A. Caspi (eds.), *Causes of conduct disorder and juvenile delinquency* (pp. 49-75). Nueva York, NY: Guilford Press.
- Moffitt, T. E., Caspi, A., Harrington, H. y Milne, B. J. (2002). Males on the life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways: Follow-up at age 26 years. *Development and Psychopathology*, 14(1), 179-207.
- Moffitt, T. E., Caspi, A., Rutter, M. y Silva, P. A. (2001). *Sex differences in antisocial behaviour: Con-*

- duct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin longitudinal study. Nueva York, NY: Cambridge University Press.
- Mokros, A., Gebhard, M., Heinz, V., Marschall, R. W., Nitschke, J., Glasgow, D. V., ... y Laws, D. R. (2013). Computerized assessment of pedophilic sexual interest through self-report and viewing time: Reliability, validity, and classification accuracy of the affinity program. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 25(3), 230-258. doi: 10.1177/1079063212454550.
- Monachesi, E. D. (1941). An evaluation of recent major efforts at prediction. *American Sociological Review*, 6(4), 478-486.
- Monachesi, E. D. (1945). A comparison of predicted with actual results of probation. *American Sociological Review*, 10(1), 26-31.
- Monachesi, E. D. (1950). American studies in the prediction of recidivism. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 41(3), 268-289.
- Monahan, J. (1981). *The clinical prediction of violent behavior*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Monahan, J. (1984). The prediction of violent behavior: toward a second generation of theory and policy. *American Journal of Psychiatry*, 141(1), 10-15.
- Monahan, J. (1988). Risk assessment of violence among the mentally disordered: Generating useful knowledge. *International Journal of Law and Psychiatry*, 11(3), 249-257. doi: 10.1016/0160-2527(88)90012-X.
- Monahan, J. (1996). Violence prediction: The past twenty and the next twenty years. *Criminal Justice and Behavior*, 23(1), 107-120. doi: 10.1177/0093854896023001008.
- Monahan, J. (2012). The individual risk assessment of terrorism. *Psychology, Public Policy, and Law*, 18, 167-205. doi: 10.1037/a0025792.
- Monahan, J. (2013). Violence risk assessment. En I. B. Weiner (Ed.), *Handbook of Psychology (vol. 11: Forensic psychology)* (2.^a ed., pp. 541-555). Hoboken, NJ: Wiley.
- Monahan, J. y Cummings, L. (1974). Prediction of dangerousness as a function of its perceived consequences. *Journal of Criminal Justice*, 2(3), 239-242. doi: 10.1016/0047-2352(74)90035-X.
- Monahan, J. y Steadman, H. J. (1996). Violent storms and violent people: How meteorology can inform risk communication in mental health law. *American Psychologist*, 51(9), 931-938. doi: 10.1037/0003-066x.51.9.931.
- Monahan, J. y Steadman, H. J. (eds.) (1994). *Violence and mental disorder. Developments in risk assessment*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Monahan, J., Heilbrun, K., Silver, E., Nabors, E., Bone, J. y Slovic, P. (2002). Communicating violence risk: frequency formats, vivid outcomes, and forensic settings. *International Journal of Forensic Mental Health*, 1(2), 121-126. doi: 10.1080/14999013.2002.10471167.
- Monahan, J., Steadman, H. J., Appelbaum, P. S., Grisso, T., Mulvey, E. P., Roth, L. H., ... y Silver, E. (2006). The classification of violence risk. *Behavioral Sciences & the Law*, 24(6), 721-730. doi: 10.1002/bsl.725.
- Monahan, J., Steadman, H. J., Robbins, P. C., Appelbaum, P., Banks, S., Grisso, T., ... y Silver, E. (2005). An actuarial model of violence risk assessment for persons with mental disorders. *Psychiatric Services*, 56(7), 810-815. doi: 10.1176/appi.ps.56.7.810.
- Monahan, J., Steadman, H. J., Robbins, P. C., Silver, E., Appelbaum, P. S., Grisso, T., y Roth, L. H. (2000). Developing a clinically useful actuarial tool for assessing violence risk. *The British Journal of Psychiatry*, 176(4), 312-319. doi: 10.1192/bjp.176.4.312.
- Monahan, J., Steadman, H., Silver, E., Appelbaum, P., Robbins, P., Mulvey, E., ... y Banks, S. (2001). *Rethinking risk assessment: The MacArthur study of mental disorders and violence*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Montero, V. (1966). La aplicación de la escala de predicción Glueck a 50 menores en la cultura puertorriqueña. *Revista de Ciencias Sociales*, X(1), 105-116.
- Moral, I. (2006a). Medidas de frecuencia de la enfermedad. En A. Guillém y R. Crespo (eds.), *Métodos estadísticos para enfermería nefrológica* (pp. 215-223). Madrid, España: SEDEN.
- Moral, I. (2006b). Modelos de regresión: lineal simple y regresión logística. En A. Guillém y R. Crespo (eds.), *Métodos estadísticos para enfermería nefrológica* (pp. 195-213). Madrid, España: SEDEN.
- Mulvey, E. P. y Lidz, C. W. (1984). Clinical considerations in the prediction of dangerousness in mental

- patients. *Clinical Psychology Review*, 4(4), 379-401. doi: 10.1016/0272-7358(84)90018-7.
- Muñoz, J. M. y López-Ossorio, J. J. (2016). Valoración psicológica del riesgo de violencia: alcance y limitaciones para su uso en el contexto forense. *Anuario de Psicología Jurídica*, 26(1), 130-140. doi: 10.1016/j.apj.2016.04.005.
- Neves, A. C., Abrunhosa, R. y Palma-Oliveira, J. M. (2011). Assessing risk for violent and general recidivism: A study of the HCR-20 and the PCL-R with a non-clinical sample of portuguese offenders. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(2), 137-149. doi: 10.1080/14999013.2011.577290.
- Nguyen, T. y Andrés-Pueyo, A. (2016). *Validez predictiva del SVR-20 y la Static-99 en una muestra de agresores sexuales en Cataluña*. Barcelona, España: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.
- NICE (2005). *Violence: The short-term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments*. Recuperado de <http://www.nice.org.uk/guidance/cg25>.
- NICE (2015). *Violence and aggression: Short-term management in mental health, health and community settings*. Inglaterra: National Institute for Health and Care Excellence.
- Nicholls, T. L., Ogloff, J. R. P. y Douglas, K. S. (2004). Assessing risk for violence among male and female civil psychiatric patients: The HCR-20, PCL:SV, and VSC. *Behavioral Sciences and the Law*, 22(1), 127-158. doi: 10.1002/bsl.579.
- Nicholls, T. L., Pritchard, M. M., Reeves, K. A. y Hilberman, E. (2013). Risk assessment in intimate partner violence: A systematic review of contemporary approaches. *Partner Abuse*, 4(1), 76-168. doi: 10.1891/1946-6560.4.1.76.
- Nicholls, T. L., Viljoen, J. L., Cruise, K. R., Desmarais, S. L. y Webster, C. D. (2010). *Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) (abbreviated manual)*. Coquitlam, Canadá: BC Mental Health and Addiction Services.
- Novaco, R. W. (2003). *Novaco Anger Scale and Provocation Inventory (NAS-PI)*. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
- Nunes, K. L., Firestone, P. y Baldwin, M. W. (2007). Indirect assessment of cognitions of child sexual abusers with the Implicit Association Test. *Criminal Justice and Behavior*, 34(4), 454-475. doi: 10.1177/0093854806291703.
- Nunes, K. L., Hermann, C. A. y Ratcliffe, K. (2013). Implicit and explicit attitudes toward rape are associated with sexual aggression. *Journal of Interpersonal Violence*, 28(13), 2657-2675. doi: 10.1177/0886260513487995.
- Ogilvie, C. A., Newman, E., Todd, L. y Peck, D. (2014). Attachment and violent offending: A meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 19(4), 322-339. doi: 10.1016/j.avb.2014.04.007.
- Ohlin, L. E. y Duncan, O. D. (1949). The efficiency of prediction in criminology. *American Journal of Sociology*, 54(5), 441-452.
- O'Leary, K. D., Smith Slep, A. M. y O'Leary, S. G. (2007). Multivariate models of men's and women's partner aggression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 75(5), 752-764. doi: 10.1037/0022-006x.75.5.752.
- Olmedo, M. y González, P. (2006). La violencia en el ámbito laboral: La problemática conceptualización del mobbing, su evaluación, prevención y tratamiento. *Acción Psicológica*, 4(2), 107-128.
- Olver, M. E. y Wong, S. C. P. (2011). A comparison of static and dynamic assessment of sexual offender risk and need in a treatment context. *Criminal Justice and Behavior*, 38(2), 113-126. doi: 10.1177/0093854810389534.
- Olver, M., Stockdale, K. y Wong, S. (2012). Short and long-term prediction of recidivism using the Youth Level of Service/Case Management Inventory in a sample of serious young offenders. *Law and Human Behavior*, 36(4), 331-344. doi: 10.1037/h0093927.
- Olver, M. E., Stockdale, K. C. y Wormith, J. S. (2009). Risk assessment with young offenders: A meta-analysis of three assessment measures. *Criminal Justice and Behavior*, 36(4), 329-353. doi: 10.1177/0093854809331457.
- Olver, M. E., Stockdale, K. C. y Wormith, J. S. (2014). Thirty years of research on the Level of Service Scales: A meta-analytic examination of predictive accuracy and sources of variability. *Psychological Assessment*, 26(1), 156-176. doi: 10.1037/a0035080.
- OMS (2011). *Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres. Qué hacer y cómo obtener evidencias*. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud.
- OMS (2014). *Global status report on violence prevention 2014*. Ginebra, Suiza: World Health Organization.

- Onifade, E., Davidson, W. y Campbell, C. (2009). Risk assessment: The predictive validity of the Youth Level of Service Case Management Inventory with African Americans and girls. *Journal of Ethnicity in Criminal Justice*, 7(3), 205-221. doi: 10.1080/15377930903143544.
- Oquendo, M. A., Baca-García, E., Graver, R., Morales, M., Montalbán, V. y Mann, J. J. (2001). Spanish adaptation of the Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11). *European Journal of Psychiatry*, 15, 147-155.
- Ostrosky-Solis, F., Romero, C., Velez, A. y Villalpando, R. O. (2009). Asociaciones implícitas como método para la detección de violencia y psicopatía. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 4(2), 170-178.
- Ostrowsky, M. K. (2010). Are violent people more likely to have low self-esteem or high self-esteem? *Aggression and Violent Behavior*, 15(1), 69-75. doi: 10.1016/j.avb.2009.08.004.
- Otto, R. K. (1992). Prediction of dangerous behavior: A review and analysis of «second-generation» research. *Forensic Reports*, 5(1), 103-133.
- Otto, R. K. y Douglas, K. S. (eds.). (2010). *Handbook of violence risk assessment*. Nueva York, NY: Routledge.
- Palmer, E. J. y Hollin, C. R. (2007). The Level of Service Inventory-Revised With English Women Prisoners: A Needs and Reconviction Analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 34(8), 971-984. doi: 10.1177/0093854807300819.
- Patton, J. H., Stanford, M. S. y Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *Journal of Clinical Psychology*, 6, 768-774.
- Payton, J. (2014). «Honor» collectivity, and agnation: Emerging risk factors in «honor»-based violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(16), 2863-2883. doi: 10.1177/0886260514527171.
- Penney, S. R., Lee, Z. y Moretti, M. M. (2010). Gender differences in risk factors for violence: an examination of the predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth. *Aggressive Behavior*, 36(6), 390-404. doi: 10.1002/ab.20352.
- Peña, X. (2009). Gestión de la calidad en las actuaciones de la policía del País Vasco (Ertzaintza) en violencia doméstica y de género. *Revista Catalana de Seguretat Pública*, 20, 143-162.
- Pérez, M., Redondo, S., Martínez, M., García-Forero, C. y Andrés-Pueyo, A. (2008). Predicción de riesgo de reincidencia en agresores sexuales. *Psicothema*, 20(2), 205-210.
- Pérez-Luco, R., Lagos, L. y Báez, C. (2012). Reincidencia y desistimiento en adolescentes infractores: análisis de trayectorias delictivas a partir de autorreporte de delitos, consumo de sustancias y juicio profesional. *Universitas Psychologica*, 11(4), 1209-1225.
- Peter, T. (2006). Mad, bad, or victim? Making sense of mother-daughter sexual abuse. *Feminist Criminology*, 1(4), 283-302. doi: 10.1177/1557085106292779.
- Petersson, J., Strand, S. y Selenius, H. (2016). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. *Journal of Interpersonal Violence*, en prensa. doi: 10.1177/0886260516640547.
- Petrunk, M. (1982). The politics of dangerousness. *International Journal of Law and Psychiatry*, 5(3-4), 225-253. doi: 10.1016/0160-2527(82)90021-8.
- Phenix, A. y Epperson, D. L. (2016). Overview of the development, reliability, validity, scoring, and uses of the Static-99, Static-99R, Static-2002, and Static-2002R. En A. Phenix y M. H. Hoberman (eds.), *Sexual Offending: Predisposing Antecedents, Assessments and Management* (pp. 437-455). Nueva York, NY: Springer.
- Phenix, A. y Hoberman, M. H. (eds.) (2016). *Sexual offending: Predisposing antecedents, assessments and management*. Nueva York, NY: Springer.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P. y Blumstein, A. (2007). *Key issues in criminal career research. New analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development*. Nueva York, NY: Cambridge University Press.
- Piquero, A. R., Jennings, W. G. y Barnes, J. C. (2012). Violence in criminal careers: A review of the literature from a developmental life-course perspective. *Aggression and Violent Behavior*, 17(3), 171-179. doi: 10.1016/j.avb.2012.02.008.
- Piquero, A. y Mazerolle, P. (eds.) (2000). *Life-course criminology: Contemporary and classic readings*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Potegal, M., Stemmler, G. y Spielberger, C. (eds.) (2010). *International Handbook of Anger. Constituent and concomitant biological, psychological, and social processes*. Nueva York, NY: Springer.
- Potter-Efron, R. T. (ed.) (2015). *Handbook of anger management and domestic violence offender treatment*. Nueva York, NY: Taylor & Francis.

- Prentky, R. y Righthand, S. (2003). *Juvenile Sex Offender Assessment Protocol II (J-SOAP-II) Manual*. Washington D.C.: U.S. Department of Justice.
- Prentky, R., Harris, B., Frizzell, K. y Righthand, S. (2000). An actuarial procedure for assessing risk with juvenile sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 12(2), 71-93. doi: 10.1177/107906320001200201.
- Pressman, D. E. (2009). *Risk assessment decisions for violent political extremism. User Report*. Ottawa, Canadá: Public Safety Canada.
- Pressman, D. E. y Flockton, J. (2012). Calibrating risk for violent political extremists and terrorists: the VERA 2 structured assessment. *The British Journal of Forensic Practice*, 14(4), 237-251. doi: 10.1108/14636641211283057.
- Pressman, D. E. y Flockton, J. (2014). Violent extremist risk assessment: Issues and applications of the VERA-2 in a high security correctional setting. En A. Silke (ed.), *Prisons, terrorism and extremism: Critical issues in management, radicalisation and reform* (pp. 122-143). Abingdon, Inglaterra: Routledge.
- Prins, H. (1999). *Will they do it again? Risk assessment and management in criminal justice and psychiatry*. Londres, Inglaterra: Routledge.
- Pujol, A., Mohino, S. y Gómez-Durán, E. L. (2014). Valoración forense del riesgo de violencia. *Medicina Clínica*, 142 (Supl. 2), 16-23.
- Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. y Cormier, C. A. (1998). *Violent offenders: Appraising and managing risk*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. y Cormier, C. A. (2005). *Violent offenders: Appraising and managing risk* (2.^a ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
- Ragusa-Salerno, L. M., Ostermann, M. y Thomas, S. S. (2013). Does the LSI-R have utility for sex offenders? *Criminal Justice and Behavior*, 40(9), 952-969. doi: 10.1177/0093854813481667.
- Ralston, C. A., Epperson, D. L. y Edwards, S. R. (2016). Cross-validation of the JSORRAT-II in Iowa. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 28(6), 534-554. doi: 10.1177/1079063214548074.
- Ralston, C. A., Sarkar, A., Philipp, G. T. y Epperson, D. L. (2015). The impact of using documented but uncharged offense data on JSORRAT-II predictive validity. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, en prensa. doi: 10.1177/1079063215582011.
- Rappeport, J. R. (1967). *The clinical evaluation of dangerousness of the mentally ill*. Springfield, IL: C. C. Thomas.
- Rathus, J. H. y Feindler, E. L. (2004). *Assessment of partner violence: A handbook for researchers and practitioners*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Redondo, S. (2008). *Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes*. Madrid, España: Pirámide.
- Redondo, S. (2009). *Intolerancia cero: Un mundo con menos normas y sanciones, también sería posible y quizás nos gustaría más*. Barcelona, España: Sello Editorial.
- Redondo, S., Luque, E., Navarro, J. C. y Martínez, M. (2005). Análisis empírico de las características y los factores de riesgo de reincidencia de una muestra de agresores sexuales encarcelados. *Anuario de Psicología Jurídica*, 15, 135-157.
- Redondo, S., Pérez, M. y Martínez, M. (2007). El riesgo de reincidencia en agresores sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20. *Papeles del Psicólogo*, 28(3), 187-195.
- Rehfsuss, M. C., Underwood, L. A., Enright, M., Hill, S., Marshall, R., Tipton, P., ... y Warren, K. (2013). Treatment Impact of an Integrated Sex Offender Program as Measured by J-SOAP-II. *Journal of Correctional Health Care*, 19(2), 113-123. doi: 10.1177/1078345812474641.
- Reimann, B. J. y Nussbaum, D. (2011). Predicting seclusion in a medium secure forensic inpatient setting. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(2), 150-158. doi: 10.1080/14999013.2011.578299.
- Requena, L. (2014). *Principios generales de criminología del desarrollo y las carreras criminales*. Barcelona, España: J. M. Bosch.
- Rettenberger, M. y Eher, R. (2013). Actuarial risk assessment in sexually motivated intimate-partner violence. *Law and Human Behavior*, 37(2), 75-86. doi: 10.1037/b0000001.
- Rettenberger, M., Boer, D. P. y Eher, R. (2011). The predictive accuracy of risk factors in the Sexual Violence Risk-20 (SVR-20). *Criminal Justice and Behavior*, 38(10), 1009-1027. Doi: 10.1177/0093854811416908.
- Rettenberger, M., Matthes, A., Boer, D. P. y Eher, R. (2010). Prospective actuarial risk assessment: A comparison of five risk assessment instruments in diffe-

- rent sexual offender subtypes. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 54(2), 169-186. doi: 10.1177/0306624x08328755.
- Rice, M. E. y Harris, G. T. (2005). Comparing effect sizes in follow-up studies: ROC Area, Cohen's d, and r. *Law and Human Behavior*, 29(5), 615-620. doi: 10.1007/s10979-005-6832-6837.
- Rice, M. E., Harris, G. T. y Hilton, N. Z. (2010). The Violence Risk Appraisal Guide and Sex Offender Risk Appraisal Guide for Violence Risk Assessment and the Ontario Domestic Assault Risk Assessment and Domestic Violence Risk Appraisal Guide for wife assault risk assessment. En R. K. Otto y K. S. Douglas (eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment* (pp. 99-119). Nueva York, NY: Routledge.
- Righthand, S., Prentky, R., Knight, R., Carpenter, E., Hecker, J. E. y Nangle, D. (2005). Factor structure and validation of the Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP). *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 17(1), 13-30. doi: 10.1177/107906320501700103.
- Ríos, J. C. y Sáez, C. (2014). Del origen al fin de la doctrina Parot. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 3.
- Robbins, P. C., Monahan, J. y Silver, E. (2003). Mental disorder, violence, and gender. *Law and Human Behavior*, 27(6), 561-571. doi: 10.1023/B:LAHU.0000004886.13268.f2.
- Roberts, K. A., Campbell, G. y Lloyd, G. (2014). *Honor-based violence: Policing and prevention*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Rubin, B. (1972). Prediction of dangerousness in mentally ill criminals. *Arch Gen Psychiatry*, 27(3), 397-407.
- Russell, B. L. (ed.) (2013). *Perceptions of female offenders. How stereotypes and social norms affect criminal justice responses*. Nueva York, NY: Springer.
- Sánchez-SanSegundo, M., Ferrer-Cascales, R., Herranz-Bellido, J., Pastor-Bravo, M. y Hodgins, S. (2014). Subtypes of severely mentally ill violent offenders in a Spanish forensic psychiatric hospital. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(3), 217-226. doi: 10.1080/14999013.2014.922137.
- Sarbin, T. R. (1967). The dangerous individual: An outcome of social identity transformations. *British Journal of Criminology*, 7, 285-295.
- Saumench, D. (1960). *Cálculo médico legal de un índice de peligrosidad*. (Tesis doctoral), Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Recuperado de <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/58748>.
- Savage, J. (ed.) (2009). *The development of persistent criminality*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Schmidt, A. F., Gykiere, K., Vanhoeck, K., Mann, R. E. y Banse, R. (2014). Direct and indirect measures of sexual maturity preferences differentiate subtypes of child sexual abusers. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 26(2), 107-128. doi: 10.1177/1079063213480817.
- Schmidt, F., Campbell, M. A. y Houlding, C. (2011). Comparative analyses of the YLS/CMI, SAVRY, and PCL:YV in adolescent offenders: A 10-year follow-up into adulthood. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 9(1), 23-42. doi: 10.1177/1541204010371793.
- Schoemaker, P. (1995). Scenario planning: A tool for strategic thinking. *Sloan Management Review*, 37(2), 25-40.
- Schwalbe, C. S. (2007). Risk assessment for juvenile justice: A meta-analysis. *Law and Human Behavior*, 31(5), 449-462. doi: 10.1007/s10979-006-9071-7.
- Schwalbe, C. S. (2008). A meta-analysis of juvenile justice risk assessment instruments: Predictive validity by gender. *Criminal Justice and Behavior*, 35(11), 1367-1381. doi: 10.1177/0093854808324377.
- Scott, P. D. (1977). Assessing dangerousness in criminals. *The British Journal of Psychiatry*, 131(2), 127-142. doi: 10.1192/bjp.131.2.127.
- Scurich, N. y Krauss, D. A. (2013). The effect of adjusted actuarial risk assessment on mock-jurors' decisions in a sexual predator commitment proceeding. *Jurimetrics*, 53(3), 395-413.
- Scurich, N., Monahan, J. y John, R. S. (2012). Innumeracy and unpacking: Bridging the nomothetic/idiographic divide in violence risk assessment. *Law and Human Behavior*, 36(6), 548-554. doi: 10.1037/h0093994.
- Serie, C. M. B., van Tilburg, C. A., van Dam, A. y de Ruiter, C. (2015). Spousal assaulters in outpatient mental health care: The relevance of structured risk assessment. *Journal of Interpersonal Violence*, en prensa. doi: 10.1177/0886260515589932.
- Shaver, P. R. y Mikulincer, M. (2011). Introduction. En P. R. Shaver y M. Mikulincer (Eds.), *Human aggression and violence: Causes, manifestations, and consequences* (pp. 3-11). Washington, DC: American Psychological Association.

- Shaw, S. H. (1973). The dangerousness of dangerousness. *Medicine, Science and the Law*, 13(4), 269-271. doi: 10.1177/002580247301300410.
- Sher, M. A. y Gralton, E. (2014). Implementation of the START:AV in a secure adolescent service. *The Journal of Forensic Practice*, 16(3), 184-193. doi: 10.1108/JFP-04-2013-0021.
- Shorey, R. C., Meltzer, C. y Cornelius, T. L. (2010). Motivations for self-defensive aggression in dating relationships. *Violence and Victims*, 25(5), 662-676. doi: 10.1891/0886-6708.25.5.662.
- Shuman, D. W. y Darwin-Looney, B. (2008). Legal issues of prediction, protection, and expertise. En R. I. Simon y K. Tardiff (eds.), *Textbook of violence assessment and management*. Washington, DC: American Psychiatric Pub.
- Silke, A. (2014). Risk assessment of terrorist and extremist prisoners. En A. Silke (ed.), *Prisons, terrorism and extremism: Critical issues in management, radicalisation and reform* (pp. 109-121). Abingdon, Inglaterra: Routledge.
- Simmons, C. A., Lehmann, P. y Cobb, N. (2008). A comparison of women versus men charged with intimate partner violence: General risk factors, attitudes regarding using violence, and readiness to change. *Violence and Victims*, 23(5), 571-585. doi: 10.1891/0886-6708.23.5.571.
- Simmons, C. A., Lehmann, P. y Cobb, N. (2009). A comparison of women versus men charged with intimate partner violence: General risk factors, attitudes regarding using violence, and readiness to change. En C. Murphy y R. D. Maiuro (eds.), *Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence* (pp. 89-131). Nueva York, NY: Springer.
- Singh, J. P. (2013). Predictive validity performance indicators in violence risk assessment: A methodological primer. *Behavioral Sciences & the Law*, 31(1), 8-22. doi: 10.1002/bsl.2052.
- Singh, J. P. y Fazel, S. (2010). Forensic risk assessment: A meta-review. *Criminal Justice and Behavior*, 37(9), 965-988. doi: 10.1177/0093854810374274.
- Singh, J. P., Bjørkly, S. y Fazel, S. (Eds.) (2016). *International perspectives on violence risk assessment*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Singh, J. P., Condemarin, C. y Folino, J. (2013). El uso de instrumentos de evaluación de riesgo de violencia en Argentina y Chile. *Revista Criminalidad*, 55(3), 279-290.
- Singh, J. P., Desmarais, S. L., Hurducas, C., Arbach, K., Condemarin, C., Dean, K., ... y Otto, R. K. (2014). International perspectives on the practical application of violence risk assessment: a global survey of 44 countries. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(3), 193-206. doi: 10.1080/14999013.2014.922141.
- Singh, J. P., Desmarais, S. L., Sellers, B. G., Hylton, T., Tirotti, M. y Van Dorn, R. A. (2014). From risk assessment to risk management: Matching interventions to adolescent offenders' strengths and vulnerabilities. *Children and Youth Services Review*, 47, 1-9. doi: 10.1016/j.childyouth.2013.09.015.
- Singh, J. P., Grann, M. y Fazel, S. (2011). A comparative study of violence risk assessment tools: A systematic review and metaregression analysis of 68 studies involving 25,980 participants. *Clinical Psychology Review*, 31(3), 499-513. doi: 10.1016/j.cpr.2010.11.009.
- Singh, J. P., Grann, M. y Fazel, S. (2013). Authorship bias in violence risk assessment? A systematic review and meta-analysis. *Plos One*, 8(9), e72484. doi: 10.1371/journal.pone.0072484.
- Skeem, J., Schubert, C., Stowman, S., Beeson, S., Mulvey, E., Gardner, W. y Lidz, C. (2005). Gender and risk assessment accuracy: Underestimating women's violence potential. *Law and Human Behavior*, 29(2), 173-186. doi: 10.1007/s10979-005-3401-z.
- Slovic, P., Monahan, J. y MacGregor, D. (2000). Violence risk assessment and risk communication: The effects of using actual cases, providing instruction, and employing probability versus frequency formats. *Law and Human Behavior*, 24(3), 271-296. doi: 10.1023/A:1005595519944.
- Smid, W. J., Kamphuis, J. H., Wever, E. C. y Van Beek, D. J. (2014). A comparison of the predictive properties of nine sex offender risk assessment instruments. *Psychological Assessment*, 26(3), 691-703. doi: 10.1037/a0036616.
- Smith, P., Cullen, F. T. y Latessa, E. J. (2009). Can 14,737 women be wrong? A meta-analysis of the LSI-R and recidivism for female offenders. *Criminology & Public Policy*, 8(1), 183-208. doi: 10.1111/j.1745-9133.2009.00551.x.
- Smith, W. R. y Monastersky, C. (1986). Assessing juvenile sexual offenders' risk for reoffending. *Criminal Justice and Behavior*, 13(2), 115-140. doi: 10.1177/0093854886013002001.

- Snowden, R. J., Gray, N. S. y Taylor, J. (2010). Risk assessment for future violence in individuals from an ethnic minority group. *International Journal of Forensic Mental Health*, 9(2), 118-123. doi: 10.1080/14999013.2010.501845.
- Soothill, K., Fitzpatrick, C. y Francis, B. (2009). *Understanding Criminal Careers*. Cullompton, Inglaterra: Willan.
- Spielberger, C. D. (1999). *State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2)*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Stalans, L. J., Yarnold, P. R., Seng, M., Olson, D. E. y Repp, M. (2004). Identifying three types of violent offenders and predicting violent recidivism while on probation: A classification tree analysis. *Law and Human Behavior*, 28(3), 253-271. doi: 10.1023/B:LAHU.0000029138.92866.af.
- Stanford, M. S., Mathias, C. W., Dougherty, D. M., Lake, S. L., Anderson, N. E. y Patton, J. H. (2009). Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and review. *Personality and Individual Differences*, 47(5), 385-395. doi: 10.1016/j.paid.2009.04.008.
- Steadman, H. J. (1973). Some evidence on the inadequacy of the concept and determination of dangerousness in law and psychiatry. *Journal of Psychiatry and Law*, 1(4), 409-426.
- Steadman, H. J. (1978). Employing psychiatric predictions of dangerous behavior: policy vs. fact. En C. J. Frederick (ed.), *Dangerous Behavior: a problem in law and mental health* (pp. 123-136). Washington, DC: National Institute of Mental Health.
- Steadman, H. J. (1980). The right not to be a false positive: Problems in the application of the dangerousness standard. *Psychiatric Quarterly*, 52(2), 84-99. doi: 10.1007/BF01071879.
- Steadman, H. J. (1983). Predicting dangerousness among the mentally ill: Art, magic and science. *International Journal of Law and Psychiatry*, 6(3-4), 381-390. doi: 10.1016/0160-2527(83)90025-0.
- Steadman, H. J. y Cocozza, J. (1978). Psychiatry, dangerousness and the repetitively violent offender. *The Journal of Criminal Law & Criminology*, 69(2), 226-231.
- Steadman, H. J. y Morrissey, J. P. (1981). The statistical prediction of violent behavior: measuring the costs of a public protectionist versus a civil libertarian model. *Law and Human Behavior*, 5(4), 263-274.
- Stewart, L. A., Gabora, N., Allegri, N. y Slavin-Stewart, M. C. (2014). Profile of female perpetrators of intimate partner violence in an offender population: Implications for treatment. *Partner Abuse*, 5(2), 168-188. doi: 10.1891/1946-6560.5.2.168.
- Stock, H. V. (2007). Workplace violence: Advances in consultation and assessment. En M. Goldstein (ed.), *Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles* (pp. 511-549). Hoboken, NJ: Wiley.
- Storey, J. E. y Hart, S. D. (2011). How do police respond to stalking? An examination of the risk management strategies and tactics used in a specialized anti-stalking law enforcement unit. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 26(2), 128-142. doi: 10.1007/s11896-010-9081-8.
- Storey, J. E. y Hart, S. D. (2014). An examination of the Danger Assessment as a victim-based risk assessment instrument for lethal intimate partner violence. *Journal of Threat Assessment and Management*, 1(1), 56-66. doi: 10.1037/tam0000002.
- Storey, J. E. y Strand, S. (2012). The characteristics and violence risk management of women arrested by the police for intimate partner violence. *European Journal of Criminology*, 9(6), 636-651. doi: 10.1177/1477370812453403.
- Storey, J. E. y Strand, S. (2013). Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 22(9), 964-980. doi: 10.1080/10926771.2013.835015.
- Storey, J. E., Hart, S. D., Meloy, J. R. y Reavis, J. A. (2009). Psychopathy and stalking. *Law Hum Behav*, 33(3), 237-246. doi: 10.1007/s10979-008-9149-5.
- Storey, J. E., Kropp, P. R., Hart, S. D., Belfrage, H. y Strand, S. (2014). Assessment and management of risk for intimate partner violence by police officers using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk. *Criminal Justice and Behavior*, 41(2), 256-271. doi: 10.1177/0093854813503960.
- Stott, D. H. (1960a). A new delinquency prediction instrument using behavioural indications. *International Journal of Social Psychiatry*, 6(3-4), 195-205. doi: 10.1177/002076406000600305.
- Stott, D. H. (1960b). The prediction of delinquency from non-delinquent behaviour. *British Journal of Delinquency*, 10, 195-210.
- Strand, S. (2012). Using a restraining order as a protective risk management strategy to prevent intimate

- te partner violence. *Police Practice and Research*, 13(3), 254-266. doi: 10.1080/15614263.2011.607649.
- Strand, S. y Belfrage, H. (2001). Comparison of HCR-20 scores in violent mentally disordered men and women: Gender differences and similarities. *Psychology, Crime & Law*, 7(1-4), 71-79. doi: 10.1080/10683160108401784.
- Straus, M. A., Hamby, S., Boney-McCoy, S. y Sugarman, D. (1996). The Revised Conflict Tactics Scales: Development and preliminary psychometric data. *Journal of Family Issues*, 17, 283-316.
- Strub, D. S., Douglas, K. S. y Nicholls, T. L. (2014). The validity of version 3 of the HCR-20 violence risk assessment scheme amongst offenders and civil psychiatric patients. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(2), 148-159. doi: 10.1080/14999013.2014.911785.
- Sturmey, P. (ed.) (2009). *Clinical case formulation: Varieties of approaches*. Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Sturmey, P. y McMurran, M. (eds.) (2011). *Forensic case formulation*. Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Sutherland, A. A., Johnstone, L., Davidson, K. M., Hart, S. D., Cooke, D. J., Kropp, P. R., ... y Stocks, R. (2012). Sexual violence risk assessment: An investigation of the interrater reliability of professional judgments made using the Risk for Sexual Violence Protocol. *International Journal of Forensic Mental Health*, 11(2), 119-133. doi: 10.1080/14999013.2012.690020.
- Szumilas, M. (2010). Explaining Odds Ratios. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 19(3), 227-229.
- Tapias-Saldaña, Á. (2011). Aplicación de los instrumentos de reincidencia en violencia HCR-20 y SVR-20 en dos grupos de delincuentes colombianos. *Criminalidad*, 53(1), 307-327.
- Telles, L. E. d. B., Folino, J. O. y Taborda, J. G. V. (2012). Accuracy of the Historical, Clinical and Risk Management Scales (HCR-20) in predicting violence and other offenses in forensic psychiatric patients in Brazil. *International Journal of Law and Psychiatry*, 35(5-6), 427-431. doi: 10.1016/j.ijlp.2012.09.001.
- Tengström, A. (2001). Long-term predictive validity of historical factors in two risk assessment instruments in a group of violent offenders with schizophrenia. *Nordic Journal of Psychiatry*, 55(4), 243-249. doi: 10.1080/080394801681019093.
- Tengström, A., Hodgins, S., Müller-Isberner, R., Jöckel, D., Freese, R., Özokyay, K. y Sommer, J. (2006). Predicting violent and antisocial behavior in hospital using the HCR-20: The effect of diagnoses on predictive accuracy. *International Journal of Forensic Mental Health*, 5(1), 39-53. doi: 10.1080/14999013.2006.10471229.
- Thijssen, J. y de Ruiter, C. (2011). Identifying subtypes of spousal assaulters using the B-SAFER. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(7), 1307-1321. doi: 10.1177/0886260510369129.
- Thomas-Peter, B. A. y Howells, K. (1996). The clinical investigation and formulation of forensic problems. *Australian Psychologist*, 31(1), 20-27. doi: 10.1080/00050069608260170.
- Thomson, R. E. (1953). A validation of the Glueck Social Prediction Scale for proneness to delinquency. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 43(4), 451-470.
- Thornberry, T. P. y Krohn, M. D. (eds.) (2003). *Taking stock of delinquency: An overview of findings from contemporary longitudinal studies*. Nueva York, NY: Kluwer Academic Publishers.
- Thornton, D. y Laws, D. R. (eds.) (2009). *Cognitive approaches to the assessment of sexual interest in sexual offenders*. Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Thornton, D., Mann, R., Webster, S., Blud, L., Travers, R., Friendship, C. y Erikson, M. (2003). Distinguishing and combining risks for sexual and violent recidivism. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 989, 225-235. doi: 10.1111/j.1749-6632.2003.tb07308.x.
- Tibbitts, C. (1931). Success or failure on parole can be predicted: A study of the records of 3,000 youths paroled from the Illinois State Reformatory. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 22(1), 11-50.
- Tibbitts, C. (1932). Reliability of factors used in predicting success or failure in parole. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 22(6), 844-853.
- Tietze, T. (2014). The Breivik controversy: Politics, terrorism and psychiatry. *Australasian Psychiatry*, 22(4), 383-385. doi: 10.1177/1039856214537127.
- Tolan, P. H. (2007). Understanding violence. En D. J. Flannery, A. T. Vazsonyi e I. D. Waldman (eds.), *The Cambridge handbook of violent behavior and aggression* (pp. 5-18). Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.

- Tollefson, D. R. y Gross, E. R. (2006). Predicting recidivism following participation in a treatment program for batterers. *Journal of Social Service Research*, 32(4), 39-62. doi: 10.1300/J079v32n04_03.
- Torrey, E. F., Stanley, J., Monahan, J. y Steadman, H. J. (2008). The MacArthur violence risk assessment study revisited: Two views ten years after its initial publication. *Psychiatric Services*, 59(2), 147-152. doi: 10.1176/appi.ps.59.2.147.
- Tully, R. J., Chou, S. y Browne, K. D. (2013). A systematic review on the effectiveness of sex offender risk assessment tools in predicting sexual recidivism of adult male sex offenders. *Clinical Psychology Review*, 33(2), 287-316. doi: 10.1016/j.cpr.2012.12.002.
- Ullrich, S., Keers, R. y Coid, J. W. (2014). Delusions, anger, and serious violence: New findings from the MacArthur violence risk assessment study. *Schizophrenia Bulletin*, 40(5), 1174-1181. doi: 10.1093/schbul/sbt126.
- UNODC (2014). *Global study on homicide 2013. Trends, context, data*. Viena, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC (2015). *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), Version 1.0*. Viena, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC (2016). *Handbook on the management of high-risk prisoners*. Viena, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Urquhart, T. A. y Viljoen, J. L. (2014). The use of the SAVRY and YLS/CMI in adolescent court proceedings: A case law review. *International Journal of Forensic Mental Health*, 13(1), 47-61. doi: 10.1080/14999013.2014.885470.
- Vachon, D. D., Lynam, D. R. y Johnson, J. A. (2014). The (non)relation between empathy and aggression: Surprising results from a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 140(3), 751-773. doi: 10.1037/a0035236.
- Van Voorhis, P., Wright, E. M., Salisbury, E. y Bauman, A. (2010). Women's risk factors and their contributions to existing risk/needs assessment: the current status of a gender-responsive supplement. *Criminal Justice and Behavior*, 37(3), 261-288. doi: 10.1177/0093854809357442.
- Van Wormer, K. S. (ed.) (2010). *Working with female offenders: A gender-sensitive approach*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Vasconcelos, A. G., Malloy-Diniz, L. y Correa, H. (2012). Systematic review of psychometric properties of Barratt Impulsiveness Scale version 11 (BIS-11). *Clinical Neuropsychiatry*, 9(2), 61-74.
- Verbrugghe, H. M., Goodman-Delahunty, J. y Frize, M. C. J. (2011). Risk assessment in intellectually disabled offenders: Validation of the suggested ID supplement to the HCR-20. *International Journal of Forensic Mental Health*, 10(2), 83-91. doi: 10.1080/14999013.2011.555934.
- Vess, J. (2011). Risk assessment with female sex offenders: Can women meet the criteria of community protection laws? *Journal of Sexual Aggression*, 17(1), 77-91. doi: 10.1080/13552600.2010.528844.
- Viljoen, J. L., Beneteau, J. L., Gulbransen, E., Brodersen, E., Desmarais, S. L., Nicholls, T. L. y Cruise, K. R. (2012). Assessment of multiple risk outcomes, strengths, and change with the START:AV: A short-term prospective study with adolescent offenders. *International Journal of Forensic Mental Health*, 11(3), 165-180. doi: 10.1080/14999013.2012.737407.
- Viljoen, J. L., Cruise, K. R., Nicholls, T. L., Desmarais, S. L. y Webster, C. D. (2012). Taking stock and taking steps: The case for an adolescent version of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability. *International Journal of Forensic Mental Health*, 11(3), 135-149. doi: 10.1080/14999013.2012.737406.
- Viljoen, J. L., Elkovitch, N. y Ullman, D. (2008). Assessing risk for violence in adolescents. En R. L. Jackson (ed.), *Learning forensic assessment* (páginas 385-414). Nueva York, NY: Routledge.
- Viljoen, J. L., Elkovitch, N., Scalora, M. J. y Ullman, D. (2009). Assessment of reoffense risk in adolescents who have committed sexual offenses: Predictive validity of the ERASOR, PCL:YV, YLS/CMI, and Static-99. *Criminal Justice and Behavior*, 36(10), 981-1000. doi: 10.1177/0093854809340991.
- Viljoen, J. L., Gray, A. L. y Barone, C. (2016). Assessing risk for violence in adolescents. En R. L. Jackson y R. Roesch (eds.), *Learning forensic assessment: Research and practice* (2.^a ed., pp. 357-390). Nueva York, NY: Routledge.
- Viljoen, J. L., Gray, A. L., Shaffer, C., Latzman, N. E., Scalora, M. J. y Ullman, D. (2015). Changes in J-SOAP-II and SAVRY scores over the course of residential, cognitive-behavioral treatment for adolescent sexual offending. *Sexual Abuse: A Journal of*

- Research and Treatment*, en prensa. doi: 10.1177/1079063215595404.
- Viljoen, J. L., Mordell, S. y Beneteau, J. L. (2012). Prediction of adolescent sexual reoffending: A meta-analysis of the J-SOAP-II, ERASOR, J-SORRAT-II, and Static-99. *Law and Human Behavior*, 36(5), 423-438. doi: 10.1037/h0093938.
- Viljoen, J. L., Nicholls, T. L., Cruise, K. R., Desmarais, S. L. y Webster, C. D. (2014). *Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) – User Guide*. Burnaby, Canadá: Mental Health, Law, and Policy Institute.
- Viljoen, J. L., Nicholls, T. L., Cruise, K. R., Douglas, J. B., Desmarais, S. L., Barone, C. C., ... y Webster, C. D. (2016). *START:AV Knowledge Guide. A research compendium on the START:AV strength and vulnerability items*. Burnaby, Canadá: BC Mental Health & Substance Use Services.
- Viljoen, J. L., Scalora, M., Cuadra, L., Bader, S., Chávez, V., Ullman, D. y Lawrence, L. (2008). Assessing Risk for Violence in Adolescents Who Have Sexually Offended: A Comparison of the J-SOAP-II, J-SORRAT-II, and SAVRY. *Criminal Justice and Behavior*, 35(1), 5-23. doi: 10.1177/0093854807307521.
- Vincent, G. M., Maney, S. M. y Hart, S. D. (2009). The use of actuarial risk assessment instruments in sex offenders. En F. M. Saleh, A. J. Grudzinskas, J. M. Bradford y D. J. Brodsky (eds.), *Sex Offenders: Identification, Risk Assessment, Treatment, and Legal Issues* (pp. 70-88). Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Vitopoulos, N. A., Peterson-Badali, M. y Skilling, T. A. (2012). The relationship between matching service to criminogenic need and recidivism in male and female youth: Examining the RNR principles in practice. *Criminal Justice and Behavior*, 39(8), 1025-1041. doi: 10.1177/0093854812442895.
- Vold, G. B. (1935). Prediction methods applied to problems of classification within institutions. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 26(2), 202-209.
- Waisanen, E. y Ackerman, M. J. (2010). Essentials of violence and risk assessment. En M. J. Ackerman (ed.), *Essentials of Forensic Psychological Assessment* (2.^a ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Walker, J. S. y Bright, J. A. (2009). False inflated self-esteem and violence: a systematic review and cognitive model. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 20(1), 1-32. doi: 10.1080/14789940701656808.
- Wallsten, T. S., Budescu, D. V., Zwick, R. y Kemp, S. M. (1993). Preferences and reasons for communicating probabilistic information in verbal or numerical terms. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 31(2), 135-138.
- Walsh, Z., Swogger, M. T., O'Connor, B. P., Schonbrun, Y. C., Shea, M. T. y Stuart, G. L. (2010). Subtypes of partner violence perpetrators among male and female psychiatric patients. *Journal of Abnormal Psychology*, 119(3), 563-574. doi: 10.1037/a0019858.
- Walters, A. A. (1956). A note on statistical methods of predicting delinquency. *The British Journal of Delinquency*, 6(4), 297-301.
- Warner, S. B. (1923). Factors determining parole from the Massachusetts reformatory: The report of the director of committee on criminal records and statistics. *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, 14(2), 172-207.
- Warren, J. I., South, S. C., Burnette, M. L., Rogers, A., Friend, R., Bale, R. y Van Patten, I. (2005). Understanding the risk factors for violence and criminality in women: The concurrent validity of the PCL-R and HCR-20. *International Journal of Law and Psychiatry*, 28(3), 269-289. doi: 10.1016/j.ijlp.2003.09.012.
- Watt, K. A. (2012). *Foundational Threat Assessment and Risk Management Skills*. Taller en Canadian Association of Threat Assessment Professional (CATAP) Conference 2012, Banff, Canadá.
- Watt, K. A., Storey, J. E. y Hart, S. D. (2013). *Differentiating between non-lethal and lethal intimate partner violence*. Comunicación presentada en 13th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Maastricht, Holanda.
- Webster, C. D. y Hucker, S. J. (2007). *Violence Risk Assessment and Management*. Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Webster, C. D., Douglas, K. S., Eaves, D. y Hart, S. D. (1997). *HCR-20: Assessing Risk for Violence (version 2)*. Vancouver, Canadá: Simon Fraser University.
- Webster, C. D., Eaves, D., Douglas, K. S. y Wintrup, A. (1995). *The HCR-20 scheme: The assessment of dangerousness and risk*. Vancouver, Canadá: Simon

- Fraser University and British Columbia Forensic Psychiatric Services Commission.
- Webster, C. D., Haque, Q. y Hucker, S. J. (2014). *Violence Risk – Assessment and Management: Advances through structured professional judgement and sequential redirections* (2.^a ed.). Chichester, Inglaterra: Wiley-Blackwell.
- Webster, C. D., Haque, Q., Augimeri, L., Brink, J., Cree, A., Desmarais, S., ... y Snowden, R. (2014). Teaching and researching SPJ guides. En C. D. Webster, Q. Haque y S. Hucker (eds.), *Violence Risk-Assessment and Management: Advances through structured professional judgement and sequential redirections* (2.^a ed., pp. 123-137). Chichester, Inglaterra: Wiley.
- Webster, C. D., Harris, G. T., Rice, M. E., Cormier, C. y Quinsey, V. L. (1994). *The violence prediction scheme. Assessing dangerousness in high risk men*. Toronto, Canadá: Centre of Criminology, University of Toronto.
- Webster, C. D., Martin, M., Brink, J., Nicholls, T. L. y Desmarais, S. L. (2009). *Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). Clinical guide for evaluation risk and recovery. Version 1.1*. Ontario, Canadá: St. Joseph's Healthcare Hamilton.
- Webster, C. D., Martin, M., Brink, J., Nicholls, T. L. y Middleton, C. (2004). *Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). Clinical guide for evaluation risk and recovery*. Ontario, Canadá: St. Joseph's Healthcare Hamilton.
- Webster, C. D., Nicholls, T. L., Martin, M.-L., Desmarais, S. L. y Brink, J. (2006). Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START): The case for a new structured professional judgment scheme. *Behavioral Sciences & the Law*, 24(6), 747-766. doi: 10.1002/bsl.737.
- Weeks, H. A. (1943). Predicting juvenile delinquency. *American Sociological Review*, 8(1), 40-46.
- Weerasekera, P. (1996). *Multiperspective case formulation. A step toward treatment integration*. Malabar, FL: Krieger.
- Weis, K. (1974). The Glueck Social Prediction Table: An unfulfilled promise. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 65(39), 397-404.
- Wenger, L. y Andrés-Pueyo, A. (2016a). Tests forenses en español para evaluar adolescentes infractores. *Papeles del Psicólogo*, 37(2), 107-117.
- Wenger, L. y Andrés-Pueyo, A. (2016b). Tests psicológicos y clínicos en español para evaluar adolescentes infractores. *Papeles del Psicólogo*, 37(2), 89-106.
- Wenk, E. A., Robison, J. O. y Smith, G. W. (1972). Can violence be predicted? *Crime & Delinquency*, 18(4), 393-402. doi: 10.1177/001112877201800408.
- White, S. G. (2013). Workplace targeted violence: Threat assessment incorporating a structured professional judgment guide. En J. R. Meloy y J. Hoffmann (eds.), *International Handbook of Threat Assessment*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- White, S. G. y Meloy, J. R. (2010). *WAVR-21: A structured professional guide for the workplace assessment of violence risk* (2.^a ed.). San Diego, CA: Specialized Training Services.
- Whitney, S. D., Renner, L. M. y Herrenkohl, T. I. (2010). Gender differences in risk and promotive classifications associated with adolescent delinquency. *The Journal of Genetic Psychology*, 171(2), 116-138. doi: 10.1080/00221320903548092.
- Wilczynski, A. (1991). Images of women who kill their infants: The Mad and the Bad. *Women & Criminal Justice*, 2(2), 71-88. doi: 10.1300/J012v02n02_05.
- Wilczynski, A. (1997). Mad or Bad?: Child-killers, gender and the courts. *British Journal of Criminology*, 37(3), 419-436.
- Wilkins, L. T. (1974). Directions for Corrections. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 118(3), 235-247.
- Williams, W. y Miller, K. S. (1977). The role of personal characteristics in perceptions of dangerousness. *Criminal Justice and Behavior*, 4(3), 241-252. doi: 10.1177/009385487700400302.
- Willison, J. S. y Lutter, Y. (2009). Contextualizing women's violence: gender-responsive assessment and treatment. En J. T. Andrade (ed.), *Handbook of Violence Risk Assessment and Treatment* (pp. 121-156). Nueva York, NY: Springer.
- Wilson, D. B. (2010). Meta-analysis. En A. R. Piquero y D. Weisburd (eds.), *Handbook of Quantitative Criminology* (pp. 181-208). Nueva York, NY: Springer.
- Wilson, E. O. (2012). *The social conquest of Earth*. Nueva York, NY: W. W. Norton & Company.
- Wong, S. C. P., Olver, M. E. y Stockdale, K. C. (2009). The utility of dynamic and static factors in risk assessment, prediction, and treatment. En J. T. Andrade (ed.), *Handbook of violence risk assessment and treatment: New approaches for mental health*

- professionals* (pp. 83-120). Nueva York, NY: Springer.
- Worling, J. R. (2004). The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (ERASOR): Preliminary psychometric data. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 16(3), 235-254. doi: 10.1177/107906320401600305.
- Worling, J. R. y Langton, C. M. (2015). A prospective investigation of factors that predict desistance from recidivism for adolescents who have sexually offended. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 27(1), 127-142. doi: 10.1177/1079063214549260.
- Worling, J. R., Bookalam, D. y Litteljohn, A. (2012). Prospective validity of the Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (ERASOR). *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 24(3), 203-223. doi: 10.1177/1079063211407080.
- Wormith, J. S. y Goldstone, C. S. (1984). The clinical and statistical prediction of recidivism. *Criminal Justice and Behavior*, 11(1), 3-34. doi: 10.1177/0093854884011001001.
- Wulf, T., Meissner, P., Brands, C. y Stubner, S. (2013). Scenario-based strategic planning: A new approach to coping with uncertainty. En B. Schwenker y T. Wulf (eds.), *Scenario-based Strategic Planning. Developing strategies in uncertain world* (pp. 43-66). Wiesbaden, Alemania: Springer-Gabler.
- Yang, M., Wong, S. C. P. y Coid, J. (2010). The efficacy of violence prediction: A meta-analytic comparison of nine risk assessment tools. *Psychological Bulletin*, 136(5), 740-767. doi: 10.1037/a0020473.
- Yang, M., Wong, S. C. P. y Woid, J. W. (2013). Violence, mental health and violence risk factors among community women: an epidemiological study based on two national household surveys in the UK. *BMC Public Health*, 13(1020). doi: 10.1186/1471-2458-13-1020.
- Yates, P. y Kingston, D. A. (2007). *The Casebook Companion: Scoring the Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP)*. Victoria, Canadá: Pacific Psychological Assessment Corporation.
- Yoon, D., Turner, D., Klein, V., Rettenberger, M., Eher, R. y Briken, P. (2016). Factors predicting desistance from reoffending: A validation study of the SAPROF in sexual offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, en prensa. doi: 10.1177/0306624x16664379.
- Zeng, G., Chu, C. M. y Lee, Y. (2015). Assessing protective factors of youth who sexually offended in Singapore: Preliminary evidence on the utility of the DASH-13 and the SAPROF. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 27(1), 91-108. doi: 10.1177/1079063214561684.
- Zeng, G., Chu, C. M., Koh, L. L. y Teoh, J. (2015). Risk and criminogenic needs of youth who sexually offended in Singapore: An examination of two typologies. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 27(5), 479-495. doi: 10.1177/1079063213520044.
- Zhou, X.-H., Obuchowski, N. A. y McClish, D. K. (2011). *Statistical Methods in Diagnostic Medicine* (2.^a ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Zimbardo, P. (2008). *El efecto Lucifer. El porqué de la maldad*. Barcelona, España: Paidós.

Índice analítico

A

Acoso, 25-26, 124, 163, 165-166, 193-199, 201.
Actuarial ajustado (véase enfoque actuarial ajustado).
Actuarial (método), 69, 101-109.
Acute, 172.
Agresión, 21-24.
Agresividad, 23-24.
Agresoras (véase mujeres).
Alcohol, 30, 31, 36, 63, 149, 150, 153, 155, 163, 165, 166, 173, 214.
Amicus curiae, 65-66.
Análisis factorial, 131, 158, 160.
Análisis funcional, 118.
Antisocial (trastorno de la personalidad), 31, 147-149, 207.
APA, 46, 65-66, 92.
Árbol de clasificación, 35, 57, 72, 104.
Área Bajo la Curva (véase AUC).
Argentina, 72, 145, 147, 160.
AUC, 91-93.
Ausencia de información (véase también prorratio), 117, 164, 215.
Autodirigida (violencia), 129.
Autoestima, 28, 208.
Autolesión, 26, 151, 176, 178, 207.

B

Barefoot vs. Estelle (caso), 64-66.
Beneficios violencia, 84-85.
B-SAFER, 114, 115, 127, 129, 131, 133, 154, 160-162, 195, 200, 208, 210.

C

Caballerosidad (hipótesis), 29.
Calendario (véase también DA), 155-156.
Cambridge (estudio), 36-37.
Capacidad preventiva, 75, 128.
Categorías, categorial, etiquetas (véase formato de resultado).
Causalidad, 27, 33, 137.
Chile, 72, 147, 177.
Colombia, 147.
Comunicación del riesgo (formato de), 130-138.
Confidencialidad, 127.
Corto plazo, 17, 61, 66, 146, 178, 181, 183.
Correlación, 80, 95, 105, 146, 150, 160, 166, 176, 177, 179, 195, 209.
Costes de la violencia, 85, 119.
COVR, 35, 105.
Credibilidad, 60, 97, 99, 114.
Criterio numérico, 133, 157.
Criterio profesional, 49, 55.
CTS -2, 23, 89, 135, 161.
Cualificación, 139, 213.
Curva (véase AUC, ROC).

D

d de Cohen (véase tamaño del efecto).
DA (Danger Assessment), 93, 115, 116, 153, 155-157, 209.
DASH, 201.
Delinuentes peligrosos, 46, 64, 74.
Delinuentes persistentes, 36, 53.
Depresión, 28, 32, 34, 35, 63, 196, 199.
Derecho a la protección vs. Derecho del evaluado, 46, 64, 99.

Deseabilidad, 27.
 Determinismo, 77-78.
 Dinamicidad, 116, 127, 133, 179, 181.
 Dinámicos (factores), 53, 72, 80, 82-84, 105, 150, 171, 172, 178, 180, 181, 183, 184, 192.
 Discapacitados, 146.
 Discrecionalidad, 75, 132.
 Doctrina Parot, 69.
Drivers (véase también factores motivadores), 86, 120.
 Drogas, 30, 31, 34-36, 59, 63, 80, 84, 122, 150, 151, 153, 154, 155, 159, 163, 165, 166, 170, 178, 196, 201, 208.
 Dunedin (estudio), 35-36.
DVRAG, 150, 162-163, 173.

E

EARL-20B, 70, 115, 179-180.
EARL-21G, 70, 115, 179-180, 204.
 Elección, violencia como, 22, 119.
 Empatía, 28, 81, 85, 119, 152, 153, 176, 184, 189.
 Encuestas, 72-73.
 Enfoque actuarial ajustado, 104, 109, 131, 133, 135, 177.
EPV-R, 114, 115, 128-131, 133, 136, 153, 154, 164-165.
ERA-20, 70, 115, 198.
ERASOR, 93, 115, 181-184, 210.
ERG 22+, 71, 115, 192-193.
 Ertzaintza, 128, 130, 136, 164.
 Escalada, 83, 124, 127, 159, 161, 170, 182, 194, 195, 200, 214.
 Escenarios (desarrollo de), 112, 113, 119, 122-125, 148, 169, 214.
 Especificidad, 89-92, 97, 99, 114, 116, 158, 162, 169.
 Esquizofrenia, 31-32, 34-36, 63, 149, 173.
 Estabilidad, 42, 48, 52, 82, 160.
 Estáticos (véase factores).
 Estrategia (véase gestión).
 Ética, 34, 58, 59, 63, 68, 105, 111.
Exp (b) (véase *Odds ratio*).
 Extremista, 70, 71, 187-193.

F

Factor:
 crítico, 57, 118, 157.
 de riesgo, 80, 82-86.
 desestabilizador, 85-86, 120-122, 214.
 desinhibidor, 85-86, 119-122, 125, 214.

dinámico, 53, 82-84, 102.
 disparador, 120-121.
 estático, 50, 82-83, 102mantenedor 120-121.
 motivador, 84-86, 119-122, 125, 214.
 precipitantes, 120-121, 209, 214.
 predisponente, 120-121, 214.
 protector, 47, 51, 70-71, 80-81, 120-122, 151-152, 175-181, 189-190, 198, 200, 214.
 Falso negativo, 88, 90, 97.
 Falso positivo, 64, 88, 90, 97, 99.
FAM, 25, 71, 115, 146, 207-208, 211.
 Fiabilidad interjueces, 112, 147, 152, 162, 164, 166, 170, 173, 179, 180, 185, 190, 195, 197, 204, 213.
 Fiabilidad test-retest, 130-131.
 Formación, 15-17, 66, 75, 132, 164, 170, 179, 192.
 Formato actuarial, 131, 133-135, 162.
 Formato de resultado.
 categoría nominal, 78, 131-132, 134-135, 146, 158, 176, 182, 183, 198.
 centiles, 133-135, 157.
 coeficiente de riesgo, 133.
 frecuencias, 131, 134.
 probabilístico, 54, 104, 133-135.
 puntos de corte no formales, 133, 158.
 tasas absolutas, 131, 133.
 Formulación, 61, 86, 112-113, 116, 118-122, 147, 157, 170, 197, 214.
 Fracción de verdaderos negativos, 89.
 Fracción de verdaderos positivos, 89.

G

Género (perspectiva de), 146, 179, 203-211.
 Gestión, 124-130.
 monitorización, 125-126.
 planes de seguridad, 120, 125, 126, 128, 156, 201, 215.
 supervisión, 120, 125, 126, 128, 156, 168, 170, 172, 195.
 tratamiento, 120, 125-127, 129, 138.
 Gestión policial, 128, 129-130, 160.

H

HCR-20, 48, 69, 70-72, 93, 112, 115, 117-118, 131, 145-148, 204.
 Hiperactividad, 36, 176, 180.

Hipótesis de futuro (véase escenarios).
 Histórico (véase factor estático).
 Homicidio, 22, 31, 32, 154-157, 159, 163, 164, 198.
 Homosexuales (violencia en relaciones), 156, 209.

I

Ideográfico, 102, 119.
 IGI-J, 117.
 Implicaciones de la valoración, 16, 46, 62, 63, 66, 137, 213.
 Imputabilidad, 22, 27, 55, 74, 137, 204.
Index offense, 149, 158.
 Índice Corminer-Lang, 149, 173.
 Informe, 113, 114, 116, 127, 130, 137-139, 213-215.
 Institución, 26, 62, 67, 128, 146.
 Intención, 22, 25, 148, 165, 189, 191-193, 198-199.
 Internamiento preventivo, 58, 64.
 Intrainstitucional, 26, 43, 49, 57, 207.
IORNS, 81.
 Ítem crítico (véase factor crítico).

J

J-SOAP, 93, 115, 183-185.
J-SORRAT, 93, 115, 184-185.
 Juicio clínico, 55, 65-66, 69, 73, 101-103, 107.
 Juicio estructurado, 69, 105-107, 211.

L

Latinoamérica, 72-73.
 Ley Clare, 78-79.
 Ley Jacob Wetterling, 79.
 Ley Megan, 79.
 Ley Palm Lychner, 79.
 Ley Sarah, 79.
 Libro rosa, 69, 105, 145.
 Límite (personalidad; trastorno), 31, 208.
 Lobo solitario, 187-188, 190-191.
LSI-R, 73, 107, 149, 150, 177, 196, 205.

M

MacArthur (estudio), 34-35, 104-105, 204, 205.
 Malo o loco, 29.

Mantenedores (véase factor).
 Metaanálisis, 93-94, 106, 170, 176-177, 183, 205.
 Meteorología, 90, 104, 135.
 Método Burgess, 43, 46-47, 49-52.
 Mezcla (escenarios), 124.
MLG, 188.
 Modelo 5Ps, 120.
 Modelo de toma de decisión, 119.
 Monitorizar (véase gestión).
 Motivador (véase factor).
 Muestra psiquiátrica, 34, 146, 151.
 Mujeres (agresoras; violencia femenina), 35, 48, 71, 128, 158, 164, 167, 203-211.
 Munchausen (síndrome), 32.

N

Naturaleza humana, 77-78, 82.
 Nominal (véase formato de resultado).
 Nomotético, 102, 119.

O

OASys, 201.
ODARA, 131, 134, 154, 156, 162-164, 209.
Odds ratio (OR), 93-96, 168.
 Orden de alejamiento, de protección (véase víctima).

P

Parafilia, 32, 83, 121, 122, 168, 170, 196, 214.
 Patriarcal (violencia; crímenes de honor), 26, 199-201.
PATRIARCH, 115, 200-201.
PCL:SV, 34, 35, 68, 72, 145, 146, 195.
PCL:YV, 68, 145, 181, 206.
PCL-R, 68, 70, 72, 107, 145, 147, 149, 150, 162, 163, 173, 206, 207.
 Pedofilia, 32.
 Peligrosidad, 16, 42, 44-45, 55-68, 73-74, 83, 138, 213.
 Penitenciario (contexto; historial; muestra; reincidencia), 26, 42, 47, 49, 65, 95, 104, 116, 128, 133, 134, 137, 146, 147, 149, 150, 157, 158, 161, 168, 169, 201, 205, 206.
Pericolosità, 42, 73.
 Planes de seguridad para la víctima (véase víctima).

Planificación de escenarios, 119, 120, 122-124.
 Ponderado (ítems; método), 43, 50, 51, 53-54, 67, 75, 113, 149, 164, 171, 172.
 Postura liberal y proteccionista, 46, 64, 99.
 Precipitantes (véase factor).
 Precisión (influencia; interferencia), 53, 68, 127.
 Predisponentes (véase factor).
 Preferencias de los profesionales, 135-136.
 Prisión permanente revisable, 74.
 PRISM (institución), 128.
 Probabilidad de reincidencia, 47-48, 50, 52, 56, 58, 64, 65, 80, 92-96, 103, 113, 128, 131-132, 134, -136, 158, 162, 169, 171-173, 185.
 Proporcionalidad, 84, 129.
 Prospectivo, 33, 150.
 Prorrato, 164.
 Protección de la víctima (véase víctima).
 Protector (véase factor).
 Psicopatía, 32, 34, 35, 68, 72, 83, 84, 147, 148, 163, 167-170, 195, 207.
 Psiquiátrico (contexto), 17, 26, 34, 35, 55, 60, 62, 63, 67, 105, 128-129, 146, 149, 204.
 Punto de corte, 60, 90, 92, 97-99, 117, 129, 131-133, 158, 162, 195, 207.

Q

Quebrantamiento, 47, 51, 83, 130, 154, 158-161, 165, 195, 201.

R

r de Pearson, 92, 94-95, 164, 166, 177, 195.
 Radicalización, 26, 71, 115, 187-193.
 RARA, 201.
 Razonamiento motivado, 136.
 Registro de delincuentes sexuales, 79.
 Registro oficial, 68, 89.
 Regla 5W, 138, 215.
 Regresión, 59, 94, 149, 162.
 Relevancia (del factor), 50, 53, 59, 63, 86, 105, 112-113, 116-118, 121, 138, 147, 150, 157, 169, 194, 197-198, 200, 214.
 Repetición (escenario), 124.
 Responsividad, 84, 148, 179, 180.
 Resultados (véase formato de).

Retrospectivo, 33, 152, 158, 204.
 Riesgo asumible, 62, 64, 97-99.
 Riesgo relativo (RR), 93-96.
 Riesgo (véase factores).
 Riesgo-necesidad-responsividad (RNR), 84, 127, 150, 179.
RM2000, 93, 115, 173-174.
 ROC, 90-92.
RRASOR, 93, 107, 115, 170-171.
RSVP, 70, 74, 112, 114-115, 117, 131, 168-170, 194, 210.
RVD-Bcn, 115, 133, 153-154, 165-166.

S

SAM, 70, 115, 194-195, 200.
 Sanitario (contexto), 129.
SAPROF, 70, 72, 81, 115, 151-152, 204.
SAPROF-YV, 71, 81, 115, 180-181.
SARA, 70, 71, 93, 115, 117, 118, 128, 129, 131, 133, 153, 154, 157-160, 194, 209.
SAVRY, 70, 81, 93, 115, 117, 175-177, 179, 184, 206.
 Sensibilidad, 89-92, 97, 99, 158, 162, 169.
 Sesgo de autor, 106.
 Sobreestimación, 45, 55-56, 58, 83, 88, 102-103, 132, 156, 172, 209.
SORAG, 70, 93, 115, 149, 150, 169, 173.
SRP, 70, 194, 196-197.
Stable, 172.
START, 26, 70, 72, 81, 115, 150-151, 204.
START:AV, 71, 81, 115, 178-179.
 Subjetividad, 27, 104, 105, 108, 132.
 Suicidio, 26, 32, 128, 151, 154, 159, 166, 178, 198, 201.
 Supervisión (véase gestión).
SVR-20, 70, 93, 115, 117, 131, 147, 149, 167-170, 174, 197.

T

Tabla de contingencia (2×2), 95.
 Tablas de configuración (Glaser), 56-57.
 Tablas de experiencia (Burgess), 47.
 Tablas de predicción, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 53-57.
 Tablas de predicción social (Glueck y Glueck), 43, 53-55, 61.
 Tamaño del efecto (*d*), 94, 99.

Tasa absoluta (véase formato de resultado).
 Tasa base de reincidencia, 47, 52, 57, 61, 63, 67, 95, 111, 136, 149, 173.
 Tasa de expectativa (Burgess), 46, 47.
 Terrorismo, 26, 187-193.
 Tipologías de agresores, 35, 68, 89, 95, 158, 160, 161, 183.
TRAP-18, 71, 190-192.
 Trastornos de la personalidad, 30-32, 34, 35-36, 59, 65, 83, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 159, 161, 170, 173, 176, 177, 196, 207, 208.
 Tratamiento (véase gestión).

V

Valor predictivo negativo, 89-90.
 Valor predictivo positivo, 89-90.
 Valoración policial, 104, 126, 128-129, 132, 133, 136, 137, 158, 160, 162, 164-166.
VERA, 70, 115, 188-190, 192.
 Víctima.
 comunicación del riesgo, 134, 137-138, 156.

factores de vulnerabilidad, 153, 157, 159-161, 164, 165-166, 194-195, 200-201.
 medidas de protección, 25, 128, 130.
 orden de protección, 25, 78, 125, 129, 130, 154, 159-160, 163, 165, 201.
 plan de seguridad, 120, 125-126, 128, 156, 201, 215.
 Victimización, 26, 30, 147-148, 151, 159, 178, 184, 185, 207, 209.
VPR, 136.
VRAG, 35, 69-71, 93, 107, 115, 134, 147-150, 173, 195, 204-206.

W

WAVR-21, 71, 115, 198-199.
WRA-20, 70, 115, 198.
WRNA (*Women's Risk/Needs Assessment*), 211.

Y

YLS/CMI, 70, 93, 145, 175-177, 181, 183, 205-206.

TÍTULOS RELACIONADOS

- ADICCIÓN A LA COMPRA, *R. Rodríguez Villarino, J. M. Otero-López y R. Rodríguez Castro.*
- ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES, *E. Echeburúa, F. J. Labrador y E. Becoña.*
- AGORAFOBIA Y ATAQUES DE PÁNICO, *A. Bados López.*
- ATENCIÓN TEMPRANA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO, *J. Piñero, J. Pérez-López, F. Vargas y A. B. Candela.*
- AVANCES EN EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD, *E. Echeburúa.*
- BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, *P. M. Ruiz Lázaro J. M. Velilla Picazo y E. González Fraile (Dirs.).*
- CÓMO ELEGIR EL MEJOR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, *S. N. Haynes, A. Godoy y A. Gavino.*
- CONSULTORÍA CONDUCTUAL, *M.ª X. Froján Parga (coord.).*
- DE LOS PRINCIPIOS DE LA PSICOLOGÍA A LA PRÁCTICA CLÍNICA, *C. Rodríguez-Naranjo.*
- DETECCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL AULA DE LOS PROBLEMAS DEL ADOLESCENTE, *C. Saldaña (coord.).*
- EL ADOLESCENTE EN SU MUNDO, *J. Toro Trallero.*
- EL JUEGO PATOLÓGICO, *E. Echeburúa, E. Becoña, F. J. Labrador y Fundación Gaudium (coords.).*
- GUÍA DE AYUDA AL TERAPEUTA COGNITIVO-CONDUCTUAL, *A. Gavino Lázaro.*
- GUÍA DE ÉTICA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, *C. del Río.*
- GUÍA DE TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES I, II Y III, *M. Pérez, J. R. Fernández, C. Fernández e I. Amigo (coords.).*
- INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL, *M. Servera Barceló (coord.).*
- INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, *J. Olivares, D. Macià, A. I. Rosa y P. J. Olivares.*
- INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, *P. J. Jiménez Martín.*
- INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, *F. X. Méndez, J. P. Espada y M. Orgilés (coords.).*
- LA INTERVENCIÓN ANTE EL MALTRATO INFANTIL, *J. Martín.*
- LA VOZ Y LAS DISFONÍAS DISFUNCIONALES, *R. M.ª Rivas y M.ª J. Fiuza.*
- LAS RAÍCES DE LA PSICOPATOLOGÍA MODERNA, *M. Pérez.*
- LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS NO SON ENFERMEDADES, *E. López y M. Costa.*
- MANUAL DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA, *I. Loinaz.*
- MANUAL DE PROMOCIÓN DE LA RESILIENCIA INFANTIL Y ADOLESCENTE, *M.ª de la F. Rodríguez, J. M. Morell y J. Fresneda (coords.).*
- MANUAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE. Trastornos específicos, *V. E. Caballo y M. A. Simón (coords.).*
- MANUAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE. Trastornos generales, *V. E. Caballo y M. A. Simón (coords.).*
- MANUAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD, *I. Amigo, C. Fernández y M. Pérez.*
- MANUAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD CON NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIA, *J. M. Ortigosa, M.ª J. Quiles y F. X. Méndez.*
- MANUAL DE PSICOONCOLOGÍA, *J. A. Cruzado Rodríguez (Coord.).*
- MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA, *J. F. Rodríguez Testal y P. J. Mesa Cid.*
- MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA GENERAL, *P. J. Mesa Cid y J. F. Rodríguez Testal.*
- MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA Y TRASTORNOS PSICOLÓGICOS, *V. E. Caballo, I. C. Salazar y J. A. Carroles (dirs.).*
- MANUAL DE TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN Y TERAPIA DE CONDUCTA, *F. J. Labrador, J. A. Cruzado y M. Muñoz.*
- MANUAL DEL PSICÓLOGO DE FAMILIA *L. M.ª Llavona y F. X. Méndez.*
- MANUAL PARA LA AYUDA PSICOLÓGICA, *M. Costa y E. López.*
- MANUAL PARA EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS DELINCUENTES, *S. Redondo Illescas.*
- MANUAL PRÁCTICO DEL JUEGO PATOLÓGICO, *J. Fernández Montalvo y E. Echeburúa.*
- MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, *C. López Soler, M. Alcántara López, M. Castro Sáez y A. Martínez Pérez.*
- MODIFICACIÓN DE CONDUCTA, *R. G. Miltenberger.*
- MÚLTIPLES APLICACIONES DE LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT), *M. Páez Blarrina y O. Gutiérrez Martínez.*
- PRESERVACIÓN FAMILIAR, *M.ª J. Rodrigo, M.ª L. Máiquez, J. C. Martín y S. Byrne.*
- PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES ALIMENTARIAS, *G. López-Guimerà y D. Sánchez-Carracedo.*
- PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS, *M. Isorna Folgar y D. Saavedra Pino (coords.).*
- PSICOLOGÍA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA, *J. A. Mora Mérida, J. García Rodríguez, S. Toro Bueno y J. A. Zarco Resa.*
- PSICOLOGÍA CLÍNICA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, *M.ª T. González (coord.).*
- PSICOLOGÍA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA, *F. J. Labrador y M.ª Crespo.*
- PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTO-JUVENIL, *R. González Barrón e I. Montoya-Castilla (coord.).*
- PSICOLOGÍA DE LA SALUD, *J. Gil Roales-Nieto (dir.).*
- PSICOLOGÍA DE LA SALUD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, *A. I. Rosa Alcázar y P. J. Olivares Olivares (Coords.).*
- PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ, *R. Fernández-Ballesteros (dir.).*
- PSICOMOTRICIDAD, *M. Bernaldo de Quirós Aragón.*
- PSICOPATOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, *R. González Barrón (coord.).*
- PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA. Adaptado al DSM-5, *M. Ortiz-Tallo.*
- PSICOPATOLOGÍA DEL DESARROLLO, *L. Ezpeleta y J. Toro.*
- PSICOPATOLOGÍA INFANTIL BÁSICA, *J. Rodríguez Sacristán (dir.).*
- PSICOTERAPIAS, *J. L. Martorell.*
- REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES CRÓNICOS, *A. Rodríguez González (coord.).*
- TDHA Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, *C. López Soler y A. Romero Medina (Coords.).*
- TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA, *F. J. Labrador Encinas.*
- TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT). Un tratamiento conductual orientado a los valores, *K. G. Wilson y M. C. Luciano Soriano.*
- TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA., *I. Moreno García.*
- TERAPIA DE GRUPO PARA LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS, *L. Carter Sobell y M. B. Sobell.*
- TERAPIA PSICOLÓGICA, *J. P. Espada, J. Olivares y F. X. Méndez (coords.).*
- TERAPIA PSICOLÓGICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, *F. X. Méndez, J. P. Espada y M. Orgilés (coords.).*
- TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL), *E. Mendoza Lara.*
- TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, *F. Alcántud Marín (coord.).*
- TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS Y DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, *M.ª P. García Vera y J. Sanz Fernández.*
- TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL MUTISMO SELECTIVO, *J. Olivares, A. I. Rosa y P. J. Olivares.*
- TRATAMIENTOS CONDUCTUALES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, *J. Olivares, F. X. Méndez y D. Macià.*
- TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS, *J. Vila Castellar y M.ª del C. Fernández-Santaella.*
- TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS Y TRASTORNOS CLÍNICOS, *A. Gavino Lázaro.*
- VIGOREXIA, *A. García Alonso.*
- VIVIR CON LA DROGA, *J. Valverde Molina.*